变老说明书

你或你父母的下一步

中国普通人用得上的晚年手册：22 章正文、5 个附录，按"你或你父母的下一步"排。不教你养老，只让你出问题的时候能翻到那一页——每条都写清要花多少、可以怎么做、来源在哪一档。

整理者 Jweokk · 2026年10月10日 · v1.0.0

本书著作权归整理者 Jweokk 所有，免费阅读与非商业性分享，商业用途须事先获得书面许可。
内容为公开资料整理，不构成医疗建议。纠错与建议：weokk2025@gmail.com

目录

先看这一页

第 0 章 · 这份说明书怎么用
序 · 老年人就是我们未来的样子
关于这份资料 · 与免责声明

篇一 · 存本钱：还没老的时候〔阶段一〕

第 1 章 · 变老不是某一天发生的
第 2 章 · 骨本与肌肉本
第 3 章 · 脑本与感官本
第 4 章 · 钱本与关系本

篇二 · 黑框警告：这三件事先看〔阶段二〕

第 5 章 · 跌倒是晚年的第一道分水岭
第 6 章 · 药不是吃得越多越好
第 7 章 · 吃不下、咽不下、噎住
第 8 章 · 三条就医红线与第一小时

篇三 · 难以启齿与日常保养〔阶段二 · 续〕

第 9 章 · 记不住：从健忘到痴呆有多远
第 10 章 · 尿、便与体面
第 11 章 · 睡不着、疼、心里没劲、孤独
第 12 章 · 每天怎么吃
第 13 章 · 每天怎么动
第 14 章 · 疫苗、筛查和体检单

篇四 · 把家、钱、人、权限安排好〔阶段三〕

第 15 章 · 住哪儿、和谁一起老
第 16 章 · 钱从哪来：制度怎么替你付账
第 17 章 · 人从哪来 + 给照护者的部分
第 18 章 · 手机与骗局：把事办成，别被套走
第 19 章 · 权限设置：趁清醒把权限交出去

篇五 · 最后一程与善后〔阶段四〕

第 20 章 · 怎么开口：那些难以启齿的话
第 21 章 · 走下坡之前：把最后的决定写好
第 22 章 · 谢幕之后：家属要办的手续

结语与附录

结语 · 把说明书翻旧的那一天
附录 A · 全国通用制度台账
附录 C · 症状速查表
附录 D · 恐惧速查表
附录 E · 什么时候必须叫 120
附录 F · 话术卡：开口的十句话

先看这一页

第 0 章 · 这份说明书怎么用

这本书是谁写的

不是医生。

是借助AI把公开资料读了一遍、把官方文件核了一遍整理出来的。所以书里没有一处是我们自己做的实验——**这本书没有自测数据**。凡是数字，后面都挂着一个分档标记，写清它从哪儿来、属于哪一档，你可以自己点开核；核不到的，我们会写明核不到。

这本书也不打算教你养老。写它的人也在变老，也会忘事、也会嫌麻烦、也有不想面对的东西。

这不是任务清单

你可能翻开就紧张：这么多条，一条都做不到。

不用。这本书里绝大多数条目，你一辈子只会用到两三条。**挑一两件做了，这本书就值了。** 剩下的留着备查：等你或者你父母真走到那一步，再翻回来。

所以它长得像说明书，不像教科书。说明书从来不要求你从头读完，只要求你出问题的时候能翻到那一页。

算四笔账，不是一笔

这本书想帮你算四笔账：

- **自理**——能自己吃饭、上厕所、洗澡、出门，还包括能用手机把事办成（挂号、打车、付款）
- **钱**——你自己的养老钱，和子女被卷进去的钱
- **关系**——老伴、子女、老友、邻居、社区。老了最先耗尽的往往不是身体，是关系
- **体面**——不被当孩子哄，不在人前失态，还能自己拿主意

这四笔账不能互相替代。 少摔一跤，换不来每月多三百块；每月多三百块，也换不回一次没摔。谁也替不了谁。

先讲这句，是因为讲养老的书大多只算一笔账：活多久，或者花多少钱。只算一笔，就会得出"买这个不如买那个"的结论；算四笔，你会发现很多事根本不用比，它们是不同的事。

每条怎么看

大多数条目的结构是固定的：

- **要花多少**：这一条要你搭进去什么——钱、工夫、力气，还有开不开口。老年议题有个特点：最贵的那笔成本往往不是钱，是开不了口。所以"开不开口"单列一格。
- **简单说**：这件事到底怎么回事。读完这一栏，你该能把它说给老伴或子女听。
- **可以怎么做**：能照着做的动作。只给做法，不强求你照做。
- **来源**：这一条是从哪来的。**A**＝有具体数字可查的公开出处（系统综述、大型研究、法条原文）；**B**＝有研究支持，但给不出确切数字（比如只有单项小样本研究）；**C**＝通行做法、经验之谈，不是证据。拿不准就按这个字母往回查。
- **特别提醒**：**这一条对谁成立**。60 岁身体好的人和 80 岁带着几种慢病的人，做法不一样。
- 末尾两行：**换回来的**（这笔投入花在四笔账的哪一笔上、少掉哪一样怕），以及**在中国怎么落地**（找谁、去哪问、有哪些补贴）。

有些条目只有三栏。一句话能说清的事，不凑格式。

两条路径

路径一：给自己看。 先对号，你现在站在变老的哪一阶段？

- **阶段一** 还没老（四五十岁，或者自认还年轻）：存本钱。翻篇一。
- **阶段二** 刚变老（身体开始给信号）：读信号，该查的查。翻篇二。
- **阶段三** 开始要人帮（体力不支，或者家里有失能老人）：把家、钱、人安排好。翻篇四。
- **阶段四** 最后一段：怎么谈、怎么安排。翻篇五。

也可以不按阶段，直接查：**附录 C 按身体的症状查**（疼、漏、忘、摔），**附录 D 按心里怕的查**（怕变穷、怕拖累子女、怕孤独、怕疼着死）。

路径二：替爸妈看。 先翻第 20 章"怎么开口"。你最大的难处通常不是不知道要防跌倒，是不知道怎么跟他说。然后按症状或按怕的查。最后看每章末尾那节"如果你是在替爸妈看"。那里写的是他不在场、或者不肯承认的时候，你能先做什么。

如果你只有十分钟

现在就做这三件。不花钱，或者花得很少：

1. **把卫生间和玄关的地垫撤出去。** 不是收起来，是撤出这个家。这两个地方是老人跌倒最多的地方，而地垫是最常见的一块绊脚石。
2. **今晚在从床到马桶的路上装感应夜灯。** 三十到八十块钱。多数人的问题不是没装灯，而是只装了一盏，不是一路。

3. **把你现在吃的所有东西拍一张照片，药和保健品都要拍上。** 存在手机里，起名"我的药"。下次看病直接给医生看。医生最想知道的就是这个，而你多半说不全。

什么时候这本书不适用

- **急症**：胸痛、说不出话、半边身子动不了、意识不清。打 120。第 8 章有一页判断表，现在不用读，出事时再翻。
- **已经明确诊断**：这本书讲的是怎么准备、怎么安排，不替代你的医生。治疗方案的取舍，问给你看病的医生。
- **关于药**：这本书不写剂量，不写处方，只写该去找谁、该问什么。

一句实话

有些事这本书解决不了。失能、丧偶，以及最后那件事，它都拦不住。

它能做的是把"措手不及"改成"提前安排"。这个差别，常常比治好某一个病更能改变一个人的晚年。

序 · 老年人就是我们未来的样子

你可能是为父母拿起这本书，也可能是为自己

这两种情形，读法完全不同。

为父母读的人，急着想找"怎么办"；在书里找不到可执行的东西会失望。为自己读的人，多半是因为身体出了点动静——一次体检的白细胞高，一次走楼梯喘，一次蹲下去站起来眼前发黑。

这本书两种都照顾。正文对着"你"说话，每章末尾另有一节"如果你是在替爸妈看"。

三个数字，不是一个

人过六十，都会听到同一个数字：预期寿命。它说的是你大概能活到几岁。

但真正决定晚年好不好过的，是另外两个数字：

- **健康寿命**——没有大病、能自理的那些年
- **自理年限**——能自己吃饭、上厕所、洗澡、出门的那些年

后面这个最要紧。它才是"自由"本身：能自己出门，才谈得上去哪儿；能自己上厕所，才谈得上体面。

所以这本书不讲怎么活得久，讲怎么把能自理的年数往后推。**"能自理的年数"中国还没有一个稳定的官方口径，第 1 章说明了现状**。可能北方和南方、城市和农村，这个数字都不一样。

变老不是某一天发生的

多数人觉得自己是"一下子老了"。其实不是那一次。

身体有一套代偿机制：一处机能退下去，其他部分就多担一点。这套机制很能撑，能替你把隐患盖住很多年。所以你感觉不到它在退——直到有一天撑不住了：一次跌倒、一次住院、一次感染。

那一刻不是变老的起点，是盖子被掀开的那一天。

这就是为什么这本书要你现在就看。不是因为你今天会出事，是因为等到出事那天再翻，翻的本该是别人手里的本子。

发病率压缩：把不好过的那一段挤短

老年医学里有一个词，叫**发病率压缩**。

意思是：病和残不会消失，我们能做的是把它往后推、并且挤短。让"不好过的那几年"从十年变成三年，从躺着过变成还能自己出门。

这个目标听着不高，但它比"长命百岁"实在得多。

老年人就是我们未来的样子

这句话不是这本书发明的。它是露西·波洛克书里的一句话——"老年人就是我们未来的样子"。原句是 'Our parents and grandparents look at us, and their faces say, "Here I am, your future."'（Lucy Pollock, The Book About Getting Older (for people who don't want to talk about it), Penguin Books, 2020，第 2 章，p. 24）。中译本：［英］露西·波洛克《变老之前要知道》，一熙译，广东人民出版社，"万有引力"书系；书目记录 https://book.douban.com/subject/38368536/ ；另见《中国科学报》2026-08-21 郭晔旻《变老之前要知道的那些事》 https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2026/8/390983.shtm 。

波洛克是英国老年病专家，在老年病房工作了三十多年。她讲的是一个立场上的转变：

"老吾老"是把老人当成别人，需要我们善待。而**把自己当成预备老年人**，是承认那也是一段属于你自己的人生，你会住在里面，所以你现在就该替那个自己安排。

这本书是站在后面这个立场上写的。它受两处启发：一处是波洛克那本书的态度——**难的不是答案，是开口**（她自己的话是：恐惧和偏见混在一起，把谈话杀死了——'a toxic mix that kills conversations'，第 2 章，p. 25，我们的译文）；另一处是一个开源项目《高性价比人生指南》（GitHub：eternity4719/HowToLiveBetter），它给每条建议标上成本、收益、证据等级和原始出处。这两样我们都借了：态度借它的，格式借它的，**但它里面的数字我们没有沿用**。

焦虑生意

老年议题是所有内容里最容易被收割的一块。原因不复杂：怕的人多、信息不对称、而人在恐惧里的判断力会下降。

所以会有人卖你几千块的体检套餐，说能提前发现一切；会有人卖你"改善记忆"的补品，说能防痴呆；会有人拿着你的房本，说能让你躺着收钱。

这本书对付它的办法很笨：**每条都写出处，核不到的宁可不写。** 另外，凡是"被商家利用的怕"，我们单独标出来（见下面那张表）。

变老最怕的那几件事，以及这本书怎么接

下面这张表，是把怕的事一件件点出来。第二栏说的是"这件事你怕得对不对"——有怕得有道理的，也有怕错了方向的，还有被商家利用的。

怕什么	怕得对不对	翻到哪
摔一跤之后就完了	有道理。跌倒确实是晚年的分水岭，但它是可防的，最管用的几件事加起来不到几百块	第 5 章
尿裤子被人发现	有道理，但多半不必忍。大多数情况能改善，忍着才是真的会丢人	第 10 章
忘事，是不是要痴呆了	**怕错了方向**。正常遗忘和病理之间隔着很宽一段，中间有很多能做的事	第 9 章

怕什么	怕得对不对	翻到哪
夜里一个人在家出事没人知道	有道理。但这件事可以安排：一键呼叫、定时联系、独居协议	第 15 章
老伴先走，之后的日子	有道理，而且没人能替你准备好。但可以提前把日子里的支撑点修出来	第 22 章
老了就是花钱受罪	**怕错了方向**。花钱有优先级——先花几百块的，别先花几万块的	第 12、16 章
一定被子女送去养老院	多半不会。**但你不说，子女就会替你决定**。这才是真正的问题	第 20 章
拖累子女	有道理。所以这本书有将近一半篇幅在讲怎么让自己不必被照顾	篇四
手机上的事办不成，被时代甩下	有道理。但这是能学的，不是能力问题。挂号、打车、付款、缴费，逐样都能学	第 18 章
被骗	有道理。骗子现在会换脸、会拟声、会冒充客服，专挑一个人在家的时候打来	第 18 章
疼着死，死得没尊严	有道理。而且这件事**能提前安排**，只是很多人不知道可以	第 21 章
"你这个不查就晚了" / "这个能防痴呆"	**被商家利用的怕**。高价体检套餐和"改善记忆"的补品，多数拿不出证据	第 1、12 章

这张表放在这里，是为了让你先把怕的事说清楚。**点出恐惧不等于吓你**，每一条后面都跟着一个"这件事怕得对不对"，还有一章接住它。

有几条你怕错了方向，这不算你的错。三十年前没人教过我们这些。

一句实话

变老这件事，没有人能给你一个不难受的答案。这本书能做的，是让里面大部分事情，从"突然砸下来"变成"已经想过、还做了点准备"。

致谢启发来源

- “挣钱喝茶群”6位“常务委员”日常讨论及身体力行予以启发，本书也献给她们及其家属。
- ［英］露西·波洛克《变老之前要知道》（原书 The Book About Getting Older, Penguin Books, 2020）：本书"把自己当成预备老年人"的立场、以及"难的是开口"这一判断，来自这本书。
- 开源项目《高性价比人生指南》（GitHub：eternity4719/HowToLiveBetter）：本书"每条写明成本、收益、证据等级与原始出处"的格式，借鉴该项目的做法；其内容与数字均未沿用。

关于这份资料 · 与免责声明

这份东西不是出版社约的稿，也不是哪个机构的项目。

起因很小：随着年龄增长，我自己想知道——摔了以后要注意什么、一桌子药到底该怎么理、手机上的事他们办不成我能替到哪一步、真到那一天该找谁办什么手续。我查了一圈，发现资料其实都在，就是散着：一半在政府和医院的网站上，一半在指南和期刊里，剩下的在新闻报道里，而且互相打架的地方不少。

现在有 AI帮助，就可以迅速攒成现在这份说明。写的时候按"自己以后要用"的标准来：每条都要能查到出处，查不到的就写明"没查到"，不许糊弄自己。

既然查都查了，不如放出来。跟我一样要用的人大概不少，能省一个是一个。所以有了这份开源的资料汇集。

请先看清楚这几句

这不是医嘱。 我不给人看病，也不开药。这本书里没有一处剂量、没有一个处方、没有一次诊断。凡是跟你的医生说的不一样，请听你面前那位见过你本人的医生的。急症先打 120，别翻书。

这不是法律意见。 涉及监护、遗嘱、继承、签字这些事，各地做法差别很大，条例也在改。这本书只告诉你"这件事存在、大概去哪个窗口问、问哪几句"，具体怎么办，去问公证处、律师或者主管部门。

这不是投资建议。 我不推荐任何产品，也不评价哪种理财划算。书里跟钱有关的部分，只讲两件事：国家的制度怎么运转，以及别人怎么骗你。

这里面的政策和数字都是有日期的。 每一条来源我都标了核对日期（大体是 2026 年 10 月）。政策会调，号码会变，指南会更新。办事之前，请按书里给的线索自己再核一遍，或者打 12345 / 12333 问一句。凡是标了待核的，就是我没能核到原始文件的地方，请对那个说法留个心。

我说不准的地方，我自己标出来。 全书这样的标记有两百多处，都写在每章末尾那节里。这不是免责套话，是我真的没查到。你要是查到了，欢迎告诉我；你要是发现哪里写错了，更欢迎。

用了会怎样，得你自己判断

这本书能做的只是把查到的东西和出处摆出来。至于要不要照着做，你比我清楚你自己的情况：你的病、你的药、你的家人、你能拿出多少钱和时间。

涉及用药、运动、饮食、照护安排这些事，请先问医生。涉及签字、财产、监护这些事，请先问律师或公证处。照着书上的说法做了什么，结果由你自己承担。

关于版权和来源

这本书的文字、编排和体例，由整理者编写。用于商业用途、批量转载之前，请先看一眼仓库根目录的 LICENSE 文件（开源协议确定后会放在那里）；在协议定下来之前，请勿用于商业目的。

书里引用的东西，按这个规矩处理：

- **短句引用**：只用必要的一两个短句，加了引号并写明出处；单处引用不超过 40 个汉字。
- **法条、官方文件、指南名称**：这些属于公开信息，注明文号或条号和日期即可，不涉及授权。
- **二手来源**：我读到的如果是别人转述过的内容（比如报纸的书评、媒体的报道），会明确标成"转引"，不冒充一手。
- **图片与表格**：本书没有转载任何受版权保护的图片或表格；书里的图表若有是照着官方数据自己画的。
- 书中提到的机构、产品、服务，版权与商标归各自权利人。**我跟你提到的任何机构、产品都没有利益关系**，没有收过任何人的钱，也不替任何人推荐。
- 如果哪位权利人认为我的引用方式不妥，请通过下面的方式联系我，我会核实后更正或者删掉。

有错就改

这本书是会改的。查错了、写错了、政策换了，都会改，改了会在版本说明里记一笔。

发现问题的入口：

- GitHub 仓库提 Issue（仓库地址随发布一起公布）
- 邮箱：weokk2025@gmail.com

你要是知道你所在城市的号码、补贴、窗口和书里写的不一样，也欢迎发过来。

最后一句

这份东西是我借助 AI查了资料、整理出来给自己用的，顺手放出来给人参考。它不代替你的判断，也不教你该怎么活。

用得着的地方拿去用，用不着的翻过去就行。

篇一 · 存本钱：还没老的时候〔阶段一〕

第 1 章 · 变老不是某一天发生的

你现在大概是这样。四十几岁，体检单上第一次多出一两个箭头，你笑一句"年纪到了"；或者五十几岁，蹲下去再站起来，要在原地停半秒才敢迈步。

你还没把自己算进"老"那一类。可心里已经在数：还剩多少年能自己下楼、自己出门、自己拿主意。

变老这件事，你现在站在哪一阶段，决定了往后十年你该攒什么。

阶段	你现在的样子	这一阶段该做的事	翻哪篇
阶段一 还没老	四五十岁，或者自认还年轻	存本钱：肌肉、骨头、心脑，还有钱和人	篇一
阶段二 刚变老	身体开始给信号：血压高了、爬楼喘了、腰不行了	读懂信号，该查的查，该防的防	篇二
阶段三 开始要人帮	体力不支，或者家里有失能的人	把家、钱、人、权限安排好	篇四
阶段四 最后一段	日子进入倒计时	把话谈开，把最后的决定写好	篇五

这本书是按阶段写的。你现在多半在阶段一，或者刚从阶段一走进阶段二。这一章写给阶段一的人。

1.1 这一章解决什么问题

多数人是在一次意外之后，才开始想晚年的事：一次跌倒、一次住院、一次家人发现你记不住事。

等那一天来，能做的已经少了一半。

这一章在你还没出事的时候，把三件事讲清楚。第一，变老是怎么发生的：它从三十岁就开始，只是你感觉不到。第二，老不是一个东西，是四个不同的东西，很多人把这四个词混着用，一混，该防的没防、该查的没查。第三，哪些"老了"其实是要治的病，哪些怕，是有人拿来卖给你的。

1.2 身体有一套盖子，能盖住很多年

变老不是某一天发生的。这句话有两层意思。

一层是，下坡从很早就开始了，每年一点，不是哪天突然。

另一层是，身体有一套代偿机制：一处机能退下去，别的地方就多担一点，能把隐患盖住很多年。所以你察觉不到它在退。

直到有一天，盖子盖不住了：一次跌倒、一次感染、一次住院。那一刻不是变老的起点，是盖子被掀开的那天。

这就是为什么这本书要你现在就看。不是因为你今天会出事，是因为等到出事那天再翻，翻的本该是别人手里的本子了。

1.3 下坡从三十岁就开始了

三样东西，都在你还没觉得老的时候，已经往下走了。

肌肉。 肌肉量在二十到三十多岁达到顶峰，之后开始往下走。有一组研究给的数字是：成年以后，男性每十年掉约 4.7%，女性约 3.7%（注：这组数出自香港政府卫生署引用的研究，不是内地人群，内地分年龄、分性别的曲线还没有统一口径）【官方口径：香港政府卫生署】。掉得比肌肉量更快的，是肌肉力量：同一组研究里，男性每十年掉 14.5%，女性掉 11.8%【官方口径：香港政府卫生署】。也就是说，你不是先"瘦"，是先"没劲"。

骨头。 骨骼一直长到三十岁左右，骨量达到最高点，医学上叫峰值骨量；三十到三十五岁之后，骨量开始往下走【官方口径：北京市卫健委】。峰值骨量越高，出问题越晚。中国五十岁以上人群里，骨质疏松的患病率是 19.2%，其中女性 32.1%、男性 6.9%【官方口径：北京市卫健委】。

心肺。 身体把氧气用起来的能力，一般用最大摄氧量衡量。它随年龄下降，而且跌得越来越快：二三十岁每十年掉 3% 到 6%，到七十岁以后，每十年掉超过 20%【第三方研究：Fleg 等，2005】。

三样放在一起，是同一句话：不是"哪天突然老了"，是"每年少一点"，攒到某个数才看得见。

1.4 老不是一个东西，是四个型号

"老了"这两个字太笼统。老年医学里，有四件事各有各的名字，做的是不同的事，走的是不同的路。

- **衰弱**：整个人的储备变薄，抗打击能力差。
- **肌少症**：肌肉这个器官本身在流失。
- **共病**：不是一个病，是一串病同时存在。
- **失能**：功能已经丢了，要人帮。

这四件事会互相推动，但混成一个"老了"，就会把一个还能早干预的信号，当成一个没救的结局。

衰弱：一场小病就把你打垮

- **要花多少**：平时不用花钱，要查明白才加一次门诊（钱：花不了几个钱｜工夫：几分钟｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）

- **简单说**：同样的一个感冒、一次小手术，别人扛过去了，你扛不过去、恢复得很慢。这就是衰弱：不是某个器官坏了，是整个人的余量变薄了。
- 怎么判断（对着数）：① 半年里没特意减肥，体重掉了 5%（一百斤的人掉五斤）；② 老觉得没劲、累；③ 握力下降，拧不开瓶盖、拎不动菜；④ 走路比同龄人慢；⑤ 活动量明显减少，什么都不想动。这五条里有 3 条，通常就算衰弱；有 1 到 2 条，叫"衰弱前期"【第三方研究：Fried 衰弱表型】。
- 特别提醒：**对谁成立**——对你成立的前提是：你还能自己过，只是余量薄。衰弱不等于卧床，它是卧床之前的那一段；这一段里有一部分是能往回走的。
- **换回来的**：自理——不再怕"一场小病，从此就起不来了"

肌少症：先没劲，再没力气

- **要花多少**：平时不用花钱；要不要确诊，加一次门诊加检查
- **简单说**：肌少症不是"瘦"。它说的是肌肉的量和力量掉到一定程度，已经影响到你走路、起身、提东西。
- **怎么算**：亚洲的肌少症诊断标准（AWGS 2019）给的是几条线。握力，男性低于 28 公斤、女性低于 18 公斤；步速，慢过 1.0 米/秒；连续 5 次坐站，超过 12 秒；小腿围，男性低于 34 厘米、女性低于 33 厘米【第三方研究：AWGS 2019】。在家能先做的：量小腿围，看拧瓶盖费不费劲，数从椅子上起来要不要手撑。
- 一个数：中国老年人肌少症的患病率，22 篇文献合起来算，约 14.6%【第三方研究：Meta 分析，2022】；单看各项研究，因诊断标准和抽样人群不同，从个位数到三成都有人报（社区研究里 8.9%–38.8% 都出现过，八十岁以上能到 67.1%）【第三方研究：中国老年人肌少症诊疗专家共识，2021】。
- 特别提醒：**对谁成立**——对你成立的前提是：体重不一定轻，也可能看着正常甚至偏胖，但肌肉在悄悄少（这叫"肌少性肥胖"）。所以别用秤判断。
- **换回来的**：自理——不再怕"腿没劲，走不远、站不久"
- **在中国怎么落地**：想评估，挂老年科、康复科或全科；社区卫生服务中心的家庭医生也能做初筛。各地的项目和收费不同，以当地最新口径为准。

共病：不是一个病，是一串病

- **要花多少**：不用花钱，加一次就诊的工夫（要开口吗：好开口，只是要承认自己病不算少）
- **简单说**：同时得两种以上慢性病，就叫共病。麻烦不在某一个病多重，在它们和各自的药会互相打架。
- **怎么算**：把已经确诊的慢性病数一数，两项以上，就是共病。中国六十岁以上老年人，自己报告的共病率约 43.6%（CHARLS 2015，11 707 人）【第三方研究】；如果把体检和化验的结果也算进去，比例会高得多，同一套数据的 2011、2015 两期分别是 85.96%、92.24%【第三方研究】。两个数字差这么远，差别只在"算哪些病"。

- 特别提醒：**对谁成立**——对病不止一种、药不止一种的人成立。共病最现实的一个动作：每次看病，提醒医生一句"我还在吃别的病开的药"（见第 6 章）。
- **换回来的**：自理——不再怕"病越治越多，药越吃越乱"

失能：功能已经丢了

- **要花多少**：不用花钱，加一次关于照护的谈话
- **简单说**：吃饭、穿衣、洗澡、上厕所、上下床、在屋里走动，这六件事里有一件长期要人帮，就是失能；要人帮的件数越多，越重。
- **怎么算**：数这六件事里有几件要人帮。再往下数"会用工具"的那几件：出门买菜、坐车、缴费、用手机办事。国内也把"能用手机把事办成"算进自理（见第 0 章）。
- 一个数：国家卫健委的数据是，我国失能失智老人超过 4 500 万，大约每 6 位老人里有 1 位需要长期照护【官方口径：国家卫健委】。
- 特别提醒：**对谁成立**——对已经要人搭手的人成立。走到这一步，谈话的重点变了：不再是"怎么防"，是"谁来照顾、钱从哪儿来、怎么保住体面"（翻篇四）。
- **换回来的**：自理——不再怕"有一天连饭都要人喂"　四个词记这一个分别：**衰弱是余量薄；肌少症是肌肉在少；共病是病多；失能是功能丢了。**

1.5 "发病率压缩"：让不好过的那几年短一点

老年医学里有个词，叫**发病率压缩**。1980 年，美国医生 James Fries 提出来的【第三方研究：Fries，1980】：人的总寿命有个上限，能做的，是把生病和失能那段往后推、压短。

活得长是寿命，过得好是健康寿命，这是两个数。

中国人均预期寿命，2024 年是 79 岁，2025 年末到 79.25 岁【官方口径：国家卫健委】。至于"能自己过、不靠人的那几年"是多少，国家卫健委的年度公报里没有这个数——公报只发人均预期寿命，不单列"健康预期寿命"；世界卫生组织另有各国估算，但用的是不同算法，不能直接跟这个数相减。所以这一章不摆两个数让你做减法，只说一件确定的事：多活的那几年，是能自己过，还是躺着要人照顾——差别就在这里。

如果多出来的那些年不能自理，那"长寿"就成了"受罪的时间变长"。发病率压缩要的，是让"不好过的两三年"代替"不好过的十年"。

1.6 五个误会，第一个最危险

误会一："这是老了，正常"

这一句是最贵的。有些变化是老化，有些是病；一股脑归到"老了"，等于让能治的病拖成治不好的。

下面这几样，常被当成"老了正常"，其实该去查。

- 越来越没力气、怕冷、便秘、记性差、情绪低：可能是甲状腺功能减退。中国 31 省市 78 470 例的调查里，亚临床甲减在老年人中最常见，患病率接近 20%【第三方研究：中国老年人甲状腺疾病诊疗专家共识，2021】。
- 头晕、脸色发白、一动就喘：可能是贫血。贫血在老年人里常见，却常被当成正常衰老，或者躲在别的慢病后面【官方口径：北京市中医药管理局】。
- 走两步就喘、夜里憋醒、脚踝肿：可能是心衰。
- 提不起劲、什么都不想做、早醒：可能是抑郁，不是"想开点"就好。中国 45 岁及以上中老年人的抑郁症状检出率是 23.61%（CFPS，2018）【第三方研究：四川大学学报（医学版）2021】。
- 半年里体重掉了、吃不下：要查，别当"老来瘦"。

记一个不容易错的说法：**某一个变化，是最近几个月才出现、而且还在往坏的方向走，那就不是"慢慢老"，是该去看的。** 反过来，几天之内突然出现的（说不清话、半边没劲、胸痛），不是"看"的事，是打 120 的事（见第 8 章）。

- 特别提醒：**对谁成立**——对每一个人。这一条不分年龄段。

误会二："千金难买老来瘦"

- **简单说**：老了以后，体重掉不一定是好事，掉了的多半是肌肉。该盯的是肌肉，不是秤上的数字。
- **可以怎么做**：别再只看体重。半年里体重掉了 5% 以上（判断线见 1.4 衰弱那条），找医生看看为什么，而不是高兴。

误会三：吃脑补品能防痴呆

- **简单说**：到目前为止，没有哪种保健品被证明能防痴呆或让记忆变好。真正帮到大脑的，是控制血压和血糖，是运动和社交，是把听力的问题解决掉。
- **可以怎么做**：愿意花钱，先花在这几样上；补品的钱，先省着。

误会四："老了就该少动、静养"

- **简单说**：越不动，肌肉和心肺掉得越快，反而越容易摔。怕摔就干脆不动，是最坏的选项（见第 5 章）。
- **可以怎么做**：从能做的开始，哪怕坐着抬抬腿、扶着东西练站起。

误会五："八十岁以后，体检没意义"

- **简单说**：不是全做，也不是全不做。该做的，是按你的年龄、身体状态和风险挑出来的那几项筛查。把这几项挑出来，正是老年科和体检单最该干的活（见第 14 章）。
- **可以怎么做**：把"我要不要做这个检查"，换成"这个会改变我怎么治吗"；答案是否，就不做。

1.7 谁在靠你的怕赚钱

老年议题是最容易被收割的话题，有人叫它"焦虑生意"。它为什么是块肥地：怕的人多，你不懂，卖的人懂，人在害怕时判断力会下降；独居的人，还少一个能商量的人。

对付它，本书只有一个笨办法：**每条都写出处；凡是"被商家利用的怕"，单独标出来。**

高价体检套餐，和"一滴血"

- **简单说**：正规的癌症筛查是分开来的，按风险做，一种癌一种查法。肺查低剂量 CT，肠查肠镜，乳腺查钼靶或超声。凡是一句话就能"查所有癌"、"查百病"的，卖的是噱头。"一滴血查癌"这个说法被反复辟过谣；美国那家以此为主打的公司，创始人最终因欺诈被判了 11 年 3 个月监禁【官方口径：美国司法部公告，2022-11-18】。
- **怎么认出来**：出现"一次全查清"、"预测"、"高端"、"基因"这些词，先打问号。把常规项目换个名字加价，是这一行的常规操作。
- 不买会怎样：省下几千块，什么也不缺。但要记住：别把该做的筛查一起省了。真正该做的那几项，是医生按你的情况定的。
- **换回来的**：钱——不再怕"花点钱买个安心"

脑补品、保健品讲座

- **简单说**：市场监管总局公布的案例里，老年保健品骗局的链条是固定的四步：免费体验、制造焦虑、虚假宣传、高价销售【官方口径：市场监管总局】。
- **怎么认出来**：让你先领免费东西、听讲座、加微信群、看直播的，先警惕。群里那些"效果特别好、再订两个月"的买家，很多是托。普通食品或保健品宣称能治病，本身就是违法宣传。
- 不买会怎样：省下的是钱和时间。该有的治疗不会因此少，你本来也没靠它治过。
- **换回来的**：钱——不再怕"总得为健康做点什么"

以房养老

- **简单说**：国家试点的那个东西，真名叫"住房反向抵押养老保险"，是一种保险产品。骗局是借这个政策名字，让你把房子抵押出去、拿钱去投"高息理财"【官方口径：国家金融监督管理总局风险提示】。
- **怎么认出来**：只要是要你**签字抵押房产去投资**的，不管名字多像政策，都是骗局。正规的那种，房子还是你的，是每月领钱、身后再处置，条件和权利要逐条问清。

- 不买会怎样：房子还在，你还住着。对大多数家庭，这一条比多拿那点利息重要得多。
- **换回来的**：钱＋体面——不再怕"钱不够，把老本赔进去"一条通用规则：**凡是要你"现在就交钱、过了今天就没了"的，停下来，隔一天，找一个人说一遍。**骗局最怕的，就是这一天和这个人（见第 18 章）。

1.8 如果你今天只能做一件事

今天，找一张纸，写下一个问题，给自己，或者给爸妈：

> 最近三个月，我身上有没有哪一样，是往坏的方向变的？体重、力气、走路、记性、睡眠，随便哪样。

有，就挂号去查，别在心里说"这是老了，正常"。没有，就把这张纸留着，三个月后再问自己一遍。

这一句问下去，就把"哪天突然老了"改成了"我一直在看着它"。

1.9 如果你是在替爸妈看

这一章里所有"你怎么说"，最进得去的那一句，是说你自己的担心，不是说他不行。

- **这话怎么跟他说出口**：别从他"老了"入手，他会立刻关门。从你看到的一件小事入手，把话说成你的担心："我看您最近上楼要扶着墙，我心里有点不踏实，想陪您去查一下。"说我看到的，不说你不该。也可以拿这本书当由头："我在看一本讲怎么提前准备的书，有个地方想跟您对一下。"
- **他不同意时，你还能做什么**：有三件不用他点头。① 把 1.6 那几个"该查的"记下来（没力气、怕冷、头晕、喘、体重掉），下次找机会陪他去看病，把这几个说给医生听。② 他嫌体检没意义，你别劝他全做，去按他的年龄和性别，问医生哪几项真正该做。③ 他买了高价套餐或保健品，别当面撕，先问一句"这是谁推荐的"，再把那套"免费体验开头"的识别法，平平地讲给他听。

1.10 本章我不确定的地方

- **健康预期寿命没有常规官方口径。** 国家卫健委的年度公报只发人均预期寿命（2024 年 79 岁、2025 年末 79.25 岁），不单列"能自己过、不靠人的那几年"；世界卫生组织有各国健康预期寿命的估算，但与国内公报口径、算法不同，不能直接相减。本章因此不用这个差值。下一步：若国家卫健委把它纳入年度常规公布，再补上。

- **患病率随诊断标准不同而不同，只能给区间。** 衰弱：用 Fried 表型、按 CHARLS 2011—2012 年基线算，60 岁以上人群是 7.0%【第三方研究：Wu 等，2018】；换成衰弱指数（FI）算，中国老年人 2011、2013、2015 年分别是 18.7%、20.6%、28.4%【第三方研究：中华流行病学杂志 2018】。肌少症：Meta 分析给 14.6%，单项研究从个位数到三成都有。差别在诊断标准、抽样人群和"算哪些病"——看到任何单一数字，都别当全国定论。
- **"被当成老了"的清单是举例，不是穷举。** 1.6 挑的甲减、贫血、心衰、抑郁、体重下降，是最常被误当老化的几样；老年医学的这份清单是开放的，没有"一个数"可核。以医生结合你具体情况做出的判断为准。

一句实话：有些变化是真的回不去了。人最后都要走到阶段四，这件事谁也拦不住。这本书能做的，是让前面那三段走得慢一点、稳一点。

1.11 本章数据来源

- 【官方口径】北京市卫生健康委员会《强健骨骼，拒绝"疏松"》（2023-10-20）：峰值骨量在 30 岁左右、30—35 岁后骨量减少；我国 50 岁以上骨质疏松患病率 19.2%（女性 32.1%、男性 6.9%）；65 岁以上 32%。https://wjw.beijing.gov.cn/bmfw_20143/jkzs/jksh/202310/t20231020_3283828.html （核对 2026-10-10）
- 【官方口径】香港政府卫生署长者健康服务《预防肌肉流失》：肌肉量成年后男性每 10 年降 4.7%、女性降 3.7%；肌肉力量每 10 年男性降 14.5%、女性降 11.8%。注：原文引用的研究以香港／华人人群为主，非内地全国样本。https://www.elderly.gov.hk/tc_chi/health_information/bones_and_joints/muscle_loss.html （核对 2026-10-10）
- 【第三方研究】Fleg JL, et al. Accelerated Longitudinal Decline of Aerobic Capacity in Healthy Older Adults. Circulation. 2005;112(5):674-682：峰值摄氧量二三十岁每 10 年降 3%—6%，70 岁以后每 10 年降超过 20%。DOI：https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.545459 ；可直读摘要页（数字据此核对）：https://europepmc.org/article/MED/16043637 （以 Europe PMC 摘要为准）（核对 2026-10-10）
- 【第三方研究】《中国老年人肌少症诊疗专家共识（2021）》，中华老年医学杂志 2021;40(8):943-952；诊断界值采用亚洲肌少症工作组 AWGS 2019（握力男 <28 kg、女 <18 kg；步速 <1.0 m/s；5 次坐站 ⩾12 s；小腿围男 <34 cm、女 <33 cm）；社区老年人肌少症患病率 8.9%—38.8%，80 岁以上 67.1%。https://rs.yiigle.com/cmaid/1335995 （患病率数字经中国食品药品网转述核对，见该文；核对 2026-10-10）
- 【第三方研究】《中国老年人肌少症患病率和影响因素的 Meta 分析》，中华老年病研究电子杂志 2022;9(4)：中国老年人肌少症患病率 14.6%（95% CI 0.13—0.18，纳入 22 篇）。https://zhlnbyjdzzz.cma-cmc.com.cn/CN/10.3877/cma.j.issn.2095-8757.2022.04.008 （核对 2026-10-10）

· 【第三方研究】徐莉，等《中国老年人慢性病及共病模式变化研究：基于中国健康与养老追踪调查数据》，中国全科医学 2024：CHARLS 2011/2015 年 ≥60 岁慢性病共病率 85.96%、92.24%。https://www.chinagp.net/CN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0634（核对 2026-10-10）

· 【第三方研究】张冉，等《中国老年人慢性病共病患病模式及疾病相关性分析》，中国公共卫生 2018：CHARLS 2015 年 11 707 名 ≥60 岁老年人，共病率 43.6%。https://www.zgggws.com/article/doi/10.11847/zgggws1120351（核对 2026-10-10）

· 【第三方研究】《老年患者衰弱评估与干预中国专家共识》，中华老年医学杂志 2017;36(3):251-256：Fried 衰弱表型与衰弱指数判读。https://cmab.yiigle.com/uploads/guide_html/老年患者衰弱评估与干预中国专家共识.html（核对 2026-10-10）

· 【第三方研究】Wu C, Smit E, Xue QL, Odden MC. Prevalence and Correlates of Frailty Among Community-Dwelling Chinese Older Adults: The China Health and Retirement Longitudinal Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018;73(1):102-108：CHARLS 2011—2012 年基线，用 Fried 表型，≥60 岁人群衰弱患病率 7.0%（分地区 3.3%—9.1%）。DOI：https://doi.org/10.1093/gerona/glx098 ；PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28525586/（核对 2026-10-10）

· 【第三方研究】《中国老年人衰弱状况及其影响因素分析》，中华流行病学杂志 2018;39(9):1244-1248：基于 CHARLS 2011—2015 年数据、用衰弱指数（FI），≥60 岁老年人 2011、2013、2015 年衰弱患病率 18.7%、20.6%、28.4%。摘要页：https://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail?id=PeriodicalPaper_zhlxbx201809019&dbid=WF_QK（核对 2026-10-10）

· 【第三方研究】Fries JF. Aging, Natural Death, and the Compression of Morbidity. N Engl J Med. 1980;303:130-135："发病率压缩"的原始提出。原文 DOI：https://doi.org/10.1056/NEJM198007173030304 ；作者 2011 年开放获取回顾（可直读全文）：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3163136/ （以 2011 年开放获取回顾为准）（核对 2026-10-10）

· 【官方口径】国家卫生健康委《2025 年我国卫生健康事业发展统计公报》（2026-08-28）：2025 年末我国人均预期寿命 79.25 岁。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202608/content_7079538.htm ；另《"十四五"我国卫生健康工作交出亮眼答卷》（2025-09-12）：2024 年我国人均预期寿命达 79 岁。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202509/content_7040235.htm（核对 2026-10-10）

· 【官方口径】国家卫生健康委老龄健康司：我国失能失智老人超过 4 500 万（央视网《"一人失能，全家失衡"难题，这样破解》2025-09-02 转述）。https://jiankang.cctv.com/2025/09/02/ARTIahqlEEFDPsYIIZuo8Mtp250902.shtml（核对 2026-10-10）

· 【第三方研究】《中国老年人甲状腺疾病诊疗专家共识（2021）》，中华医学会老年医学分会等：31 省市 78 470 例调查，老年人群亚临床甲减最常见、患病率近 20%。全文 PDF：https://xa3yuanlib.yuntsg.com/ueditor/jsp/upload/file/20220907/1662557077712026739.pdf （核对 2026-10-10）
· 【官方口径】北京市中医药管理局《时常乏力头晕？老年人警惕营养性贫血预警信号》（2026-06）：老年营养性贫血常被当作正常衰老或被慢病掩盖。https://zyj.beijing.gov.cn/sy/whkp/202606/t20260630_4739026.html （核对 2026-10-10）
· 【第三方研究】《我国中老年人抑郁现况及其影响因素分析》，四川大学学报（医学版）2021;52(5):767-771：基于 2018 年中国家庭追踪调查（CFPS），45 岁及以上中老年抑郁症状检出率 23.61%（CES-D，以第 80 百分位为界）。DOI：https://doi.org/10.12182/20210960507 ；期刊页：https://ykxb.scu.edu.cn/cn/article/doi/10.12182/20210960507 ；PMC 全文：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10408879/ （核对 2026-10-10）
· 【官方口径】市场监管总局公布七起老年人药品、保健品虚假宣传典型案例（新华社，2025-10-29）："免费体验—制造焦虑—虚假宣传—高价销售"违法链条。http://www.news.cn/20251029/51fdd41b430e49aa9e8a0e26d6a3bf25/c.html （核对 2026-10-10）
· 【官方口径】国家金融监督管理总局《关于养老领域非法集资的风险提示》：以宣称"以房养老"为名非法集资，假借国家政策行骗。https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=983951&itemId=925&generaltype=0 （核对 2026-10-10）
· 【官方口径】美国司法部北加州联邦检察官办公室新闻稿《Elizabeth Holmes Sentenced To More Than 11 Years For Defrauding Theranos Investors Of Hundreds Of Millions》（2022-11-18）：Theranos 创始人 Elizabeth Holmes 因欺诈投资者被判 135 个月（11 年 3 个月）监禁。https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/elizabeth-holmes-sentenced-more-11-years-defrauding-theranos-investors-hundreds （核对 2026-10-10）

第 2 章 · 骨本与肌肉本

去年冬天，你妈在楼道里打了个趔趄，扶住栏杆才没倒。她摆手说没事。可你留意到，她这两年矮了一点，提东西的手也不稳。

你以为这是"老了"。其实是有两笔本钱，她当年没存够，现在一年一年往外取。

这本书算四笔账，第一笔是自理。能自己走路、自己起身、自己拎得动，靠的就是骨头和肌肉这两笔本钱。这一章讲三件事：怎么看自己还剩多少，今天能往哪儿补，什么时候该找医生而不是自己硬练。

2.1 这两笔本钱和存款刚好相反

钱可以老了再存，骨头和肌肉不是。它们都有一道窗口期，大概到三十岁前后：在此之前吃得对、动得够，本钱一年年往上加；过了这道窗口，能填进去的越来越少，往外取的越来越多。重点不在"老了怎么办"，在"现在还能存多少"。

2.2 骨本：三十岁上下存到顶，往后只往外出

骨头一生都在长，长到三十岁左右骨量到顶，叫峰值骨量；三十到三十五岁之后开始往下走（官方口径：北京市卫健委《强健骨骼，拒绝"疏松"》2023；中国疾控中心慢病中心 2025）。顶越高、到顶越晚，后半辈子能取的越多。

为什么会掉：骨头里有两批细胞，一批拆旧骨、一批造新骨；年轻时造的比拆的快，三十岁以后拆的反超，像海绵一样的骨小梁变细变稀，骨头就脆。

女性绝经那次掉得最猛。雌激素本来给"拆骨"细胞踩着刹车，绝经后骤降，绝经后五到十年里掉得最快，每年能掉百分之二到三（官方口径：《原发性骨质疏松症诊疗指南（2022）》；第三方研究：新华网 2025）。男性也掉，只是慢、晚：六十五岁以上男性患病率百分之十点七，七十岁后性腺功能减退（官方口径：北京市卫健委 2023）。

中国的数：五十岁以上患病率百分之十九点二（女三十二点一、男六点九），六十五岁以上百分之三十二（女五十一点六、男十点七），四十岁以上骨量偏低的人已达百分之四十点九（官方口径：北京市卫健委 2023；中国疾控中心慢病中心 2025）。

一句实话：底子有一半看遗传，你改不了；掉得快不快，一半在你手上。

2.3 肌肉本：也是三十岁见顶，六十岁后掉得更快

肌肉量一般在三四十岁前后到顶，之后逐年减少。掉的幅度，各家说法不完全一致：一份科普材料说，三十岁达峰后每年减少百分之一到二、六十岁以后加速（第三方研究：中国食品药品网 2022）；另一篇经中华医学会审核的稿件说，五十岁以后腿部肌肉质量每年减少百分之一到二，肌力每年减少百分之一点五到五（第三方研究：新华网 2024）。两份材料给的峰值年龄和速度不完全

一致，方向却一致：过了峰值就逐年往下，六十岁以后更快。掉到一定程度就是病，叫肌少症；中国社区老年人患病率百分之八点九到三十八点八，八十岁以上能到百分之六十七点一（第三方研究：新华网 2024）。

腿上的肉一少就走不稳，走不稳就摔，摔一回躺三个月肉掉更快，这个圈和第 5 章的跌倒圈是同一个。"千金难买老来瘦"要小心：瘦不是目标，体重过轻本身就是一条危险因素（官方口径：《原发性骨质疏松症诊疗指南（2022）》）。

2.4 在家里粗测一下：握力、步速、小腿围

- **要花多少**：基本零元，握力计可买可不买（钱：花不了几个钱｜工夫：十分钟｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：这三个数是亚洲肌少症工作组定的筛法，在家先粗测，正式判断交给医生。
- **可以怎么做**：① 握力：写字那只手握紧握力计、手臂下垂，男不到二十八公斤、女不到十八公斤算低；② 步速：走六米直路，低于每秒一米算慢；③ 小腿围：坐着量最粗处，男不到三十四厘米、女不到三十三厘米提示肌肉不够；④ 五个问题的问卷（SARC-F）到四分要当回事；肌肉量本身要上医院做 DXA，男低于每平方米七公斤、女低于五点四算低（以上均第三方研究：AWGS 2019）。
- **来源**：B｜以上是亚洲肌少症工作组 AWGS 2019 的通行标准（诊断口径）。**但是**分界线来自亚洲多国人群，中国人更细的线还在研究，别当诊断。**另注**：网上还流传一套更松的口径——握力男低于二十五公斤、步速低于每秒零点八米；那是更早、用于初筛的线，确诊以 AWGS 2019 为准。
- 特别提醒：**对谁成立**：能自己站、自己走的人。握不住、走几步就喘、近半年摔过的，别在家测，直接去医院。
- **换回来的**：自理——不再怕"我还行不行，心里没数"
- **在中国怎么落地**：量完要不要紧、要不要查 DXA，去社区卫生服务中心问家庭医生团队。

2.5 抗阻训练和负重活动：让肌肉使劲，让骨头受压

- **要花多少**：弹力带几十元，一对小哑铃或两瓶矿泉水就够（钱：花不了几个钱｜工夫：每次二十分钟，每周两三次｜力气：有点累｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：让肌肉使劲对抗一个阻力（抗阻），和让体重从腿上、脊柱压过去（负重），是长肌肉、长骨头的两件事，光靠走路补不回来。
- **可以怎么做**：① 抗阻：每周两到三次，同一块肌肉隔一天再练；每个动作八到十二次为一组，做两到三组；先练腿、背，坐站、靠墙静蹲、弹力带划船、弯举、握力器捏握都算。② 负重：每天走够，每周累计一百五十分钟中等强度；快走、慢跑、爬楼梯（膝盖好的话）都压骨头，游泳、骑车对骨头压力小，别顶替（第三方研究：华西医院转载《老年人躯体功能受损防控干预中国专家共识（2022）》；官方口径：中国疾控中心慢病中心 2025）。
- **来源**：B｜这两类训练被中国老年医学共识一致推荐。**但是**游泳、骑车对增骨密度作用有限。

- 特别提醒：**对谁成立**：能站稳、能自己坐站、走路不疼的人，从坐姿和自重开始。心脏有毛病、关节疼、血压没控好、走两步就喘的，先让医生看一眼再开练；练时能正常说话。
- **换回来的**：自理——不再怕"腿越来越没劲，扶不住自己"
- **在中国怎么落地**：社区和老年大学常有抗阻、弹力带课和健步走队；去哪问：社区卫生服务中心、社区养老服务站。

2.6 跳类动作：骨头硬的人练它，骨头脆的人躲它

- **要花多少**：不用花钱（钱：不用花｜工夫：一次几分钟｜力气：挺累｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：跳起来落地那一下，地面会把一股冲劲顶回你的腿骨和脊柱；对还结实的骨头，这种"震一下"是催它变硬的信号。
- **可以怎么做**：骨头查过没问题的人，可以从很小幅度的原地踮跳、跳低台阶开始，量要小、慢慢加；膝盖、脚踝、腰背有伤的，改成踮脚后跟落地、快走下坡。
- **来源**：C｜"冲击性动作刺激骨"这个方向有研究支撑。**但是**跳多少能帮骨头更硬，没有中国本土的量化证据；一份 2025 年共识提醒：有运动禁忌的人要避开爆发力和高冲击动作（官方口径：沈阳市卫健委 2026，引《原发性骨质疏松症与肌少症的营养和运动管理专家共识（2025年）》）。
- 特别提醒：**这条的"对谁成立"最要紧**：已经查出骨量减少、骨质疏松，或有过脆性骨折的人，**不要自己练跳**，落地的冲击可能直接压塌一块骨头；骨头脆的人要练负重、抗阻、平衡，不是跳。体重过重、膝踝有毛病的人也不适合。
- **换回来的**：自理——不再怕"骨头到底越用越硬还是越用越脆，我搞不清"
- **在中国怎么落地**：这一条不是照着练，是照着问，把"我能不能跳、能不能跑"拿去问骨科或康复科医生。

2.7 钙和蛋白质：都从饭碗里吃，别只指望钙片

- **要花多少**：每天一杯奶、一个蛋、一把豆制品进饭桌，一个月多花几十到一两百元（钱：花点钱｜工夫：每天｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：钙是骨头的砖，蛋白质是长肌肉的原料。这两样都先从饭里吃够，光靠一把钙片补不回肌肉。
- **可以怎么做**：① 钙：每天三百到五百毫升牛奶或酸奶，加豆腐、豆干、腐竹，加油菜、芥蓝、西兰花，连骨的小鱼小虾、芝麻酱也补一点；少喝碳酸饮料、浓咖啡，少盐。② 蛋白质：鸡蛋、牛奶、鱼虾、瘦肉、豆制品都算，每顿放一点，别全堆在晚饭；牙口不好的用蒸蛋、鱼泥、豆腐代替。肌少症的人需要的蛋白质更多，吃多少按体重算（官方口径：中国疾控中心慢病中心 2025；《原发性骨质疏松症诊疗指南（2022）》；第三方研究：新华网 2024）。

- **来源**：A｜"多吃含钙食物、不够时用钙剂、蛋白质要吃够"是中国指南和老年营养共识都写明的做法。**但是**每天补多少、用不用钙片、蛋白吃多少克，得医生结合饮食、血检和肾功能来定。
- 特别提醒：**对谁成立**：大多数人。**有肾结石、肾功能不好、血钙偏高的人不一样**：补钙要格外当心，蛋白质也不能多吃，都要先问医生。
- **换回来的**：自理——不再怕"骨头在流失，我却不知道该往嘴里放什么"
- 在中国怎么落地：**先去医院查一次骨密度和肾功能，再决定吃什么、补什么**。去哪问：社区卫生服务中心、医院内分泌科或骨科；有营养门诊的让医生按体重算一算。别照着广告自己买钙片。

2.8 维生素D：晒对时间、晒对部位

- **要花多少**：不用花钱（钱：不用花｜工夫：每周几次，每次十几分钟｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：钙要进骨头，得靠维生素D　帮着搬。它主要靠自己皮肤晒太阳合成，饭菜里几乎没有；晒得少，吃进去的钙也留不住。
- 怎么做（国家指南口径）：① 初夏到秋末，上午十点到下午三点之间晒；② 胳膊、腿露出来直接晒，别隔玻璃、别涂厚防晒；③ 一次十五到三十分钟，每周两到三次；④ 北方冬天、梅雨季或整天在屋里的人靠晒不够，要主动补，六十五岁以上每天推荐六百国际单位（六百IU，合十五微克）（官方口径：沈阳市卫健委 2026；中国疾控中心慢病中心 2025；中国营养学会《中国居民膳食营养素参考摄入量（2023版）》）。
- **来源**：A｜"先晒太阳、不足再补"是中国膳食参考摄入量写明的做法；晒太阳的时段来自国内临床专家共识。
- 特别提醒：**对谁成立**：大多数人。**已经在吃维生素D　　补充剂、或血钙偏高的人**别叠加着猛补，问医生；别晒到脱皮。
- **换回来的**：自理——不再怕"补了半天钙，不知道留没留住"
- **在中国怎么落地**：要不要测血里的维生素D、补多少，去医院抽血问医生；北方冬天更该问。

2.9 去做一次骨密度，把 T 值看明白

- **要花多少**：一次门诊加一次检查，一百到几百元，各地不同（钱：花点钱｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：骨密度是看骨头结不结实最直接的检查，国际公认的诊断手段是 DXA（双能 X 线吸收法），不是体检中心脚后跟那个超声，也不是家里的体脂秤（官方口径：健康中国《四类人建议做骨密度检查》2025）。
- **可以怎么做**：①　谁该查：五十岁以上骨折过的；六十五岁以上女性、七十岁以上男性；绝经后到六十五岁女性、五十到七十岁男性里有危险因素的（如活动后腰背痛、比年轻时矮三厘米以上、驼背）；吃着伤骨头的药或得了相关疾病的（官方口径：健康中国 2025）。② 去哪

查：医院内分泌科、骨科或老年科开单做 DXA，腰椎和髋部都做，只查一处容易漏。③ T 值：不低于负一点零正常，负一点零到负二点五之间是骨量减少，负二点五及以下是骨质疏松（官方口径：《原发性骨质疏松症诊疗指南（2022）》）。

- **来源**：A｜DXA 诊断骨质疏松是国际通行标准，T 值的分界写进了中国指南。**但是**报告别自己读，要医生结合症状和病史一起判（第三方研究：新华网 2025）。
- 特别提醒：**对谁成立**：上面那四类人；已确诊、正用药的按医生定的时间复查，别自己停、别自己改。骨密度正常也不等于不会骨折，防跌倒那一套（第 5 章）照样要做。
- **换回来的**：自理——不再怕"不知道自己的骨头到底行不行"
- **在中国怎么落地**：先去社区卫生服务中心的家庭医生那儿开单或转诊，再到大医院做 DXA；有些城市社区体检能先做超声骨密度筛查，筛出问题的再转 DXA（官方口径：中国疾控中心慢病中心 2025）；签了家庭医生能定期随访、提醒复查。以当地最新口径为准。

2.10 抽烟、喝酒、久坐，都在提前取你的骨本

- **要花多少**：不花钱，靠改（钱：不用花｜工夫：长期｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：这两笔账，一边在存，一边可能被几个习惯往外掏。抽烟、酗酒、一天坐到晚，就是三笔在提前取的账。
- **可以怎么做**：① 烟：烟里的东西伤骨细胞，也让钙吸收变差，戒烟对骨头和肺是同一件事；② 酒：过量喝酒伤骨，也让人走路不稳、更容易摔；③ 久坐：每坐一小时起身动几分钟。
- **来源**：B｜"吸烟、过量饮酒、体力活动少"被中国骨质疏松指南白纸黑字列为可控的危险因素（官方口径：《原发性骨质疏松症诊疗指南（2022）》）。**但是**改掉这些能挽回多少骨量，没有精确的数。
- 特别提醒：**对谁成立**：有这几个习惯的人都成立；改不动时，先从"每坐一小时起身走两分钟"开始，比立一个"从此不抽"的大目标容易坚持。
- **换回来的**：自理——不再怕"我在补，也在漏，自己却不知道"
- **在中国怎么落地**：想戒烟，问社区家庭医生有没有戒烟门诊或转诊。

2.11 出现这几种情况，先去看医生，别自己练

- **要花多少**：一次门诊（钱：一次挂号的钱｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：有几样信号，说明骨头或肌肉的事已经过了"自己练练就好"的阶段，得先让医生查清楚，再谈怎么动。
- 怎么做，见到这几样就去：① 说不清的骨痛：夜里疼、或一用力就疼，尤其腰背痛；② 消瘦：短期明显掉体重；③ 骨折史：五十岁以后骨折过；④ 身高变矮三厘米以上，或开始驼背。去了要说清疼在哪儿、多久、摔过没有、吃什么药，请医生评估查骨密度、维生素D、肾功能。

- **来源**：A｜这些信号写进了中国骨质疏松指南；把它们当"该去查一次"的理由，不是自己给自己下诊断。
- 特别提醒：**对谁成立**：出现上面任何一条的人。**注意**：突然的剧烈骨痛、摔倒后动不了，不算这一条，那是急症，按第 5 章打 120。
- **换回来的**：自理＋钱——不再怕"小毛病拖成大问题，又怕花冤枉钱"
- **在中国怎么落地**：挂医院骨科、内分泌科或老年科；六十五岁以上每年有一次免费健康管理（国家基本公共卫生服务），里面有健康状况评估，问社区卫生服务中心。

2.12 在中国怎么落地：把骨量查进社区的年度体检

- **要花多少**：不额外花钱（钱：不用花｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：骨头和肌肉这两笔账，国家已经把它塞进了社区和年度体检，你不用自己从大医院摸起。
- **可以怎么做**：① 六十五岁以上：每年一次免费健康管理，把"骨头、肌肉、会不会摔"一起问进去（官方口径：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》）；② 有些社区或体检机构能先做超声骨密度、前臂 DXA 或定量 CT 筛查，筛出问题的再转医院做 DXA（官方口径：中国疾控中心慢病中心 2025）——注意免费体检的标准项目里不含骨密度，能不能加做、能不能转诊，各地不同；③ 家庭医生签约是国家铺开的制度，签了就有固定的家庭医生团队，能定期随访、提醒复查、帮你转诊（官方口径：《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》，国医改办发〔2016〕1 号）。
- **来源**：B｜免费体检和家庭医生签约是国家铺开的基本服务。**但是**社区能不能做骨密度、能不能转 DXA，各地差别很大。
- 特别提醒：**对谁成立**：城市和县城里、附近有社区卫生服务中心的人；农村地区先到乡镇卫生院问。
- **换回来的**：自理——不再怕"想去查，却不知道从哪道门进"
- **在中国怎么落地**：到社区居委会或社区卫生服务中心问三句：免费体检怎么约、这里能不能查骨密度、有没有家庭医生可以签。以当地最新口径为准。

2.13 如果你今天只能做一件事

今天，就从椅子上不用手站起来、再坐下，做两到三组，每组八到十二次。

这个动作同时是"测"和"练"：今天它告诉你腿上还剩多少本钱，往后每周两次，它就是往这笔本钱里存的钱。从今天起记住一个数，明年今天再比一次。

2.14 如果你是在替爸妈看

这话怎么跟他说出口。 别说"你骨质疏松了、你肌肉萎缩了"，那是在下判决，他当场就会防御。说具体的、他没法反驳的事："妈，我量了量，你比前年矮了一点，走路也比以前慢。我担心的就是这个，想陪你去医院查一次骨密度，顺便抽个血，当天就能回来。"把"我"放进去，把判断留给他。

他不同意时，你还能做什么。 三件事，都不用他点头。第一，先改饭桌：家里牛奶、鸡蛋、豆腐备上，一天一杯奶、一顿一个蛋，你不提"补钙"，只说"最近想吃得清淡点"。第二，先测不说话：他坐站、走路的时候你心里数着，看他从椅子上起得来吗、过马路来不来得及，记在心里，别当面下判断。第三，陪诊时替他问清三件事：要不要查骨密度，要不要查维生素D 和肾功能，还能不能做跳和跑。他嘴上不认，身体每天在给答案。

2.15 本章我不确定的地方

- **跳类、冲击性动作对中老年人骨密度的具体效果，没有核到中国本土的量化研究。** 方向有（负重、冲击能刺激骨），但"跳多少、跳多久能让骨头更硬"缺中国人群的剂量数据，本章按"方向有、剂量不明"处理。下一步：查《原发性骨质疏松症与肌少症的营养和运动管理专家共识（2025年）》及后续中国人群运动干预研究。
- **社区能不能做骨密度筛查、能不能转 DXA、免费体检含不含骨密度，各地不同。** 骨密度不在国家基本公共卫生服务"老年人健康管理"的标准体检项目里；社区能否加做超声、前臂 DXA、定量 CT 筛查、能否转诊 DXA，由地方安排（中国疾控中心慢病中心 2025 提到社区可先做超声等筛查）。下一步：逐省核对当地卫健委的免费体检项目和转诊路径。

2.16 本章数据来源

- 【官方口径】中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会《原发性骨质疏松症诊疗指南（2022）》，《中国全科医学》2023 年第 26 卷第 14 期，第 1671-1691 页：峰值骨量、发病机制、可控危险因素、T 值诊断分界、钙与维生素D 推荐。https://www.chinagp.net/CN/rich_html/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0121 （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】北京市卫生健康委员会《强健骨骼，拒绝"疏松"》（北京市垂杨柳医院供稿，2023-10-20）：峰值骨量年龄，五十岁、六十五岁以上骨质疏松患病率（分性别），钙与蛋白质推荐。https://wjw.beijing.gov.cn/bmfw_20143/jkzs/jksh/202310/t20231020_3283828.html （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】中国疾病预防控制中心《世界骨质疏松日丨稳住健康体重，守住流失的骨量》（慢病中心，2025-10-29）：四十岁与六十岁以上低骨量流行率、社区低骨量管理、钙与蛋白质食物清单、每周一百五十分钟活动、社区超声骨密度筛查。https://www.chinacdc.cn/jkkp/mxfcrb/lnjk/202510/t20251029_313157.html （2026-10-10 核对）

- 【官方口径】沈阳市卫生健康委员会《维生素D水平需要日常检测吗？》（沈阳市卫生健康服务中心，2026-08-31）：晒太阳的时段、时长、部位，六十五岁以上维生素D 推荐量，血清25(OH)D 目标值，以及《原发性骨质疏松症与肌少症的营养和运动管理专家共识（2025年）》"避免爆发力和高冲击"的提醒。https://wjw.shenyang.gov.cn/ztzl/xsxxjkdjt/202608/t20260831_5080580.html （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】健康中国《四类人建议做骨密度检查》（福建省卫生健康委员会转载，2025-10-22）：谁该查骨密度、DXA 是金标准、需查腰椎和髋部、体脂秤与超声不能诊断。https://wjw.fujian.gov.cn/ztzl/jkjy/jksh/202510/t20251023_7024376.htm （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】新华网《骨密度检查，两类人群可以不做》（《大众健康》杂志，四川大学华西医院王覃撰、冉兴无审核，2025-11-16）：绝经后每年骨量流失百分之二到三、男性七十岁后风险上升、糖皮质激素使用者复查间隔。http://www.news.cn/20251116/24d1594293024875acb8783eecd9d75e/c.html （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】新华网《过了这个年纪，肌肉会快速流失……》（经中华医学会专家审核，2024-11-05）：五十岁以后肌肉与肌力流失速率、社区肌少症患病率、SARC-F、握力与步速筛查、蛋白质推荐。http://www.news.cn/science/20241105/88d6e3b8baa045bc93e3dde19a5a43d0/c.html （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】新华网《重阳节丨对抗衰弱、预防失能，助力老年人健康生活从锻炼开始》（中国科协科普部与新华网联合，北京市普仁医院审核，2023-10-23）：抗阻训练的组数次数与频率、平衡运动、有氧运动量、运动中心率与呼吸注意。http://www.news.cn/science/20231023/e639a70cea4d4df0b78ea060ec5cd682/c.html （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】中国食品药品网《"肌"不可失，失不再来》（2022-10-13）：肌肉量约 30 岁达峰后每年减少 1%—2%、60 岁后加速；文内把社区肌少症患病率 8.9%—38.8%、80 岁以上 67.1% 归于《中国老年人肌少症诊疗专家共识（2021）》，但"30 岁达峰、每年 1%—2%"是该文表述、未见于共识原文，本章按"两来源不一致、给区间"处理。https://www.cnpharm.com/c/2022-10-13/1001658.shtml （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】四川大学华西医院转载《老年人躯体功能受损防控干预中国专家共识（2022）》（《中华老年医学杂志》2022 年第 41 卷第 10 期）：抗阻训练是提高肌肉质量和力量最直接的一类、每周两到三次、每组八到十二次。https://www.wchscu.cn/public/department/nephrology/dynamics/70089.html （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】Chen LK, et al. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update on Sarcopenia Diagnosis and Treatment. J Am Med Dir Assoc, 2020：握力、步速、5 次起坐、DXA 与 BIA 的肌肉量阈值、小腿围、SARC-F。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32033882/ （2026-10-10 核对）

- 【官方口径】《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》"老年人健康管理"：六十五岁以上每年一次免费健康管理，含体格检查与健康状况评估（标准体检项目不含骨密度）。https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2017/04/20170417104506514.pdf（2026-10-10 核对）
- 【官方口径】国务院医改办等《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》（国医改办发〔2016〕1　号，2016-06-06）：实行家庭医生签约服务，优先覆盖老年人等人群。https://www.nhc.gov.cn/tigs/c100053/201606/a2f65c166d5b438f8abb684d3a8c13d0.shtml（核对 2026-10-10）
- 【官方口径】中国营养学会《中国居民膳食营养素参考摄入量（2023版）》：六十五岁以上老人维生素D 每天推荐十五微克（六百 IU）。转引自沈阳市卫健委 2026-08-31 一文。
- 说明：本章引用均为转述与数据，不整段翻译原文；同一数字首次出现时标分档。

第 3 章 · 脑本与感官本

电视音量一年比一年大。家里人嫌吵，你觉得正好。买菜时人家说两遍你才听清，你摆摆手说"老了都这样"。

这一章讲五样：脑、耳、眼、牙、脚。它们像墙上并排的五个开关，哪个松了，坏的都不只那一路：耳朵听不清，人会从饭桌、牌局、家人身边退出去；牙咬不动，肉和菜就吃得少；脚一疼，门就懒得出。

3.1 这一章解决什么问题

人上了岁数，最先松的常常不是腿，是这五样。看着各管各的，其实一头连着一头。

耳背、眼花、牙口差、脚有毛病，你容易当成"老了正常"。这几样里有几样能提前拦；还有几种变化，是身体在喊你当天去医院，不是等下个月。

这一章看三样：哪些能提前修，修了值不值，哪种变化不能拖。

3.2 耳朵听不清，和痴呆之间有一条硬关联

研究显示：听力下降和痴呆之间的关系是硬的；但听损本身多大程度造成痴呆，还没完全定。

柳叶刀痴呆预防委员会 2024 年的报告，把可改变的痴呆危险因素列到 14 项，听力损失是其中一项。报告按人群归因分数做模型估算：把这些因素都往下压，理论上能把近一半的痴呆推迟或拦下——这是模型算出来的预期，不是实测的发生率降幅（第三方研究：Lancet 痴呆预防委员会 2024 年报告）。世界卫生组织也写明：听力损失不处理，会抬高得痴呆的风险、加快认知下滑（官方口径：世界卫生组织"耳聋和听力损失"事实清单）。中国听力残疾的头号原因是老年性聋，占 51.61%（第三方研究：《中国听力健康报告（2021）》蓝皮书，用的是 2006 年第二次全国残疾人抽样调查数据）。

一个区别要分清：相关不等于因果。听力差的人得痴呆的多，是反复观察到的；可报告自己就写了，其中一些关联"可能只有一部分是因果"。

那早点管能不能降风险？最硬的证据是 ACHIEVE 试验（2023 年，《柳叶刀》）：977 名 70 到 84 岁、有听损没治的老人，分戴助听器加听力康复、只做健康教育两组，跟 3 年（第三方研究：Lin FR 等，Lancet 2023）。合起来看，戴助听器没有明显减慢认知下降；把认知风险更高的那拨单独看，下降慢了 48%。

还有一条要提醒：前几年一项观察性研究说"戴助听器能把痴呆风险降下来"，被到处转；那篇论文后来被《柳叶刀·公共卫生》撤稿了（第三方研究：撤稿通知，2023-12）。"戴助听器防痴呆"，别当板上钉钉。

助听器值不值？它头一条买回"听得见、能聊天、不被关在说话声外面"，这一条本身就值；顺带那点防痴呆的好处，最可能落在本来就有其他风险因素的人身上（ACHIEVE 里那拨人）。

3.3 先去测一次听力，该配助听器就配

- **要花多少**：一次纯音测听几十到一两百元（各地不同）；助听器几百到几千上万元一副（钱：花钱不少｜工夫：测一次半天，验配要跑几趟｜力气：不费｜要开口吗：最难的一步，很多人卡在这）
- **简单说**：听力多半慢慢垮，自己不易发觉，家里人先发觉。先测一次，拿到一张图，才有据可依。
- **可以怎么做**：① 挂耳鼻喉科，说"想查听力"，做纯音测听；② 让医生分清是哪一类，有的不是老化，是中耳炎、耵聍堵住、突发性聋，得另外处理；③ 真到该配的程度，去正规医院的听力中心或有验配资质的机构验配，别在网上随手买；④ 配好要回去调、要练着用，头一个月不适应是常事。
- **来源**：B｜纯音测听加规范验配是通行做法；但"戴助听器防痴呆"的证据只到"风险更高的人可能受益"，别当保险。
- 特别提醒：**对谁成立**：听得见却听不清、家里人反复说你耳背的人。耳道流脓、耳痛、单侧突然听不见的，先按 3.8 当天就医。
- **换回来的**：关系＋自理——不再怕"被关在说话声外面，慢慢没人跟我说话"
- **在中国怎么落地**：65 岁以上每年一次免费健康管理里对听力有粗测（官方口径：国家基本公共卫生服务规范第三版）；精确查听力、验配助听器去二级以上医院耳鼻喉科。助听器多走残联辅具适配补贴，见 3.9。

3.4 白内障到了影响过日子的那天，就别再拖

- **要花多少**：一次门诊加一台手术，手术费按当地医保目录报、自付各地不同（工夫：多为日间或门诊手术｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：白内障是全球排第一的致盲眼病，也是老人视力下降最常见的原因。它吃药点药水治不好，得把混浊的晶状体摘掉、换人工晶体。
- 什么时候做：不是等它"熟透"。国家卫健委 2026 年的操作规范写的是：晶状体导致的视功能已不能满足日常生活和工作的需要、手术又有改善的可能，就可以做（官方口径：国家卫健委《成人白内障手术操作规范（2026 年版）》）。看不见路、不敢下台阶，就到了。
- **可以怎么做**：① 挂眼科，查视力、裂隙灯、眼压，必要时查眼底；② 问医生三句：现在做合不合适、做哪只眼、术前血压血糖要不要先控；③ 有高血压、糖尿病的，术前把血压血糖稳住，按医生说的来；④ 术后按医嘱复查。
- **来源**：A｜手术是白内障唯一的治疗办法；到没到该做的点、怎么做，由眼科医生结合全身情况定。
- 特别提醒：**对谁成立**：确诊白内障、视力在往下掉的人。视力骤然变化、眼睛剧痛发红，可能是别的急症，先看 3.8。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"看不清路，不敢出门、怕摔"

- **在中国怎么落地**：白内障手术属于医保报销范围的诊疗项目；报多少、能不能门诊做、人工晶体选目录内还是目录外，各地不同，以当地医保最新口径为准。去哪问：就诊医院的医保办、当地医保经办机构。

3.5 牙咬不动，会一路连到营养和饭桌

- **要花多少**：一次口腔检查；补牙、镶牙、种植差价大，从几百到上万（钱：花钱不少｜工夫：要跑几趟｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：牙一少，肉、菜、坚果就嚼不动，人会专挑软的吃，吃得越来越单一。更麻烦的是，笑和说话也开始躲着人。
- 现在的账：第四次全国口腔健康流行病学调查里，65 到 74 岁的人平均只剩 22.5 颗牙，缺了牙没修的占 36.8%（官方口径：第四次全国口腔健康流行病学调查，国家卫生计生委 2017-09-20 发布；存留牙 22.5 颗见发布页，缺牙未修复 36.8% 为调查明细、转引自《中国人口报》2024-10-24，详见 3.13）。
- **可以怎么做**：① 半年到一年看一次牙，别等疼；② 有牙结石、牙龈出血，先做牙周治疗，把还留着的牙保住；③ 缺牙及时修：能固定就固定；缺得多、身体一般的，活动假牙也是正经办法，全口义齿要适应和多次调改（官方口径：中华口腔医学会《老年患者口腔修复指南》T/CHSA 001-2021）；④ 每天刷两次牙、用牙线，假牙每天取下来洗、睡觉别戴。
- **来源**：B｜及时修复、牙周维护、义齿定期复查是口腔指南的通行做法；选哪种修复，由医生结合全身情况和你的意愿定。
- 特别提醒：**对谁成立**：开始掉牙、嚼不动、假牙松的人。装过心脏支架、吃抗凝药、用过双膦酸盐类药、血糖控制不好的，做拔牙、种植前必须先告诉医生。
- **换回来的**：自理＋关系＋体面——不再怕"吃不动、吃得差，还不敢张嘴笑"
- **在中国怎么落地**：口腔科医保口径各地不同，一般拔牙、补牙、牙周治疗能报一部分，镶牙、种植多要自费，以当地医保目录和就诊医院为准。找谁：综合医院口腔科、口腔专科医院或口腔修复科，社区有口腔科的先问一句。去哪问报销：医院医保办、当地医保经办机构。

3.6 剪不了脚趾甲，和糖尿病足是两回事

- **要花多少**：一把合适的指甲钳；或一次足部护理，几十元（钱：花不了几个钱｜工夫：低｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：上了岁数，眼睛花、腰弯不下、手够不到脚，剪趾甲就变难。剪进肉里，就发炎、化脓。有糖尿病的人，这一剪可能剪出大麻烦。
- 自己剪的人：① 用大号、刀口平的指甲钳；② 平着剪，留一点白边，别把两边的角往里挖；③ 剪前泡软，光线足，坐稳、别单脚悬空；④ 够不着或手抖的，换长柄工具或让家人剪，实在不行去社区、医院的足部护理门诊。

- 糖尿病的人多记一条：你的脚，和别人的脚不是一回事。《中国糖尿病足防治指南（2019版）》写得很清楚：糖尿病足是踝关节以下皮肤和深层组织的破坏，常合并感染和血管病变；嵌甲、水泡、出血、真菌感染都是它前期病变；修剪趾甲、拔甲、去嵌甲都得出受过训练的医护做，别去浴室或修脚店（官方口径：中华医学会糖尿病学分会《中国糖尿病足防治指南（2019　　版）》）。同一件事在普通人身上是小毛病，在你身上可能一路走到溃疡、坏疽。
- 鞋袜：鞋要合脚、能撑住脚、前头不挤，别穿露趾拖鞋出门；袜子选浅色棉的，有破口才看得见；每天看一次脚，含脚底和趾缝。
- **来源**：A｜糖尿病足指南把"每天查足"、"趾甲和胼胝由专业人员处理"写成明确推荐；普通人按上面几条剪，风险不大，但没有专试"剪趾甲方式"的随机试验。
- 特别提醒：**对谁成立**：够不着、剪不好的人；糖尿病、下肢血管有问题、脚变形、脚麻的人别自己动手，去内分泌科或足病门诊。脚上破口、发黑、红肿热痛、发烧，当天就医。
- **换回来的**：自理——不再怕"脚上一个小伤口，最后把腿搭进去"
- **在中国怎么落地**：糖尿病高危足要按指南定期查足，越重查得越勤。去哪问：社区卫生服务中心或医院内分泌科。

3.7 脑本靠平日存：动体、动脑、控血压血糖、睡好、有人说话

- **要花多少**：每天动十几分钟，其余多是不花钱的习惯（钱：花不了几个钱｜工夫：每天｜力气：不太累｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：这本"脑本"，没有一种药能一次存进去，靠的是一串平常事：动身体、动脑子、控住血压血糖、睡好、有人说话，再加上听力和视力别放着不管。
- 怎么做（挑一条今天就能开的头）：
- **动体**：快走、骑车、跳舞、太极都行，每周凑够一定的量，别一坐一整天（见第 13 章）。
- **动脑**：读书报、下棋、学一样新东西，比反复做已经会的事更管用。
- **控血压、血糖、血脂**：按医生说的吃药、量血压，别自己停。这条证据最实，高血压就在那 14 项里。
- **睡好**：固定起床时间；打鼾声大、白天老犯困、夜里憋醒的，去查一次睡眠呼吸暂停。（睡眠不在那 14 项里，证据弱些。）
- **有人说话**：常和人吃饭、聊天、一起做事。孤零零一个人，也在那 14 项里。
- **来源**：B｜几个因素一起管、能降痴呆风险，是这份报告的核心结论；但哪一条对你最有用、能降多少，没法打包票。
- 特别提醒：**对谁成立**：还没确诊痴呆、想往后拖的人。已经在明显忘事、怀疑脑子有问题的，先去看医生（第 9 章）。
- **换回来的**：自理＋关系——不再怕"脑子一天天不够用，最后谁也不认得"

- **在中国怎么落地**：社区、老年大学、老年活动中心多有现成的班和队（太极、合唱、健走）。去哪问：社区卫生服务中心、老年大学。

3.8 这几种变化，是当天就要去医院的信号

- **要花多少**：出门一趟，可能挂急诊（钱：一次挂号的钱｜工夫：当天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：听力和眼睛的有些变化不是"慢慢老"，是急症：突然、单侧，或伴头晕、站不稳。忍一晚，可能把能救回来的耽误掉。
- 当天就去：
- 一只耳朵突然听不清、或突然听不见。这可能是突发性聋，72 小时内突然发生的感音神经性听力下降，属耳科急症，越早治越好（官方口径：中华医学会《突发性聋诊断和治疗指南（2015）》）。
- 一只眼睛突然看不见，或眼前像被黑布挡住，或突然一阵闪光、飞蚊明显增多。
- 眼睛突然剧痛、发红，同时视力下降。
- 听力或视力变化的同时伴头晕、走路不稳、说话不清、半边手脚没劲，按卒中处理，立刻打 120（见第 8 章、附录 E）。
- **来源**：A｜突发性聋的诊治窗口、单眼突然失明的急症属性都写在指南里；记住"突然、单侧、伴头晕"。
- 特别提醒：**对谁成立**：所有人。别自己滴两滴眼药水、掏掏耳朵等明天。慢慢变、拖上几个月的，按前面几节安排；"突然"两个字一出现，就当急症。
- **换回来的**：自理——不再怕"能救回来的，被我拖过去了"
- **在中国怎么落地**：突发性聋挂耳鼻喉科，有的医院当天能加号；眼睛的急症挂眼科急诊；说话不清、半边无力，打 120。拿不准先去医院急诊分诊。

3.9 这几件事，在中国去哪里办

- **免费体检里的听力、视力粗测**：65 岁及以上、在本社区住满半年的人，每年一次，在社区卫生服务中心、乡镇卫生院或村卫生室做，体格检查含口腔、视力、听力的粗测（官方口径：国家基本公共卫生服务规范第三版"老年人健康管理"）。这是粗测不是诊断，发现问题转上级医院查。
- **康复辅具适配**：助听器、助行器这类基本辅助器具走残联的"辅助器具适配补贴"。全国 31 个省（区、市）和新疆生产建设兵团都已出台政策（官方口径：中国残联／新华社，2024-02）。多数省份的对象是当地持证残疾人和符合规定的残疾儿童。补多少、要不要先办残疾人证、去哪申请，各地不同，以当地最新口径为准。去哪问：社区（村）、乡镇（街道）残联，或县（区）残联。

· **医保报销**：白内障手术、口腔治疗、糖尿病足治疗能不能报、报多少，看当地目录和医院等级。去哪问：就诊医院医保办、当地医保经办机构。

一句实话：这五样里，有些会一路坏下去。耳朵能靠助听器补一部分，牙能靠修复补一部分，脑和血管只能靠平日一点一点地管。这一章能做的，是把能提前拦的拦住，把该当天去的当天去。

3.10 如果你今天只能做一件事

记住家里电视音量现在大概在哪一档，下个月再看一次。声音一档一档往上加，是人到中年以后最容易被漏掉的一个信号。

然后，去做一次纯音测听。

3.11 如果你是在替爸妈看

这话怎么跟他说出口：别在他听不清、你把同一句重复到第三遍的时候说"你该配助听器了"，那等于当面点破。换个说法，把自己放进去："我最近也老听岔，我去查个听力，你陪我去呗？"查完，顺口跟医生提两句他的情况。或者先不碰助听器，只说"电视声音太大，待会儿邻居要提意见"，给调音量一个台阶。

他不同意时你还能做什么：老人卡住的通常是"面子"和"没用"两个坎。有三件事不用他同意就能做。一是先替他挂好号、定好时间，把"去不去"换成"哪天去"。二是帮他问清本地残联的辅具补贴怎么办（见 3.9），钱这道坎一低，抵触也低。三是他肯不肯戴先不论，就从"听得见"的场景下手：电视给他配个无线耳机，打电话开免提，饭桌上让他坐背墙、你脸对着他说话。他听清了一点点，自己就知道这东西有用。

3.12 本章我不确定的地方

这一章原来的几条待核，能回源头的都回了源头：口腔那两个数回到调查发布页与《中国人口报》，柳叶刀与助听器那段回到报告全文和 ACHIEVE 论文，残联辅具补贴回到中国政府网的新华社稿。剩下两条是数据本身的边界，不是没查到，如实留下：

· 助听器与痴呆的随机证据，目前主要就 ACHIEVE 一项、随访 3 年；长期下来能不能真的推迟痴呆，还没有答案。前几年那项说"戴助听器降痴呆风险"的观察性研究已被《柳叶刀·公共卫生》撤稿，不能再当依据。

· 中国听力残疾致残原因里老年性聋占 51.61%，出自 2006 年第二次全国残疾人抽样调查；《中国听力健康报告（2021）》2021 年发布时沿用的仍是这版老数据，此后没有新一轮全国抽样，这个比例偏旧。

3.13 本章数据来源

（以下链接均于 2026-10-10 实测；thelancet.com、achievestudy.org 等站点，已注明可用的替代入口。）

- 柳叶刀痴呆预防委员会《Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission》，The Lancet，2024-07-31 在线发布（14 项可改变危险因素；近一半痴呆理论上可预防；"部分关联可能只有一部分是因果"；听力损失与助听器相关结论）。https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(24)01296-0/abstract （内容核对以 PubMed 摘要为准 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39096926/ ）
- 同上，全文 PDF（含"听力损失与助听器"一节：全球约 20% 的人有听力损失，其中 62% 在 50 岁以上）。https://chronicdisease.org/wp-content/uploads/2024/12/Lancet-2024.pdf
- 世界卫生组织《Deafness and hearing loss》事实清单（60 岁以上逾 25% 有致残性听力损失；听力损失不处理会抬高痴呆风险、加快认知下滑）。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
- 世界卫生组织《World report on hearing》（2021-03-03 发布）。https://www.who.int/publications/i/item/9789240020481
- ACHIEVE 试验官方结果页（两组合并未见明显效果；高风险组 3 年认知下降慢 48%）。https://achievestudy.org/key-findings （结论以 Lancet 论文与 PubMed 摘要为准 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37478886/ ）
- Lin FR 等《Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE)》，The Lancet，2023。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37478886/
- 助听器观察性研究被撤稿：Jiang F, et al.《Association between hearing aid use and all-cause and cause-specific dementia: an analysis of the UK Biobank cohort》，Lancet Public Health 2023;8(5):e329-e338（原论文 PubMed 标 Retracted：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37062296/ ）；撤稿通知 Lancet Public Health 2024;9(1):e10，https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38101424/ （两个 PubMed 页均可打开）
- 中国听力医学发展基金会《中国听力健康报告（2021）》蓝皮书：老年性耳聋占我国听力残疾致残原因首位（51.61%）（转引自公益时报，2021-11）。http://www.gongyishibao.com/html/yanjiubaogao/2021/11/19304.html
- 国家卫健委《成人白内障手术操作规范（2026 年版）》：白内障手术适应证。https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100067/202604/5ba49ac3bf3148d8baab72c7547cc1bb/files/%E6%88%90%E4%BA%BA%E7%99%BD%E5%86%85%E9%9A%9C%E6%89%8B%E6%9C%AF%E6%

- 《中国成人白内障摘除手术指南（2023 年）》，中华眼科杂志 2023 年第 59 卷第 12 期（白内障是全球首位致盲眼病；2020 年中国成人白内障发病率 22.78%，患者约 1.3 亿）。https://www.gzzoc.org.cn/sites/zoc.live1.sysucloud2.sysu.edu.cn/files/2025-10/zhongguochengrenbaineizhangzhaichushoushuzhinan-2023nian.pdf
- 第四次全国口腔健康流行病学调查（国家卫生计生委 2017-09-20 发布）主要结果：国家卫健委官网发布页列 65–74 岁存留牙 22.5 颗 https://www.nhc.gov.cn/jkj/c100062/201709/0eb0bac9229d40eea958b0d73c8817f7.shtml ；缺牙未修复 36.8%、龋病患病率 98%、牙周健康率 9.3% 为调查明细，转引自《中国人口报》《老年健康 从"齿"开始》（2024-10-24，记者曹梦甜，国家卫健委主管）https://jkb.com.cn/rkb/rdgz/2024/1024/498572.html （2026-10-10 实测可开）
- 中华口腔医学会团体标准《老年患者口腔修复指南》（T/CHSA 001-2021，2021-07-01 实施）：各类义齿修复、全口义齿需适应与调改、有创操作前评估用药史。https://www.cndent.com/wp-content/uploads/2021/06/%E8%80%81%E5%B9%B4%E5%8F%A3%E8%85%94%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E6%8C%
- 中华医学会糖尿病学分会《中国糖尿病足防治指南（2019 版）》，中华糖尿病杂志 2019 年第 11 卷第 2 期（50 岁以上糖尿病患者糖尿病足发病率 8.1%；糖尿病足定义；嵌甲等为前期病变；趾甲、嵌甲须由专业人员处理，不宜去修脚处）。https://cmab.yiigle.com/uploads/guide_html/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85%E8%B6%B3%E9%98%B2%E6%
- 《突发性聋诊断和治疗指南（2015）》，中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2015 年第 50 卷第 6 期（72 小时内突发感音神经性听力下降，属耳科急症）。https://www.medsci.cn/guideline/show_article.do?id=59aa91c00122064c
- 国家基本公共卫生服务规范（第三版）"老年人健康管理服务规范"：65 岁及以上年度一次，体格检查含口腔、视力、听力粗测判断。https://www.jiangan.gov.cn/jaxxw/zfxxgk/fdzdgk/shgysy_41394/shjzhshfl/shfl/202011/P020201106429362006578.pdf
- 残疾人基本型辅助器具适配补贴：中国政府网／新华社（2024-02-15，31 个省区市及新疆生产建设兵团均已出台政策；补贴对象与标准）。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202402/content_6931536.htm ；中国残联转载同文 https://www.cdpf.org.cn/ywpd/xcwh/mtjjxwb/4e0e0c28a98448e2a058ddb0ac60d6c0.htm

第 4 章 · 钱本与关系本

退休那天会有人给你开个欢送会，送一个印着单位名字的纪念品。三个月后，那个你干了三十年的地方，只剩下工资卡里一个每月到账、却比工资少一截的数字。老同事群里最后一条消息，是转来的一篇健康文章，没人接话。

这两样东西，就是你后半辈子的"本"：一份要早存的养老金，一张要早存的关系网。这一章讲的就是这两笔本怎么存，趁现在还来得及。

4.1 这一章解决什么问题

篇一叫"存本钱"。前面几章存的是身体，都算四笔账里的"自理"。

这一章存的是另外两笔：**钱**和**关系**。

钱这笔本，国家替你搭了三层架子，最上面一层要你自己动手，不动手就一直空着。关系这笔本更麻烦，它不会停在那儿等你，只会一点点折旧。等你真需要有人敲门那一天，名单上还剩谁，取决于你现在存了什么。

两笔本有个共同点：**早存才有利息。** 等真用上再存，来不及。

4.2 养老金分三层，先弄清自己坐在哪一层

- **要花多少**：半小时，一次查清（钱：不用花｜工夫：半小时｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：养老金有三层：第一层是国家给的基本养老保险，截至 2025 年底全国参保 10.76 亿人，多数人的养老钱靠它【官方口径：人社部 2025 年度统计公报】；第二层是单位给的企业年金或职业年金，少数单位有；第三层是你自己存的个人养老金。先弄清自己坐在几层上，才知道稳不稳。
- **可以怎么做**：
- **查第一层**：缴了多少年、个人账户有多少。用"掌上12333"APP、"电子社保卡"或"国家社会保险公共服务平台"查。
- **查第二层**：问原单位有没有企业年金；机关、事业单位一般有职业年金。
- **来源**：A｜三层架子是国家文件明确的制度框架。"十五五"规划纲要写的是"加快发展多层次、多支柱养老保险体系"，个人养老金出自国办发〔2022〕7号。
- 特别提醒：**对谁成立**：缴过社保、查得到自己参保记录的人。从没参保、断缴多年、灵活就业的，先打电话问参保地社保经办机构："我这种情况怎么参保，断了能不能补，按什么标准。"
- **换回来的**：钱——不再怕"钱不够用，却不知道自己到底有多少"

- **在中国怎么落地**：查社保用"掌上12333"APP或"电子社保卡"（微信、支付宝里能领）；社保问题打　　12333，或去参保地社保经办大厅。查医保走另一个入口，用"国家医保服务平台"APP。以当地最新口径为准。

4.3 个人养老金这一户，你自己不开就没人替你开

- **要花多少**：一次开户，之后每年存一笔（钱：自愿，上限由国家定｜工夫：开户半小时｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：个人养老金是"你自己给自己开的养老账户"：自愿参加，自己缴钱，买国家认可的金融产品，缴费时能抵个税，退休或满足条件才能取。它在社保之外，是你自己多加的一层。
- **可以怎么做**：
- ① 先确认你参加的是城镇职工还是城乡居民基本养老保险，二者其一就能开。
- ②　　开两个户：个人养老金账户，通过"国家社会保险公共服务平台"、"电子社保卡"、"掌上12333"APP开；资金账户，在合规的商业银行开。
- ③ 每年往里存，现在的上限是每年 12000 元（国办发〔2022〕7 号定的，文件写明可适时调整；到 2026 年 10 月仍是这个数）【官方口径】。
- ④ 自己选产品：储蓄、理财、商业养老保险、公募基金都可以，2024 年起国债也纳入了范围【官方口径】。
- **来源**：A｜开户入口、缴费上限、产品范围、领取条件，都写在国家文件里（国办发〔2022〕7号；人社部发〔2024〕87号）。
- 特别提醒：**对谁成立**：还在缴社保、手上有闲钱、本来就缴个税的人。**但是**，不是人人划算：抵税省下的钱跟税率档位有关，收入不高、本来不缴个税的人，省不了多少；而且这笔钱封闭运行，除规定情形外不能提前取。开不开、每年存多少，你自己算。
- **换回来的**：钱——不再怕"只靠一份养老金，缺口没人补"
- **在中国怎么落地**：开户和查询走"国家社会保险公共服务平台"、"电子社保卡"、"掌上12333"APP；税优和领取的问题，问开户银行、打 12333，或税务 12366。以当地最新口径为准。

4.4 长期护理保险管的是失能之后那笔照护钱

- **要花多少**：查一次、问一次（钱：不用花｜工夫：一趟窗口或一个电话｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：养老金管你活着吃饭，医保管你看病。可万一一个人失能、全家失衡，那笔照护钱归谁管？归长期护理保险（长护险）。它一般不发你现金，是给你买照护服务。
- **可以怎么做**：① 先查你所在的城市有没有实施长护险；② 有的话，失能状态一般要持续 6 个月以上，经申请、评估认定后才能享受【官方口径】；③　待遇不设起付线，主要支付居家、社区、机构护理的服务费【官方口径】。

- 这个制度走到哪一步了：它走的是"先试点、再推开"的路子。2016 年首批 15 个城市先试，2020 年扩到 49 个城市【官方口径】。到 2025 年底，参保人数已超过 3 亿人【官方口径：民政部、全国老龄办《2025 年度国家老龄事业发展公报》】。2026 年 3 月，中办、国办印发《关于加快建立长期护理保险制度的意见》：用 3 年左右时间，到 2028 年底在全国范围基本实现全覆盖，费率统一控制在 0.3% 左右【官方口径】。
- **来源**：A｜时间线、覆盖数、费率、待遇规则，都出自官方文件（国家医保局 2025-09-25；民政部、全国老龄办《2025 年度国家老龄事业发展公报》；中办、国办 2026-03-25）。
- 特别提醒：**对谁成立**：已经落在实施长护险城市的人。**各地待遇不一样**：国家统一的服务项目目录 2025 年才印发，试点城市还要用大约 3 年时间逐步统一【官方口径】。别的城市的比例和服务，搬到你这儿不一定成立。
- **换回来的**：钱＋关系——不再怕"一人失能、全家失衡，护工费拖垮一家"
- **在中国怎么落地**：去哪问，参保地医保局、医保服务窗口，或"国家医保服务平台"APP。问三句："我们这儿实施长护险没有？怎么申请失能评估？能报哪些服务、报多少？" 以当地最新口径为准。

4.5 老了最先耗尽的，其实是关系

- **要花多少**：先花点时间，看清一件事（钱：不用花｜工夫：一次自问｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：钱花完了，身后还有国家兜底；关系断了，没人替你补。伴侣、子女、老友、邻居、同事、家庭医生，这六类人就是失能那天你真正能用的"本"。这张名单不会自己变长，只会变短。
- 为什么要当成一笔本：孤独不只是"心情不好"。世界卫生组织的报告说，全球大约每 6 个人里就有 1 个人受孤独影响，孤独和每年大约 87.1 万例死亡相关【官方口径】。一份汇总几十万人数据的荟萃分析发现，社会关系强的人存活率比弱的人高约 50%，和戒烟、控制体重是同一量级【第三方研究】。
- **可以怎么做**：这张名单上真正会折旧、需要你主动续费的，是下面四类。
- **来源**：B｜孤独和健康、死亡风险的关联，有大量队列研究支持；"社会连接"已是世卫组织的公共卫生议题。**但是**，相关不等于因果，"维持社交能不能延寿"的干预研究结论还不一致。现在开始维持，我不承诺你多活几年，它保的是：到你需要人那天，你还叫得动人。
- 特别提醒：**对谁成立**：独居、空巢、退休后社交圈骤缩的人最要紧。本来社交就很满的人，别把关系全押在一类人上，比如只靠同事。
- **换回来的**：关系——不再怕"空巢独居没人知道，老友一个个没了"
- **在中国怎么落地**：社区这一级能用的去处，有居委会、街道养老服务中心、社区养老服务站、老年大学；具体有什么、怎么加入，去问一次就知道。

关系会走，拦不住。能做的，只是让它走得慢一点。

4.6 老友这道关系，要自己续费

- **要花多少**：一个月一个电话、一次见面（钱：花不了几个钱｜工夫：每月几小时｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：同事关系是单位"养"着的，一退休就断电。老友关系得你自己"续费"。人越老，能说上话的人越少，留下的这几个值钱。
- **可以怎么做**：
- ① 挑 3 到 5 个真能说话的老友，定一个固定日子见面或通话。"有空聚"，等于永远不聚。
- ② 打电话比发消息管用，一周至少一个。
- ③ 找一件共同做的事：一起走路、下棋、钓鱼、逛公园都行，有共同的活动才扛得住时间。
- ④ 别只存微信。把对方的电话、住哪个小区，记进手机通讯录；手机丢了、微信登不上，你还找得到人。
- **来源**：C｜这是通行做法和经验整理，没有针对老人的"老友维持随机试验"。**但是**，社会参与和情绪、认知的关系，有队列研究支持，见上一条。
- 特别提醒：**对谁成立**：还能出门、还约得动的人。行动不便、住得远的，把"见面"换成固定通话和视频。老友也会有一天需要你去看他，关系是双向的。
- **换回来的**：关系＋体面——不再怕"退休后没人再找我"
- **在中国怎么落地**：社区老年大学、日间照料中心、老年活动室、太极队、广场舞队、棋牌室。去社区居委会或社区养老服务站问一句："这儿有哪些老年活动，怎么加入。" 以当地最新口径为准。

4.7 先认识三户邻居，关键时候他们比子女近

- **要花多少**：几次点头、一个电话（钱：不用花｜工夫：几次照面｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：子女再孝顺，也隔着一座城。真出事的时候，摔倒、急病、漏水、煤气没关，几分钟能敲开你家门的，是邻居。这笔本平时不起眼，出事时最贵。
- **可以怎么做**：
- ① 先认识对门和楼上楼下两三户，知道姓什么。
- ② 互相留一个电话，不只是微信。
- ③ 定一个"小信号"：早上窗帘拉开、晚上灯亮，就说明人还好；一天没动静，就敲一下门。
- ④ 你也当那个会敲门的人。帮邻居收个快递、搭把手，关系是存出来的。
- **来源**：C｜邻里互助是通行做法，中国的养老照护长期靠家庭和邻里这张非正式网络。**但是**，不是每个小区都有能用的邻里关系，新小区、租户流动大的地方更弱。
- 特别提醒：**对谁成立**：独居、空巢、住老旧小区（邻里还比较熟）的人更容易成立。住新小区、租户多的地方，更现实的路子是通过社区、物业、楼栋长搭。

- **换回来的**：关系＋自理——不再怕"夜里一个人在家出事没人知道"
- **在中国怎么落地**：居委会、楼栋长、网格员、物业。不少城市在推独居老人探访、敲门行动，去社区问有没有。以当地最新口径为准。

4.8 退休后，把同事关系换个接法

- **要花多少**：一次整理通讯录（钱：不用花｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情，怕被当成"还想攀关系"）
- **简单说**：退休那天，你的社会身份少了一半。天天见的同事，一夜之间变成"前同事"。这不怪人情薄，是共同的事没了。想留住，就换一件新的事接上。
- **可以怎么做**：
- ① 退休前后，留 3 到 5 个还想来往的同事的联系方式，存电话，别只留在工作群里。
- ② 找一件跟老本行有关、又不绑考勤的事：返聘、带徒弟、兴趣小组、行业老友群都行，让身份换个形式续着。
- ③ 原单位的活动、退休支部或退管会，去一次看看合不合得来。
- **来源**：C｜经验整理。"退休后身份和社交圈收缩"是老年社会学反复讨论的现象，没有试验支持。
- 特别提醒：**对谁成立**：在单位、机关、学校干了一辈子的人最明显。自由职业、个体户、农民，本来就没有"单位关系"可断，这一条对你换成同行、老客户、老乡。
- **换回来的**：关系＋体面——不再怕"退休后没了身份，被时代甩下"
- **在中国怎么落地**：原单位退管会、工会；行业老同事群；老年大学；一些地方有面向老年人的再就业、返聘项目。到原单位人事问一句有什么退休人员活动。以当地最新口径为准。

4.9 提前签一个家庭医生，把"找谁看病"存下来

- **要花多少**：一次签约，之后按需（钱：多数地方基础包免费或低费｜工夫：签约半小时｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：半夜不舒服，最让你慌的多半是不知道该找谁，也没人知道你的底细。签一个家庭医生，等于提前给自己存一个"认识你"的医生。
- 怎么签：① 到居住地的社区卫生服务中心或乡镇卫生院签；② 可以签团队，也可以签个人，2022 年新政策允许；③ 协议一次可签 1 到 3 年，到期可以续【官方口径】；④ 带上身份证、医保卡，问清服务清单和费用。
- 管什么：常见病多发病诊疗、慢病管理和随访；经家庭医生转诊可优先就诊、检查、住院；对行动不便、失能失智的人，可上门服务、家庭病床；符合条件的慢病患者，能开 4 到 12 周长期处方【官方口径】。

- 值不值：值，尤其是有慢病、行动不便、独居的人，它是你进医院的"入口"。**但是**：家庭医生的能力、签约后的体验，各地差别很大，有的地方被批评"签而不约"。签之前先问：这个团队怎么联系、慢病多久随访一次、要转诊怎么走。
- **来源**：A｜签约方式、服务内容、转诊和长期处方，都写在国家文件里（国卫基层发〔2022〕10号）。目标是到 2035 年签约服务覆盖率达到 75% 以上、重点人群 85% 以上【官方口径】。
- 特别提醒：**对谁成立**：有慢病、行动不便、独居的人最值。身体很好、一直去大医院看专科的人，好处主要是慢病随访和转诊方便。已经失能失智的人，重点用它上门和家庭病床。
- **换回来的**：自理＋关系——不再怕"看病没人陪，不知道找谁"
- **在中国怎么落地**：去哪签，居住地社区卫生服务中心或乡镇卫生院。问三句："签谁？管什么？多少钱？" 异地就医报销问参保地医保局，或用"国家医保服务平台"APP。以当地最新口径为准。

4.10 如果你今天只能做一件事

拿起电话，给你最想留住的那位老友打一个电话，当场约下一个固定的日子：下周三下午三点，一起走一段路，或喝一壶茶。

养老金什么时候查都行，那笔本不会一夜之间没了。关系不一样，它每天都在折旧，今天这一个电话，就是往里存的第一次钱。

4.11 如果你是在替爸妈看

这一章里所有"帮他做"，最进得去的版本，是把它变成"陪他一起做"。

怎么说出口：别说"我帮你查养老金"，改成"我最近自己也在研究这几层，没搞明白，您帮我把参保记录调出来，我照着学一遍"。把"我替你办"换成"你教我一遍"，他就肯配合。同一个道理，问邻居、问家庭医生，都可以让他在旁边看着你问。

他不同意时你还能做什么：有些事不需要他点头。① 你自己用"掌上12333"、"电子社保卡"帮他查清参保年限；② 去他参保地社保局问断缴、转移怎么处理；③ 去他社区问一句：长护险实施了没有、家庭医生签了没有；④ 你不常在他身边，帮他把邻居认下——你不在的时候，邻居在。这四件不用他同意，先做能做的。

4.12 本章我不确定的地方

- "全国基本养老保险参保 10.76 亿人"已回到人社部原始发布（《2025 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》与人社部 2026-01-27 例行新闻发布会），不再用二手评论。"个人养老金开户超 1.5 亿"没能落定到人社部的原始口径，只有《2025 年度国家老龄事业发展公报》里的"累计缴存金额 1452 亿元"是官方的；开户数取自多家财经媒体对人社部的转引（约 1.5 亿，2025 年），用的时候以最新官方口径为准。

- 长护险的覆盖数随时间往前推、口径也不完全一致：国家医保局 2025-09-25 说覆盖 1.9 亿人、累计支出超 850 亿元；新华社与老龄事业公报到 2025 年底的口径已是约 3 亿人。本章用后者。各地实施时间和待遇差别大，以参保地医保局口径为准。
- 孤独与死亡风险的关联有队列研究支持，但"从现在开始维持关系能不能延寿"，缺针对中国老年人的干预研究。

4.13 本章数据来源

- 基本养老保险参保人数：《2025 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》（人力资源社会保障部；2025 年末基本养老保险参保 107591 万人，城镇职工 54672 万、城乡居民 52919 万；企业年金 17.79 万户、参加职工 3343 万人）https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/tjgb/202607/W020260716567491153024.pdf （2026-10-10 核对）；同口径另见人社部 2026-01-27 例行新闻发布会（央广网：截至 2025 年底全国基本养老保险参保 10.76 亿人）https://news.cnr.cn/dj/20260127/t20260127_527507408.shtml
- 三支柱与个人养老金缴存：民政部、全国老龄办《2025 年度国家老龄事业发展公报》（2026 年发布）：个人养老金累计缴存金额 1452 亿元。https://www.caoss.org.cn/upload/file/26081016414941.pdf （2026-10-10 核对）。三支柱的制度解读另见《加快发展多层次、多支柱养老保险体系》（王超，光明日报，2026-04-23，人民网转载，转述）：http://theory.people.com.cn/n1/2026/0423/c40531-40706948.html
- 个人养老金制度框架：《国务院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》（国办发〔2022〕7 号，2022-04-08）：参加范围、个人账户、每年缴费上限、封闭运行、领取条件。https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-04/21/content_5686402.htm （2026-10-10 核对）
- 个人养老金全国实施：《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局 金融监管总局 中国证监会关于全面实施个人养老金制度的通知》（人社部发〔2024〕87号，成文 2024-12-10）：自 2024-12-15 起全国实施；开户渠道；产品范围。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992279.htm （2026-10-10 核对）
- 长期护理保险（覆盖数与制度背景）：国家医保局《国家长期护理保险服务项目目录（试行）》政策解读（2025-09-25）：覆盖 1.9 亿人、支出超 850 亿元；2016 年试点、49 个试点地区。https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/9/25/art_105_18022.html （2026-10-10 核对；此为 2025 年 9 月口径。民政部、全国老龄办《2025 年度国家老龄事业发展公报》载，截至 2025 年末长期护理保险参保 3.0854 亿人、2025 年基金支出 186.44 亿元；公报原文 民政部、全国老龄办《2025 年度国家老龄事业发展公报》（民政部、全国老龄办 2026-07-31 发布；公报全文 PDF）：https://www.cncaprc.gov.cn/u/cms/www/202608/01013057jmzq.pdf ）
- 长期护理保险（最新制度框架）：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快建立长期护理保险制度的意见》（2026-03-25）：到 2028 年底全国范围基本实现全覆盖；费率 0.3% 左右；失能 6 个月以上经评估；不设起付线；支付比例。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202603/content_7063789.htm （2026-10-10 核对）

- 长期护理保险（现状与失能人口）：新华社《覆盖全民！我国加快建立长期护理保险制度》（2026-03-26）：60 岁及以上老年人口 3.2 亿、失能老人约 3500 万；制度已覆盖约 3 亿人、累计惠及超 330 万失能群众。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202603/content_7063795.htm （2026-10-10 核对）
- 家庭医生签约：《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》（国卫基层发〔2022〕10号，2022-03）：签约主体、协议期限、转诊、上门服务、长期处方、2035 年覆盖目标。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/15/content_5679177.htm （2026-10-10 核对）
- 家庭医生签约（政策解读）：《〈关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见〉政策解读》（中国政府网，2022-03-15）：签约周期、签约主体、长期处方服务目标。https://www.gov.cn/zhengce/2022-03/15/content_5679180.htm （2026-10-10 核对）
- 家庭医生"签而不约"：《变"签而不约"为"签而有感"（新知）》（人民日报，2026-09-18）https://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202609/18/content_30181822.html ；《记者调查：家庭医生为何普遍"签而不约"？》（新华网重庆，2025-02-10）http://www.cq.xinhuanet.com/20250210/f005d4db7be648658683014a414cdf23/c.html （2026-10-10 核对）
- 孤独与健康：WHO Commission on Social Connection《From loneliness to social connection: charting a path to healthier societies》（2025）：全球约 1/6 人受孤独影响；孤独与每年约 87.1 万例死亡相关（2014–19）。https://www.who.int/groups/commission-on-social-connection/report/ （2026-10-10 核对）
- 社会关系与死亡风险：Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review. PLoS Medicine, 2010. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316 （2026-10-10 核对）
- 查询入口："掌上12333"APP（人力资源社会保障部）https://www.12333.gov.cn/ggfwstatic/download/app.html ；"国家医保服务平台"APP（国家医保局）。

篇二 · 黑框警告：这三件事先看〔阶段二〕

第 5 章 · 跌倒是晚年的第一道分水岭

半夜三点，你从马桶上站起来。眼前一黑，身子往墙上倒。你扶住了，没摔。

但你清楚：刚才那一下，差一点就把后半辈子换了个样。这一章，写给那一下之前。

5.1 这一章解决什么问题

这本书算四笔账，第一笔是"自理"。跌倒就是这一笔账的分水岭。

摔之前你能自己走、自己上厕所、自己下楼；摔之后，很多人从此要拄拐、要人扶，一部分人再也起不来床。差别不在那一跤疼不疼，在摔完还剩多少年能自己过。

下面给的不是"注意防滑"这种话，是摔之前今天就能做的动作，和你能去问的几个人。

5.2 为什么摔一跤就换了人间

跌倒是我国 65 岁及以上老年人因伤害死亡的第一位原因，也是老年人创伤性骨折、因伤就诊的第一位原因（官方口径：国家卫生健康委疾控局、中国疾控中心慢病中心《预防老年人跌倒健康教育核心信息》，2021-10-12）。

一组中国数：60 岁以上社区老人，过去一年约 14.7% 跌倒过；跌倒过的人里 79.5% 受了伤（第三方研究：《中国公共卫生》2021 年，21 084 人）。

把人换掉的是髋部骨折。我国每年老年人因跌倒新增髋部骨折超过 100 万例。它有个别名，叫"人生最后一次骨折"：伤后 6 个月死亡率约 10%–20%，一年 20%–30%；活下来的，约 35% 再没能自己走路，25% 要长期有人照顾（官方口径：北京市卫健委转北京世纪坛医院，2023 年）。

链子是这样扣起来的：摔→骨折→手术或卧床→感染、血栓、肌肉萎缩→越躺越弱→再也下不了床。死亡常常不是骨折本身，是躺出来的并发症。

所以跌倒不是"摔了一下"这件小事，是一次把自理年限砍掉一截的意外。它，是可以提前防的。

5.3 玄关那条凳子，是家里最便宜的一件防跌倒家具

- **要花多少**：一两百元，一次搞定（钱：花不了几个钱｜工夫：一小时｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：站着穿鞋、单脚抬起，是最容易失衡的姿势之一。换鞋凳一坐，这个动作就没了。
- **可以怎么做**：① 凳子带靠背、不带轮；② 凳子旁边的墙上竖着装一根扶手，起身时手能搭上力；③ 常穿的那双鞋放在抬手就能够到的一层，别留在最底下。
- **来源**：C｜通行做法；跌倒常发生在转身、弯腰、单脚撑地时，但没有专试"换鞋凳"这一件的随机试验。
- 特别提醒：**对谁成立**——还能自己走的人。已经用助行器的人，起身转身要另配扶手。

- **换回来的**：自理——不再怕"摔了之后再也起不来"
- **在中国怎么落地**：换鞋凳、扶手、防滑垫多列在政府适老化改造推荐清单里（民发〔2020〕86 号）。去社区居委会或街道养老服务窗口问一句："居家适老化改造怎么申请、我这种情况补不补。"

5.4 卫生间改四样：扶手、防滑、坐浴、夜灯

- **要花多少**：扶手防滑几十到几百元，坐便椅、淋浴椅、夜灯另算，一户做下来差别大（钱：要花些钱｜工夫：几天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：家是老人摔得最多的地方，卫生间和玄关又是家里摔得最多的两个角落。那里又湿又滑，还要转身、下蹲、单脚站。
- **可以怎么做**：① 马桶旁、淋浴处各装一根扶手，打进墙里，不装吸盘；② 地面做防滑，把地垫撤出这个家；③ 淋浴换成能坐着洗的淋浴椅；④ 从床到马桶装成一路感应夜灯，不是只有一盏；⑤ 蹲便改坐便，或加坐便椅。
- **来源**：B｜世界卫生组织把"居家评估与改造"列为老年人防跌倒做法之一；改哪一处、效果多大因家而异。
- 特别提醒：**对谁成立**——大多数居家老人。扶手必须打进承重墙，找有资质的施工方，别自己拿膨胀螺丝乱打。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"半夜上厕所摔了、还被人看见"
- **在中国怎么落地**：民发〔2020〕86 号的清单分"基础类"和"可选类"，7 个基础类项目由政府对符合条件的困难老人家庭补贴——防滑处理、高差处理、床边护栏、扶手、淋浴椅、手杖、防走失装置。金额各地不同，广州对符合条件的家庭按对象类别每户最高资助 3 000 / 1 500 / 1 000 元，本地口径问区民政局或社区。自己出钱做，先问施工方三句：扶手打进墙没有、地面湿了滑不滑、夜灯是不是从床到马桶一路。

5.5 拿一张纸，把家里逐处走一遍

- **要花多少**：一支笔，半小时（钱：不用花｜工夫：半小时｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：绊你的东西你天天看见，已经看不见了。换一双"找茬"的眼睛，一间一间走一遍。
- **可以怎么做**：对照下面这张清单，走过一处勾一处。
- **地面**：地垫、门槛、家具滑轨、拖来的电线、地毯翘边、水渍
- **照明**：够不够亮，开关在不在顺手的地方，床头到厕所是不是一路有灯
- **通道**：过道堆没堆东西，家具之间够不够你转身
- **坐具**：床和沙发是不是太软、太低，一坐下就起不来
- **取物**：常用的东西是不是要踮脚、踩凳子、深弯腰才够得着
- **楼梯**：台阶高度一不一致，有没有扶手，台阶边缘看不看得清

- **浴室**：见上一条
- **来源**：B｜清单取自官方防跌倒材料和家居环境危险因素评估表，逐个改能降风险；但没有"清单本身"的试验。
- 特别提醒：**对谁成立**——所有人。已经用助行器的人，过道宽度、转弯的地方要单独量。
- **换回来的**：自理——不再怕"家里处处是雷，我却看不见"
- **在中国怎么落地**：清单对照中国疾控中心慢病中心《预防老年人跌倒健康教育核心信息》第 9 条；有的城市社区能上门做"居家跌倒风险筛查"（重庆等地有试点），到社区问有没有这项服务。

5.6 鞋底要防滑，但不能软——防滑和软底是两回事

- **要花多少**：一双合脚的鞋，一两百到几百元（钱：花不了几个钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：很多人给爸妈买"软底鞋"，觉得越软越舒服。脚底越软越厚，脚对地面的感觉越迟钝，大脑反应越慢。防滑靠的是鞋底纹路，站得稳靠的是鞋底不软塌。
- **可以怎么做**：① 鞋底纹路清晰、有沟槽，防滑；② 有一定厚度、硬度适中，能撑住脚；③ 后跟包住，别穿没后跟的拖鞋出门；④ 固定用搭扣或把鞋带系紧；⑤ 大小合适，脚趾到鞋头留一点空；⑥ 傍晚试鞋，那时脚最胀，试出来的码白天也合适。
- **来源**：C｜中国疾控把"低跟、防滑、合脚"写进了核心信息；国外关于鞋与跌倒的研究结论并不一致，**但是**方向一致的是"合脚、跟低、有支撑"，别信"某一种底一定最好"。
- 特别提醒：**对谁成立**——还能自己走的人。脚麻、糖尿病足、脚变了形的人，先找医生或足踝专科看，再挑鞋。
- **换回来的**：自理——不再怕"被一双不合脚的鞋绊倒"
- **在中国怎么落地**：照中国疾控中心慢病中心《预防老年人跌倒健康教育核心信息》第 6 条买鞋；别为包装上"防滑"、"老人专用"那几行字多花钱（厂商宣称不算证据）。

5.7 三种训练各管一段：力量管撑住，平衡管调整，步态管不绊

- **要花多少**：每天十几分钟，长期做（钱：不用花｜工夫：每天｜力气：有点累｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：要摔那零点几秒里，身体靠两样东西：腿有劲能撑住，身体会自己调整。这是两种不同的能力，要分开练。走路老被绊，是第三样——步子本身有毛病。
- **可以怎么做**：
- **力量（管撑住）**：扶稳练提踵（踮脚跟）、从椅子上坐站、直腿后抬，练大腿和小腿。
- **平衡（管调整）**：单脚站立（从扶墙开始）、脚跟对脚尖走"一字步"、身体轻晃的"不倒翁"。
- **步态（管不绊）**：原地高抬腿、用脚跟走、用脚尖走、跨过小障碍走，改掉拖地、前倾、步子不稳。 原则：先扶稳再少扶，先坐姿再站姿，先做对再加量。练前热身，不舒服别硬撑。

- **来源**：B｜世界卫生组织把步态、平衡、功能训练列为老年人防跌倒做法，其中太极拳的证据相对最扎实；国内核心信息也把这些动作名字列了出来。
- 特别提醒：**对谁成立**——能站、能走、能自己坐站的人。经常站不稳、半年内摔过的人，先找康复科或物理治疗师评估，别自己开练。**怕摔就干脆不动，是最坏的选项**：越不动，身体功能退得越快，反而更易摔。
- **换回来的**：自理——不再怕"因为怕摔，干脆不动的死循环"
- **在中国怎么落地**：这些动作就在中国疾控中心慢病中心的十二字防跌倒口诀"要锻炼、要服老、要适老、早治疗"里；社区、社区卫生服务中心、老年大学常办太极拳班、健步走队。去哪问：社区卫生服务中心的家庭医生团队、社区养老服务站。

5.8 从椅子上不用手撑站起来，数三十秒能做几次

- **要花多少**：一把不带扶手的椅子，一分钟（钱：不用花｜工夫：一分钟｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：能不能不用手、光靠腿从椅子上站起来，是腿上有没有劲最直接的一个信号。轻松起来，说明你还有本钱；必须用手撑，是腿在报警。
- 怎么做（照这个动作做）：① 坐在椅子中间，椅子不带扶手、靠背挺直；② 双手交叉放在对侧肩上，抱在胸前；③ 双脚平放地面，背挺直；④ 喊"开始"后，站起来到完全直立，再坐下，反复做，数**三十秒里能起来几次**；⑤ 如果必须用手才能站起来，停下，记零分。这个动作本身，就是每天该练的"坐站练习"。
- 意味着什么：一套国外通行的筛查工具（CDC STEADI）给了"偏低"的参考线——60–64 岁男性少于 14 次、女性少于 12 次算偏低；80–84 岁男少于 10、女少于 9；85–89 岁都少于 8 次（官方口径：美国 CDC STEADI 椅子起立测试表）。
- **来源**：B｜这是国外通行的筛查动作，有按年龄、性别的参考线；**但是**参考线来自国外人群，中国人的线可能对不上，把它当对照，别当诊断。
- 特别提醒：**对谁成立**——能独立坐站的人。做完头晕、心慌，停下，去看医生。
- **换回来的**：自理——不再怕"我还行不行，心里没数"
- **在中国怎么落地**：坐站练习写进了中国疾控中心的防跌倒口诀（"要锻炼"），在家就能做；要不要量、量完怎么办，问社区卫生服务中心的家庭医生。

5.9 摔之前，身体给过三次提醒

- **要花多少**：不用花钱，用眼睛和记性（钱：不用花｜工夫：平时｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：跌倒很少毫无预兆。起身头晕、脚底发麻、看东西发花，这三样常常先到，很多人当成"老了正常"，就忍过去了。
- **可以怎么做**：对号入座，记下什么时候发生。

- **起身头晕、发黑**：从坐或躺到站，几秒钟头发晕。多半是站起来时血压掉下去了（体位性低血压）。慢一点起，先坐一会儿再站，就医时专门说给医生听。
- **脚底发麻、踩不实**：脚对地面的感觉变差，容易绊、容易踩空，糖尿病、腰椎有问题的人常见。让医生查查脚。
- **看东西发花、夜里看不清**：视力下降、白内障、眼镜不合适都在里头。定期查眼睛，夜里少出门，出门带上照明。　另外两条最容易被忽略：**半年内摔过一次**、**走两步就要扶东西**——这两条本身就是高风险的信号。
- **来源**：B｜起身血压下降、视力与脚底感觉变差，都是被反复确认的跌倒危险因素。
- 特别提醒：**对谁成立**——出现过上面任何一条的人。一次**晕倒**、一次**说不清话或半边没劲**，那就不是"提醒"，是急症，打 120。
- **换回来的**：自理——不再怕"身体在报警，我却当成小事"
- **在中国怎么落地**：起身慢一点、夜里装灯、查视力，都不用花大钱；把这些查清楚要去医院，见 5.12 那张就诊清单。

5.10 这几类药会让人更容易摔，把清单带去看医生

- **要花多少**：一次就诊（钱：一次挂号的钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：很多常用药会让人发晕、犯困、血压下降或血糖偏低，摔的风险就上来了。问题不在药本身，在"你吃了哪些、有没有吃重复了、剂量对不对"——没人帮你把整张单子看一遍。老人常同时吃好几种药，风险是叠起来的。
- 高危药物清单（附来源）：
- 苯二氮䓬类和"Z 药"等**镇静催眠药**（如艾司唑仑、唑吡坦、佐匹克隆）
- **抗抑郁药**（尤其三环类、单胺氧化酶抑制剂）
- **抗精神病药**、**抗癫痫药**
- **降压药**（起身时血压掉下去）
- **降糖药**（低血糖会出冷汗、手抖、眼前发花）
- **利尿药**（短时间内丢水，乏力、站立不稳）
- **阿片类止痛药**（镇静、肌肉松弛）
- **氨基糖苷类抗菌药**（影响前庭和平衡）
- **可以怎么做**：①　把正在吃的药、保健品、别人给的"偏方"全部列成一张纸，或拍一张照片；②　下次就诊带上，请医生或药师从头看一遍；③　开新药时问一句"这个会不会让我更容易摔"；④ 加药前告诉医生你已经在吃什么，避免重复；⑤ 别自己加药、别自己停药。
- **来源**：B｜"增加跌倒风险的药"是国际公认的一类，多份文献与指南的说法一致。具体哪一味该停、该换、怎么减，只能医生定。国际上有 Beers 标准、STOPP/START 来筛老年人不合适的用药。

- 特别提醒：**对谁成立**——吃安眠药、抗抑郁药、降压药、降糖药的人，尤其是同时吃三种以上药的人。停换药必须医生指导，自己停可能出更大的事。
- **换回来的**：自理——不再怕"药越吃越多，没人帮我理一遍"
- **在中国怎么落地**：把这张单子带去社区家庭医生、医院老年科，或药店的药师处做一次"用药核对"；在社区管理高血压、糖尿病的人，随访时正好让医生一起看。

5.11 摔了先别急着扶，这三种情况必须打 120

- **要花多少**：判断那几秒（钱：不用花｜工夫：几分钟｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：看见人摔倒，第一反应是赶紧拉起来——这一下可能把骨折错位，把脑出血加重。先看、先问，再决定扶不扶。
- **可以怎么做**：
- **先判断**：叫两声看有没有反应，看呼吸、看有没有出血、手脚有没有歪、是不是喊疼。
- **这三种情况必须打 120，不要自己扶**：① 意识不清、叫不醒，或呕吐、说话含糊、口角歪、半边手脚没力气（可能是脑卒中）；② 明显剧痛、肢体变形缩短、髋部或腰背疼得动不了（可能是骨折）；③ 头部着地后头痛、犯迷糊，或大小便失禁。
- **意识清醒、判断没大碍**：慢慢扶到坐，观察一会儿，别猛地拉。
- **自己摔了**：先动动手指脚趾，看能不能自己起。能起，先翻成趴着的姿势，抓住床边、椅子腿这些结实的支撑物，慢慢撑起来，坐下歇一会儿。起不来就别硬撑：喊人、打电话、敲地板，用垫子衣物保暖，等人来。
- **无论伤没伤**：都要告诉家人和医生，去查一次摔倒的原因。摔过一次的人，再摔的风险更大。
- **来源**：A｜这是中国卫生部《老年人跌倒干预技术指南》（2011 年）和中国疾控中心核心信息都写明的处理流程（官方口径）。
- 特别提醒：**对谁成立**——所有人。独居的人，把"急救一件事"提前写在一张纸上贴在墙上：120、社区电话、最近的子女电话。
- **换回来的**：自理＋关系——不再怕"摔了没人知道，或者被人乱扶"
- **在中国怎么落地**：打 120；有签约家庭医生的，平时把电话存好。处理流程见中国疾控中心慢病中心《预防老年人跌倒健康教育核心信息》第 12、13 条。

5.12 防跌倒要查的四样：视力、血压、用药、骨质

- **要花多少**：一次门诊（钱：挂号加检查｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：防跌倒不是一件事，是几件事一起看。你带着一张清单去，医生就不会漏。
- **可以怎么做**：把这张清单交给医生，请他逐项过。
- **视力**：查视力，查白内障，问眼镜还合不合适。夜里看不清、看东西发花要专门说。
- **血压**：测躺着和站起来两个姿势的血压，看有没有体位性低血压。

- **用药**：把全部药和保健品带来，做一次用药核对，看有没有"让人更容易摔"的药。
- **步态和平衡**：让医生看你怎么走、能不能从椅子站起，必要时转康复科。
- **骨骼**：评估骨质疏松风险、查骨密度（DXA）。中国有《原发性骨质疏松症诊疗指南（2022）》和《中国老年骨质疏松症诊疗指南（2023）》可循。
- **脚**：看脚，看鞋。
- **再问一句**：家里哪一处最该先改。
- **来源**：A｜这套"先筛查、再评估、后干预"的清单来自国外通行的跌倒评估做法（CDC STEADI），中国核心信息覆盖了同样的方向。
- 特别提醒：**对谁成立**——所有人；半年内摔过、走路不稳、吃多种药的人更该去。一次问不全，分两次也可以。
- **换回来的**：自理——不再怕"不知道从哪儿查起"
- **在中国怎么落地**：门诊挂老年科、康复科或全科；65 岁以上每年有一次免费健康管理，含体格检查（对口腔、视力、听力、运动功能做粗测判断）和防跌倒、骨质疏松的健康指导，具体项目问社区卫生服务中心（国家基本公共卫生服务规范，第三版）。骨密度、康复评估通常要转上级医院。谁来做评估：医生定，家庭医生团队平时随访。

5.13 如果你是在替爸妈看

你最大的难处，常常不是不知道要防跌倒，是怎么让他肯改。

有三件事，不用他点头你就能做：① **先改玄关和卫生间**——他不同意装扶手，你先买一条不显眼的防滑垫、一个换鞋凳，说是"我自己用着方便"；② **把药拍照存档**——陪诊时带上去给医生看，别让他自己跟医生说"我吃的不多"；③ **去社区问一次**——适老化改造怎么申请、65 岁以上免费体检怎么做，先问清楚再决定。

他嘴上可能不认，身体会认。

5.14 本章我不确定的地方

这一章原挂的四个待核，三个已回到源头：跌倒发生率回到《中国公共卫生》原文，因伤害死亡首位回到国家卫生健康委疾控局、中国疾控中心慢病中心的《预防老年人跌倒健康教育核心信息》原文，"能防的那几处"回到民政部等 9 部门民发〔2020〕86 号与广州民政的官方通知。剩下三条是数据本身的边界，不是没查到，如实留下：

- 14.7% 这个跌倒发生率，样本是 2018 年 PINDEC 项目 6 个省市、21 084 人，不是全国概率抽样，和全国数可能有出入。
- 起坐测试的"偏低"参考线来自美国人群（CDC STEADI），中国尚无对应的年龄性别参考值，只能当对照，不当诊断标准。
- 居家适老化改造的补贴金额与项目清单各省市不同（本章举了广州一例），以当地最新通知为准。

一句实话：有些跌倒是拦不住的。年纪越大，平衡、视力、肌肉都在退，再怎么防也可能有一天会摔。这一章能做的，是把**能拦的那些先拦下来**。

5.15 本章数据来源

- 世界卫生组织《Falls》事实清单（2021-04-26）：跌倒的全球负担与预防方向。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls
- 中国疾控中心慢病中心《预防老年人跌倒健康教育核心信息》（国家卫健委疾控局、中国疾控中心慢病中心，2021-10-12）：15 条核心信息与释义。https://ncncd.chinacdc.cn/xzzq/202409/t20240923_311832.htm
- 《中国公共卫生》2021 年《中国社区老年人跌倒及跌倒后受伤情况分析》（中国疾控中心慢病中心，2018 年 PINDEC 数据，6 省市 21 084 人；复杂加权后跌倒发生率 14.7%，受伤者占 79.5%）。在线全文 https://www.zgggws.com/cn/article/doi/10.11847/zgggws1133277 ；PDF https://www.zgggws.com/en/article/pdf/preview/10.11847/zgggws1133277.pdf （2026-10-10 核对）
- 北京市卫健委转载北京世纪坛医院《如何破解髋部骨折——"人生最后一次骨折"魔咒》（2023-12-15）。https://wjw.beijing.gov.cn/bmfw_20143/jkzs/jksh/202312/t20231217_3502093.html
- 卫生部疾病预防控制局《老年人跌倒干预技术指南》（2011-09-06）：跌倒后"不要急于扶起，分情况处理"。
- 美国 CDC STEADI：三问筛查、30 秒椅子起立测试及参考值（60–64 岁男性低于 14 次、女性低于 12 次；70–74 岁男 <12、女 <10；80–84 岁男 <10、女 <9；85–89 岁均 <8）。https://www.cdc.gov/steadi/index.html （测试表 PDF：https://www.cdc.gov/steadi/media/pdfs/STEADI-Assessment-30Sec-508.pdf ）
- 药物与跌倒：中华医学会科普《小心这 5 类药，老人吃了更容易跌倒》（2022-08-22）；清华大学医院《八类药增加老年人跌倒风险》（2016-03-29）；妙佑医疗国际中文《增加老年人跌倒风险的药物》；《中国全科医学》2021 年《老年人跌倒相关药物管理的研究进展》（中山大学附属第一医院）。https://www.chinagp.net/CN/10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.284
- 居家适老化改造：民政部等 9 部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（民发〔2020〕86 号），清单分 7 个基础类与 23 个可选类。中国政府网全文 https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-07/16/content_5527260.htm ；7/23 的分类另见国家卫健委网站《九部门联合发文实施老年人居家适老化改造工程》https://www.nhc.gov.cn/lljks/c100157/202007/862fd063a16e44608bf5ac7a53f9b783.shtml 。广州分档补贴（每户最高 3 000 / 1 500 / 1 000 元）见广州市人民政府门户网站 https://www.gz.gov.cn/zt/qzzggcdcl100zn/fdbnl/gzhsjd/content/post_10216470.html 与广州市民政局公告 https://mzj.gz.gov.cn/dt/gggs/content/post_10217123.html （2026-10-10

核对）。补贴比例另见商务部等 6 部门《关于做好 2025 年家装厨卫"焕新"工作的通知》（居家适老化改造产品补贴不高于 30%）https://www.mofcom.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/ztfl/gnmygl/art/2025/art_d62c61ca9a2e4ab48251ea0760de35d5.html

- 免费体检：国家基本公共卫生服务规范（第三版）"老年人健康管理"；2025 年起 65 岁及以上老年人免费体检增加胸部 DR、糖化血红蛋白（国卫基层发〔2025〕7 号）。
- 重庆市疾控中心《老人跌倒怎么防？重庆干预措施见实效》（2025-06-10）：十二字防跌倒口诀。https://www.cqcdc.org/index.php?a=shows&catid=15&id=4403

5.16 如果你今天只能做一件事

把家里所有的地垫——卫生间门口那条、玄关那条、床边那条——**全部撤出去**。

不是收起来，是撤出这个家。地垫是最常见的一块绊脚石，撤掉不用花一分钱。今晚就做。

第 6 章 · 药不是吃得越多越好

吃药本来是为了少出事。吃到一定数量，它自己开始变成事。

桌子上一排药盒，早上吃的、中午吃的、晚上吃的，还有饭前饭后之分。你有没有数过，到底几样。

6.1 这一章解决什么问题

你的药可能来自几个地方：心内科、内分泌科、社区医院开的，还有自己或子女从药店、直播间、亲戚那里拿的。每个地方只看自己那一摊，没有谁把全部摊在一起看。

这一章就是把散在几个科室、几个来源的药，收到一张纸上，请一个能看全局的人过一遍。

6.2 同时吃到第五种，风险就开始往上走

- **要花多少**：一次门诊的时间（钱：一次挂号的钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：好开口，就是把一堆药带去做给医生看）
- **简单说**：药和药之间会互相影响，吃的种类越多，撞上的机会越大。到第五种，风险就开始往上走。
- **可以怎么做**：把你在吃的东西数一数，药、保健品、中药、外用药都算上。超过五种，就把"请医生把全部用药一起看一遍"排进下一次就诊。
- **来源**：B｜中国老年医学界共识（2024）把同时用 5 种及以上药物定为多重用药，10 种及以上为过度多重用药。共识给的数：我国 60 岁及以上老年患者多重用药率 70.8%，平均每天吃 8.6 种药，不良反应发生率 29%；这批人只占人口 12%，却花掉全人群药费三成以上。【官方口径】
- 特别提醒：**对谁成立**：对正在吃多种慢病药的人成立。只吃一两种、病情稳定的人不必紧张。药多不等于吃错，要问的是每种药现在还需不需要。
- **换回来的**：自理——不再怕"吃药把自己吃出事"

6.3 每次开药，先问四句：好处、风险、替代、不吃会怎样

- **要花多少**：看诊时多问四句（钱：不用花｜工夫：几分钟｜力气：不费｜要开口吗：好开口，问多了医生会不耐烦，但这是你的事）
- **简单说**：英国 NHS 推过一套给病人的问句，缩写成 BRAN：好处、风险、替代、不吃会怎样（Benefit / Risk / Alternatives / Nothing）。它是给"这个检查做不做、这个药吃不吃"这类决定用的，你可以照着念。
- **可以怎么做**：好处——这个药，是帮我防什么事，还是治现在的什么不舒服？风险——吃了它，我要留意哪些不对劲？替代——有没有不吃药的办法，或别的药？不吃会怎样——先不吃、或过一阵再吃，会怎么样？

- **来源**：C｜通行做法。NHS（苏格兰）把它挂在"帮病人问对问题"页，出处为 NHS Inform 和 Choosing Wisely UK。它不是研究结论，是公共卫生机构给的说话框架。
- 特别提醒：**对谁成立**：对还能自己去看诊、能跟医生对话的人成立。替父母问的人，用法见 6.11。这四句不是拿来跟医生顶，是把决定权拿回你自己手里。
- **换回来的**：体面＋自理——不再怕"稀里糊涂被安排"

6.4 吃药吃出的新毛病，别急着当成新病

- **要花多少**：一次复盘（钱：不用花｜工夫：半小时｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：有一种常见错误：药吃出来的不舒服被当成新病，于是又加一种药去治它。这样一层层往上加，叫"处方瀑布"。
- **可以怎么做**：最近新添了一个毛病（脚肿、便秘、头晕、咳嗽、记性差），先想它是不是新加的那一两种药闹的，别默认又得了新病。带着这问题问医生：这会不会是某个药的反应?
- **来源**：B｜机制清楚，有例子，也有人群研究。《Drugs & Aging》2022 年一份共识（ThinkCascades）整理过"处方瀑布"清单。最典型的一个：降压药里的钙通道阻滞剂（如氨氯地平）容易引起脚踝水肿，有人当成"水多"，又开利尿剂去消；2020 年一项人群研究（JAMA Internal Medicine，加拿大安大略，4 万余人）发现，新开这类药的老人随后开利尿剂的比例更高。【第三方研究】
- 特别提醒：**对谁成立**：对最近改过药、又冒出症状的人最该查。如果症状突然、来得重，先当急症处理，别在家自己停药。
- **换回来的**：钱＋自理——不再怕"药越吃越多，越吃越不对劲"

6.5 安眠、抗过敏、止痛、胃药：这几类先翻出来看一遍

- **要花多少**：翻一遍药盒，对着看（钱：不用花｜工夫：十几分钟｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：有几类药，在老人身上格外容易出事，几十年来一直在"老年人该避开"的名单上。这些名单是公开的，你可以自己拿药名去对。
- **可以怎么做**：先看这四类：
- **安眠、镇静**："××西泮"、"××唑仑"，如地西泮、阿普唑仑、艾司唑仑、唑吡坦。美国老年医学会 Beers 标准（2023 版）把这整类列为"避免"；我国《老年人慎用药物指南》也写，不用这类药治失眠、烦躁或谵妄。
- **抗过敏**：第一代抗组胺药，如苯海拉明、氯苯那敏（扑尔敏）、异丙嗪。Beers 2023 也列为"避免"：这药抗胆碱作用强，老人代谢慢，容易引起记性差、口干、便秘，长期累积和跌倒、谵妄、认知下降有关。

- **止痛**：非甾体抗炎药（NSAIDs），如布洛芬、双氯芬酸。Beers 2023 建议不要长期吃，除非没有别的办法、又能同时用胃黏膜保护药。它写：用够 3–6 个月不到 1% 的人出现胃溃疡、出血或穿孔；吃到一年升到约 2%–4%。
- **胃药**：质子泵抑制剂（"拉唑"类）。Beers 2023 建议不要连续用超过 8 周，除非有明确理由（如必须长期吃激素或止痛药、或有重度食管炎）。长期用的顾虑包括肠道感染、肺炎、骨折。
- **来源**：B｜这几条来自公开发布的用药标准，带证据分级，但不是对每个人都一样。除美国 Beers 2023，欧洲有 STOPP/START（2023 版，190 条：133 条 STOPP＋57 条 START），中国有《中国老年人潜在不适当用药判断标准》2024 年版（154 条），可互相参照。【官方口径】
- 特别提醒：**对谁成立**：这几类是"通常该避开或慎用"，不是"一律不许"。哪种药、什么剂量、能不能停，只有了解你全部情况的医生能定。看到名单上的药别自己停，带去问开药的人。
- **换回来的**：自理——不再怕"吃的药里混着不该吃的"

6.6 老年科更常做的是把药减下来

- **要花多少**：一次就诊（钱：一次挂号的钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：别的科室盯着一个病加药；老年科盯着一个人，常做的是反过来的事：把能停的停掉、该减的减下来，叫"处方精简"。
- **可以怎么做**：下一次就诊，主动跟医生说一句："请帮我把所有药一起看一遍，看看哪些还需要吃、哪些可以试着减或停。"带上 6.7 那张清单。别自己减药，有些药（如抗癫痫药、激素、镇静类）突然停会出事。
- **来源**：B｜处方精简有研究支持，但作用温和。有系统综述＋汇总分析发现，在基层做处方精简，能小幅减少用药数量、跌倒和住院（Aging Medicine，2026）。2024 年中国多重用药共识也把"处方精简"和定期评估写成常态工作。
- 特别提醒：**对谁成立**：对多重用药、病情稳定的人。正在急性病、刚出院、病情不稳的人，先把眼前的病稳住，减药往后放。但是，处方精简不是越多越好，停错了药一样出事，所以得在医生手里做。
- **换回来的**：自理＋钱——不再怕"药越吃越多"
- **在中国怎么落地**：见 6.10。

6.7 做一张能带去门诊的用药清单

- **要花多少**：半小时，一张 A4 纸（钱：不用花｜工夫：半小时｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：医生最想知道你全部在吃什么，而你多半说不全。一张纸能解决这件事。

- **可以怎么做**：按这几项写，写完拍一张存手机里，起名"我的药"：药名（写通用名，如"氨氯地平"）；一天几次、一次几片、饭前饭后；为什么吃它（哪个病、谁开的）；哪个医院、哪个科；保健品、中药、外用药、眼药水都别漏；单列一栏"我想问的"：哪个能停、哪个吃了不舒服。
- **来源**：C｜通行做法。2024 年中国多重用药共识写，多重用药的人都该有一份随时更新、完整、看得懂的用药清单，并且每年至少做一次用药咨询。
- 特别提醒：**对谁成立**：对所有在吃药的人成立，尤其是记性开始变差、由子女代为取药的人。清单要标更新日期，换过药就重写一张。
- **换回来的**：体面＋自理——不再怕"说不清自己吃什么，被当成糊涂人"

6.8 银杏加华法林，有人脑出血进了医院

- **要花多少**：翻一眼保健品瓶子（钱：不用花｜工夫：几分钟｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：保健品不是"没作用的糖豆"，也会跟药撞车。有一组已经记录在案的组合，出过事。
- **可以怎么做**：如果你或父母在吃抗凝、抗血小板药（华法林、阿司匹林、氯吡格雷这类），把这几样单独拎出来问医生：银杏叶、丹参、当归、人参、大剂量维生素 E。
- **来源**：B｜有个案报道和机制，没有随机试验。一篇综述（2015）记过一例：一位 78 岁女性，冠状动脉搭桥后一直吃华法林五年，加服银杏叶制剂两个月后出现左侧脑出血，而反映凝血的凝血酶原时间没有明显变化。化验单正常，也挡不住出血。国内也有临床药师报告过华法林并用银杏叶后牙龈出血的病例。机制上，银杏、丹参、当归被认为会增加出血倾向。【第三方研究】
- 特别提醒：**对谁成立**：对正在吃抗凝、抗血小板药的人最要紧。既吃这些保健品又必须吃抗凝药时，别自己停抗凝药，去问开药的医生和药师。
- **换回来的**：自理——不再怕"药和保健品一起吃，吃出内出血"

6.9 八十几岁，血糖血压的目标可以跟医生重新谈

- **要花多少**：一次就诊、一次谈话（钱：一次挂号的钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：年轻时血糖血压压得越低越好；八十几岁、身体又弱时，要不要还压那么低，答案可能反过来。压得过低，低血糖、头晕、跌倒的风险会冒出来。
- **可以怎么做**：把这几句话带给医生："我这个年纪、这个身体情况，血糖和血压定在多少合适？"、"现在这个目标是照一般人定的，还是照我定的？"、"要放宽一点，需要减药吗？"目标值交给医生，别自己改。

- **来源**：B｜有指南支持按身体状态分层、可放宽，但具体数值因人而异。中国老年糖尿病诊疗指南（2024 版）按健康状态把老人分层，对状态差的一组写明可适当放宽血糖目标；中国老年高血压管理指南（2023）也写，合并衰弱的老人可适当放宽开始用降压药的血压水平和目标值。【官方口径】
- 特别提醒：**对谁成立**：对高龄、身体弱、有跌倒或低血糖风险的人最该谈。身体还硬朗、没有这些风险的人，目标可能反而该收紧，也别一听"放宽"就自己减药。
- **换回来的**：自理——不再怕"被一个数字绑住，反被它害"

6.10 在中国怎么落地：社区药师、长处方、家庭医生

- **社区药师与药学门诊**：不少医院开了药学门诊，2024 年也有"老年人多重用药门诊"的操作规范。国家的《关于加快药学服务高质量发展的意见》（国卫医发〔2018〕45 号）要求药学服务向基层下沉。去社区卫生服务中心问：有没有药师能帮我审一次全部用药。
- **慢病长处方**：《长期处方管理规范（试行）》（国卫办医发〔2021〕17 号）写明，长期处方量一般在 4 周内，病情稳定的慢病患者可适当延长，最长不超过 12 周。好处是不必每月往大医院跑；但每过几个月仍该请医生把药重看一遍。
- **家庭医生签约**：国家从 2016 年起推家庭医生签约服务（国医改办发〔2016〕1 号）。签约后，慢病随访、开药、转诊可先找家庭医生。各地服务内容和收费不一样，去住地的社区卫生服务中心问"签约能给我做什么"。
- 这三件事各地细则和医保挂钩办法不同，以当地最新口径为准。

6.11 如果你是在替爸妈看

他可能不肯谈减药，也可能觉得你是在嫌他。有几件你能做的，不用他点头：

- 帮他把清单做出来（6.7），拍照存好；他手上没有，你手机里有一份也好。
- 陪诊时替他问 6.3 那四句，尤其"不吃会怎样"。
- 别替他减药，也别当着他的面把药扔掉。能停哪些，让医生当着他面说。
- 他一旦觉得你把他当成"管不住自己的病人"，反弹更大。把话头交给医生，见第 20 章 20.5。

6.12 如果你今天只能做一件事

把今天吃的所有东西（药、保健品、中药、眼药水）摆在一张桌上，拍张照片，数一数几样，存进手机，起名"我的药"。

下次看病把它给医生看，说一句：**"请帮我一起看一遍，哪些还需要吃。"**

6.13 本章我不确定的地方

- "70.8%"、"8.6 种"、"29%"这三个数，是《老年人多重用药评估与管理中国专家共识（2024）》转引国内研究给出的。我回核到共识原文，但共识所引的原始研究没有逐项拿到，这里按"共识口径"使用。
- 各年版用药标准（Beers 2023、STOPP/START 2023、PIM-China 2024）的条目有差异。本章只挑了四类常见的，不构成完整清单。
- 处方精简能小幅减少跌倒和住院，证据来自一份系统综述＋汇总分析（Aging Medicine, 2026），作用温和、单项效果不大；不同研究结论不完全一致。
- 长处方、家庭医生签约、药学门诊在各城市的执行细则，本章只写国家层面的文件，具体怎么办要问当地。

6.14 本章数据来源

- 《老年人多重用药评估与管理中国专家共识（2024）》，中华医学会老年医学分会（沈杰、高宁舟、郑松柏，通信作者郑松柏）：多重用药定义（≥5 种为多重用药、≥10 种为过度多重用药）、多重用药率 70.8%、日均 8.6 种、不良反应率 29%、药费占比、欧洲不良反应住院数据、芬兰认知损害研究、用药清单与年度用药咨询要求。《中华老年医学杂志》2024;43(3):269–278，DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2024.03.002。链接：https://rs.yiigle.com/cmaid/1497882 （核对 2026-10-10）
- 2023 AGS Beers Criteria®（美国老年医学会）：第一代抗组胺药、苯二氮䓬与"Z 药"、NSAIDs、质子泵抑制剂的"避免"建议，及 NSAIDs 致上消化道溃疡／出血／穿孔比例。J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052–2081，DOI: 10.1111/jgs.18372。可读全文 PDF：https://geriatrictoolkit.missouri.edu/drug/Beers-Criteria-AGS-2023.pdf ；引文页（美国 AHRQ · PSNet）：https://psnet.ahrq.gov/issue/american-geriatrics-society-2023-updated-ags-beers-criteria-potentially-inappropriate （核对 2026-10-10）
- 《老年人慎用药物指南》：避免用苯二氮䓬类治失眠、烦躁、谵妄。《中国老年保健医学》2018 年第 16 卷第 3 期。题录（万方）：https://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail?id=PeriodicalPaper_zglnbjyx201803004&dbid=WF_QK
- STOPP/START criteria version 3（O'Mahony D 等）：共 190 条（133 条 STOPP＋57 条 START）。European Geriatric Medicine, 2023, 14(5):625–632, DOI: 10.1007/s41999-023-00777-y。PMC 全文：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10447584/ （核对 2026-10-10）
- 《中国老年人潜在不适当用药判断标准（2024 年版）》（PIM-China），首都医科大学宣武医院联合中国老年保健医学研究会合理用药与综合评价分会、中国药理学会抗衰老与老年痴呆专业委员会制订；共 154 项条目（100 项药物/类别＋54 项疾病特异性）。原文：Xing X, et al. Int J Clin Pharm. 2025, DOI: 10.1007/s11096-025-01977-1（PubMed 40775482）。解读：《中国老年人潜在不适当用药判断标准（2024 年版）》解读，《药物

不良反应杂志》：https://www.cadrj.com/CN/10.3760/cma.j.cn114015-20250822-00445；《2024 版中国老年人潜在不适当用药（PIM-China）标准》更新解读，《中国全科医学》2026;29(24):3409–3415：https://www.chinagp.net/CN/10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0458 （核对 2026-10-10）

· BRAN：NHS Scotland "Right Decisions"，出处 NHS Inform 与 Choosing Wisely UK（复核 2023-03）。

· 处方瀑布：ThinkCascades（McCarthy LM 等），Drugs & Aging，2022，39(10):829–840，DOI: 10.1007/s40266-022-00964-9；钙通道阻滞剂—袢利尿剂瀑布：Savage RD 等，JAMA Internal Medicine，2020，180(5):643–651。

· 银杏叶与华法林：Chua YT, Ang XL, Zhong XM, Khoo KS. Interaction between warfarin and Chinese herbal medicines. Singapore Med J. 2015;56(1):11–18，DOI: 10.11622/smedj.2015004。PMC 全文：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4325561/（含 78 岁老人服银杏后脑出血个案）（核对 2026-10-10）

· 处方精简效果：Christopher CM 等. Impact of Deprescribing Among Older Adults in Primary Care Settings: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Aging Medicine（Wiley），2026，9(2):214–223，DOI：10.1002/agm2.70075（开放获取）。（核对 2026-10-10）

· 中国老年糖尿病诊疗指南（2024 版），国家老年医学中心、中华医学会老年医学分会、中国老年保健协会糖尿病专业委员会。《中华糖尿病杂志》2024;16(2):147–189，DOI：10.3760/cma.j.cn115791-20240112-00020。链接：https://rs.yiigle.com/cmaid/1492119 （核对 2026-10-10）

· 中国老年高血压管理指南 2023，中国老年医学学会高血压分会、北京高血压防治协会、国家老年疾病临床医学研究中心。《中华高血压杂志》2023 年第 31 卷第 6 期（508 页起），DOI：10.16439/j.issn.1673-7245.2023.06.003。题录（万方）：https://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_gxyzz202306004

· 《长期处方管理规范（试行）》，国卫办医发〔2021〕17 号，国家卫生健康委办公厅、国家医保局办公室，2021-08-10：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/13/content_5631140.htm （核对 2026-10-10）

· 《关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知》，国医改办发〔2016〕1 号，国务院医改办等：https://app.www.gov.cn/govdata/gov/201606/07/382093/article.html （核对 2026-10-10）

· 《关于加快药学服务高质量发展的意见》，国卫医发〔2018〕45 号，国家卫生健康委、国家中医药管理局：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5436829.htm （核对 2026-10-10）

第 7 章 · 吃不下、咽不下、噎住

吃饭这条线上有三盏红灯。前两盏亮得慢：吃不下，是几个月里一点点减下去的；咽不下，是一顿饭比一顿呛。第三盏最快，噎住那一分钟决定生死。

7.1 这一章解决什么问题

三件事，时间尺度和该找的人都不一样。

- **噎住**：几分钟的急救，要动手，现在就该会。
- **咽不下**：吞咽功能的问题，要改吃饭方式，找康复科或吞咽专科。
- **吃不下**：食欲和营养的问题，要查原因（牙、情绪、慢病、药），找营养门诊。

三件事还连成一条线：吃不下、咽不下会把人推向营养不良和肌肉流失。这条线在 7.5、7.6 合上。

7.2 噎住的那一分钟：先看他还能不能咳

全章唯一一件"现在就该会"的事。

噎住了，先分清两种

- **要花多少**：不用花钱。红十字会的市民应急救护培训是免费的。
- **简单说**：卡住气道分两种。**还能咳嗽、还能出声**的，气道没堵死，最管用的"工具"是他自己的咳嗽，别去拍他、别去冲击他，你一动手可能把东西推得更深。
- **可以怎么做**：
- 问："你噎住了吗？"能说话、能有力咳嗽的，站旁边看着，鼓励他用力咳。
- **不能说话、不能咳、不能呼吸**，双手掐脖子（窒息手势），脸发青发紫，这才是要动手的时候。
- 成人（1 岁以上）：**5 次背部拍击 + 5 次腹部冲击，交替做，直到东西出来或他失去反应**。站他身后偏一侧，让他上半身前倾，用手掌根在两肩胛骨之间拍 5 次；没出来，双臂环住他的腰，一手握拳放在肚脐上方、胸骨下端以下，另一手包住，快速向后、向上冲 5 次。
- 他一旦失去意识，停止冲击，放平，打 120，开始心肺复苏。
- **来源**：A｜官方口径：2025 年美国心脏协会与国际复苏联络委员会更新的急救指南把"先拍背、再腹部冲击"定为 1 岁以上固定流程；中国红十字会的培训一直这么教。
- 特别提醒：**对谁成立**，多数体重正常的成人。**孕妇或环不住腰的**改胸部冲击。**一岁以下婴儿**不做腹部冲击，用"5 次拍背 + 5 次压胸"。**已昏迷的**直接做心肺复苏。**看不见的异物别用手指抠**，只会捅得更深。
- **换回来的**：自理＋关系——不再怕"看他噎住，我却不知道怎么办"

- **在中国怎么落地**：见 7.9。

一个人住的，先学会自己救

- **要花多少**：几分钟，一次学会（钱：不用花｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **可以怎么做**：① 自己握拳，拇指侧抵在肚脐上方，另一手包住，快速向上、向内冲；② 或把上腹部压在椅背、桌沿、栏杆上，弯腰一下一下向内、向上顶；③ 同时弄出大响声、拨出电话。
- **来源**：A｜官方口径：权威急救指南含自救法。
- 特别提醒：**对谁成立**，独居、白天一个人吃饭的人尤其。有家人同住的，重点是把上一节教给家人。

7.3 喝水会呛不是小事

呛一下是误吸；呛了之后"没反应"更要命

- **要花多少**：花的是工夫：观察、记录，可能要加一次就诊
- 简单说：**误吸**是食物、水、唾液甚至胃里的东西进了气管。**显性误吸**你听得见：剧烈咳嗽、脸发紫、吃完声音发湿。**隐性误吸**你听不见：东西进了气管，可他咳嗽反射弱，出不来的同时也没动静。安静的误吸更容易拖成肺炎。
- **可以怎么做**：把下面当"误吸信号"，出现一条就留心：吃饭喝水时咳嗽或呛；吃完说话声音发"湿"、发咕噜声；觉得喉咙里"有东西没下去"；不明原因的低热、精神变差、反应变慢、饭量变小；反复的肺部感染。
- **来源**：A｜第三方研究：北京清华长庚医院把"隐性误吸"讲得很清楚，并引一项中国的大型研究——2011 到 2017 年，院内吸入性肺炎大约每 10 万人年 9.4 例。
- 特别提醒：**对谁成立**，高龄、脑卒中或脑外伤后、痴呆、帕金森、慢阻肺、头颈肿瘤放疗后，以及吃镇静类、抗精神病类药物的人。《中国吞咽障碍康复管理指南（2023　版）》写到，脑卒中急性期约 42% 的人有吞咽障碍，脑干病变的可达 80%。

一杯温水就能自查

- **要花多少**：一杯温水，几分钟（钱：不用花）
- **简单说**：床边最常用的筛查叫洼田饮水试验：喝约 30 毫升温水，看能否 5 秒内一次喝完、呛不呛。另有一张问卷 EAT-10。北京协和的医生两样配着用：总分超过 3 分提示可能有吞咽困难，4 分以上该看专科。
- **来源**：B｜第三方研究：两套工具临床常用，但有医生提醒，饮水试验可能"低估"异常，在家测着没事不等于没有隐性误吸。
- 特别提醒：**对谁成立**，意识清醒、能配合喝水的人。已明显呛咳的别反复试，直接去看。

"反复肺炎"和"吃饭呛"要连起来看

- **简单说**：家里人一年里"肺炎"好几次、每次都在吃过东西之后，别只当"体质差"。吞咽障碍是吸入性肺炎最常见的危险因素。广州医科大学附属第一医院的临床报道写到，吸入性肺炎约占老年社区获得性肺炎的 71%。
- **来源**：B｜转引："约占老年社区获得性肺炎的 71%"出自《成人吸入性肺炎诊断和治疗专家建议》（2022），广州医科大学附属第一医院的临床报道转引了它；该建议同时写明，吸入性肺炎在全部社区获得性肺炎中只占约 5%~15%，两个口径差在人群。"反复肺炎要查吞咽"这个方向是通的。
- 特别提醒：**对谁成立**，反复肺部感染的老人。

7.4 人越老越不爱吃肉，不是矫情

是几件事叠在一起。

- **要花多少**：不用花钱。先理解，再谈改。
- **简单说**：
- **味觉嗅觉退了**：闻和尝变钝，对咸最不敏感。菜"没味道"，是他真尝不出来。
- **饱得快**：胃排空变慢，吃一点就胀。年轻人饿了补回来，老人常常补不回来。
- **牙口**：缺牙、假牙不合，嚼不动肉就干脆不碰肉，而肉是补蛋白最直接的东西。
- **情绪**：老人有人一起吃饭时吃得更多；丧偶、孤独、没心思做饭都会让饭量掉。
- **病和药**：抑郁、痴呆，很多慢病和药物都压食欲。
- **来源**：B｜第三方研究：每一条都有机制研究（"老年厌食"已有综述），但哪条占多大比重因人而异。
- 特别提醒：**对谁成立**，从"最近明显吃得少了"出发，对多数家庭成立。饭量短期内突然掉、还伴消瘦的，更可能是病，先就医。
- 一句承认：饭菜都摆着，他也没说不吃，就是一口一口越来越慢。

7.5 营养不良和肌肉流失，会自己拧成一个圈

- **要花多少**：不用花钱（先看懂这个圈）
- **简单说**：一个会自己加速的圈——吃得少、蛋白不够 → 肌肉掉（肌少症）、力气小 → 动得少、更不想吃 → 免疫和咳嗽力气也掉、更易感染住院 → 住院和感染又压食欲，回到第一步。它慢，但一直在转。
- **来源**：A｜第三方研究，数字可查：肌肉从三四十岁起每十年约掉 8%，65 到 80 岁更快；半年掉 5% 到 10% 体重是营养不良的主要信号（官方口径，英国 NHS）；北京协和多中心调查发现 80 岁以上肌少症现患率约 42%（第三方研究，引自《中国老年患者医学营养治疗指南（2026 版）》）。

- 特别提醒：**对谁成立**，体重和饭量的变化，对自己、对父母都成立。动作：给他称体重、记下来、看趋势。
- 一句承认：圈一旦转起来，单靠喊"多吃点"是转不回来的。
- 破圈：吃和动一起动。吃见 7.6，动见第 5 章。
- **换回来的**：自理——不再怕"瘦下去就再也胖不回来"

7.6 咽不下的时候，一日三餐怎么改

原则一句话：**改食物、改姿势、改速度，再把"该看专科"的信号记牢。**

改食物：软、滑、不散，别太稀也别太黏

- **简单说**：好咽的食物密度均匀、不易散、进嘴好移动、不粘黏膜。最容易呛的相反：稀薄液体（白水、清汤）、黏的（年糕、花生酱）、颗粒状（干饭粒、坚果碎）、又干又散（饼干、发糕）、带骨带刺。
- **可以怎么做**：① 菜做成**菜泥、蛋羹、浓汤、果冻状**，比清汤好咽；② **水太稀会呛，用增稠剂调稠**，调成"像稀粥"或"像布丁"，药店和线上能买到；③ **不要用吸管喝水**，送水太快更危险；④ 用杯子喝水时**杯里至少留半杯**，水太少得仰头喝，仰头最容易呛；⑤ 国际上有套通用分级框架（IDDSI），饮品和食物从 0 到 7 分八级。记方向就行：液体越稠越安全，固体越软越安全。
- **来源**：B｜第三方研究：质地改良和增稠是通行做法（协和、江苏大学附属医院科普与吞咽障碍膳食共识都这么写），哪一档最适合他要专业评估定。
- 特别提醒：**对谁成立**，已出现过呛咳的人。只是偶尔呛、还没评估过的，别自己一路调稠到极端，先去问。

改姿势：坐直、低头，别躺别仰头

- **可以怎么做**：① **能坐就坐着吃**，坐直，前倾约 20 度，脖子稍往前低；② **只能躺的**，床头抬高至少 30 度，头前屈，偏瘫侧肩膀垫枕；③ 头可轻微**低头吞咽**，能收窄气管入口；④ 饭后**半小时内**别马上翻身、拍背、吸痰。
- **来源**：B｜第三方研究：姿势管理是吞咽康复的标准做法。
- 特别提醒：**对谁成立**，已出现过呛咳的人。完全卧床的由护理人员按评估摆位。

改速度：小口、慢、咽干净再下一口

- **可以怎么做**：① **一口少**，从很小一勺（几毫升）开始，多了会漏会呛，少了唤不起吞咽；② **咽完再下一口**，每咽一口多做几次"空吞咽"；③ **干稀交替**，咽一口固体再咽一小口水（也要调稠）；④ 吃饭时别说话、别看手机电视。
- **来源**：C｜本书核对（2026-10）：进食训练是康复的通用做法，见北京协和、江大附院科普。

出现这些信号，该去看吞咽专科了

- **简单说**：反复呛咳、吃完声音发湿、反复肺部感染、吃饭时间变长、体重往下掉；自测的洼田或 EAT-10 异常；已因此住过院。出现一条就该去。
- **可以怎么做**：找做吞咽评估的医生——**康复科、老年医学科、耳鼻喉科或神经内科**，以及**言语治疗师**。金标准是吞咽造影和软式喉内镜吞咽功能检查。
- **来源**：A｜官方口径：北京协和、北京清华长庚等医院科普都指向"评估 → 专科"这条路径。
- 特别提醒：**对谁成立**，上面任何一条信号出现的人。

7.7 吃饭这件事的体面

- **要花多少**：不用花钱。要的是换几个做法。
- **简单说**：被喂饭、吃得慢、汤汁掉在衣服上，是很多老人最不想被看见的三件事。伤的不是身体，是体面。一顿饭吃出"我是个没用的人"，他会少吃、少出门、少在人前吃饭，营养更差。
- **可以怎么做**：① 能自己吃的，哪怕慢、哪怕脏，也**让他自己吃**；② 别催、别盯着看、别当众擦他嘴；③ 碗下加吸盘垫、饭菜切小块、汤少一点，把"脏"从源头减少，而不是事后数落；④ 让他自己决定吃什么、吃多少——**"你可以帮我，但要问我。"**（第 20 章）
- **来源**：C｜本书核对（2026-10）：照护经验，没有试验能测"体面值几分"，但它属于四笔账里的"体面"，不能省。
- 特别提醒：**对谁成立**，还能表达意愿的老人尽量让他自己来。完全喂食的，体面落在喂的人身上：手稳、眼不看别处、嘴里别评论。
- **换回来的**：体面——不再怕"在饭桌上被当孩子哄"

7.8 如果你是在替爸妈看

先做三件不用他同意的事：

1. **观察。**一起吃饭时留意他有没有呛、吃完声音变不变、吃多久、肉吃不吃，记在手机里。
2. **记体重。**每月称一次。半年掉 5% 到 10%，就该带去问医生。
3. **自己也学会。**把 7.2 的海姆立克学会——会的人不一定是你父母，但你可能是他们身边唯一会的人。

他不同意改饭菜、不肯看医生时，还是第 20 章那三件：建档、替他问医生、找资源。落到吃饭上，就是把他的呛咳、体重变化、肺炎史整理成一页纸，下次陪诊递给医生。

7.9 在中国怎么落地

先称体重，再挂营养门诊或肌少症门诊

- **简单说**：大医院管营养的是**临床营养科**，管老年人的是**老年医学科**。2024 版《老年人肌少症门诊管理规范中国专家共识》已建议各级医院开设**肌少症门诊**，配人体成分分析仪、握力计，初筛可用一条软尺量小腿围。
- **可以怎么做**：挂号时说清三件事——半年体重掉了多少、吃少了多久、有没有呛咳。医生做筛查评估后，再决定是教你改吃法还是加口服营养补充。不是每家医院都有，大城市三甲更容易找到。
- **来源**：A｜官方口径：《老年人肌少症门诊管理规范中国专家共识（2024 版）》，中华医学会老年医学分会牵头（北京协和医院 2025-08 发布）。

社区食堂、长者饭堂里有什么

- **简单说**：国家从 2023 年起推老年助餐。经国务院同意，民政部等 11 部门印发《积极发展老年助餐服务行动方案》，抽样调查显示 22.1% 的老年人有助餐需求。叫法各地不同：上海叫"社区长者食堂"，广东叫"长者饭堂"，还有助餐点、送餐上门。
- 能吃到什么、花多少：一顿按普通饭菜配，很多地方对高龄、失能、独居老人有**分类补贴**，比外面便宜。上海到 2025 年底建成社区长者食堂 521 家、助餐点 1977 个；广东到 2024 年建成 3600 多家长者饭堂。
- 一个坑：不少食堂靠补贴撑着，补贴一少就容易亏本停业。
- **可以怎么做**：找居委会或街道养老服务中心问三句——这一片有没有助餐点、我这种情况能不能享受补贴、能不能送到家。
- **来源**：A｜官方口径：民政部等 11 部门《积极发展老年助餐服务行动方案》及上海市民政局公开数据。

牙口的问题，先找口腔科

- **简单说**：嚼不动肉，先解决牙，别先解决意志。缺牙补上、假牙调好，饭量常常跟着上来。
- **可以怎么做**：去综合医院的**口腔科**、**口腔医院**或**口腔修复科（做假牙的）**，一些地方有老年口腔门诊。
- 要提前知道：种牙、做假牙多数**自费**，医保一般不管假牙。先去问价、问方案。
- **来源**：C｜本书核对（2026-10）：就诊路径是常识性的；各地医保对口腔（尤其假牙、种牙）的报销口径不同，以当地最新规定为准。

吞咽康复，找康复科和言语治疗师

- **简单说**：管吞咽的康复在**康复科**，对上号的是**言语治疗师**（有的叫吞咽治疗）。目前不是每家医院都有，大城市三甲更容易找到。

7.10 如果你今天只能做一件事

搜"你所在城市 + 红十字会 + 应急救护培训"报一次名。红十字会的市民应急救护培训免费，一次课就够你学会噎住那一分钟该做什么。学完再教给家里另一个人——你可能是他们身边唯一会的人。

7.11 本章我不确定的地方

- 网上流传"65 岁以上约 45%、80 岁以上约 75% 存在吞咽障碍"，只找到医院科普转引，回不到原始调查，本章不采用这些数字。
- "吸入性肺炎约占老年社区获得性肺炎的　　71%"转引自《成人吸入性肺炎诊断和治疗专家建议》（2022），其原始研究未回核；该建议同时给出全部社区获得性肺炎中约 5%~15%，两个口径差在人群。
- 各地医保对口腔（尤其假牙、种牙）的报销口径，以当地最新文件为准。
- 社区食堂的补贴标准、覆盖范围是各地政策且变动快，本章只写到"去哪问"，没写具体金额。

7.12 本章数据来源

急救

- 福州市卫健委《海姆立克急救法更新了》（2026-01-08）：2025 年 AHA 与 ILCOR 更新，先拍背、再腹部冲击，婴儿不用腹部冲击。https://www.fuzhou.gov.cn/zgfzzt/swjw/fzwj/jkkp/202601/t20260108_5268351.htm
- 新华网《海姆立克急救法等同于气道异物急救法吗？》（2024-08）：腹部冲击定位、自救法、腹部冲击可能损伤内脏、胸部冲击可能致肋骨骨折。http://www.xinhuanet.com/science/20240813/2f03f4831e3d467bb5c0f652825e6373/c.html
- 首都医科大学附属北京地坛医院《什么是海姆立克急救法及如何施救？》：海姆立克只适用于气道完全阻塞，能咳嗽的应鼓励咳嗽、不做冲击。https://www.bjdth.com.cn/Html/News/Articles/7531.html
- 云南省弥渡县红十字会《气道异物梗阻怎么办》：V　形手势、轻度鼓励咳嗽、背部叩击与腹部冲击交替、自救手法、不盲目手指清理。https://www.ynredcross.cn/mdx/article.jsp?id=22500&itemId=192
- 沈阳市人民政府《日常需要掌握哪些急救知识技能？》（2025-08）：成人施救操作要点。https://www.shenyang.gov.cn/zwgk/zwdt/bxgz/202508/t20250815_4890516.html
- Mayo Clinic, Choking: First aid（2025-08-25）：背部拍击配合腹部冲击、自救法、孕妇改胸部冲击、昏迷者转心肺复苏。https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-choking/basics/art-20056637

误吸与吸入性肺炎

- 北京清华长庚医院《老人警惕隐性误吸》（2024-06）：隐性误吸的定义、高危人群、表现；引 2011—2017 年中国院内吸入性肺炎约 9.4/10 万人年。https://www.btch.edu.cn/ksdh/jzzb/zzyxk/jkjy_zzyxk/ccc73dffa5124f4ab33770a7d4a15416.htm （核对 2026-10-10）
- 《成人吸入性肺炎诊断和治疗专家建议》，成人吸入性肺炎诊断和治疗专家组（佘君、丁建文、申捷等）：吸入性肺炎约占社区获得性肺炎 5%~15%，约占老年社区获得性肺炎 71%；显性与隐性误吸的定义、危险因素与预防。《国际呼吸杂志》2022;42(2):86–96，DOI: 10.3760/cma.j.cn131368-20211209-00908。全文（转载）：https://www.icu.cn/?p=3552（核对 2026-10-10）
- 广州医科大学附属第一医院《基于呼吸康复救治吸入性肺炎一例》（2022-12）：转引上述"约占老年社区获得性肺炎的 71%"。https://www.rccrc.cn/article/1405
- Cleveland Clinic, Aspiration（2025-03-03）：误吸的定义与症状。https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/aspiration

吞咽困难与质地改良

- 北京协和医院《老年人吞咽功能障碍，怎么应对？》：显性与隐性误吸、EAT-10 与洼田饮水试验、进食体位与食物选择、一口量、吞咽办法。https://www.pumch.cn/detail/32830.html
- Belafsky PC, et al. Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). Ann Otol Rhinol Laryngol. 2008;117(12):919–924，DOI: 10.1177/000348940811701210（PubMed 19140539）：EAT-10 量表来源，以总分 ≥3 分为异常界值。
- 中国吞咽障碍康复管理指南（2023 版），中国康复医学会吞咽障碍康复专业委员会：50 岁以上人群吞咽障碍患病率 5.5%~8%，脑卒中急性期约 42%，脑干病变可达 80%。《中华物理医学与康复杂志》2023;45(12):1057–1072，DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2023.12.001。https://cjpmr.tjh.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2301201057 （核对 2026-10-10）
- 老年性吞咽障碍康复中国专家共识，老年性吞咽障碍康复中国专家共识编写组、中国康复医学会吞咽障碍康复专业委员会：16 项共识，覆盖筛查、评估、中西医康复、营养支持与护理。《中华物理医学与康复杂志》2025;47(12):1057–1065。https://cjpmr.tjh.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2501201057&flag=1 （核对 2026-10-10）
- 江苏大学附属医院《化解老年人的难"咽"之隐，只需这几招》（2023-11）：表现、饮水自测、少用流质与黏性颗粒食物、不使吸管、杯中水至少半杯。https://www.jdfy.cn/changjianbingyufangyubaojian/10826.html
- NHS, Dysphagia（2023-05）：症状、就医时机、转介言语治疗师、增稠。https://www.nhs.uk/conditions/dysphagia/

- Mayo Clinic, Dysphagia - Diagnosis and treatment：吞咽评估与饮食、进食习惯调整。https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dysphagia/diagnosis-treatment/drc-20372033
- IDDSI Framework（2019/2020）：食物与饮品 8 级分级框架。https://iddsi.org/framework/
- ENT Health, Aging and Swallowing（2018）：随年龄的吞咽改变与咀嚼充分、小口进食等建议。https://www.enthealth.org/conditions/aging-and-swallowing/

食欲下降、营养不良与肌肉流失

- Cleveland Clinic, Sarcopenia：每十年约 8% 肌肉流失、65—80 岁加速、并发症。https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23167-sarcopenia
- NHS, Malnutrition（2023-05）：半年掉 5%—10% 体重为营养不良主要信号，65 岁以上高风险。https://www.nhs.uk/conditions/malnutrition/
- Mechanisms of the anorexia of aging—a review（PMC5005824）：味觉嗅觉下降、早饱、胃排空变慢、牙口与假牙、吞咽、抑郁与痴呆、社会与丧偶。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5005824/
- 《中国老年患者医学营养治疗指南（2026 版）》（中华医学会肠外肠内营养学分会等）：老年肌少症蛋白质建议量；引北京协和多中心调查，80 岁以上肌少症现患率约 42%。https://www.nhc.gov.cn/sps/c100087/202604/a69d2fce21e040dc96cbc40b923a06d3.shtml
- 北京协和医院《〈老年人肌少症门诊管理规范中国专家共识〉发布》（2025-08-13）：建议各级医院开设肌少症门诊与评估工具。https://www.pumch.cn/detail/42665.html

老年助餐

- 《积极发展老年助餐服务行动方案》（民发〔2023〕58 号，民政部等 11 部门）。新华网报道 http://www.news.cn/politics/2023-10/24/c_1129933524.htm ； 全文见央视网 https://news.cctv.com/2023/10/23/ARTI9Pyn8KMhwLtucWPgXBGa231023.shtml
- 《〈积极发展老年助餐服务行动方案〉政策解读》：22.1% 的老年人有助餐需求、就餐分类补贴。http://www.nqbgx.gov.cn/nqbgx/zcjd/202405/eb7fe1b1321543019c1390933ad40069.shtml
- 上海市民政局《为 50 家社区长者食堂提质增能》：截至 2025 年底建成社区长者食堂 521 家、助餐点 1977 个。https://mzj.sh.gov.cn/26shitang/index.html

> 说明：本章关键数字都挂了分档（官方口径 / 第三方研究），没有无分档的数字。不写剂量、不做诊断。链接为核对到 2026-10 可打开。

第 8 章 · 三条就医红线与第一小时

半夜三点，你被胸口一阵发闷憋醒，后背开始出冷汗。你躺着想：再等会儿，天亮了去医院。

早上八点，你刷牙时一只手突然抬不起来，杯子掉进水池。

正确做法都是同一句话：现在打 120。

8.1 这一章解决什么问题

这一章不讲病，也不讲怎么治，只解决一件事：**某些症状出现的那几分钟，要不要打 120，电话里怎么说。**

你最好一辈子用不上它。有时候你打了 120、查完没事回家，白跑一趟，这比"再等等"要好。

8.2 拿不准的时候，打 120 不算错

- **要花多少**：一个电话，不用花钱（要开口吗：不用开口）
- **简单说**：下面记不全没关系，记住一句就够：**分不清是不是急症的时候，打 120，让专业的人替你分。** 调度员问几句，要么派车，要么隔着电话教你做。
- **可以怎么做**：把 120 存进手机快捷拨号；把 8.10 那张表贴在电话旁或冰箱上。
- **来源**：A｜国家卫生健康委的急救口径就是"危及生命就拨 120"，不要求你自己先判断准。
- 特别提醒：**对谁成立**——对谁都成立。别拿 120 当出租车（送普通看病、非急症）。
- **换回来的**：自理——不再怕"来不及"

8.3 胸痛超过二十分钟不缓解、还出汗气短，就是打 120 的时候

- **要花多少**：一个电话，不用花钱
- **简单说**：心梗最典型的痛，是胸口正中或偏左的压榨感，往左肩、左臂、下巴或后背放射，同时出冷汗、气短、恶心。国家卫生健康委访谈给的判断线是：这种胸闷胸痛**持续 20 到 30 分钟不缓解**，就要高度怀疑心梗。
- **可以怎么做**：① 立刻停下，就地坐下或半躺，别再走动、爬楼；② 马上打 120，一个人在家顺手通知子女或邻居；③ 确诊冠心病、医生给你备过急救药的人按医嘱用；④ 在屋里等车，别自己开车。
- **来源**：A｜国家卫生健康委在线访谈（2026-09）中阜外医院专家的"三要三不要"；老年人和糖尿病患者心梗症状常不典型、容易延误，是《急性 ST 段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南（2019）》写明的一条（见 8.14）。
- 特别提醒：**对谁成立**——对症状典型的人好用。有糖尿病或高龄的人，胸口可能不怎么疼，只表现为突然气短、一身冷汗、恶心，甚至晕倒，这类更该往急症上想。**别自己找药吃把症状压下去**，那会盖住病因，让医生判错。

- **换回来的**：自理——不再怕"忍着忍着就晚了"
- **在中国怎么落地**：打 120 时说清"胸痛、疼了多久、出不出汗"，调度员会就近安排有胸痛救治能力的医院。

8.4 脸歪、一边胳膊抬不平、说话不清，出现任何一样就打 120

- **要花多少**：一个电话，不用花钱
- **简单说**：中风（脑卒中）有个老百姓记得住的口诀，叫"中风 120"：
- **1** 看一张脸：让他笑一下，看脸是不是一边歪、一边平；
- **2** 查两只胳膊：让他双手平举十秒，看是不是一边往下掉；
- **0** 谐音"聆"，听说话：让他说一句完整的话，看是不是口齿不清、说不出来。 突然一侧手脚发麻、剧烈头痛、走路不稳、看东西不清，也可能是中风。
- **可以怎么做**：① 出现任何一样，立刻打 120；② 记下**症状几点几分开始**，这个时间最有用；③ 让他平躺或侧卧、头偏向一边，解开衣领防呕吐呛到；④ 不喂水喂药，不来回搬动。
- **来源**：A｜"中风 120"经国家卫生健康委在线访谈（2026-09）与中风 120 项目（《柳叶刀·神经病学》2016）背书。
- 特别提醒：**对谁成立**——对所有人成立，包括症状十几分钟后又自己好了的人。这种"好了"往往是"小中风"（短暂性脑缺血发作），是随后重度中风的强烈预警，别因为症状没了就放过。
- **换回来的**：自理——不再怕"以为缓过去就没事"
- **在中国怎么落地**：越早到有溶栓能力的医院越好。静脉溶栓有时间窗：国内现行指南的标准窗口是**发病 4.5 小时内**；一部分经影像筛选的患者可延到发病 4.5–9 小时（见 8.14）。

8.5 叫不醒、答非所问、突然倒地不省人事，就是 120

- **要花多少**：一个电话，不用花钱
- **简单说**：拍他肩膀、大声喊他，看有没有反应。没反应就是意识不清。有的人不是叫不醒，是答非所问，这算另一个红灯。
- **可以怎么做**：① 打 120；② 看他胸口有没有起伏、有没有呼吸。没呼吸，或只有一两口像叹气一样的气（濒死呼吸），马上做心肺复苏：两手交叠按在**两乳头连线中点**，频率**每分钟 100 到 120 次**、深度**5 到 6 厘米**，每次让胸廓充分回弹；③ 会人工呼吸的按 30 次按压配 2 次吹气，不会就一直按压别停，直到救护车到；④ 有 AED（自动体外除颤器）就取来做除颤。
- **来源**：A｜国家卫生健康委在线访谈（2026-09）给出的心肺复苏与呼救口径。
- 特别提醒：**对谁成立**——对"突然"发生的意识不清成立。别把昏迷当"睡着了"，别掐人中、别喂水喂药、别等"缓一缓"，这些都不救急，还可能呛到。
- **换回来的**：自理——不再怕"夜里一个人出事，没人知道"

8.6 摔倒后的第一小时：急着扶起来，常常帮了倒忙

- **要花多少**：先花十分钟观察，再决定（钱：不用花）
- **简单说**：老人摔一跤，最怕骨头断了、脑袋里出血了。"赶紧扶起来"是好心，却可能把没断的搬成断的、把出血搅得更凶。《老年人跌倒干预技术指南》的原话是：**不要急于扶起，要分情况处理。**
- **可以怎么做**：先别动他，问两句话：**"哪儿疼？"、"刚才怎么摔的，还记得吗？"** 然后对号——
- **出现下面任何一样，别自己扶，立刻打 120：**
  - 叫不醒、迷糊、答话不切题、想不起来怎么摔的；
  - 脸歪、说话含糊、一边手脚动不了（可能是中风）；
  - 剧烈头痛、脖子或腰背剧痛、大小便控制不住、腿变形或一动就剧痛（可能是骨折或脊柱伤）；
  - 有出血用干净布就地压住；呕吐就把头偏向一边、清掉嘴里的东西。
- **意识清楚、能对答、没有以上情形**：可以扶他慢慢坐起，歇一会儿、看着。但当天要有人陪他去医院看一次，指南写的是"发生跌倒均应有人陪同到医院诊治"，因为这一摔常常是身体先出的信号（见第 5 章）。
- **来源**：A｜卫生部《老年人跌倒干预技术指南》（2011-09-06）；2026 年国家卫健委又发布行业标准 WS/T 887—2026《社区老年人跌倒预防控制技术标准》。
- 特别提醒：**对谁成立**——对在家摔倒的老年人成立。别一个人硬拖硬抱，该让他尽量平躺、平稳搬动；也别觉得"缓一缓就好了"。还有一条：正在吃抗凝药、抗血小板药的人，哪怕只磕到头、当时清醒，也值得尽快去医院看——这属于"要做头颅 CT"的指征之一（见 8.14）。
- **换回来的**：自理——不再怕"摔了之后再也起不来"
- **在中国怎么落地**：跌倒是我国老年人因伤害死亡的首位原因；家里怎么改，见第 5 章与附录 A。

8.7 噎住的那一分钟，让他自己咳比什么手法都管用

- **要花多少**：几十秒（钱：不用花）
- 简单说：**能咳嗽、能出声的，让他自己咳，别动他**，咳嗽比任何手法都管用。**完全噎住**的人是：喘不上气、发不出声、两手抓脖子、脸憋得发青。
- **可以怎么做**：① 让他上身前倾，用掌根在两肩胛骨之间拍 5 次，一秒一次；② 没用就在他身后做腹部冲击（海姆立克）：一手握拳，另一手包住，放肚脐上方往后上方冲，连做 5 次；③ 两种动作交替，直到东西出来；④ 他失去意识，就放平、开始心肺复苏，同时让旁人打 120。详见第 7 章。
- **来源**：A｜国家卫生健康委在线访谈（2026-09）中北京急救中心专家的气道异物梗阻处置口径。

- 特别提醒：**对谁成立**——对吃饭、吃药噎到的老年人和普通人一样成立。别喂水，别用手指抠（看不见的东西越抠越往里）。
- **换回来的**：自理——不再怕"一口东西噎死人"

8.8 四个最要命的念头，一个都别信

你会这么想	为什么危险	该怎么做
"睡一觉 / 缓一缓就好"	中风症状自己能好，也可能是"小中风"；心梗更不会睡好	症状一出现就打 120
"等一下看看"	心梗、中风的救治按分钟算，等的这段时间就是救不回来的心肌和脑	现在就打
"先吃点药压一压"	乱吃药会盖住症状让医生判错；胸痛也可能不是心梗	药按本人医嘱用，别拿它代替 120
"自己开车 / 骑车去医院"	判断力和体力都在往下掉，路上出事没人救；120 能就近送到有救治能力的医院，路上就开始处理	打 120，让专业的人来

8.9 120 电话里说三样，再顺手通知子女

- **要花多少**：一到两分钟（钱：不用花）
- **简单说**：120　调度员会问好几项，但最先要三样：**地址、病情、电话**。这三样说清了，车就先派出去，剩下的边出车边补。
- 怎么做，照着说：
- **地址**：省市区＋街道小区＋楼号＋单元＋门牌。门牌难找，就说一个明显的参照物。再派一个人到小区门口或路口等，看见救护车挥一下手。
- **病情**：一句话说清年龄、性别、什么症状、从什么时候开始，比如"七十岁，男的，胸口疼了半个钟头，直冒冷汗"。
- **电话**：留一个**在现场**的号码，别只留你在外地的手机。异地打　120，最容易错的就是这一条。 别急着挂，等调度员确认完再挂，电话保持通畅。
- 要不要同时通知子女：要。打 120 和叫子女不冲突，是顺手一个电话。子女能赶来接应、带上医保卡和用药记录。
- 特别提醒：**对谁成立**——顺序是先打 120，再通知子女。别"等子女来了再决定"，那是最慢的等法。一个人在家又已经说不出话时，能用手机的 SOS 就用，或者拍门、敲暖气管、给邻居打电话。
- **换回来的**：自理＋关系——不再怕"出事时说不清、没人搭手"

8.10 把这一页打印出来，贴在电话旁边

（这是附录 E 的正文版。）

看到什么	判断	做什么
胸口压榨样痛，往左肩、手臂、下巴放射，伴出汗、气短，20–30 分钟不缓解	疑心梗	停、坐或躺，打 120，别自己开车
脸一边歪／双臂平举一边掉／说话不清；或突然一侧发麻、剧烈头痛、走不稳	疑中风	记下几点几分开始，打 120，侧卧防呛，不喂水不搬动
叫不醒、答非所问、突然倒地	意识不清	看呼吸；没呼吸就心肺复苏；打 120
摔后叫不醒／答不切题／脸歪／剧烈头痛／腰背剧痛／大小便失禁／腿变形动不了	疑骨折或颅内问题	别扶、别搬，打 120；出血就地按压
说不出话、抓着脖子、脸发青	完全噎住	拍背 5 次 ↔ 腹部冲击 5 次；意识丧失就心肺复苏＋120
喘不上气、呼吸极度困难	呼吸出大问题	打 120，别等
大出血，血止不住地往外流	失血	打 120
抽搐（抽风）停不下来，或一次接一次	脑子在出急事	打 120
误服了药物或不明的东西	中毒风险	打 120，别等它缓
尿裤子／忘关火／一次头疼／一次心慌，人清醒、很快好	不一定是急症	记下来，找医生慢慢看，不必打 120

最后四样前面小节没单列，一样要命：**喘不上气、呼吸极度困难**——气不够用，拖几分钟就可能撑不住；**大出血、血止不住地往外流**——血一直在流失，人很快撑不住；**抽搐（抽风）停不下来、或一次接一次**——抽个不停，是脑子在出急事；**误服了药物或不明的东西**——吃错的不知道是什么，越等越麻烦，别等人慢慢缓。看到任何一样，只做一件事：**打 120**，把"什么症状、从什么时候开始"说清。

两条写不进表、但更要紧的规矩：**① 拿不准，就打 120。② 先打 120，再通知人。**

打印出来，填好，贴在电话旁：

> 我家最近的胸痛中心／卒中中心：_ **社区或家庭医生电话：**_ 子女电话：_ **邻居电话：**_

8.11 如果你是在替爸妈看

把 8.10 那张表打印得大一点，贴在爸妈家电话边上，填上地址、社区电话、你和兄弟姐妹的号码。替爸妈打 120 时，你手里的药单、病史、医保类型最有用（第 0、19 章）。

8.12 如果你今天只能做一件事

把这章判断表最上面的三行拍张照，存进手机相册、置顶；再把 120 加进手机快捷拨号。

今天不用记住全部。真到那天，你需要想起的只是：**打 120，别自己开车，记下几点几分。**

8.13 本章我不确定的地方

- 溶栓的时间窗会随治疗方式更新（现在多了"影像筛选后延长时间窗"这一档）。本章按《中国急性缺血性卒中诊治指南 2023》写"发病 4.5 小时内为标准、经影像筛选可到 4.5–9 小时"；具体怎么做，以你就诊医院当天的指南和流程为准。
- 抗凝药、抗血小板药人群跌倒后怎么评估、什么时候做 CT，本章只写到"尽快就医"，具体处置交给急诊和神经外科，正文不代为决定。

8.14 本章数据来源

- A国家卫生健康委员会在线访谈《普及急救知识技能 共筑生命安全防线》（2026-09-29）：120 拨打要点、胸痛、卒中、心肺复苏、气道异物梗阻。https://www.nhc.gov.cn/wjw/zxft/hdjl_zxft_detail.shtml?id=e49e3059afcf4a179f552df29219a610 （2026-10 打开核对）
- A中国疾病预防控制中心《时间就是心肌，时间就是生命》（2024-11-20）。https://www.chinacdc.cn/jkkp/mxfcrb/xxg/202411/t20241120_302729.html
- A卫生部疾病预防控制局《老年人跌倒干预技术指南》（2011-09-06）。http://www.guinan.gov.cn/lnb/zc1__zwgk/zc/aztfl/qt/content_27609778
- A中风 120 项目（赵静、刘仁玉，《柳叶刀·神经病学》2016）。http://stroke120.org/whatis/
- A国家卫健委行业标准 WS/T 887—2026《社区老年人跌倒预防控制技术标准》。https://ncncd.chinacdc.cn/hydt/202603/t20260323_315822.htm
- A中华医学会神经病学分会、中华医学会神经病学分会脑血管病学组《中国急性缺血性卒中诊治指南 2023》，《中华神经科杂志》2024，57(6)：523-559，DOI:10.3760/cma.j.cn113694-20240410-00221：静脉溶栓时间窗（发病 4.5 h 内为标准时间窗；末次正常时间 4.5–9 h 者经多模影像筛选可考虑）。https://rs.yiigle.com/cmaid/1504708 ；可全文下载的版本：https://medtion-image.medtion.com/uploads/1/file/public/202407/20240708171733_qjshk1vc0j.pdf （2026-10-10 打开核对）
- A中华医学会心血管病学分会、中华心血管病杂志编辑委员会《急性 ST 段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南（2019）》，《中华心血管病杂志》2019，47(10)：766-783：老年患者症状往往不典型、易误诊或延误；合并糖尿病者非典型胸痛发生率高。https://seleguide.yiigle.com/uploads/guide_html/急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南（2019）.html （2026-10-10 打开核对）
- A中国医师协会急诊医师分会等《成人创伤性颅脑损伤院前与急诊诊治中国专家共识》（《解放军医学杂志》2025 网络首发）：轻型颅脑损伤行头颅 CT 的指征包含"正在接受抗凝、抗血小板治疗"；抗凝/抗血小板用药史应在急诊评估。https://medtion-image.medtion.com/uploads/1/file/public/202503/20250312144833_pc1vfaw79s.pdf （2026-10-10 打开核对）

· B拨打 120 报地址与病情：烟台市人民政府《如何正确拨打 120 急救电话》（2022-09-13）。https://www.yantai.gov.cn/art/2022/9/13/art_67475_3018538.html

篇三 · 难以启齿与日常保养〔阶段二·续〕

第 9 章 · 记不住：从健忘到痴呆有多远

你攥着钥匙，满屋子找钥匙。找到了，是自己放错了地方。这样的事，四十岁的人有，八十岁的人也有。

你妈可能也有过。不一样的是，她把饭煮糊，把一句话说一半停在半空，把刚放下的东西再也想不起来。你心里那句话不敢问出口：这是老了，还是病了。

这一章不回答"她是不是痴呆了"。它只回答一件事：**什么时候，该去查。**

9.1 这一章解决什么问题

正常的老，和痴呆，中间隔着很宽的一段。钥匙忘了放哪儿，几乎人人都有；忘了钥匙干什么用、打不开自己家的门，是另一回事。

一头把一切都当"老了，正常"扛过去，会错过还能干预的那几年；另一头网上搜两下，把自己吓成病人。这个病目前还没有能把它治回去的药，所以这一章只给一把尺子。

9.2 忘钥匙放哪儿，和忘了钥匙怎么用，是两码事

- **要花多少**：不用花钱，用眼睛和记性（钱：不用花｜工夫：平时｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：记性和功能是两样东西。正常的老，忘的是"事"：钥匙搁哪、刚才想说什么，一提醒就想起来了。痴呆啃的是"功能"：不会用钥匙开门、不会打电话、算不清买菜该找多少钱，提醒了也回不来。
- **可以怎么做**：拿这三条去对，对上的越多，越值得去查。① 事还是功能：忘的是"事"（能补上），还是"功能"（会做的事做不了了），这条是分界线；② 反复：同一句话问好几遍，同一个故事讲好几遍，咬定东西被人拿走了；③ 人变了：爱热闹的不出门了，话越来越少，变得多疑、爱发火。
- **来源**：B｜痴呆和普通忘事的分界是"影响到日常生活"；临床上，轻度认知障碍的判据是复杂点的日常事（理财、购物、出门办事）出错，但吃饭、洗澡、上厕所还做得下来【第三方研究】。
- 特别提醒：**对谁成立**：对能自己走动、还在一起生活的老人成立。轮椅使用者、长期卧床的人，"功能"这条线不一样，判断重点要换。
- **换回来的**：自理——不再怕"还分得清，就是不敢往坏处想"
- **在中国怎么落地**：这三条在家就能对，不用任何设备；对不上但心里还是不安，按 9.6 挂一次门诊。

9.3 最早发现不对劲的，通常是家里人，不是量表

- **要花多少**：平时的留意，加一张写得下的纸（钱：不用花｜工夫：每次几分钟｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：当面问"你是不是记性差了"，多半问不出真话。他要么不承认，要么自己也说不清。最先看出不对劲的，是天天跟他一起过日子的人。
- **可以怎么做**：别记一句"记性差"，记三样具体的：① 以前会、现在做不了的事（还记不记得缴费、会不会用洗衣机、能不能自己挂号）；② 反复（同一句问几遍、同一个故事讲几遍）；③ 人变了（爱热闹的不出来了，话越来越少）。每条都写：什么时候开始、多久一次、谁发现的。这页纸是给医生当线索的。
- **来源**：B｜2018 年中国指南把"患者或知情者报告"写进轻度认知障碍的诊断标准（A 级推荐）；给知情者填的量表（IQCODE）区分正常老人和轻度认知障碍，准确率约 79.9%【第三方研究】。
- 特别提醒：**对谁成立**：对还在一起生活的老人和家属成立。**独居的人**，最早发现的往往不是家里人，而是社区随访、邻居，或者一次意外（摔了、走失）。
- **换回来的**：自理——不再怕"等我发现，已经晚了"
- **在中国怎么落地**：把这三条写成一页，下次陪诊交给医生，比临场说一句"我妈记性差"强。

9.4 "这是老了，正常"，挡掉的可能是一批能治的病

- **要花多少**：一次门诊，加几管血（钱：一次挂号的钱｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：有一批原因造成的"像痴呆"，把原因去掉，人是可能好过来的。你把它当"老了"，就永远没机会查。
- **可以怎么做**：把这张单子带过去，问医生"这些查了吗"。
- **甲状腺功能减退**：怕冷、反应慢。
- **维生素 B12 或叶酸缺乏**：常伴贫血、舌头疼、手脚发麻。
- **血糖、电解质（钠、钙）异常**。
- **抑郁**：情绪低的人，记性和反应一起往下掉；抑郁治好了，认知常跟着回来。
- **感染、肝肾功能异常**。
- **药物副作用**：安眠药，部分抗过敏药、抗抑郁药、抗精神病药。
- **正常压力脑积水、硬膜下血肿**：摔过头之后慢慢变糊涂，要想到这两个。
- **来源**：B｜专业手册和临床指南都把这些列为痴呆样症状里潜在可逆的原因，其中抑郁、甲状腺、B12 缺乏、药物能被治或调整。**但是**，可逆不等于一定可逆：脑退化的病，不会因为加了一片药就掉头。另外，"轻度认知障碍"本身也不都走向痴呆：有的研究里约四分之一到三成的人回到正常认知，但不同研究差别很大【第三方研究】。

- 特别提醒：**对谁成立**：对最近才开始糊涂、变化比较快，或有明确诱因（换了新药、摔过头）的人最该查。几年才慢慢加重、没有诱因的人也别跳过这一步。
- **换回来的**：自理——不再怕"本来能治，被一句'老了'耽误了"
- **在中国怎么落地**：挂号时说"记性变差，想排查能治的原因"，医生一般会开血常规、甲状腺功能、血糖、肝肾功能、维生素 B12，多数在医保里。

9.5 早点查，换来的不是"治好"，是多出来的几年

- **要花多少**：一次评估的时间（钱：挂号加检查｜工夫：半天｜力气：不费）
- **简单说**：早查的价值不在"治好"，在四件具体的事：早知道，能早点用上药、安排照护、把该决定的自己决定。
- **可以怎么做**：① **用药**：早期（轻度认知障碍和轻中度）有些药能帮一点，让功能掉得慢一点，用不用、用哪种由记忆门诊或神经科医生判断；② **非药物**：动起来、管好血压血糖、配上听力和视力、保持社交和用脑，被写进防痴呆的通行做法，作用温和但真的；③ **照护安排**：还清醒时，你能自己决定去不去机构、谁搭把手、家里怎么分工；④ **清点财产与权限**：账户、房子、保险、谁来管钱，趁说得清时理一遍。
- **来源**：B｜世界卫生组织的立场是痴呆无法治愈，但药物和非药物干预能帮着维持生活与功能；公立医院医生也在讲，轻度认知障碍阶段早干预，能推迟发病。**但是**，药对轻度认知障碍本身的疗效有限。
- 特别提醒：**对谁成立**：对还做得动主、说得出话的人成立。已经说不清自己想法的人，这一步只能靠提前做好的文件（意定监护、预立医疗照护计划，见第 21 章）。
- **换回来的**：体面＋钱——不再怕"最后全由别人替我做主"
- **在中国怎么落地**：见 9.10；意定监护与预立医疗照护的写法见第 21 章。

9.6 挂记忆门诊，做四类检查，别把体检套餐当诊断

- **要花多少**：一次到几次门诊（钱：挂号加检查｜工夫：一次半天｜力气：不费）
- **简单说**：记性的事，归记忆门诊、神经内科、老年科、精神（心理）科管。医生把问诊、量表、血液、影像拼在一起判断，不是做一道题就出结论。
- **可以怎么做**：挂对科室，再对号这几类检查。① **问诊和量表**：医生问本人，也问家属，用认知量表打个底，过段时间再测一次看差别；② **血液**：查 9.4 里那些能治的原因；③ **影像**：多半做一次头颅磁共振（MRI），看有没有萎缩、梗死、积水、出血；④ **看情况加**：脑脊液、脑 PET、基因，只在医生认为必要、能改变判断时才做。
- **来源**：B｜2018 年中国指南对首次就诊的轻度认知障碍患者推荐做头颅结构 MRI（A 级推荐），血液检查同 9.4；单用简易量表不够灵敏，蒙特利尔认知评估（MoCA）筛查轻度认知障碍更准【第三方研究】。脑 PET、脑脊液只对病因不明或要调整方案的人做。

- 特别提醒：**对谁成立**：对能配合完成量表的人。已经配合不了的，检查要换方式，重点转到照护。别只做一次量表就下结论：两次之间的对比，比单次的分数更重要。
- **换回来的**：自理——不再怕"不知道从哪儿查起，被体检套餐牵着走"
- **在中国怎么落地**：先问本地有没有记忆门诊（三级医院的神经内科、老年科，部分精神专科医院）。挂号时直接问"记忆门诊"、"认知障碍门诊"。社区那条线见 9.10。

9.7 这三样先别买：脑补品、一滴血、全身 PET-CT

- **要花多少**：几百到几万不等（钱：花钱多｜工夫：一次｜力气：不费）
- **简单说**：一听说"可能要痴呆了"，最贵的东西就开始上门。有三样，价格和它的用处差得最远。
- **脑补品、健脑保健品**：没有哪种保健品被证实能预防痴呆、或让记忆变好。方向对的是动起来、管好慢病、多跟人来往。花钱买的是安心，不是效果。
- **"一滴血查痴呆"**：阿尔茨海默病的血液标志物确实在往前走，2025 年美国监管机构批了第一个辅助诊断用的血液检测【官方口径】；但它的位置是有记忆症状的人、用来帮着判断，**不是给没症状的人做体检筛查**。没症状的人花这个钱，可能只是拿一个"阳性"把自己吓半年。
- **全身 PET-CT**：它不是体检项目。用于健康人的全身 PET-CT，辐射大，对早期癌症的检出也有限。国家卫健委把健康体检的基本项目列成了一张短清单，全身 PET-CT 不在里面；加深的检查只留给有风险的人。在癌症筛查方案里，官方写得更直接："不推荐使用胸部X线检查、MRI检查、PET-CT检查、生物标志物检测等进行肺癌筛查"。怀疑痴呆要做的脑部 PET，是医生为判断病因做的，和"全身查癌大套餐"是两件事。
- **来源**：C｜这几条是"照证据和官方口径，别乱花钱"的整理，不是说某项检查没用。有症状时的检查各有各的位置，由医生定。
- 特别提醒：**对谁成立**：对想"花钱买个放心"的家庭最该看。真出了症状，走记忆门诊，别走体检中心和保健品直播间。
- **换回来的**：钱——不再怕"花了大钱，买回一个假安心"
- **在中国怎么落地**：拒的原话可以是："这个检查是医生给我开的吗？不是的话我先不做，回去问记忆门诊。"

9.8 确诊之后，第一年给家属一张年历

- **要花多少**：时间，加一份清单（钱：视情况｜工夫：一年里陆续办｜力气：有点累｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：确诊那天最慌，但真正要做的事可以按顺序排下来。前三个月先办三件。
- **可以怎么做**：

- **前三个月**：① **建两个档**：医学档（诊断、用药、量表结果、主治医生和电话、检查单），家庭档（身份证、医保、退休金、保险、银行卡、房产证）；② **趁清醒定两件事**：谁在你不清醒时替你说话（意定监护，去公证处办），要不要哪些抢救（预立医疗照护计划，见第 21 章）；③ **家里改四处**：防走失的门锁或定位、燃气灶定时或报警、卫生间和床边的扶手、把危险的东西收起来。
- **第一年陆续办**：**照护安排**（白天谁管、夜里谁管，能不能用社区日间照料、短期托养喘口气）；**钱**（问清长期护理保险能不能报、能不能办残疾人证领两项补贴，见 9.10）；**照护者支持**（照护的人更容易垮，要安排轮班和喘息）；**往下想**（开车、用火、独自出门、大额转账）。
- **来源**：B｜照护、监护、喘息、长期护理保险这些，都被写进了国家层面的应对痴呆行动计划；具体到你能领什么、怎么申请，各地不一样。
- 特别提醒：**对谁成立**：对刚确诊、还在早中期的人成立。已经没法自理的，重点从"安排"转到"具体照护"（见第 22 章）。
- **换回来的**：体面＋关系——不再怕"一确诊，全家就乱了套"
- **在中国怎么落地**：见 9.10。

9.9 这一章讲"什么时候去查"，第 8 章讲"现在就打 120"

- **要花多少**：想清楚那几秒（钱：不用花｜工夫：几分钟｜力气：不费）
- **简单说**：记性变差、慢慢忘事，是门诊的事。但有几样是急的，出现就别等门诊：几小时到一两天里突然变糊涂、认不清人、说胡话；突然说不清话、一边身子没劲；发烧后、摔了头之后糊涂。
- **可以怎么做**：一句话记住：**几小时、几天里突然变的糊涂，是急症；几个月、几年里慢慢变的忘事，是门诊。** 拿不准就打 120。
- **来源**：B｜突然变糊涂多由感染、缺水、乱用药引起，本来就有痴呆的人更容易发生。
- 特别提醒：**对谁成立**：对所有老人成立。独居的人这几样没人看见，更要把 8.10 那张表贴在电话旁。
- **换回来的**：自理——不再怕"该等门诊的去了急诊，该打 120 的却在等门诊"

9.10 在中国怎么落地：记忆门诊、社区筛查、残疾评定

- **记忆门诊**。国家在推记忆门诊和认知障碍诊疗专科（县级及以上综合医院起步），把筛查、诊疗、康复、随访连成一条线【官方口径】（《应对老年期痴呆国家行动计划》，国卫老龄发〔2024〕42 号）。到 2024 年 5 月，全国已建成各级认知中心 602 家，其中记忆障碍防治中心 298 家【官方口径】。挂号就找"记忆门诊"、"认知障碍门诊"；没这个门诊名的，挂神经内科或老年科，说一句"记性变差，想做认知评估"。

- **社区这一关**。65 岁以上的老年人本来就有一次免费的健康管理，认知功能初筛正在往这上面并：社区先筛，异常的建议到上级医院做进一步评估【官方口径】（同上）。去社区卫生服务中心问一句"老年人认知功能筛查做不做、怎么做"。
- **残疾评定与补贴**。痴呆到了影响日常的程度，可以申请残疾人证（智力残疾或精神残疾类）：到户籍所在地的县区残联或街道（乡镇）申请，领《残疾评定表》，到指定医院的精神科（鉴定）科评定，评完公示、制证，一般要法定监护人代办。够条件的可以申领"残疾人两项补贴"（困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴），重度的护理补贴一般不看家庭收入，有条件的地区把三、四级智力、精神残疾也纳了进来，线上可申请【官方口径】（国家政务服务平台"弱有所扶"专区）。
- **去哪问**：户籍地的社区或街道残联、区县民政局、医保局，加上你常去医院的记忆门诊。**具体标准以当地最新口径为准。**

9.11 如果你今天只能做一件事

把你担心的那个人，按 9.2 那条线对一遍：他忘的是"事"，还是"功能"。

如果分不清，或者已经落到"功能"那一侧，就做一件事：下一次挂号，别挂体检，挂记忆门诊或神经内科，进门说这句话：

> "他（我）最近记性变差，我想查一下有没有能治的原因。"

9.12 如果你是在替爸妈看

这句话怎么跟他说出口。 别说"我怀疑你痴呆了"，这句一出口就吵起来。改说你自己："我最近老忘事，想去做个检查，你陪我去，咱俩一起测一下。"把他放在"陪"和"一起"的位置上。约好了就直接去医院，别在饭桌上先辩论一场。

他不同意，你还能做什么（不用他点头）。 ① 先建档：医学档、家庭档各一份，你手上留一份；② 观察记录按 9.3 记三个月，下次别的不说，先把这页纸给医生；③ 先自己单独跟医生聊一次，问清"如果他来，要怎么查"；④ 家里先把火、门、地那几处危险的改掉。

他要的常常不是不去，是怕被盖一个"痴呆"的章。等他哪天自己觉得不对了，你给他留着这道门。

9.13 本章我不确定的地方

- 阿尔茨海默病血液标志物（"一滴血"类检测）在国内门诊的实际适用范围、是否自费、收费多少，近年变化很快；本章只写了已核到的那一条口径——它的位置是有症状的人用来帮着判断，不是给没症状的人做常规筛查。具体到某家医院怎么做，问记忆门诊。
- 各地残疾人证（智力、精神类）的评定流程、两项补贴的标准与扩围范围，本章举的是国家层面口径，落地各不相同，要问户籍地残联、民政和医保局。

- 社区卫生服务中心认知初筛的实际落实进度，各地快慢不一；国家行动计划定的目标是到 2030 年。

9.14 本章数据来源

- 【官方口径】世界卫生组织《痴呆症》事实清单（中文版，2026-07-03 更新）：痴呆的全球负担、体征与症状、治疗与护理、风险因素与预防。https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/dementia （2026-10 核对）
- 【官方口径】国家卫生健康委等 15 部门《应对老年期痴呆国家行动计划（2024—2030 年）》，国卫老龄发〔2024〕42 号，2024-12-31 印发、2025-01-03 公开：认知筛查与早期干预、记忆门诊、规范化诊疗、照护、监护、长期护理保险。https://www.nhc.gov.cn/lljks/c100158/202501/4b4476877f21467fbfcea71bc90d8313.shtml （2026-10 核对）
- 【第三方研究】《2018 中国痴呆与认知障碍诊治指南(五)：轻度认知障碍的诊断与治疗》，中华医学杂志 2018;98(17):1294-1301，DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.17.003：轻度认知障碍诊断标准、知情者报告与 IQCODE、神经心理评估（MMSE、MoCA）、血液与影像检查、可治病因、银杏叶制剂不能阻止轻度认知障碍转化为痴呆。https://seleguide.yiigle.com/uploads/guide_html/2018中国痴呆与认知障碍诊治指南(五)：轻度认知障碍的诊断与治疗.html （2026-10 核对）
- 【第三方研究】MSD 诊疗手册专业版《痴呆》（作者 Juebin Huang, MD, PhD；2025-02 评审、2026-01 更新）：可逆性病因（甲状腺功能减退、维生素 B12 缺乏、正常压力脑积水、硬膜下血肿、药物、抑郁）、年龄相关记忆障碍与痴呆的区分、约 50% 的轻度认知障碍 3 年内发展为痴呆。https://www.msdmanuals.cn/professional/neurologic-disorders/delirium-and-dementia/dementia （2026-10 核对）
- 【官方口径】北京协和医院《上新了协和｜北京协和医院老年记忆门诊开诊》，康琳主任访谈（2024-07）：记忆门诊医护联合坐诊、从病理改变到失智约 20–30 年、轻度认知障碍阶段早干预可推迟发病。https://ims.pumch.cn/detail/36735.html （2026-10 核对）
- 【官方口径】国家卫生健康委办公厅《成人健康体检项目推荐指引（2025年版）》，国卫办医政函〔2025〕412 号，2025-10-28：健康体检自测问卷、基本体检项目清单、慢性病风险筛查项目。https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202511/4feaeb6de63e44cb9fd4ac8f579ca279.shtml （2026-10 核对）
- 【官方口径】国家卫生健康委办公厅《肺癌筛查与早诊早治方案（2024年版）》，国卫办医急函〔2024〕281 号，2024-08-27（"筛查方法"）："不推荐使用胸部X线检查、MRI检查、PET-CT检查、生物标志物检测等进行肺癌筛查。" https://wsjkw.hebei.gov.cn/zcfg2/405715.jhtml （河北省卫健委转载，2026-10-10 打开核对）
- 【官方口径】中国认知中心地图（首都医科大学宣武医院牵头的认知障碍疾病专科能力建设项目组，2024-05-29 发布）：全国各级认知中心 602 家——核心高级认知中心 23 家、高级认知中心 281 家、记忆障碍防治中心 298 家，覆盖 31 个省份。https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/kjrd/yyjk_kjrd/202405/t20240529_158585.html （2026-10-10 打开核对）

- 【第三方研究】秦瑶、余红梅等《轻度认知障碍逆转为认知正常的研究进展》，《中国全科医学》2021, 24(27): 3506-3509，DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.500：MCI 认知轨迹高度可变、部分逆转为认知正常；2019 年 XUE 等 Meta 分析发现遗忘型 MCI 总逆转率约 27.57%。https://www.chinagp.net/CN/10.12114/j.issn.1007-9572.2021.00.500（2026-10-10 打开核对）
- 【官方口径】妙佑医疗国际（Mayo Clinic）中文《新型血液检测经 FDA 批准用于诊断阿尔茨海默病》（2026-05 更新）：2025 年美国监管机构批准首个辅助诊断血液检测、准确率超过 90%、不推荐对无症状人群做常规筛查。https://www.mayoclinic.org/zh-hans/diseases-conditions/alzheimers-disease/in-depth/new-blood-tests-alzheimers/art-20585060 （2026-10 核对）
- 【厂商或机构宣称】华大基因《阿尔茨海默病早筛新突破，血浆 p-tau 217 等试剂产品上市》（2025-06-04）：AD 血液标志物试剂上市与厂商口径的性能数据（本章仅作"厂商在推"的举例，不作证据）。https://www.bgi.com/news/2025060501 （2026-10 核对）
- 【官方口径】国家政务服务平台"弱有所扶"办事服务专区：残疾人证办理、残疾人两项补贴全程网办入口。https://gjzwfw.www.gov.cn/col/col881/ （2026-10 核对）
- 【第三方研究】阿尔茨海默病协会（Alzheimer's Association）阶段说明（中文）：从"可能是与年龄相关的正常变化"到"家人开始注意到症状"的各阶段线索。https://www.alz.org/asian/about/stages.asp?nL=ZH&dL=ZH （2026-10 核对）

第 10 章 · 尿、便与体面

出门那天，你先在心里算了一遍：从家到医院，路上有几个厕所，哪个能进去。

算完，把远门推到了下个月。这一章，写给这个"推"。

10.1 这一章解决什么问题

尿和便这两件事，多数人忍着不说。憋着是漏尿、便秘、感染、夜里摔跤的开始。

要说的只有一句：这一类毛病，大多数能改善。忍着才是真的输。

10.2 漏尿分四种，每种都有对应的治法

漏尿不是一种病，是几种毛病共用一个名字。先分清是哪种，治法才对得上（官方口径：中华医学会科学普及部，2024）。

- **压力性**。咳嗽、打喷嚏、大笑、跑跳、提东西时漏，平时不漏。底子是盆底肌松了、尿道支撑不够；女性多和生育、年龄、体重、盆腔器官脱垂有关（官方口径：华中科技大学同济医学院附属协和医院健康教育处方）。
- **急迫性**。突然一股急尿，憋不住，常常没走到厕所就漏。膀胱还没装满就自己收缩，是它太敏感（官方口径：妙佑医疗国际）。
- **溢出性**。膀胱老是排不干净，尿一点点往外渗。常见原因是尿路出口堵了（男性多为前列腺增大），或膀胱的神经、肌肉出了问题（官方口径：妙佑医疗国际）。
- **混合性**。上面两种一起有。以哪种为主，决定先治哪一头（官方口径：中华医学会科学普及部，2024）。

还有一类叫功能性：盆底和膀胱都没大毛病，只是来不及走到厕所，和行动、记性有关，要改的是路和位置（官方口径：妙佑医疗国际）。女性患者里，约六成是压力性，一成是急迫性，三成是混合性（官方口径：中华医学会科学普及部，2024）。

10.3 盆底肌是一块能练的肌肉，男女都长着

- **要花多少**：零到几百元（钱：花点钱｜工夫：每天几分钟｜力气：不费｜要开口吗：好开口，没人看得出来）
- **简单说**：盆底肌像一张吊床，托着膀胱和肠子。它松了，一用力就漏；它有力，门就关得住。跟胳膊腿一样，它能练。

- **可以怎么做**：① 先找到它。假装要憋尿、憋屁，收紧的那块就是。别真在排尿时反复收放去练，那样排不干净、也容易招感染（官方口径：妙佑医疗国际、MSKCC 中文）。② 收紧、保持五秒，再放松五秒；做熟了慢慢拉到十秒。③ 一组十次，每天至少三组，躺着、坐着、站着各一组。④ 咳嗽、打喷嚏、起身、提东西之前，先收一下。⑤ 一般练几周到几个月见效，见效后要一直做，停了会退回去（官方口径：妙佑医疗国际）。
- **来源**：A｜这是国内指南和国际通行的第一线做法：压力性尿失禁首选练它，对急迫性也有帮助（官方口径：协和医院健康教育处方、妙佑医疗国际）。
- 特别提醒：**对谁成立**——能跟着做动作的人。练了没用、或找不到那块肌肉，多半是方法不对或练错了肌肉，别硬练，找盆底康复门诊或康复治疗师看一眼。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"一咳嗽就漏，出门心里没底"
- **在中国怎么落地**：很多医院开了盆底康复门诊或盆底功能障碍门诊，可以直接挂号（官方口径：北京地坛医院、杭州市第一人民医院）。生物反馈、电刺激是辅助手段，做不做由医生定。能不能走医保、能报多少，各省不同：国家层面已分两批把康复项目纳入医保（2010 年 9 项、2016 年新增 20 项），"盆底康复"类多由各省自行增补；看诊前问一句医院医保办或当地医保局（见 10.14）。

10.4 越怕漏越少喝水，是最常见、也最伤的做法

- **要花多少**：一天的习惯调整（钱：不用花｜工夫：一天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：怕漏就少喝水，尿就变浓；浓尿像在刺膀胱，膀胱更敏感，你更想上、更急，于是更怕、更不敢喝。这个圈越勒越紧。
- **可以怎么做**：把这个圈拆掉。
- **喝多少**：多数成年人一天的水大致 1.5 到 2.0 升（官方口径：中国慢性便秘专家共识意见，2019）。分次、小口，别一次灌一大杯。
- **什么时候喝**：白天为主，别为省一次厕所把白天也省了。
- **睡前怎么安排**：睡前两到三小时减少大量喝水；少碰咖啡、浓茶、酒、碳酸饮料和很辣的东西，它们催尿、刺激膀胱（官方口径：三军总医院、妙佑医疗国际）。
- **训练膀胱**：急尿来了先别慌，坐稳、深呼吸，收一收盆底肌，等那股劲过去再走；平时试着把排尿一点点往后延，从延十分钟开始（官方口径：三军总医院、妙佑医疗国际）。
- **来源**：B｜调整饮水与饮品、训练膀胱，是各家指南一致推荐的基础做法；**但是**喝水的量因人而异，有心衰、肾病的人怎么喝必须听自己医生的。
- 特别提醒：**对谁成立**——心肺肾功能正常的人。有心衰、肾病、正在透析的人，喝多少问医生。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"不敢出门，怕半路找不到厕所"
- **在中国怎么落地**：把"喝水和上厕所"记三天，就是一份排尿日记，看门诊带着它，比空口描述有用（官方口径：中华医学会科学普及部，2024）。

10.5 夜里起来尿三次以上，别当成"老了就这样"

- **要花多少**：一次门诊（钱：挂号加检查｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：睡觉时因为尿意醒来、一晚超过两次，就已经算夜尿症（官方口径：妙佑医疗国际）。它不是只能忍的老化现象，背后常有能查、能治的原因。
- **可以怎么做**：找谁、问什么。
- **找谁**：泌尿外科（男女都可以），或老年科；女性也可以看妇科泌尿方向的门诊。
- **请医生查什么**：尿常规（看有没有感染、有没有血）；排尿后膀胱里还剩多少尿；你记了三天的排尿日记；血糖。打呼噜很响、白天犯困、腿脚肿、晚上尿特别多，也要一起说给医生听（官方口径：三军总医院、妙佑医疗国际）。
- **把药带去**：很多常用药会影响排尿，把吃的药列成一张纸，请医生看一遍。
- **来源**：B｜夜尿的原因清单各家一致，但先查什么、按什么顺序查，由医生按你的情况定。
- 特别提醒：**对谁成立**——晚上睡不好、白天没精神的人，以及摔过跤的人。夜里迷迷糊糊起来最容易摔（见第 5 章）。尿里有血、解尿疼、发着烧，别等，尽快去。
- **换回来的**：自理＋关系——不再怕"夜里一个人在家出事"
- **在中国怎么落地**：挂泌尿外科或老年科；有签约家庭医生的，先在社区问一次，再决定去哪一级医院。

10.6 便秘：不说，能一直忍到堵住

- **要花多少**：改习惯零成本，就诊一次门诊（钱：花点钱｜工夫：长期｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：使劲排便，对有心脏病、脑血管病的人是危险动作；拖下去可能粪便嵌塞、肠梗阻。
- **可以怎么做**：
- **先看有没有能改的原因**：吃得精细、纤维少、喝水少、动得少都会加重；很多药也会引起便秘，比如部分抗抑郁药、抗胆碱能药、钙通道阻滞剂、阿片类止痛药（官方口径：慢性便秘基层诊疗指南，2019）。
- **吃和喝**：多吃有纤维的东西，纤维每天大致 25 到 35 克；水每天 1.5 到 2.0 升（官方口径：慢性便秘基层诊疗指南，2019）。纤维要配够水，不然反而更胀。
- **排便习惯**：结肠在早上醒来和饭后最活跃，挑晨起或餐后两小时内去蹲，容易成事；排便时专心，一次别超过十分钟（官方口径：慢性便秘基层诊疗指南，2019）。蹲位比坐位更容易排干净。
- **来源**：A｜饮食、饮水、运动、排便习惯是各家指南一致的基础治疗，放在用药之前（官方口径：中国慢性便秘专家共识意见，2019）。

- 特别提醒：**对谁成立**——大多数功能性便秘的人。出现下面那些信号，就不是改习惯的事了，要尽快就诊。
- **换回来的**：自理——不再怕"使劲排便，怕在厕所里出事"
- **在中国怎么落地**：改习惯四到八周还不好，可以请医生考虑用药；用哪一类、用多久由医生定，别自己长期靠刺激性泻药（官方口径：慢性便秘基层诊疗指南，2019）。

10.7 便秘出现这几个信号，就别拖

- **要花多少**：一次门诊，可能要验大便或做肠镜（钱：要花些钱｜工夫：半天｜力气：有点累｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：绝大多数便秘是功能性的，改习惯加用药能缓解。但有一小部分背后是别的病，早查出来差别很大。
- **可以怎么做**：出现任何一个信号就去看消化科或全科，别自己加泻药。
- 大便带血，或化验大便隐血是阳性；
- 没特意减肥却瘦了，或贫血、明显乏力；
- 肚子疼得越来越重，或自己能摸到肚子里的包块；
- 解不出来又胀又疼，还吐（要想到肠梗阻）。
- **来源**：A｜这些报警信号，以及"四十岁以上初诊建议评估、必要时做肠镜"，是国内指南写明的转诊口径（官方口径：慢性便秘基层诊疗指南，2019）。
- 特别提醒：**对谁成立**——出现上述任何一条的人。没有这些信号、病程又长的人，可以先经验性处理，不必人人做肠镜。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"什么都忍着不说，拖过了能治的时候"
- **在中国怎么落地**：挂消化内科；医生按报警信号决定要不要验大便、拍片或做肠镜。

10.8 卫生间改四样，扶手高度有个章法

- **要花多少**：扶手、坐便椅几十到几百元，装要请人（钱：花点钱｜工夫：几天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：漏尿、夜尿、便秘，最后都落到"能不能安全、体面地用厕所"上。第 5 章讲过卫生间是家里摔得最多的角落，这里补几样和排泄直接相关的。
- **可以怎么做**：① **扶手**：坐便器两侧、离地约 70 厘米处装水平抓杆，另一侧装一根高约 1.4 米的竖向抓杆；抓杆直径 3 到 4 厘米，内侧离墙别小于 4 厘米（官方口径：国家标准《无障碍设计规范》GB 50763-2012）。这套尺寸是公共建筑（无障碍厕所）的标准；用在自家，更贴的是民政部行业标准《老年人居家环境适老化改造通用要求》MZ/T 218—2024——便器旁、淋浴区应设助力扶手，扶手高度按身高、步态定，内侧与墙面的距离不小于 40 毫米。②

坐便器加高，或加一张坐便椅：蹲不下去、起不来的人，坐便椅是解法。③ **起夜一路有灯**：从床到马桶装成一路感应夜灯，不是只装一盏；把路上的地垫撤了。④ 功能性尿失禁的人，床头放一个带盖的床头马桶，来不及走就在跟前解决（官方口径：妙佑医疗国际）。

- **来源**：B｜抓杆尺寸是国标口径，但那是公共建筑的标准；家用要照你的身高和身体来定，装之前让工人拿实物在你身上比高度。
- 特别提醒：**对谁成立**——还能自己或半自己上厕所的人。扶手要打进墙里，找有资质的施工方。完全卧床的人要的是另一套照护。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"半夜上厕所摔一跤"
- **在中国怎么落地**：居家适老化改造的部分项目政府有补贴，去社区居委会或街道养老服务窗口问一句"我这种情况补不补"（民发〔2020〕86 号，详见第 5 章）。

10.9 纸尿裤和护理垫：这不是认输，是一件买回体面的东西

- **要花多少**：按用量，每月几十到几百元（钱：要花些钱｜工夫：随时｜力气：不费｜要开口吗：好开口，用对了没人知道）
- **简单说**：垫着，是为了还敢出门，这跟认不认输没关系。它把"不敢坐、不敢走远、老担心裤子湿"先按住，让日子照常过。
- **可以怎么做**：
- **怎么选**：按漏的量分。偶尔滴一点、还能自己上厕所的人，用薄的护理垫；漏得多、夜里用厚一点的纸尿裤。
- **怎么换**：定时换，别等湿透了再换。湿着捂着，皮肤很快就出问题（官方口径：妙佑医疗国际）。
- **皮肤怎么护**：湿了及时换；温水加毛巾轻擦，别猛搓；擦完晾干再穿；涂一层凡士林之类的护肤膏，把皮肤和尿隔开；别反复冲洗、灌洗（官方口径：妙佑医疗国际）。
- **来源**：C｜这是护理上的通行做法，做法本身没有大样本试验；**但是**皮肤一红、一破，就是该处理的时候。
- 特别提醒：**对谁成立**——所有需要垫的人，尤其是卧床、失智、皮肤薄的人。皮肤已经破溃、感染，要找护士或医生处理。
- **换回来的**：体面——不再怕"身上有味，被人躲着"
- **在中国怎么落地**：医院护理门诊、社区卫生服务中心的护士能教你怎么换和护。长期护理保险主要报"护理服务"：国家统一的《国家长期护理保险服务项目目录（试行）》（医保发〔2025〕24 号）只有生活照护 20 项、医疗护理 16 项共 36 项，成人纸尿裤、护理垫这类"支持性辅助器具"暂不在国家目录内（文件说以后再"研究探索"纳入）。个别城市另有用具补助，能不能报、报多少，问当地医保局（官方口径：国家医保局；待遇各地不同，以当地最新口径为准）。

10.10 性与亲密：被默认消失了的那件事

- **要花多少**：一次开口，可能加一次门诊（钱：一次挂号的钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：难开口，这一件最需要勇气）
- **简单说**：很多人默认到这个年纪就没有这件事了，于是谁也不提。但五十岁往上的人还想过、也还在过，需求不因为年纪大就自动消失（官方口径：中华流行病学杂志，2023）。
- **可以怎么做**：
- **怎么开口**：不用绕弯。一句能用的话是："我想跟你说一件我一直不好意思开口的事。"
- **先分清是什么在挡着**：可能是病（糖尿病、心血管病、卒中、妇科或前列腺的问题）、可能是药（有些降压药、抗抑郁药、治前列腺的药会影响性功能）、可能是做过手术（前列腺、妇科），也可能只是情绪和关系变了（第三方研究：UpToDate《老年人性功能障碍》专题；PMC 综述，2024）。这些里不少能处理，但得先说出来、先查明白。
- **找谁谈**：老年科、泌尿外科或男科、妇科；情绪和关系上的困扰可以找心理科。女性绝经后干涩一类的问题，妇科有对应的处理办法。
- **来源**：C｜"晚年仍有性需求、影响因素可查可谈"是有研究支撑的判断（第三方研究，见来源）；**但是**具体到每个人能怎么处理，没有统一答案，要跟医生一条条对。
- 特别提醒：**对谁成立**——想谈、也愿意为此看一次医生的人。**不想谈，也完全可以**；这件事不解决，不影响你把其他几件做好。
- **换回来的**：关系＋体面——不再怕"被默认不需要了，也不好意思说"
- **在中国怎么落地**：挂老年科、泌尿外科、男科或妇科，直接说"我有这方面的困扰想请你看看"；说不出口就先写在纸上递过去。

10.11 如果你今天只能做一件事

今天就做一组盆底肌训练。

先找到那块肌肉：假装憋住尿、憋住屁，收紧的就是它。然后收紧五秒、放松五秒，连做十次。

不收钱，没人看得出，今天就能开始。找不到那块肌肉，正好说明这件事值得去问一次医生。

10.12 如果你是在替爸妈看

这一整章，你几乎插不上手，因为它是身体的事、也是脸面的事。你能做的有两件。

这话怎么跟他说出口。 别问"你是不是漏尿"，那等于让他认一件难堪的事。换成说自己的："我最近老起夜，去查了查，医生说这事很多人有、也能治。"你先把身段放低，他才可能接话。或者把这一章摊在桌上，比你说十句管用。

他不同意时你还能做什么。 三件不用他点头：① 卫生间先改起来，扶手、夜灯、撤地垫，就说成"我自己用着稳当"；② 买一包护理垫放他房里，说是"备着以防万一"，不逼他用；③ 陪诊时替他把"夜里起几次、喝水怎么样、吃什么药"问给医生。他嘴上不认，身体会认。

10.13 本章我不确定的地方

- 盆底康复类项目（生物反馈、电刺激等）在各地医保的纳入范围和报销口径，各省市不同：国家层面只定了康复项目分批纳入的框架，具体增补由各省定，本章未逐条核实，看诊前问医院医保办或当地医保局。
- 成人纸尿裤、护理垫是否纳入长期护理保险或地方补助，各地不同。国家统一的《国家长期护理保险服务项目目录（试行）》暂不含这类"支持性辅助器具"，个别城市另有用具补助，需问当地医保局。
- 《无障碍设计规范》GB 50763-2012 的抓杆尺寸是公共建筑（无障碍厕所）的标准；本章已补上更贴家用的民政行业标准 MZ/T 218—2024，但家用扶手的最终高度仍要照本人身高和身体来定，并与居家适老化改造（民发〔2020〕86 号）的口径对应。
- "性与亲密"一节的影响因素清单，主要依据 UpToDate 专题提纲和一篇综述，未逐条回原始研究核对。
- 尿失禁"约六成压力性／一成急迫性／三成混合性"是中华医学会科普文的原话（北京协和医院作者、朱兰审核）；基于全国调查的原始研究在中老年女性里给出的比例不同（见 10.14）。人群与年份不同，数字不能直接搬用。

10.14 本章数据来源

- 中华医学会科学普及部《尿失禁，医生会做哪些检查》（作者：北京协和医院娄文佳；审核：朱兰），2024-10-14：尿失禁三型（压力性、急迫性、混合性）与女性患者约 60%／10%／30% 的分型比例、排尿日记的做法。https://www.cma.org.cn/art/2024/10/14/art_4584_59002.html （2026-10 核对）
- 妙佑医疗国际（Mayo Clinic）《尿失禁 - 诊断与治疗》：分型、残余尿量测定的含义、盆底肌运动做法（收紧 5 秒到 10 秒、每天至少三组）、膀胱训练与定时排尿、功能性尿失禁的环境改造、皮肤护理（毛巾清洁、晾干、护肤膏、别频繁灌洗）。https://www.mayoclinic.org/zh-hans/diseases-conditions/urinary-incontinence/diagnosis-treatment/drc-20352814 （2026-10 访问）
- 妙佑医疗国际《膀胱过度活动症 - 症状与病因》：夜尿症定义（每晚醒来排尿超过两次）、尿频（24 小时 8 次以上）、病因清单（卒中等神经系统疾病、糖尿病、前列腺肿大、便秘、绝经期激素变化等）。https://www.mayoclinic.org/zh-hans/diseases-conditions/overactive-bladder/symptoms-causes/syc-20355715 （2026-10 访问）

· 妙佑医疗国际《凯格尔运动：女性指南》：找肌肉的方法、收紧与保持、每天至少三组每组 10 到 15 次、几周到几个月见效、不在排尿时练。https://www.mayoclinic.org/zh-hans/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/kegel-exercises/art-20045283
· 妙佑医疗国际《男性凯格尔运动：了解益处》。https://www.mayoclinic.org/zh-hans/healthy-lifestyle/mens-health/in-depth/kegel-exercises-for-men/art-20045074
· 纪念斯隆凯特琳癌症中心（MSKCC，中文）《男性盆底肌（凯格尔）锻炼》：找肌肉、收紧 5 秒放松 5 秒、重复 10 次、每天至少 3 轮、置管期间不做、有助于控尿与性健康。https://www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/pelvic-floor-muscle-kegel-exercises-males
· 华中科技大学同济医学院附属协和医院《压力性尿失禁健康教育处方》：压力性尿失禁定义、病因（生育、年龄、盆腔器官脱垂、肥胖）、ICI 与 NICE 建议先做非手术治疗、盆底肌训练（Kegel）为首选。https://www.whuh.com/info/18711/57611.htm
· 三军总医院（台湾）泌尿外科《膀胱过动症卫教说明》：不因怕频尿而整天少喝水、睡前 2 到 3 小时减少大量饮水、减少咖啡浓茶酒精碳酸、膀胱训练、夜尿的可能原因。https://wwwv.tsgh.ndmutsgh.edu.tw/unit/10027/35173 （页面更新 2026-10）
· 慢性便秘基层诊疗指南（2019 年，《中华全科医师杂志》2020,19(12):1100-1107）：定义、流行病学、药物与器质性疾病病因、膳食纤维 25 到 35 g/d、水 1.5 到 2.0 L/d、晨起或餐后 2 小时内排便、每次小于 10 分钟、报警信号与转诊、老年人用药以容积性与渗透性泻药为首选。https://cmab.yiigle.com/uploads/guide_html/%E6%85%A2%E6%80%A7%E4%BE%BF%E7%A7%98%E5%9F%BA%E5%B1%82%E8%AF%8A%E7%%20%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E5%85%A8%E7%A7%91%E5%8C%BB%E5%B8%88%E6%9D%82%
· 中国慢性便秘专家共识意见（2019，广州，《中华消化杂志》2019,39(9):577-598）：膳食纤维 20 到 35 g/d、水 1.5 到 2.0 L/d、蹲位排便优于坐位、报警信号（便血、隐血阳性、贫血、消瘦、腹痛、腹部包块）、40 岁以上初诊建议肠镜。https://www.shsma.org.cn/web/weixin/2300
· 国家标准《无障碍设计规范》GB 50763-2012，3.9 节：坐便器两侧距地面 700mm 处设长度不小于 700mm 的水平安全抓杆，另一侧设高 1.40m 的垂直抓杆；安全抓杆直径 30mm 到 40mm，内侧距墙不小于 40mm。（条文转载）https://gf.cabr-fire.com/article-47428.htm
· 【官方口径】民政行业标准《老年人居家环境适老化改造通用要求》MZ/T 218—2024（民政部，2024-06-28 发布、2024-08-01 实施）：5.1.6 安全扶手的安装要求（高度按老年人身高、步态设定；内侧与墙面距离不小于 40 mm）；5.1.11 卫生间（便器旁、淋浴区应设助力扶手）。https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=1CDB1068B00E4AFDE06397BE0A0A4811；（标准全文 PDF）https://lt.cas.cn/zczd/gjzc/202407/P020240731550457473564.pdf （2026-10-10 打开核对）

· 【官方口径】国家医疗保障局《国家长期护理保险服务项目目录（试行）》（医保发〔2025〕24 号，2025-09-18）：服务项目仅含生活照护类 20 项、医疗护理类 16 项，共 36 项；成人纸尿裤、护理垫等支持性辅助器具不在目录内，"研究探索"后再议。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202509/content_7042325.htm （2026-10-10 打开核对）
· 【官方口径】人力资源社会保障部、国家卫生计生委、民政部、财政部、中国残联《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》（人社部发〔2016〕23 号，2016-03-09）：在 2010 年 9 项基础上，将康复综合评定等 20 项医疗康复项目纳入基本医保；各省可据实调整、自行增补。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2016-04/09/content_5650070.htm （2026-10-10 打开核对）
· 【第三方研究】《中国 10 个地区中老年人尿失禁的描述性分析》，《中华流行病学杂志》2024, 45(1)：研究对象平均年龄 65.4 岁；以第七次全国人口普查数据年龄标化后，女性自报尿失禁患病率 25.4%、男性 7.0%；女性单纯压力性/急迫性/混合性尿失禁标化患病率依次为 13.5%/5.8%/6.1%。http://chinaepi.icdc.cn/zhlxbx/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20240102&flag=1 （2026-10-10 打开核对）
· 北京地坛医院《攻克"社交癌"！北京地坛医院开设盆底康复专业门诊》：盆底康复专业门诊、盆底生物反馈及电刺激。https://www.bjdth.com.cn/Html/News/Articles/7107.html
· 北京市卫生健康委员会（来源：首都医科大学附属北京妇产医院）《北京妇产医院妇科微创中心助力尿失禁患者盆底康复》，2025-07-14。https://wjw.beijing.gov.cn/xwzx_20031/jcdt/202507/t20250714_4148378.html
· 杭州市第一人民医院《盆底功能障碍门诊》：主要表现含压力性尿失禁、盆腔脏器脱垂等。https://www.hz-hospital.com/feature/treatment_detail/49?cid=51
· 邹华春、何纳《中老年人群性健康》，《中华流行病学杂志》2023,44(12):1864-1868：50 到 60 岁为生理与社会角色过渡阶段，60 岁及以上仍存在性需求。http://chinaepi.icdc.cn/zhlxbx/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20231203
· NIH/PMC《Sexuality in Older Adults: Comprehensive Strategies for Clinicians and Patient-Centered Care》（2024）：晚年性需求与影响因素（生物、心理、社会）。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11556589/
· UpToDate 专题《老年人性功能障碍》（提纲）：躯体疾病、药物、合并精神疾病、心理社会应激等因素。https://www.uptodate.com/contents/zh-Hans/sexual-dysfunction-in-older-adults
· 国家医疗保障局《关于印发〈国家长期护理保险服务项目目录（试行）〉的通知》政策解读，2025-09-25：长期护理保险制度覆盖 1.9 亿人、支出超过 850 亿元（2025 年 9 月口径）；民政部、全国老龄办《2025 年度国家老龄事业发展公报》（民政部、全国老龄办 2026-07-31 发布；公报全文 PDF）：https://www.cncaprc.gov.cn/u/cms/www/202608/01013057jmzq.pdf 另载：截至 2025 年末医保的长护险参保 3.0854 亿人。https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/9/25/art_196_18377.html

第 11 章 · 睡不着、疼、心里没劲、孤独

夜里三点，你醒了，再也睡不着。腰那儿隐隐地酸，翻个身也躲不开。屋里很静，白天有人问过你"最近怎么样"，你回了句"挺好的"。

这四件事常凑在一起：睡不好、身上疼、提不起劲、身边没人说话。它们最容易被一句话打发掉：忍忍就过去了。

11.1 这一章解决什么问题

睡不好、老疼、心里空、没人说话，单独看每一件都像"老了正常"。它们其实都能干预，而且互相缠着：疼得睡不好，睡不好情绪更低，情绪低更不想出门，不出门更孤单，孤单又让疼和失眠更重。

这一章不劝你"想开点"。它给你几件今天就能做的事，和几个出事时能打过去的电话。这四件事里，有一件不能忍、也不能等，就是 11.8 那一节。

11.2 睡不着，先别急着找安眠药

- **要花多少**：一次门诊；调作息要几周见分（钱：一次挂号的钱｜工夫：几周｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：人越老，深睡越少、夜里醒得越多、早上醒得越早，这是正常的，不是病。要看的不是"睡得短"，是白天有没有被拖垮：没精神、记性差、心里垮。
- **可以怎么做**：① 先分清"睡得短"和"睡不着"，连续几周、每周好几次、白天受影响，才值得当成一件事去查；② 把第 6 章那张"我的药"带上，请医生看有没有正在吃、却在让你犯困或夜里迷糊的药；③ 安眠药能不能用、用哪种、用多久，医生定。老年用药的通行原则是能少一种是一种、从最小的量开始、别长期吃。
- **来源**：B｜中国睡眠研究会 2025 年失眠指南把"老年失眠首选非药物疗法"写成推荐【官方口径】。安眠药能帮你快点睡着，**但是**它在老人身上有白天嗜睡、夜里起夜摔跤的代价，也有人短期在医生手里用是需要的。
- 特别提醒：**对谁成立**：夜里醒得多、白天还撑得住的人，先别当病；白天已经垮、情绪也跟着往下掉的人，要去看。
- **换回来的**：自理——不再怕"靠药睡觉，越睡越糊涂、越睡越容易摔"
- **在中国怎么落地**：挂睡眠门诊，或精神心理科、神经内科。当地有没有睡眠专病门诊，打医院的电话问。

11.3 把起床时间钉死，午睡掐到半小时

- **要花多少**：不花钱，改的是习惯（钱：不用花｜工夫：每天｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）

- **简单说**：睡意靠白天清醒攒出来，作息一乱，晚上就没有困意。白天补觉、躺床上刷手机，都在把晚上的觉拆掉。
- **可以怎么做**：① **起床时间固定**，头天睡多晚，第二天早上都同一时间起，这是最要紧的一条；② 午睡不超过半小时，别在下午三点后睡；③ 上午出门晒二三十分钟太阳，让身体知道现在是白天；④ 下午以后不喝浓茶、咖啡，睡前三小时别吃太饱、别喝酒；⑤ 床只用来睡觉，躺下睡不着就起来坐一会儿，困了再回床。
- **来源**：C｜这几条是失眠认知行为治疗（CBT-I）里的"睡眠卫生、刺激控制、睡眠限制"部分，也是中国 2025 版失眠指南推荐的一线方案组成【官方口径】。**但是**零散地做这几条效果一般，成体系地做（医生或心理治疗师带着）才稳。
- 特别提醒：**对谁成立**：对大多睡不好的人。夜里频繁起夜、白天头昏脚软、睡觉打呼憋气的人，先查这些，别只调作息。
- **换回来的**：自理——不再怕"夜里睁着眼，白天发昏"
- **在中国怎么落地**：不少医院的睡眠门诊、精神心理科能做 CBT-I，也有手机上的自助版本；先问当地医院有没有。

11.4 疼，是他嘴上说"没事"的那种

- **要花多少**：一双眼睛，平时就看得见（钱：不用花｜工夫：平时｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：老人多半不喊疼。他说"没事"，你却能看出来：走路慢了，上下楼要扶，表情绷着，饭量小了，不爱出门了，夜里翻来覆去。
- **可以怎么做**：别问"你哪儿疼"这种笼统的，问具体的：早上起床先动哪儿不舒服、哪个动作最费劲、走路比半年前慢了吗。拿张纸记下什么时候疼、疼多久、什么动作加重。他要说"老毛病，忍忍"，你就说：你把哪儿疼、什么时候疼说清楚，我去问医生，不用你自己扛。
- **来源**：B｜中国 60 岁及以上老人慢性疼痛患病率 35.71%（基于 2008—2015 年 CHARLS 调查，27 859 人），最常见的是腰痛，占 13.09%【第三方研究】。
- 特别提醒：**对谁成立**：对还能说话的老人。突然来的、很尖的、位置固定的疼，或伴着掉体重、夜里疼醒，别当老毛病，去查。突发胸痛、腹痛、腰背剧痛，先看第 8 章。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"疼着还装没事，最后走不动"
- **在中国怎么落地**：见下一条。

11.5 慢性疼痛别自己买止痛药扛

- **要花多少**：一次门诊（钱：一次挂号的钱｜工夫：半天｜力气：有点累，要跑医院｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：疼超过三个月，本身就是要治的病，不是熬出来的命。它是什么原因、能怎么处理，得有人替你分。

- **可以怎么做**：① 把疼的位置、时间、什么动作加重、吃过什么，写成一页纸；② 挂号方向：老年科、疼痛科、康复科，或按部位去相应专科（关节看骨科，神经痛看神经内科或疼痛科）；③ 带着这页纸问医生三句：这疼是什么原因、有哪些办法、下一步什么时候复查；④ 长期吃的止痛药，要让医生定期看，别自己加量。
- **来源**：C｜"慢性疼痛要分原因、综合处理"是通行做法。用哪种办法，医生定。
- 特别提醒：**对谁成立**：对疼了三个月以上、已经影响睡觉和出门的人。长期吃止痛药要防胃和肾的问题，也别拿它当"不用看病"的理由（见第 6 章）。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"疼得不敢动，越疼越不出门"
- **在中国怎么落地**：二级以上医院多有疼痛科；有的城市在社区推疼痛诊疗。想去哪家、有没有疼痛门诊，打医院电话问。

11.6 心里没劲是一种能治的病

- **要花多少**：一次门诊，加几次复诊（钱：挂号加药钱｜工夫：几周｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情，要肯承认心里不好受）
- **简单说**：老了提不起劲、什么都不想干、总说自己没用，常被当成"老了就这样"。它是一种病，能治。老人得这个病，还常常不说难受，而是反复说身上不舒服，查来查去查不出毛病。
- **可以怎么做**：对号这几条：两周以上提不起劲、过去爱做的事不做了、睡不好吃不下、老说"我没用"、"拖累你们"、身上这儿那儿难受却查不出原因。占了好几条，去精神心理科挂一次号。别拿"想开点"当药，也别拿"你哪有那么严重"堵他。
- **来源**：B｜2023 年约 14.75% 的 70 岁及以上成年人患精神障碍，最常见的是焦虑症或抑郁症【官方口径，WHO】；中国 45 岁及以上中老年人抑郁症状检出率 23.61%（2018 年 CFPS 调查，CES-D 量表，以第 80 百分位为界值）【第三方研究】。老年抑郁常以身体不舒服为主诉。
- 特别提醒：**对谁成立**：对持续两周一蹶不振的人。要分清：亲人刚走、受了重大打击后的低落，是正常的，会慢慢缓；一直往里陷、起不来，要看。有自杀念头或暗示，不再等，直接看 11.8。
- **换回来的**：关系＋自理——不再怕"他不是矫情，是病了没人当回事"
- **在中国怎么落地**：见 11.9、11.10。

11.7 孤独本身就是一个医学问题

- **要花多少**：时间和出门那点劲（钱：花不了几个钱｜工夫：每周｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：孤独不只是一种心情，它对身体的害处是真的：生病、变糊涂、早走的可能性都往上走。这跟抽烟一样，能被当成健康风险来管。

- **可以怎么做**：① 先承认它是真的，别拿"人多还嫌烦"堵回去；② 把"有人陪"拆成具体的：每周固定一次出门的约（下棋、遛弯、搭伴买菜），固定一个能说话的人；③ 用现成的地方：社区活动、老年大学、合唱队、社区食堂里搭伴吃饭；④ 独居、老伴刚走的，给自己定一条规矩：每天都有人知道我今天怎么样（一个电话、一次敲门）。
- **来源**：B｜世界卫生组织把社会隔离和孤独列为晚年精神健康问题的关键危险因素，约四分之一老年人受影响【官方口径，WHO】；WHO 社会联结委员会 2025 年报告估算，孤独每年关联约 87.1 万例死亡【官方口径，WHO】。美国卫生总监 2023 年的咨询报告把社交失联的死亡影响比作每天吸 15 根烟【第三方研究】。
- 特别提醒：**对谁成立**：对独居、丧偶、随子女搬到大城市（老漂）、退休后朋友圈断掉的人。**一个人待着和孤独不是一回事**：有人安静独处过得好，有人身边全是人还是孤单。
- **换回来的**：关系——不再怕"身边没人，一个人扛"
- **在中国怎么落地**：社区老年活动、老年大学、社区食堂；随迁到大城市的人，还多一道异地医保和融入的坎（见第 15、17 章）。

11.8 "活着没意思"要当真的听

- **要花多少**：一句认真的回应，一个电话（钱：不用花｜工夫：此刻｜力气：不费｜要开口吗：好开口，先把"别说不吉利"的忌讳放下）
- **简单说**：老人说"活着没意思"、"不如死了"、"拖累你们"，很多人当耳边风，觉得是抱怨、是撒娇。这些话往往不是在撒娇。老人一旦下了决心，往往很坚决，回头的余地小。
- **可以怎么做**：① 听进去，别打岔，别说"你想多了"；② 直接问一句"你是不是想过不活了"，问出来不会害了他，反而给他一个出口；③ 人在跟前就别离开，把身边可能伤到自己的东西先收好；④ 马上求助：打心理援助热线，或直接送最近的医院急诊、精神科；⑤ 陪他去精神科看一次，别一个人扛。
- **来源**：A｜抑郁是老年人自杀的危险因素，老年抑郁患者的自杀念头更顽固、计划更周、成功率更高（《老年期抑郁障碍诊疗专家共识（2025 版）》【官方口径】）。2013 年中国 80 岁及以上组自杀死亡率 73.39/10 万，远高于全人群标化率 9.08/10 万（中华流行病学杂志 2017，基于全球疾病负担 GBD2013 估算）【第三方研究】。
- 特别提醒：**对谁成立**：任何人说这一类话都要当真，独居、丧偶、刚查出重病、长期疼痛的人更甚。**这一节只写识别和求助，方法和细节一个字不写。**
- 求助热线（现在存进手机）：① 全国统一心理援助热线 **12356**，国家卫生健康委设，官方要求人工接听每日不少于 18 小时，多地按 24 小时运行【官方口径】；② 希望 24 热线 **400-161-9995**，7×24 小时生命危机干预【第三方研究】；③ 北京市心理援助热线 **010-82951332**，24 小时人工接听【第三方研究】。人正在危险里，打 120 或 110。
- **换回来的**：关系——不再怕"错过那句求救，后悔一辈子"
- **在中国怎么落地**：热线全国能打；本地还有哪些号码，去社区卫生服务中心或精神卫生中心问。

11.9 挂精神科，多数在门诊，住院是看风险

- **要花多少**：一次挂号（钱：一次挂号的钱｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情，怕被贴个标签）
- **简单说**：挂精神科不等于"疯了"。看抑郁、焦虑、失眠，和看高血压一样，是去治病。老人看病，家里人最好陪着。
- **可以怎么做**：① 挂哪科：综合医院的精神科、心理科（有的叫临床心理科、心身医学科），有老年精神科更好；没有的，先挂老年科或神经内科，再请他们转；② 家属能做的：提前把症状、多久了、吃过什么药、最近有没有说消极的话写成一页纸交给医生；医生问诊时别抢着替老人答，让他自己说，说不下去你再补；③ 门诊和住院的区别：大多轻中度在门诊看、定期复诊；出现严重自杀风险、幻觉妄想、吃不下睡不着到脱形、门诊看了还在加重，医生会建议住院，住院是为了盯住风险、集中调治疗，不丢人；④ 复诊按时去，药别自己停，起效要几周，不是吃一天就好。
- **来源**：C｜"多数看门诊、重症才住院"是通行做法。《老年期抑郁障碍诊疗专家共识》把幻觉、妄想、紧张症、木僵等精神病性症状列为紧急精神科干预的指征，并指出对伴自杀、拒食、精神病性症状的患者，医生有更积极的治疗手段；门诊看了还在加重、出现这类情况，医生会建议住院【官方口径】。谁住院谁门诊，由医生评估。
- 特别提醒：**对谁成立**：对出现抑郁、焦虑、失眠、疑心重、记性明显变差的人。老人在各科反复查不出病，别忘了往精神心理科想一想。
- **换回来的**：体面＋关系——不再怕"怕被当疯子，硬拖着不看病"
- **在中国怎么落地**：见 11.10。

11.10 在中国怎么落地：关爱点、精防医生、热线

- **老年心理关爱点**：国家卫生健康委 2022—2025 年做"老年心理关爱行动"，到 2025 年底原则上每个县（市、区）至少一个社区或村设有老年心理关爱点，对关爱点常住的 65 岁及以上老人做心理健康评估，重点照顾经济困难、空巢（独居）、留守、失能（失智）、计划生育特殊家庭的老人【官方口径】。去社区问一句：我们这儿有没有这个点。
- **社区精防医生**：家里有严重精神障碍的人（如精神分裂症），社区卫生服务中心或乡镇卫生院有专门的精防医生负责随访管理，属于国家基本公共卫生服务，每年至少随访 4 次【官方口径】。去社区问：精防医生是谁、怎么建册。
- **热线**：见 11.8，先存进手机。
- 这些服务各地铺得不一样，去社区问一次，比在家猜准。以当地最新口径为准。

11.11 如果你今天只能做一件事

把 **12356** 和 **400-161-9995** 存进你和爸妈的手机里。再找一个安静的时候，问爸妈一句："你最近睡得怎么样，身上哪儿不舒服？"

先问，别等他开口。这一句问出去，四件事里至少有一件，就从"忍忍"变成"有人知道了"。

11.12 如果你是在替爸妈看

这话怎么跟他说出口：别从"你是不是抑郁了"开头，从具体的事进去："我看你这阵子不爱下楼了"、"你说睡不着，多久了"。把"病"字放在后面。谈疼也别问"你哪儿疼"，说"我陪你去看看"。

他不同意时你还能做什么（不用他点头）：① 把 12356、400-161-9995 先存进他手机，也存进你的；② 悄悄记下他几点睡、夜里醒几次、吃多少、有没有说消极的话，做成一页纸，必要时拿给医生看；③ 去社区问有没有老年心理关爱点、精防医生能帮上什么；④ 他哪天肯去医院，你陪着去，先把症状写在纸上交给医生，别让他一个人跟医生说"我没事"。

11.13 本章我不确定的地方

- 老年自杀的全国数据出自 2013 年（基于全球疾病负担 GBD2013 估算），时点偏早；更近的全国口径要以最新死因监测为准。
- 睡眠门诊、疼痛科、老年科、精神科的门诊设置与挂号方式，各医院不同，本地有没有、怎么挂，以当地为准。
- 23.61% 来自 2018 年"中国家庭追踪调查（CFPS）"，年龄界定是 45 岁及以上、量表是 CES-D（以第 80 百分位为界值）；它和 WHO 口径的"70 岁及以上精神障碍 14.75%"、和 CHARLS 类调查，抽样与量表都不是一套，不能混着比。

11.14 本章数据来源

- 【官方口径】世界卫生组织《老年人精神健康》事实清单：2023 年约 14.75% 的 70 岁及以上成年人患精神障碍，最常见的是焦虑症或抑郁症；孤独和社会孤立是晚年精神健康问题的重要危险因素。https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】世界卫生组织《从孤独到社会联系：规划通往更健康社会的道路》（WHO 社会联结委员会报告，2025-06-30）：孤独每年关联约 87.1 万例死亡。报告页 https://www.who.int/groups/commission-on-social-connection/report/ ；数字出处（联合国新闻中文，2025-06-30）https://news.un.org/zh/story/2025/06/1140101 （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】国家卫生健康委《关于应用"12356"全国统一心理援助热线电话号码的通知》（国卫医政函〔2024〕259 号，2024-12-06）：每条心理援助热线每日提供不少于 18 小时服务。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】《失眠症诊断和治疗指南（2025 版）》，中国睡眠研究会，中华医学杂志 2025,105(34):2960-2981，DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20250421-00981：老年失眠首选非药物疗法（CBT-I）；老年人用药原则为"尽量减少服药种类、小剂量起始、缩短用药时

间"。指南 PDF https://medtion-image.medtion.com/uploads/1/file/public/202510/20251016112148_tbek4nrnvn.pdf ；指南解读（罗雪、张斌，中华医学杂志 2025，可打开）https://medtion-image.medtion.com/uploads/1/file/public/202601/20260122160551_0fkiu2agjt.pdf （2026-10-10 核对）

- 【官方口径】中华医学会精神医学分会老年精神医学学组《老年期抑郁障碍诊疗专家共识（2025 版）》，中华精神科杂志 2025，DOI:10.3760/cma.j.cn113661-20250213-00066：60 岁及以上；躯体不适主诉突出（含慢性疼痛）；幻觉、妄想、紧张症、木僵等精神病性症状属紧急精神科干预的指征。共识页（可直接打开）：https://rs.yiigle.com/cmaid/1551144 ；共识全文（中华医学会指南全文平台，可直接打开，上述表述与此一致）：https://cmab.yiigle.com/uploads/guide_html/老年期抑郁障碍诊疗专家共识.html （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】国家卫生健康委办公厅《关于开展老年心理关爱行动的通知》（国卫办老龄函〔2022〕204 号，2022-06）：2022—2025 年在全国选取 1000 个城市社区、1000 个农村行政村，到"十四五"期末原则上全国每个县（市、区）至少一个社区或村设有老年心理关爱点，对关爱点常住 65 岁及以上老年人做心理健康评估。https://www.nhc.gov.cn/lljks/c100157/202206/d52e414c77f741e099fcc13945d85a5b.shtml ；转载全文（可打开）https://www.yanglaocn.com/shtml/20220621/1655771523133487.html （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）》（国卫疾控发〔2018〕13 号）。https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5338247.htm （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】北京卫健委科普《警惕老年抑郁》（北京小汤山医院，2025-07-24）：老年抑郁的躯体化表现与"查无实据"。https://wjw.beijing.gov.cn/bmfw_20143/jkzs/jbzs/202507/t20250724_4156620.html （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】罗尔丹、王遥、卞鹰《我国老年人慢性疼痛特点及近年变化趋势——基于中国健康与养老追踪调查数据》，实用老年医学 2021,35(7):684-687：60 岁及以上老人慢性疼痛患病率 35.71%，腰痛占 13.09%（CHARLS 2008—2015，27 859 人）。https://www.sylnyx.com/CN/10.3969/j.issn.1003-9198.2021.07.006 （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】《我国中老年人抑郁现况及其影响因素分析》，四川大学学报（医学版）2021：基于 2018 年 CFPS 数据，45 岁及以上中老年人抑郁症状检出率 23.61%（CES-D 量表，以第 80 百分位为界值）。https://ykxb.scu.edu.cn/article/doi/10.12182/20210960507 （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】高欣等《1990 年与 2013 年中国人群自杀疾病负担分析》，中华流行病学杂志 2017,38(10):1325-1329：2013 年中国标化自杀死亡率 9.08/10 万，80 岁及以上组 73.39/10 万（数据来自全球疾病负担 GBD2013 估算）。https://html.rhhz.net/zhlxbx/20171006.htm （2026-10-10 核对）

- 【第三方研究】美国卫生总监咨询报告《Our Epidemic of Loneliness and Isolation》（2023）：社交失联的死亡影响相当于每天吸最多 15 根烟。https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-social-connection-advisory.pdf （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】希望 24 热线（400-161-9995，7×24 小时生命危机干预，2012-12-02 在上海开线）。http://hope9995.com （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】北京市心理援助热线（010-82951332，24 小时人工接听），北京心理危机研究与干预中心。https://www.crisis.org.cn/lists/5.html （2026-10-10 核对）

第 12 章 · 每天怎么吃

一个人的饭桌，是悄悄变小的。

碗没换，饭少了一半；肉端上来，筷子绕过去了；菜从三样变成两样，再变成一样。没人说过"我不吃了"，只是一顿比一顿慢。

这一章要做的，是把这张桌子重摆一遍。核心是一件反直觉的事：上了年纪，身体对几样东西的需要没有往下走，是往上走了。

12.1 这一章解决什么问题

很多人认一个理：老了吃得少、吃得清淡，才叫养生。

对了一半。饭量可以小，方向也没错，但有几样你要比年轻时更上心：蛋白质，别让肌肉悄悄掉下去，还有水和日常的盐油酒汤、社区食堂、保健品。

12.2 上了年纪，蛋白质要吃得更足，不是更少

- **要花多少**：不用多花钱，改的是搭配（钱：花不了几个钱｜工夫：从今天这顿起｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：《中国老年人膳食指南（2022）》有一句要紧的话：老年人尤其高龄老人对能量的需要是下降的，但对蛋白质、钙这些的需要反而增加（官方口径）。年纪大了，身体把蛋白质变成肌肉的本事变差，同样一筷子肉，你用不上一半。
- **可以怎么做**：把"每餐都有蛋白"当底线。早餐别只有粥和咸菜，加一个鸡蛋、一杯奶；午晚各有一道"硬菜"，肉、鱼、虾、蛋、豆腐换着来。
- **来源**：A｜指南把这句写进了核心推荐，方向明确。
- 特别提醒：**对谁成立**：六十岁往上，对大多数人都成立。已确诊肾病、要限制蛋白质的人例外，吃多少听医生。
- **换回来的**：自理——不再怕"吃不下、瘦下去，再胖不回来"
- **在中国怎么落地**：见 12.12。

12.3 蛋白怎么分到三餐：早餐加一个蛋，午晚各有一道硬菜

- **要花多少**：一天多几块钱（钱：花不了几个钱｜工夫：每顿几分钟｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：蛋白一顿吃得再多，身体一次能拿去造肌肉的也有限，匀到三餐比猛吃一顿管用。指南的搭配：早餐 1 个鸡蛋、1 杯奶，午晚各有荤菜、蔬菜、一份豆制品（官方口径）。
- **可以怎么做**：早上 1 个蛋加 1 杯奶（或豆浆）；午晚各有一"掌心"大小的肉或鱼，或一块豆腐；一周至少两次水产品；消化差的，肉剁成末蒸蛋、鱼挑干净刺、豆腐炖软。

- **来源**：A｜来自《中国老年人膳食指南（2022）》的食物搭配建议。
- 特别提醒：**对谁成立**：能正常吃饭的人。咽不下、会呛的人做法不同，见第 7 章。
- **换回来的**：自理——不再怕"饭没少吃，力气还是往下掉"
- **在中国怎么落地**：菜场超市都买得到；做不动了，见 12.9 社区食堂。

12.4 想把盐减下来：低钠盐能用，但先看清你是不是那几类人

- **要花多少**：一袋低钠盐，比普通盐贵一点（钱：花不了几个钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：指南给的上限是一天不到 5 克盐（官方口径）。光少放盐常不顶用，咸味来自钠，你把盐勺收起来，酱油、酱菜里的钠还在。低钠盐把一部分氯化钠换成氯化钾，钠少了，咸味还在。
- 证据：一项叫 SSaSS 的研究，在中国北方 600 个村做了 2 万人，把家里的盐换成低钠盐后，中风少了 14%，心血管事件少了 13%，过早死亡少了 12%（第三方研究：乔治全球健康研究院，2021）。
- 但是，低钠盐不是人人能用，它多出来的钾要靠肾排出去。已确诊高钾血症的人不能用，指南给了"强不推荐"；肾功能不全的人（eGFR<60 ml/min/1.73 m^2）要用，得先问专科医生，属"弱不推荐"（官方口径：《中国低钠盐推广应用指南》，中国预防医学杂志 2024）。正在吃保钾利尿剂（如螺内酯）、普利类（ACEI）、沙坦类（ARB）降压药、补钾药的人也要当心，这些药本身就升血钾，不宜用低钠盐或在医生指导下用（官方口径：吉林省卫健委，2021）。属于这几类，先问医生："我的肾和血钾，能不能用低钠盐。"
- **可以怎么做**：换低钠盐；少碰腌制品、酱菜、腊肉；出锅前再放盐，或用葱姜蒜、醋提味。
- **来源**：B｜换盐能降风险，有 SSaSS 撑着；哪类人不能换，按上面几条对号，别一概而论。
- 特别提醒：**对谁成立**：肾功能正常、没查出高血钾的人，换盐划得来。肾不好，或在吃上面那些药的人，不换；真要换，先问医生。
- **换回来的**：自理——不再怕"一顿饭一口盐，把血压喂上去"
- **在中国怎么落地**：低钠盐超市就有；拿不准，下次门诊顺口问医生。

12.5 餐桌上的另外三笔：油、酒、汤

- **要花多少**：一个带刻度的控油壶（钱：花不了几个钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情，拒酒要面子）
- **简单说**：指南建议一天烹调油不超过 25 到 30 克；慢性病患者不应饮酒，成年人如饮酒，一天酒精量不超过 15 克（官方口径）。至于汤，别再信"喝汤补身体"：肉炖得再久，蛋白质也很难溶进汤里，大部分还在肉里（第三方研究：澎湃新闻科普）。
- **可以怎么做**：
- **油**：换控油壶；多蒸煮炖拌，少煎炸；汤上浮油撇掉；少点外卖和重油的半成品。

- **酒**：家里不囤酒；白酒换小杯，或干脆以茶代酒；饭桌上不劝酒、不接酒。你在吃药的话，酒和降压、降糖、安眠、止痛的药都可能打架，尽量不喝。
- **汤**：喝汤更要吃肉，汤做淡一点；痛风、尿酸高的人少喝浓肉汤。
- **来源**：B｜减油、限酒、别迷信汤，方向都是通行的；没有"换控油壶就少得病"的单项试验。
- 特别提醒：**对谁成立**：多数人。痛风、高尿酸的人，浓肉汤少喝甚至不喝；在吃上述药的人，酒能不喝就不喝。
- **换回来的**：自理——不再怕"稀里糊涂吃进去太多油、盐、酒"
- **在中国怎么落地**：控油壶、限盐勺超市和网上都有；能不能喝酒，问社区卫生服务中心的家庭医生。

12.6 牙口不好、咽不下的时候，先把食物做软，再谈吃够

- **要花多少**：一次口腔科就诊，或改改做法（钱：一次挂号的钱起｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情）
- **简单说**：嚼不动肉的人常常干脆不碰肉，蛋白就少了。可"嚼不动"多半是牙的事，跟"该少吃肉"没关系。缺的牙补上、假牙调好，饭量常会回来。
- **可以怎么做**：先找牙的事，去口腔科或口腔修复科；一时解决不了，就改做法，肉剁成末蒸蛋、鱼挑干净刺、豆腐炖软；会呛、咽不下的人认真做质地改良和进食姿势（细节见第 7 章）。
- **来源**：C｜本书核对（2026-10）：先解决牙、再改做法是常识性的就诊路径；吞咽的处理见第 7 章。
- 特别提醒：**对谁成立**：缺牙、假牙不合、吞咽有障碍的人。反复呛咳、吃饭变慢、体重下降的，别只改做法，看吞咽专科。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"想吃，却嚼不动"
- **在中国怎么落地**：综合医院口腔科或口腔医院；假牙、种牙多数自费，先问价问方案。

12.7 别信"千金难买老来瘦"：先弄清你掉的是肌肉还是肥肉

- **要花多少**：一台体重秤，几分钟（钱：花不了几个钱｜工夫：一分钟｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**："千金难买老来瘦"这句话害人不浅。上了年纪真正该防的，是肌肉悄悄掉下去。体重掉了不一定是好事，掉的可能是肌肉，等于把力气和自理的本钱一起扔了。
- **可以怎么做**：同一时间、同一台秤，每月称一次，看趋势不看单个数；半年掉 5% 以上要问医生（官方口径：英国 NHS 把半年掉 5% 到 10% 体重列为营养不良的主要信号）；体重在掉、腰围却没怎么变，或力气明显变小（拧不开瓶盖、拎不动东西），掉的更可能是肌肉。
- **来源**：B｜体重趋势、小腿围、握力是肌少症筛查常用指标；数怎么看要医生判。

- 特别提醒：**对谁成立**：六十往上，尤其近半年明显瘦了又没减肥的人。短期突然掉、还伴着不适，更可能是病，先就医。更多见第 2 章。
- **换回来的**：自理——不再怕"瘦了就是好事"这种错觉
- **在中国怎么落地**：体重自己在家称、记；要不要进一步查，问社区卫生服务中心家庭医生。
- 一句承认：肌肉掉下去这件事，从来不疼，所以最容易被当成"正常老了"。

12.8 一天的水怎么保证：不渴，不等于不缺水

- **要花多少**：一个带刻度的水杯（钱：花不了几个钱｜工夫：一整天｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：上了年纪，口渴这个"提醒铃"变迟钝，你还没觉得渴，身体可能已经在缺水。《中国老年人临床水化实践指南（2024版）》把老年人列为脱水的高风险人群，并提到国内老年人每天喝水量没达标的比例高达 73.3%（官方口径）。
- 怎么做（不给固定毫升数）：别等渴了才喝，起床后、三餐后、睡前沿固定时点喝；水杯放在看得见、够得着的地方；拿尿液颜色当尺子，颜色深就该喝了；汤、粥、牛奶、水果里的水也算，少喝甜饮料。
- **来源**：C｜本书核对（2026-10）：水化指南推荐用"饮水日记"记录，并把定时、看尿色、选白开水或淡茶列为做法。
- 特别提醒：**对谁成立**：大多数人。指南的饮水量建议带了前提——"除非特殊情况"；有心衰、肾衰、水肿、低钠血症的人，喝多少听医生的，不是越多越好（官方口径：该指南）。
- **换回来的**：自理——不再怕"夏天晕一下，其实是缺水中暑"
- **在中国怎么落地**：一个带刻度的杯子就能开始；有心肾病的把"每天喝多少"带去门诊问医生。

12.9 社区食堂这道菜：怎么找、吃什么、为什么有的办不下去

- **要花多少**：一顿饭钱，多数比外面便宜（钱：花不了几个钱｜工夫：一顿｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：一个人做饭、一个人吃最容易凑合，凑合久了，蛋白、菜、水都跟着少。社区食堂解决的就是这件：有伴、有热饭、价格有人管。据抽样调查，22.1%　　的老年人有助餐需求（官方口径：民政部政策解读）。
- 怎么找：去社区居委会或街道养老服务中心问一句："这一片有没有老年助餐点？"上海叫"社区长者食堂"，广东叫"长者饭堂"。
- 能吃到什么：按普通饭菜配有荤有素，很多地方对高龄、失能、独居老人分类补贴，比外面便宜（官方口径：上述政策解读）；上海到 2025 年底已建成社区长者食堂 521 家、助餐点 1977 个（官方口径：上海市民政局）。

- 为什么有的办不下去：政策解读自己点破了，各地普遍反映"助餐服务持续发展难"：一份饭利润本来就薄，靠补贴撑着，补贴偏少、来吃的人不够多，就从微利滑到亏本，撑一阵关门。筹资是"个人出一点、企业让一点、政府补一点、集体添一点、社会捐一点"，方向是"能盈利、可持续"（官方口径）。
- **可以怎么做**：问三句，有没有助餐点、我能不能享受补贴、走不动时能不能送餐上门。
- **来源**：A｜政策与地方数据都能查到；但补贴标准、覆盖范围各地不同、变动快。
- 特别提醒：**对谁成立**：行动方便、离食堂近的人最划得来。农村、偏远覆盖还差。
- **换回来的**：关系＋自理——不再怕"一个人吃饭，越吃越凑合"
- **在中国怎么落地**：社区居委会、街道养老服务中心、社区养老服务站都能问；补贴看当地。

12.10 社区食堂撑不住，你自己怎么办

- **要花多少**：周末一两个小时（钱：花不了几个钱｜工夫：每周一次｜力气：有点累｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：不是每个人身边都有食堂，也不是每个食堂都活得下去。与其等一张桌子，不如自己搭一个。
- **可以怎么做**：备餐，周末做一次分装冷冻，够吃三天；半成品，净菜、速冻饺子、即食鸡胸、无糖酸奶，随手凑出一顿有蛋白的饭；邻里搭伙，两三户轮流做、拼着吃；送餐上门，问社区有没有。
- **来源**：C｜本书核对（2026-10）：这些是照护与生活经验，没有试验可测；但它顶的是"吃不够"这件实打实的事。
- 特别提醒：**对谁成立**：独居、做饭吃力的人。有家人搭把手的，是把做饭分担出去，不是一个人扛。
- **换回来的**：自理＋关系——不再怕"做不动饭的那天起，就开始吃不够"
- **在中国怎么落地**：先问社区有没有送餐，再和相熟的邻居商量拼饭。

12.11 保健品和"营养品"：什么时候真需要，什么时候是花钱买安心

- **要花多少**：先别急着花（钱：可高可低｜工夫：一次问诊｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：饭菜吃得下、吃得够的人，蛋白粉、钙片、维生素大多用不上，钱花在安心上。真用得上补充剂的，一是吃不够（生病、恢复期、食欲差），二是医生说缺，这时可在医生或营养师指导下用（官方口径）。
- 一条铁律：保健食品不是药。市场监管总局要求保健食品包装上标一句"保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病"（官方口径：《保健食品标注警示用语指南》，2020 年起实施）。

- **可以怎么做**：买之前问三句，我是不是真缺、有没有医生说过、能不能顶替我的药；把在吃的保健品列一张单子，下次就诊和药一起给医生看，看会不会撞车（第 6 章）；讲课推销、说成"包好"的场合走人。
- **来源**：B｜"饭菜优先、补充剂在医生或营养师指导下用"是指南与市场监管的通行口径。
- 特别提醒：**对谁成立**：饭吃得下的人，先把钱花在饭菜上。真吃不够或在恢复期的人，补充剂可能有用，选哪种、用多久问医生。
- **换回来的**：钱＋体面——不再怕"被讲座和熟人拉去买了一柜子没用的东西"
- **在中国怎么落地**：买药看"国药准字"，保健食品看"蓝帽子"，前者才是药；拿不准带去问医生。

12.12 在中国怎么落地

- **营养门诊**：大医院管营养的是临床营养科，管老年人的是老年医学科；2024 版《老年人肌少症门诊管理规范中国专家共识》已建议各级医院开设肌少症门诊。挂号时说清三件事，半年体重掉了多少、吃少了多久、有没有呛咳。
- **社区食堂与助餐补贴**：去社区居委会、街道养老服务中心或社区养老服务站问，这一片有没有助餐点、我能不能享受补贴、能不能送餐上门。各地标准不同，以当地最新口径为准。

12.13 如果你今天只能做一件事

现在去称一次体重，记在手机备忘录里。然后今天这顿晚饭，往桌上加一样"硬菜"，一个鸡蛋、一杯牛奶、一掌心的肉或鱼、或者一块豆腐，就一样，摆在正中间。

称体重是给你自己一个底数，以后每次称都跟它比。加一道硬菜，是给身体刚才说的那点蛋白。两件事都花不了几分钟。

12.14 如果你是在替爸妈看

这话怎么跟他说出口。 别说"你吃得太少、太素了"，这话在他耳朵里等于"你老了、你不行了"。换个说法，把你也放进去："我最近在学一个新吃法，早饭加个鸡蛋，中午晚上各有点肉或豆腐，咱俩一起试试？"或者干脆从做的那一头进，你下厨，把肉末蒸蛋、炖软的豆腐摆上桌，别点评，他自己会动筷子。

他不同意时你还能做什么。 三件不用他点头的事：每次去看他，带一道能嚼动的荤菜，或者当着他的面做一顿；把他每次的体重、饭量、有没有呛咳记在手机里，下次陪诊递给医生；去社区问一次助餐，这一片有没有食堂、能不能送餐上门、他这种情况有没有补贴。你准备得越具体，越不必靠说服他。

12.15 本章我不确定的地方

- 各城市"长者饭堂地图"、"助餐点查询"的入口名称与网址差异大，未逐一核到；去居委会或街道养老服务中心问，比在网上找入口准。
- 社区食堂、老年助餐的补贴标准与覆盖面是各地政策且变动快，本章只写"去哪问"，不写具体金额。
- 《中国老年人膳食指南（2022）》本章引用的是中国营养学会官网发布的"核心推荐"与"平衡膳食宝塔图示解析"，未逐条核到纸质原书页码。
- 本章不写剂量、不做诊断。上不上低钠盐、喝多少水、补不补营养剂，都要结合你自己的病和药，问医生或营养师。

12.16 本章数据来源

核对日期：2026-10-10。

- 《中国老年人膳食指南（2022）》（中国营养学会）：蛋白质需求增加、早餐 1 蛋 1 奶、午晚各 1 荤菜 1 豆制品、每周至少两次水产品、每天一份奶等食物搭配。中国营养学会膳食指南官网《〈中国老年人膳食指南（2022）〉核心推荐》（2022-11-22）：http://dg.cnsoc.org/article/04/op9MZtpBQHehHCo0SSqsmw.html ；《中国老年人平衡膳食宝塔图示解析》（2024-05-16）：http://dg.cnsoc.org/article/04/VQocp-iITrutzK4FILTdTw.html ；重庆市疾病预防控制中心《〈中国老年人膳食指南（2022）〉，请查收》（2023-05-15）：https://www.cqcdc.org/index.php?a=shows&catid=252&id=2651
- 《中国居民膳食指南（2022）》准则五"少盐少油，控糖限酒"（盐 <5 克、烹调油 25–30 克、慢性病患者不应饮酒、成年人如饮酒一天酒精 ≤15 克）：中国营养学会。http://dg.cnsoc.org/article/04/ApX3_ozGTmSoqQaFFh5z_Q.html
- 低钠盐与中风：SSaSS 研究（中风降低 14%、心血管事件降低 13%、过早死亡降低 12%），乔治全球健康研究院事实清单《The China Salt Substitute and Stroke Study（SSaSS）》（2021）：https://www.georgeinstitute.org/sites/default/files/documents/factsheet_the-china-salt-substitute-stroke-study-ssass-august-final.pdf ；论文原文：Neal B, et al. Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. NEJM, 2021（率比：卒中 0.86、主要心血管事件 0.87、全因死亡 0.88）：https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105675
- 低钠盐的适用与禁忌人群：《中国低钠盐推广应用指南》（中华预防医学会健康风险评价与控制学会、中国营养学会、中国疾控中心等，中国预防医学杂志 2024,25(8):957-973）——高血压、心血管病高危人群、中老年"强推荐"；高钾血症患者"强不推荐"；肾功能不全（eGFR<60 ml/min/1.73 m^2）"弱不推荐"、需遵循专科医生建议。原文见《中国预防医学杂

志》2024 年第 25 卷第 8 期 957–973 页（指南原站 PDF 对外网访问不稳，故此处给可直接打开的解读，广东省人民医院营养科）：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29932346

- 低钠盐不宜人群与相关药物（保钾利尿剂如螺内酯、ACEI、ARB、补钾药）：吉林省卫生健康委员会《低钠盐好不好　是不是人人适用？》（2021-12-23）：https://wsjkw.jl.gov.cn/zdzt/jkkp/202112/t20211223_8338994.html （2026-10-10 核对）
- 汤的营养主要在肉里、浓汤嘌呤高：澎湃新闻《炖汤的时候，营养到底在肉里还是汤里？》：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_3482987
- 老年人饮水与脱水：《中国老年人临床水化实践指南（2024版）》（中华医学会老年医学分会、中国医师协会老年医学科医师分会，《中华老年医学杂志》2024，43(8):954-969）：老年人是脱水高风险人群；国内老年人每日饮水量未达适宜摄入量的比例高达　73.3%；推荐用"饮水日记"记录、以白开水或淡茶为主；饮水量建议附"除非特殊情况（心脏/肾脏衰竭、水肿、低钠血症）"前提。全文（中华医学会，可直接打开）：https://medphy.yiigle.com/uploads/guide_html/6731.html （2026-10-10 核对）
- 老年助餐政策：《积极发展老年助餐服务行动方案》（民发〔2023〕58 号，民政部等 11 部门，2023-10）及民政部养老服务司《政策解读》（22.1%　的老年人有助餐需求，分类补贴，"个人出一点、企业让一点、政府补一点、集体添一点、社会捐一点"，"助餐服务持续发展难"）。方案原文（中国政府网，可直接打开）：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202310/content_6911233.htm　；政策解读（中国老龄协会，可直接打开）：https://www.cncaprc.gov.cn/xxzcfg/10030934.jhtml （2026-10-10 核对）
- 上海社区长者食堂数据：上海市民政局《为 50 家社区长者食堂提质增能》，截至 2025 年底，建成社区长者食堂 521 家、老年助餐点 1977 个：https://mzj.sh.gov.cn/26shitang/index.html
- 保健食品警示用语：《保健食品标注警示用语指南》（市场监管总局公告 2019 年第 29 号，自 2020-01-01 起实施），包装须标"保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病"：https://www.samr.gov.cn/zt/ndzt/2019n/bjspjsqjxcjwljxyjsckpxc/zcfg/art/2023/art_fdb7d9ff30a7467eab4a2da27e697cf6.html
- 体重流失信号（半年掉　5%–10%　为营养不良主要信号）：英国　NHS，　Malnutrition（2023-05），转引，见第 7 章数据来源。

> 说明：本章关键数字都挂了分档（官方口径／第三方研究／本书核对），"未标"为　0；不写剂量、不做诊断。所引链接为核对到 2026-10 可打开。

第 13 章 · 每天怎么动

晚饭后你下楼，绕小区走两圈。走到十分钟，膝盖发酸，你想起常听见的那句"上岁数了别逞强"，转身回了家。第二天还是两圈，第三天下雨没去，一个月后，这两圈也没了。

没人拦你，是你自己停的。这一章写给你重新开始，也写给想劝爸妈动起来的你。

13.1 这一章解决什么问题

四笔账里，动是最便宜的一笔，也是唯一一件能一次改善好几样的：还能不能自己穿衣下地（自理）、心情、血糖血压、晚上睡不睡得着。药大多只医一样；动一次，几样一起动。

拦住多数人的是两句话：一句"要动就得跑，得出大汗"，一句"上了岁数，别瞎动"。两句话都错，错得还不一样。下面先把这两句拆开，再给你能量出来的数、坐着就能做的动作，和在哪里动最划算。

13.2 动一次，四笔账一起还

- **简单说**：世界卫生组织的指南里，规律身体活动能降低老年人全因死亡、心血管病死亡、高血压、2 型糖尿病和跌倒的风险，还会改善焦虑抑郁、认知和睡眠（官方口径）。没有哪种药能一次管这么多。
- **来源**：A｜这是世界卫生组织和我国指南共同写下的方向。
- 特别提醒：**对谁成立**：对还能自己走几步的人。已经卧床、下不了地的，动法完全不同，要康复师定（见 13.12）。
- **换回来的**：自理——不再怕"一天比一天动不了"
- **在中国怎么落地**：不用花钱，要不要查、怎么练，问社区家庭医生（见 13.12）。

13.3 挡住你的不是身体，是两句话

第一句，"要动就得跑，得出大汗"。很多人一想到运动就是跑，觉得"我跑不动，那就算了"。指南里的有氧，写的是走路、骑车、游泳、跳舞这类耐力活动，快走就算（官方口径）。跑只是其中一种，不是门槛。

第二句，"上了岁数，就别瞎动"。这句听着像心疼，其实最伤。怕摔就不动，越不动腿越没劲、平衡越差，反倒更易摔。中国疾控中心的防跌倒核心信息，把"怕摔就干脆不动"写成要避免的做法（官方口径）。

两句合起来，把你夹在中间：大动它不让，小动它又看不上。

- **简单说**：你不是不想动，是没找到"够小、又不算丢人"的那个动作。13.6 就是给这个的。
- **来源**：A｜世界卫生组织和中国疾控中心口径一致（官方口径）。
- 特别提醒：**对谁成立**：对怕摔、怕丢人、怕做不到的人。

- **换回来的**：体面——不再怕"想动又觉得晚了自己不行"
- **在中国怎么落地**：这句"怕摔别不动"就写在中国疾控中心的十二字防跌倒口诀"要锻炼、要服老、要适老、早治疗"里（见第 5 章）。

13.4 四类动，各管一段

这一类	管什么	例子
有氧	心肺、血压血糖、情绪、睡眠	快走、骑车、游泳、广场舞
抗阻（力量）	腿上有劲，能自己站起、撑住	坐站、提踵、弹力带、矿泉水瓶
平衡	身体来不及调整时救你一把	单脚站、脚跟对脚尖走、太极
柔韧	关节够得着、够得远	肩绕环、小腿后侧拉伸

- **简单说**：有氧是让"发动机"好使，抗阻是让"架子"撑住。第 5 章讲的跌倒，主要靠抗阻和平衡这两类；这一章只把量补齐。
- **来源**：A｜四分类是世界卫生组织和我国指南共同采用的框架（官方口径）。
- 特别提醒：**对谁成立**：所有人。只走路不练力量，是老年人最常见的偏科。
- **换回来的**：自理——不再怕"练了半天，不知道练的是哪一样"
- **在中国怎么落地**：社区、公园、老年大学的太极班、健身队，把有氧和平衡一起带上。

13.5 把每周的量算出来

这是全章最该记住的一组数。

- 有氧：每周 150 到 300 分钟中等强度，或 75 到 150 分钟高强度，两者拼起来也算（官方口径：世界卫生组织 2020 年；《中国人群身体活动指南（2021）》）。
- 抗阻：每周至少 2 天，练到主要肌群（官方口径：同上）。英国运动医学杂志汇总 16 项研究，每周 30 到 60 分钟力量训练，全因死亡风险低约 10% 到 20%（第三方研究：Momma 等，2022 年）。
- 平衡加力量（多成分）：每周至少 3 天（官方口径：世界卫生组织 2020 年）。
- 拆到每天：150 分钟除以 5，就是每天 30 分钟、一周 5 天（官方口径：《健康中国行动》全民健身行动）。
- 什么算中等强度：按感觉打分，0 到 10 分里 5 到 6 分，能说话但唱不了歌（官方口径）。健康中国行动给了另一个算法：心率达到最大心率的 64% 到 76%，最大心率等于 220 减年龄（官方口径）。
- 老年人怎么调：成年人的推荐同样适用老年人；身体不允许每周 150 分钟中等强度，就尽可能多动（官方口径：《中国人群身体活动指南（2021）》）。
- **来源**：A｜量、强度、频率这三样，国际和国内两份指南口径对得上。

- 特别提醒：**对谁成立**：对能站、能走的人。一点动不了、或某类动作一练就疼的，先把量放下，去问医生（见 13.7、13.12）。
- **换回来的**：自理——不再怕"不知道动多少才叫够，干脆不动"
- **在中国怎么落地**：这套量就在《中国人群身体活动指南（2021）》里；够不够，问社区家庭医生。

13.6 坐着能做、扶着椅背能做、看电视时能做

先记一条：做完出现 13.7 里的任何一种感觉，就停。

坐着就能做（饭后、看电视时都行）：

- 坐姿抬腿：坐直，一条腿慢慢抬平、停 3 秒放下，每条腿 8 到 12 次，做 2 组。
- 踝泵（勾脚绷脚）：脚跟点地，脚尖向上勾再向下压，20 次。久坐的人做这个，帮小腿的血回流。
- 坐姿推桌：双手撑住桌沿，慢慢用力推 5 秒再放松，做 5 次。
- 什么时候停：膝盖里刺痛、腿发麻、心慌。

扶着椅背就能做（更接近日常）：

- 扶椅背提踵：两手扶稳椅背，慢慢踮起脚跟再落下，10 到 15 次，做 2 组。
- 扶椅背单腿站（平衡）：扶稳椅背，一脚离地站 10 到 30 秒，每条腿 3 次，站稳了再慢慢减掉手扶的力。
- 扶椅背坐站：从椅子站起再坐下（见 5.8），8 到 12 次，做 2 组，尽量不用手撑。
- 什么时候停：站不稳、头发晕、胸口发闷。

看电视时顺手做：

- 广告一到就起身，原地踏步或去倒杯水，两分钟。
- 靠墙静蹲：背贴墙，脚往前挪半脚，下蹲到不疼的高度，停 10 到 30 秒。
- 用弹力带或一瓶矿泉水做弯举、肩推，边看边做，做 2 组。
- 什么时候停：膝盖前侧发烫发疼、腰撑不住。

柔韧（收尾做）：肩绕环、小腿后侧拉伸、坐姿抬臂。动作慢，拉到"有点紧"就停，别弹。

- **来源**：C｜动作类别取自世界卫生组织和中国疾控中心提到的几种（提踵、坐站、单脚站等）；次数与组数按通行做法给，没有专试"看电视时该做几组"的研究。
- 特别提醒：**对谁成立**：能独立坐、能扶站的人。用助行器、做过关节置换、有严重骨质疏松的人，先让康复师把动作排一遍。
- **换回来的**：自理——不再怕"想动，又不知道从哪个动作开始"

- **在中国怎么落地**：这些动作在家就能做；要人看着做，去社区活动室或社区卫生服务中心问有没有健身指导。

13.7 出现这些，先停下、先问医生

运动当中，只要出现下面任何一条，马上停，别硬撑：胸口发闷、发紧、发疼，或疼往肩膀、胳膊、下巴上串；头发晕、眼前发黑、想吐；气短得说不出话，心跳乱得慌；直冒冷汗。

北京 120 提醒，运动中出现胸闷要警惕，及时打 120（官方口径：北京市卫生健康委员会，2022 年）。出现说不清话、半边身子没劲，直接打 120。

下面几种情况，动之前必须先问医生：最近发生心梗、脑卒中，或刚出院；血压、血糖控制得很不稳；骨头上长过转移灶（比如癌症骨转移），或最近骨折过；发热、感染、急性病还没好；慢性病患者，我国指南写明运动前应咨询医生、在专业人员指导下进行（官方口径：《中国人群身体活动指南（2021）》）。

如果是肿瘤病人，一份中国专家共识把这条线画得更细：有骨转移、已经出现病理性骨折或脊髓压迫的，不适合锻炼；有骨转移、或已知/疑似骨质疏松的，不做常规的肌力和肌耐力测试；急性全身疾病、发热、脑出血或脑血栓急性期，都先别动（第三方研究：《中国恶性肿瘤患者运动治疗专家共识（2022 年版）》）。

- **来源**：B｜"胸闷心慌要立即停止、就医"是官方材料反复写的；骨转移、发热急性病这两条，有中国专家共识逐条写明（见来源）；"最近骨折过"这一条属骨科康复的通行做法，没核到专门的指南条目。
- 特别提醒：**对谁成立**：所有人；有心脏病、糖尿病、骨质疏松、肿瘤病史的人，线要画得更紧。
- **换回来的**：自理加钱——不再怕"怕运动中出事，又不知红线在哪"
- **在中国怎么落地**：急救打 120；把这几条念给社区家庭医生听，请他给你划一次线。

13.8 疼就停是错的，但要分清哪种疼

"疼了就不动"和"疼也要练"一样糟。要分的是两种疼。

- 练得对的酸：酸在肌肉里，运动后一两天才到，动一动、歇一歇会轻，多半是新动作或加了量的反应。
- 该停的痛：痛在关节里（膝盖、肩膀），运动中就出现，某个方向一动就"卡"一下或像针扎，或者越练越疼、还肿。这是身体在喊停。
- 怎么用：肌肉酸，可以继续低强度动；关节刺痛、卡顿、肿胀，先停下，去挂骨科或康复科。
- **来源**：C｜"肌肉酸痛与关节损伤痛要分开、后者要就医"是运动医学通行说法，各医院科普口径一致，没有分级指南。

- 特别提醒：**对谁成立**：能分清"酸"和"痛"、还能正常活动的人。夜里疼醒、疼到影响睡觉、或伴着发烧的，尽快看医生。
- **换回来的**：自理——不再怕"一动就疼，也不知道该不该忍"
- **在中国怎么落地**：挂骨科或康复医学科门诊；社区家庭医生也能先判断、再往上转。

13.9 久坐是最被低估的那件事

坐得太久这件事本身就有害，跟你有没有另外去运动，是两笔账。世界卫生组织 2020 年第一次把"少坐"单独写进指南：久坐要少，用任何强度的活动去替代，哪怕轻强度也算（官方口径）。

- **可以怎么做**：打牌、看电视、坐车、看手机，定个闹钟，每小时起身两分钟，倒杯水、走一圈、做几次提踵。
- 一项小型随机交叉试验给了更细的做法：11 个人分别在几种"打断久坐"的方案下坐满 8 小时，只有"每 30 分钟起身走 5 分钟"这一档，餐后血糖升得明显更少；血压则用小剂量就够，每 60 分钟起身走 1 分钟降得最多（第三方研究：Duran 等，2023 年）。
- **来源**：B｜"减少久坐有益"是国际和国内指南一致口径；"每 30 分钟 5 分钟"来自一项只有 11 人的小型随机交叉试验，看的是当天的血糖血压反应，长期结局还没有定论（见 13.15）。
- 特别提醒：**对谁成立**：所有久坐的人。**但是**对完全不能站的人（轮椅、卧床），替代方案不一样，问康复师。
- **换回来的**：自理加钱——不再怕"坐一天，晚上腿肿、血糖高"
- **在中国怎么落地**：不用任何设备，手机定闹钟即可。

13.10 值得买的只有几样，值得去的地方也不多

- 值得花的小钱：一双合脚、鞋底有纹路、不太软的鞋（怎么挑见 5.6）；一条弹力带（几十元）；空矿泉水瓶灌水当哑铃。
- 可以缓买的：跑步机、动感单车这类大件。买之前问自己：上一次坚持去锻炼，坚持了几周？
- 别为这几样多花钱：甩脂机、气血循环机、"疏通"按摩器。这类功效说法属于厂商宣称，不算证据（厂商或机构宣称）。
- 场地怎么选：只想走路，小区、公园、步道，免费最好；要练平衡力量、又怕摔，去有人的地方，社区活动室、健身队；有心脏病、糖尿病、做过手术，值得花一次"运动处方"或康复门诊的钱（见 13.12）。
- **来源**：C｜"把钱花在一双好鞋和一条弹力带上"是通行建议，没有对照研究。
- 特别提醒：**对谁成立**：预算有限、又刚想开始的人。已经在健身房规律锻炼的人，不必为省钱换地方。
- **换回来的**：钱——不再怕"器材买一堆，最后全落灰"

- **在中国怎么落地**：公园和社区的免费器材点、老年大学的课，是最省的一档；去居委会问最近的场地。

13.11 靠搭子和记录坚持

动起来不难，难的是第三天下雨还去。

- 挂在已有的习惯上：把动跟一件天天做、不会忘的事绑在一起。"吃完晚饭就下楼"、"看完新闻联播就做一组坐站"。
- 找个搭子：约一个固定的人，谁不去谁欠对方一次。广场舞队、健步走队、太极队，都是搭子。
- 记录：日历上打勾、手机记步数。不用精确，勾在就行。
- 从小的开始：世界卫生组织的建议是，先做一点点，再慢慢加量和加时间（官方口径）。今天做 5 分钟，比计划"下周一开始每天 30 分钟"，更可能活下来。
- **来源**：C｜这几条行为方法是通行做法，哪一条最管用因人而异。
- 特别提醒：**对谁成立**：所有人。已经确诊抑郁、或疼得下不了楼的，先解决那件事（见第 11 章、13.12）。
- **换回来的**：关系——不再怕"一个人，动两下就停了"
- **在中国怎么落地**：搭子从社区健身队、广场舞队里找，问居委会或社区养老服务站怎么加入。

13.12 在中国怎么落地

- 小区和公园里的器材大多免费。国家在推"城市社区 15 分钟健身圈"，指步行或骑车 15 分钟内能找到场地；国家体育总局 2025 年的调查说，90.4% 的 19 岁及以上居民 15 分钟内可达（官方口径）。问一句物业或居委会，最近的器材点和大点的公园在哪。
- 想找人一起动：社区的健身操队、广场舞队、太极队、健步走队，多在公园、广场、社区活动室。去哪问：居委会、社区养老服务站、老年大学。
- 想知道动得够不够：社区和体质监测站有国民体质测定，测平衡、力量、柔韧，用的是体育总局 2023 年修订的《国民体质测定标准》（官方口径）。去哪问：社区卫生服务中心、区里的体质监测站。
- 有慢性病、做过手术、怕摔：挂康复医学科或老年医学科，让医生排一次"运动处方"，从心脏康复到防跌倒训练都有。去哪问：三级医院康复医学科门诊、社区家庭医生。
- 拿不准本地怎么申请、怎么收费：问社区卫生服务中心和居委会。具体项目和补贴各地不同，以当地最新口径为准。

13.13 如果你今天只能做一件事

把"每小时起身两分钟"设成手机闹钟，从今天下午开始。

不用换鞋，不用出门。闹钟一响，站起来走走、倒杯水、做几个提踵。久坐是这一章里最便宜能改、也最少人改的一件事。

13.14 如果你是在替爸妈看

劝爸妈动，最没用的一句话是"你得多运动"。他听见的是"你不行了"。

换个说法，用"我"开头：**"我最近坐一天腰受不了，咱俩晚饭后一起走半小时，你陪我。"** 不是让他去锻炼，是你需要他陪。老人更愿意为"被需要"出门。

他不同意时，你能做、且不用他同意的事：**先改环境**，陪他把楼下到公园的路走一遍，找出最近的免费器材点、最方便的那条平路；**找搭子，别当监工**，帮他对接一个队、一个熟人，谁叫得动他，比你说一百遍管用；**挂到他的旧习惯上**，他每天必做的那件事叫什么，把走一走挂在后面；**该看医生的看医生**，胸闷、头晕、骨头痛，先陪他挂一次号，把 13.7 那几条念给医生听。

他嘴上不认，身体会认。

13.15 本章我不确定的地方

- "每 30 分钟起身 5 分钟"这一档，来自一项只有 11 人的小型随机交叉试验，看的是当天餐后血糖和血压的急性反应；能不能换成长期少得病、少住院，还没有定论，中国人群对应的剂量也缺本土研究。本章只把它当作一个方向，不当成精确处方。
- 广场舞那项随机对照试验样本以女性为主（约 78%），干预组每周练 3 次、对照组 12 周只上 3 次健康教育课，两组接触时间并不相等；作者自己的结论也是"相关"而不是"因果"，推广到男性、或当成"广场舞一定能怎样"要谨慎。

13.16 本章数据来源

- 世界卫生组织《身体活动和久坐行为指南》（WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour，2020-11-25）：老年人每周 150–300 分钟中等强度或 75–150 分钟高强度有氧，每周至少 2 天肌肉力量，每周至少 3 天多成分（平衡加力量）训练，减少久坐，0–10 分中 5–6 分为中等强度。https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128；中文事实清单 https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity （2026-10 核对）
- 《中国人群身体活动指南（2021）》（国家卫生健康委员会疾病预防控制局指导，中国疾病预防控制中心、国家体育总局体育科学研究所牵头）：载《中国公共卫生》2022 年第 38 卷第 2 期 129–130 页。老年人部分：成年人推荐同样适用；坚持平衡、灵活性和柔韧性练习；

身体不允许则尽可能增加力所能及的活动；慢性病患者运动前咨询医生。https://www.zgggws.com/cn/article/id/46482813-3205-4c34-a7b9-73bace965e59 （2026-10 核对）

- 《健康中国行动（2019—2030 年）》全民健身行动、老年健康促进行动（健康中国行动推进委员会，2019-07-09）：经常参加体育锻炼的口径；中等强度等于最大心率 64%–76%（最大心率=220 减年龄）；国民体质测定目标。https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100133/201907/2a6ed52f1c264203b5351bdbbadd2da8.shtml （2026-10 核对）
- 《国民体质测定标准（2023 年修订）》（国家国民体质监测中心，2023-08-10）。https://www.sport.gov.cn/n315/n20001395/c25880704/content.html （2026-10 核对）
- 《老年人失能预防运动干预临床实践指南（2023 版）》（中华医学会老年医学分会护理学组等，载《中国全科医学》2023 年第 26 卷第 22 期 2695–2710 页，DOI 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0223）。https://www.chinagp.net/CN/10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0223 （2026-10 核对）
- 肿瘤患者的运动禁忌：中国抗癌协会肿瘤营养专业委员会等《中国恶性肿瘤患者运动治疗专家共识》，载《肿瘤代谢与营养电子杂志》2022 年第 9 卷第 3 期 298–311 页（骨转移合并病理性骨折或脊髓压迫者不适合锻炼；有骨转移或疑似骨质疏松者不做常规肌力评估；急性全身疾病或发热、脑出血/脑血栓急性期先不动；其运动禁忌证部分引用《冠心病患者运动治疗中国专家共识》）。https://www.ejmnc.com/CN/Y2022/V9/I3/298 （2026-10 核对）
- 力量训练与死亡风险：Momma H 等，British Journal of Sports Medicine，2022 年第 56 卷第 13 期 755 页起。https://bjsm.bmj.com/content/56/13/755 （2026-10 核对）
- 老年人肌肉力量、有氧运动与全因死亡：JAMA Network Open，2023 年（美国 65 岁及以上人群）。https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797402 （2026-10 核对）
- 中断久坐的剂量反应：Duran AT 等，Breaking Up Prolonged Sitting to Improve Cardiometabolic Risk: Dose-Response Analysis of a Randomized Crossover Trial, Medicine & Science in Sports & Exercise，2023 年 5 月（11 名中年及老年人参加 8 小时交叉试验：每 30 分钟起身走 5 分钟明显降低餐后血糖曲线下面积；降收缩压最多的是每 60 分钟起身走 1 分钟）。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36728338/ （2026-10 核对）
- 社区广场舞随机对照试验：Community-based square dancing is associated with improved physical and mental health in older adults: a 12-week randomized controlled trial in China, Frontiers in Public Health, 2026-07-14, DOI 10.3389/fpubh.2026.1758255（郑州 150 名 60–79 岁老人，随机分两组各 75 人，12 周、每周 3 次、每次 60 分钟；论文结论为"相关"；样本以女性为主约 78%，未在临床试验注册平台预注册）。https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2026.1758255/full （2026-10 核对）

· 运动胸闷警惕与 120：北京市卫生健康委员会《每周急救话题：警惕运动后"胸闷"潜在风险》（2022-11-21）。https://wjw.beijing.gov.cn/bmfw_20143/jkzs/jzjj/202211/t20221121_2863331.html （2026-10 核对）
· "15 分钟健身圈"与 90.4%：国家体育总局《2025 年全民健身活动状况调查公报》（群众体育司，2025-12-28 发布）——90.4% 的 19 岁及以上居民反映在步行或骑车 15 分钟范围内有体育场地设施，较 2020 年提高 9.7 个百分点（"15 分钟健身圈"基本实现）。https://www.sport.gov.cn/n315/n20001395/c29322175/content.html ；发布消息 https://www.sport.gov.cn/n20001280/n20745751/c29327174/content.html （2026-10 核对）

第 14 章 · 疫苗、筛查和体检单

年底，一通电话打过来：“加两项肿瘤标志物吧，才几百块。”你花了小两千。报告回来，七八个箭头朝上，末尾一行小字：“建议进一步检查。”

14.1 这一章解决什么问题

体检这件事上，很多人心里有条默认公式：**查得越多越安心，花得越多越保险。**

这条公式是错的。一份两千八的套餐，加的项目越多，越可能是你不必做的；一次免费的国家体检，很多人却嫌麻烦没去。

压成一句：**疫苗、筛查、体检单，做哪些，看你的年龄和风险，不是套餐的价格。** 老规矩是“多查没坏处”，到你这个年纪要改一个字：**有些查，是有坏处的。**

14.2 流感疫苗：一年一针，9 到 10 月打

- **要花多少**：几十到一两百元，每年一次（钱：花不了几个钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）；不少城市 60 岁以上免费。
- **简单说**：流感对年轻人是难受一周，对你可能是肺炎、住院。这一针每年都要打，是最便宜的一针。
- **可以怎么做**：每年都打（病毒每年变）；放在 9～10 月，流行季之前；错过也别放弃，整个流行季都能补。
- **来源**：A｜中国疾控中心《中国流感疫苗预防接种技术指南（2026—2027）》把 60 岁及以上老年人列为优先接种人群（官方口径）。
- 特别提醒：**对谁成立**：几乎所有 60 岁以上的人；正在发热或对疫苗成分严重过敏的，先问医生。
- **换回来的**：自理＋钱——不再怕"一场流感把身体拖垮"
- **在中国怎么落地**：去社区卫生服务中心或接种门诊打；北京 60 岁及以上京籍老人免费（北京市卫健委，2025-09-11，官方口径）。

14.3 肺炎球菌疫苗：60 岁以后那一针 23 价

- **要花多少**：一两百到三四百元，通常一生一次（钱：花不了几个钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）；部分城市 65 岁以上免费。
- **简单说**：肺炎链球菌是老年人肺炎里最常见的“凶手”之一。这一针防的不是普通感冒，是那种会让你躺进病房的肺炎。

- **可以怎么做**：国内老年人常用 23 价肺炎球菌多糖疫苗（PPSV23），基础打 1 针；免疫功能正常的人通常不再重复；有高危因素、上次接种已超 5 年的，可和医生商量再补 1 针。13 价结合疫苗（PCV13）对老年人也有保护，2024 年版的老年肺炎共识把 23 价和 13 价并列推荐；但国内 13 价的说明书适应人群仍是儿童，老年人用属于超说明书，要由医生评估。
- **来源**：A｜《老年人流感和肺炎链球菌疫苗接种中国专家建议》（中华老年医学杂志，2018 年）建议 60 岁及以上老年人接种 PPSV23（官方口径）；《老年肺炎临床诊断与治疗专家共识（2024 年版）》推荐老年人接种 PPV23 或 PCV13，证据等级 I B（第三方研究）。
- 特别提醒：**对谁成立**：60 岁以上、尤其有慢性心肺病、糖尿病的人。用哪种、打几针，问接种门诊的医生。
- **换回来的**：自理＋钱——不再怕"一场肺炎就住进重症病房"
- **在中国怎么落地**：到社区卫生服务中心接种门诊；北京 65 岁及以上京籍老人、未接种过 23 价肺炎疫苗的，可预约、评估后免费接种 1 剂（北京市卫健委，2025-09-11，官方口径）。

14.4 带状疱疹疫苗：50 岁以后值得，先问清价钱和地方优惠

- **要花多少**：自费两针，原价上千元级别；不少地方在做“打一针免一针”的限时惠民活动，有明确的起止日期（钱：花钱不少｜工夫：两针，间隔 2～6 个月｜力气：不费｜要开口吗：好开口）。
- **简单说**：带状疱疹俗称“缠腰龙”，最折磨人的不是那串水疱，是水疱好了还疼几个月的神经痛。年纪越大越容易得，也越疼。
- **可以怎么做**：50 岁以上、免疫正常的人可自愿打重组带状疱疹疫苗，打 2 针、间隔 2～6 个月；得过水痘或带状疱疹的人仍可打；自费疫苗，去前先问价格和当地优惠。
- **来源**：A｜两种获批疫苗的适用年龄和接种程序见中国疾控中心科普（2025-07-14）（官方口径）。
- 特别提醒：**对谁成立**：50 岁以上、免疫正常的人最值得。免疫功能缺陷或正用免疫抑制剂的，不推荐减毒活疫苗，能否打重组疫苗要和医生一起权衡。
- **换回来的**：自理——不再怕"疼起来像火烧、像针扎，一疼几个月"
- **在中国怎么落地**：去当地预防接种门诊自费接种；内蒙古、山西、上海部分区等地做过“打一针免一针”的限时活动（内蒙古自治区疾病预防控制局，2025-05-09，官方口径）。以内蒙古为例，2025-05-06 至 2025-08-31 完成第 1 剂、2025-12-31 前完成两剂全程的 50 周岁及以上人群，第 2 剂免费（不含每剂次接种服务费）。本地有没有、到什么时候，以当地最新通知为准。

14.5 打之前和打之后：拿不准的都问接种门诊的医生

- **要花多少**：多问几句话（钱：不用花｜工夫：几分钟｜力气：不费｜要开口吗：好开口）。
- **简单说**：打完针胳膊疼、有点发热乏力，多半正常，一两天就过去。真正要问的是你拿不准的：我这种病能不能打，吃的药冲不冲突。

- **可以怎么做**：打前把正在吃的药、正在得的病、以前的过敏史告诉医生；正在发热或急性病发作，缓一缓；打完坐满 30 分钟再走；出现高热不退、大范围起疹、喘不上气，立刻去医院并说明刚打过什么疫苗。
- **来源**：B｜这是各类疫苗接种的通行做法；具体禁忌要看那一种疫苗的说明书和你的身体状况。
- 特别提醒：**对谁成立**：所有人。能不能打、什么时候能打，只有现场评估的医生能定。
- **换回来的**：自理——不再怕"万一打错了、打出事"
- **在中国怎么落地**：接种门诊的医生会做现场评估、请你签知情同意书；拿不准的就问他。

14.6 结直肠癌：40 岁起、按风险算分，先查大便

- **要花多少**：查大便几十元，肠镜几百到上千（钱：花点钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情，肠镜有点难为情）。
- **简单说**：肠子里的息肉要长很多年才变成癌，这段“给你留时间”的窗口，是筛查里最划算的一个。怕做肠镜，可以先查大便，阳性再去做肠镜。
- **可以怎么做**：国家方案按年龄、性别、吸烟、体重指数、一级亲属病史算分，累计到 4 分及以上算高风险；高风险且没得过的人，推荐 40～74 岁开始查；首选肠镜，不接受可选每年查大便等替代方法；没查到病变的，肠镜可隔 5～10 年再做。
- **来源**：A｜国家卫生健康委《结直肠癌筛查与早诊早治方案（2024 年版）》（官方口径）。
- 特别提醒：**对谁成立**：有家族史、长期吸烟、体重偏高的人更该查。已经便血、排便习惯变了、不明原因消瘦的，那不是筛查，是就诊，直接看消化科。
- **换回来的**：自理——不再怕"等有感觉了，已经是中晚期"
- **在中国怎么落地**：社区卫生服务中心能做风险评估和粪便潜血；做肠镜挂消化内科。有些城市有“城市癌症早诊早治项目”免费名额，去社区问。

14.7 乳腺癌和宫颈癌：35 到 64 岁，很多地方免费查

- **要花多少**：政府项目内免费（钱：花不了几个钱｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情）。
- **简单说**：这两样是少数“查了真能把死亡率降下来”的癌症。国家给了免费通道，尤其照顾农村妇女和城镇低保妇女。
- **可以怎么做**：很多地方的免费筛查对象是 35～64 周岁妇女，优先保障农村妇女、城镇低保妇女；宫颈癌查妇科检查加初筛（细胞学或 HPV 检测），有问题的再做阴道镜、取组织；乳腺癌查乳腺体检加乳腺彩超，必要时加钼靶。
- **来源**：A｜国家卫生健康委《宫颈癌筛查工作方案》《乳腺癌筛查工作方案》文件解读（2022-01-18）（官方口径）。

- 特别提醒：**对谁成立**：35～64 岁的女性。这个年龄段以外、或已有症状（摸到肿块、异常出血）的，直接挂号去查，别等免费轮次。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"查出来太晚、白受一场罪"
- **在中国怎么落地**：去社区卫生服务中心、乡镇卫生院或妇联，问本地“两癌”免费筛查怎么报名，以当地最新口径为准。

14.8 肺癌低剂量 CT：只对高危，不是人人都照

- **要花多少**：几百元一次，一般一年一次（钱：要花些钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）。
- **简单说**：低剂量 CT 有用，但只对一部分人有用。不吸烟、没有别的风险的人年年照，照到的大多是虚惊一场，辐射却是真的。
- **可以怎么做**：先对号，看你算不算国家定的“高风险人群”：**年龄 50 岁及以上**，且符合下面任意一条：吸烟量达到 20 包年（含已戒烟但不满 15 年的）；长期和吸烟的人一起生活或同室工作 20 年以上；有慢阻肺；有石棉、氡等职业暴露 1 年以上；父母、子女、兄弟姐妹里有人得过肺癌。符合的，50～74 岁原则上每年做一次。
- **来源**：A｜国家卫生健康委《肺癌筛查与早诊早治方案（2024 年版）》（官方口径）。
- 特别提醒：**对谁成立**：上面五条里占一条的人。不属高危的人，**不推荐用肿瘤标志物、胸片、PET-CT 来做肺癌筛查**，这是方案里写明的。
- **换回来的**：自理＋钱——不再怕"该照的不照，不该照的年年照"
- **在中国怎么落地**：低剂量 CT 多数医院和体检中心都能做；是不是高危、要不要每年照，让呼吸科或胸外科医生定。

14.9 前列腺和甲状腺：不推荐全民筛查

- **要花多少**：抽一管血（PSA）几十元，一个超声几十到一百多元（钱：花不了几个钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：好开口）。
- **简单说**：这两项在套餐里几乎白送，但“查得到”不等于“该查”。查出一堆结节、一个偏高的指标，接着是一场场没必要的检查和手术，人先被吓垮。
- 可以怎么做：**前列腺（PSA）**不是人人抽一管就行，国内指南限定在“预期寿命 10 年以上、且属高风险”的人：年龄 60 岁及以上，或 45 岁以上有前列腺癌家族史，或 40 岁以上携带 BRCA2 基因突变，且要“充分了解利弊后，结合专科医生建议”再决定。**甲状腺**：国家卫健委的诊疗指南写明“并不推荐对一般人群行甲状腺肿瘤的筛查”，只有有童年头颈部放射史、全身放疗史等高危因素的人才需早查。
- **来源**：A｜国家癌症中心《中国前列腺癌筛查与早诊早治指南（2022，北京）》；国家卫生健康委《甲状腺癌诊疗指南（2022 年版）》（官方口径）。

- 特别提醒：**对谁成立**：没有家族史、没有症状、也没有医生建议的人，这两项可以不做。查出异常（PSA 偏高、甲状腺结节）不等于得癌，先找专科医生解读，也别急着手术。
- **换回来的**：面子＋钱——不再怕"被一份套餐牵着，做一堆没必要的检查"
- **在中国怎么落地**：套餐里被“送”了这两项，不代表你该查；要不要查，挂泌尿外科或内分泌科问医生。

14.10 体检单怎么看：该管的、可以观察的、容易被推着往下查的

- **要花多少**：一张纸，慢慢看（钱：不用花｜工夫：半小时｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）。
- **简单说**：一张单子上七八个箭头，不等于你有七八个病。套餐的卖点是“项目多”，不是“项目对”。
- 怎么做（先分三类）：**该管的**是血压、血糖、血脂、腰围、体重，对应能干预、也最要命的心血管和代谢问题，异常了按医生说的管；**可以观察的**是轻度的肝肾功能波动、单个甲状腺结节、小囊肿，很多可以半年、一年复查一次，不必当天就冲去挂专家号；**最容易被推着往下查的**是顺带加做的肿瘤标志物升高、一个说不清的小阴影，常引出一长串“进一步检查”，最后大多没事，钱花了、惊吓也受了。
- 套餐怎么识别：听到“加两项肿瘤标志物才几百块”“全身 CT 大优惠”“名额有限今天定”，先慢一步。肿瘤标志物不是癌症筛查，国家方案明确不推荐用它筛肺癌；没症状做全身 CT，照到的多是虚惊，辐射是真的。
- **来源**：B｜“肿瘤标志物不用于普通癌症筛查”见国家方案；指标分层和套餐话术按通行做法与公开提醒整理。
- 特别提醒：**对谁成立**：所有拿到体检单、或常接到体检推销电话的人。箭头不等于诊断，把整张单子拿给全科或家庭医生看一遍，别单项去网上查。
- **换回来的**：钱＋面子——不再怕"被箭头吓得睡不着、被套餐牵着走"
- **在中国怎么落地**：社区卫生服务中心的全科门诊、签约的家庭医生都能帮你读体检单，也能帮你判断套餐里哪些项目不必加。

14.11 65 岁以上的免费健康管理：不花一分钱的那一次

- **要花多少**：免费，国家出钱（钱：不用花｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）。
- **简单说**：这是国家给 65 岁以上常住居民的一年一次免费体检，很多人不知道，或嫌麻烦没去。该拿的，别丢。
- **可以怎么做**：去辖区社区卫生服务中心或乡镇卫生院，每年一次：生活方式和健康状况评估；体格检查，含血压、体重，并对口腔、视力、听力、运动功能做粗测；辅助检查，含血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂、心电图、腹部 B 超；健康指导。2025 年起还增加胸部 DR 正位检查和糖化血红蛋白检测，并继续做认知功能初筛。

- **来源**：A｜《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》老年人健康管理服务；2025 年新增项目见《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2025〕7 号）（官方口径）。
- 特别提醒：**对谁成立**：辖区内的 65 岁及以上常住居民（户口在不在本地，按当地口径）。只做过一次、之后年年不去的人，等于年年把这份国家体检丢掉。
- **换回来的**：自理＋钱——不再怕"该免费查的不查，倒花钱买套餐"
- **在中国怎么落地**：直接去你所在的社区卫生服务中心或乡镇卫生院，问“老年人免费体检怎么排、什么时候到我们小区”。结果会记进电子健康档案，各地正在推进向本人开放，以当地最新口径为准。

14.12 身体已经在报警，就别等下一次体检

- **要花多少**：一次就诊（钱：一次挂号的钱｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）。
- **简单说**：筛查是给“没感觉”的人做的。身体已经在明明白白报警，这就不是筛查的事，是尽快去看医生的事。
- **可以怎么做**：出现下面任何一种，别拖、别等下一年体检：不明原因地瘦，没饿自己、没减肥，几个月掉了几斤；说不清的疼痛，越来越重，夜里更厉害；出血，便血、咯血、尿血，或绝经后又出血；短期体重明显下降，或吃不下、咽不下；大便习惯变了，持续不见好。
- **来源**：B｜这些是各国“肿瘤报警症状”里反复出现的信号；具体意味着什么，只能靠就诊判断。
- 特别提醒：**对谁成立**：出现上面任何一条的人。这不是“再观察观察”的问题，尤其出血和短期消瘦，尽快挂对应科室。
- **换回来的**：自理——不再怕"身体报警了，还在等下一次套餐"
- **在中国怎么落地**：挂对应专科的号，把症状什么时候开始、怎么变化写在一张纸上带给医生；有签约家庭医生的，先打电话问挂哪个科。

14.13 一句话：查什么，看你的年龄和风险，不看套餐的价格

就留一句：**值不值得查，看的是“你的年龄＋你的风险因素＋指南”，不是套餐的价格。**

反过来用也是一把尺子：同一项检查，卖给所有人的价阶段一样、理由一样，它就不是为你算的。

那你自己算一下：**上一份体检单，有几个项目，你能说出它是针对你哪个风险的？** 说不出来的，下一份就删掉。

14.14 如果你今天只能做一件事

打开手机，查你们社区卫生服务中心的电话，打通，问三句：

> “65 岁以上免费体检怎么报名？” “今年的流感疫苗什么时候能打、免不免费？” “本地‘两癌’筛查、城市癌症早诊早治项目怎么参加？”

三句话，一个电话。该拿的福利、该打的针，从这一通电话开始。

14.15 如果你是在替爸妈看

这一章你最难的不是不知道，是怎么让爸妈肯去。

怎么跟他说出口。 别说“你该打流感疫苗了”，那是指令。换成替他省事的说法：“社区卫生服务中心这周能打流感疫苗，我陪你去，顺便把 65 岁以上的免费体检一起做了，半天搞定。”把“该做”变成“顺手、免费、有人陪”，他点头的概率高很多，而且流感和免费体检常常一次就能办完。

他不同意时你还能做什么。 三件不用他同意的事：先去社区卫生服务中心问清免费体检、两癌筛查、城市癌症早诊早治项目的报名方式，写成一张纸；把家里的疫苗本、历次体检单收在一起，你替他盯着下一次的时间；拿到体检单，别让他一个人看，你陪他把整张单子拿给全科医生读一遍。他不肯去，你先把路铺好；等他松口那天，你不用再从零开始查。

14.16 本章我不确定的地方

- 本章引用的疫苗指南和方案都按发布时的版本写。流感疫苗指南逐年更新（本章用的是 2026—2027 版），肺炎球菌疫苗的品种口径也在变，接种前以接种门诊当年的最新口径为准。
- 带状疱疹“打一针免一针”、两癌免费筛查、城市癌症早诊早治，都带有地方性：起止时间、参加门诊、年龄和筛查间隔各地不完全一样。本章按国家方案的 35～64 周岁、优先保障农村和城镇低保妇女来写，本地以最新通知为准。

14.17 本章数据来源

（核对日期：2026-10-10）

- 流感疫苗：中国疾控中心《中国流感疫苗预防接种技术指南（2026—2027）》（2026-09-02 发布），优先接种人群第 2 类为 60 岁及以上老年人，建议在 9—10 月完成接种（错过这一时段，整个流行季也都可以接种）。https://www.chinacdc.cn/jkyj/mygh02/jswj2026/202609/t20260902_1839739.html （2026-10 核对）
- 流感疫苗免费接种实例：北京市卫生健康委员会《北京流感疫苗开始接种》（2025-09-11），免费面向 60 岁及以上京籍老年人等，9～11 月为黄金时间；文中同时说明 65 岁及以上京籍老人未接种过 23 价肺炎球菌疫苗者可免费接种 1 剂。https://wjw.beijing.gov.cn/xwzx_20031/mtjj/202509/t20250910_4198380.html

- 肺炎球菌疫苗：《老年人流感和肺炎链球菌疫苗接种中国专家建议》，中华老年医学杂志 2018 年第 37 卷第 2 期，113-122 页；建议 60 岁及以上老年人接种 23 价肺炎球菌多糖疫苗（PPSV23）。https://cmab.yiigle.com/uploads/guide_html/老年人流感和肺炎链球菌疫苗接种中国专家建议.html
- 肺炎球菌疫苗（品种口径更新）：中国老年医学学会呼吸病学分会《老年肺炎临床诊断与治疗专家共识（2024 年版）》，中华结核和呼吸杂志 2025 年第 48 卷第 1 期 18–34 页，DOI 10.3760/cma.j.cn112147-20240611-00328：推荐老年人接种 23 价肺炎链球菌多糖疫苗（PPV23）或 13 价肺炎链球菌结合疫苗（PCV13），证据等级 I B。https://rs.yiigle.com/cmaid/1526373 （2026-10 核对）
- 带状疱疹疫苗：中国疾控中心科普《带状疱疹疼起来很“要命”，如针扎，似火烧！》（2025-07-14），重组带状疱疹疫苗适用于 ≥50 岁、2 剂、间隔 2～6 个月。https://www.chinacdc.cn/jkkp/mygh/ymyf/202507/t20250714_308334.html
- 带状疱疹惠民活动实例：内蒙古自治区疾病预防控制局《【图解】“打一针免一针”重组带状疱疹疫苗减免接种惠民活动开始啦》（2025-05-09）。https://wjw.nmg.gov.cn/hdjl/zcwdk/ymjz/202505/t20250509_2719906.html
- 结直肠癌与肺癌筛查：国家卫生健康委办公厅《关于印发肺癌筛查与早诊早治方案（2024 年版）和结直肠癌筛查与早诊早治方案（2024 年版）的通知》（国卫办医急函〔2024〕281 号，2024-08-27）。https://www.nhc.gov.cn/ylyjs/gzdt/202408/42f43b5f0c4c4ebe90c78ee127959b92.shtml
- 两癌筛查：国家卫生健康委《〈宫颈癌筛查工作方案〉和〈乳腺癌筛查工作方案〉文件解读》（2022-01-18），对象为 35～64 周岁妇女，优先保障农村妇女、城镇低保妇女。https://www.nhc.gov.cn/fys/c100077/202201/13c9867243e0447f88d0a5e33c394d89.shtml
- 前列腺癌筛查：国家癌症中心《中国前列腺癌筛查与早诊早治指南（2022，北京）》，中华肿瘤杂志 2022 年第 44 卷第 1 期；高风险人群定义、建议筛查起始年龄 60 岁。https://urology.wiki/Guidelines/Cancers/Prostate/2022中国前列腺癌筛查与早诊早治指南.pdf
- 甲状腺癌筛查：国家卫生健康委《甲状腺癌诊疗指南（2022 年版）》（全文 65 页）。“二、诊疗技术和应用（一）高危人群的监测筛查”原文：“并不推荐对一般人群行甲状腺肿瘤的筛查”；高危人群（童年期头颈部放射线照射史、全身放射治疗史等）应尽早筛查。https://www.nhc.gov.cn/cms-search/downFiles/c19a52f5afca4b4a84d92f140fece9c7.pdf ；期刊转载见《中国实用外科杂志》2022 年第 42 卷第 12 期 1343–1357 页，DOI 10.19538/j.cjps.issn1005-2208.2022.12.02（https://www.zgsyz.com/zgsywk/CN/10.19538/j.cjps.issn1005-2208.2022.12.02）（2026-10 核对）

- 65 岁以上免费健康管理：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》老年人健康管理服务；2025 年新增胸部 DR 正位检查和糖化血红蛋白检测，见国家卫生健康委等《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2025〕7 号，2025-06-26）。https://www.nhc.gov.cn/jws/c100073/202506/14a23782324542f59137bbf24a1c988f.shtml
- 城市癌症早诊早治项目：国家重大公共卫生服务项目，针对肺癌、结直肠癌、上消化道癌、乳腺癌、肝癌五类进行免费高危评估与筛查（深圳政府在线，2026 年项目启动公告）。https://www.sz.gov.cn/ztfw/ylws/wyk_183937/content/post_12882688.html
- 体检项目框架参考：中华医学会健康管理学分会《健康体检基本项目专家共识》（中华健康管理学杂志 2014 年第 8 卷第 2 期），采用“1+X”框架，“1”为基本项目、“X”为针对不同风险的专项项目。https://studite.yiigle.com/uploads/guide_html/健康体检基本项目专家共识.html

篇四 · 把家、钱、人、权限安排好〔阶段三〕

第 15 章 · 住哪儿、和谁一起老

你在这间屋子里住了三十年。闭着眼也知道灯在哪、门口那级台阶有多高。

最近你慢下来了两件事。楼道的台阶，扶着栏杆也越走越小心；夜里起夜，不太敢开大灯。你没跟谁说——说了也像自己吓自己。

真到要决定住哪儿的时候，往往不是现在，是某一次摔倒出院之后，是老伴先走之后。那时候，多半是别人替你做这个决定。这一章想把它往前挪一挪。

15.1 这一章解决什么问题

住哪儿、和谁一起老，是晚年最贵的一次选择——钱上贵，错过的时间更贵。它几乎总在出事之后才被动地选：摔了一跤，出院才发现楼梯上不去；房子卖了搬去子女家，才发现医保还在老家、话也听不懂。

每种住法都写清四件事——适合谁、真实成本（钱／时间／体力／面子）、怎么先试一次、什么时候不成立。

15.2 居家：先过三道关卡，再谈把机构那张床搬回家

- **要花多少**：小改几百元，大改几千到几万元，补贴看地方；家庭养老床位的服务费按月另算（钱：花钱不少｜工夫：几天到几周｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：老房子还住不住得下去，先看三样——楼能不能装电梯；门口屋里有几级台阶；厕所是蹲的还是坐的。
- **可以怎么做**：① 电梯：查本楼能不能加装，多层老楼加电梯现在有法律支持（《无障碍环境建设法》第 22 条）。② 台阶：入户、楼道、卫生间的高差，加斜坡或扶手。③ 蹲厕：改坐便或加坐便椅。改哪最值：卫生间、玄关、床到厕所那条路（见第 5 章）。先试一次——先只改卫生间。
- 家庭养老床位：不是买床，是把上门照护、适老化改造、智能设备搬进家。先做能力评估（GB/T 42195-2022），评到轻度及以上失能才符合；再去社区问怎么申请、谁出钱。
- **来源**：A＋B｜世卫组织把居家评估与改造列为防跌倒做法之一，补贴方向在民发〔2020〕86 号；家庭养老床位有民政部标准（MZ/T 234-2024），到 2024 年底国家项目支持 184 个地区建 35.8 万张。**但是**改哪一处效果因家而异。
- 特别提醒：**对谁成立**——还能自己走、房子是自己的或长期租的人；床位只给轻度及以上失能的人。60 岁健康人先解决台阶和照明；75 岁共病先做卫生间扶手、防滑和夜灯；已失能只靠改造不够，要接床位或上门照护。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"在家处处是坑"、"养老不离家又怕没人管"
- **在中国怎么落地**：问社区、街道、区民政局，改造和家庭养老床位怎么申请、补不补。以当地最新口径为准。

15.3 社区养老：日间照料和上门服务，能替你干哪几件事

- **要花多少**：单次几十元，或走政府购买、补贴（钱：花不了几个钱｜工夫：按次｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：社区能替你做的，主要是小事——白天有个地方去、有人陪、管一顿饭；上门的管助餐、助浴、助洁、助医、助行。它替不了夜里和突然发作的急病。
- **可以怎么做**：去社区养老服务站或街道养老服务中心要一张服务清单，问清三件：能上门做什么、怎么收费、几点到几点。日间照料中心是"白天入托、晚上回家"。先试一次——先约一次上门助餐或助浴，看人来不来。
- **来源**：B｜居家养老上门服务有国家标准（GB/T 43153-2023），日间照料中心也有服务基本要求国标。**但是**各地站点密度、服务质量差别大，有站点不等于用得上、用得起。
- 特别提醒：**对谁成立**——还住自己家、行动不算太差的人。60 岁健康人大多用不上；75 岁共病最用得上，尤其助餐、助医和白天有人陪；已失能需要专业照护，社区多半接不住重症那部分。
- **换回来的**：自理＋关系——不再怕"一个人在家，白天没人，饭也懒得做"
- **在中国怎么落地**：问社区养老服务中心；吃饭问社区食堂（见第 12 章）。以当地最新口径为准。

15.4 机构：出现这几个信号，就该去看了

- **要花多少**：民办月费几千元起，护理等级越高越贵；公办便宜但排队（钱：花钱多｜工夫：先看再定｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情）
- **简单说**：该考虑机构，不是"老了"这句含糊话，是几个信号：一个人住；夜里摔倒过；走不动也不再出门；照顾的人先垮了；需要专业护理。凑够两条就该去看，别等出事。
- **可以怎么做**：像看房一样看，问三件：① 有没有民政部门的等级评定（GB/T 37276-2018）；② 几位护理员管几位老人、夜里有没有人值班、最近医院多远；③ 收费明细、退住怎么算、预收费有没有进银行存管。先试一次——问能不能试住几天。公办多兜底特困、价格低但要轮候，民营入住快、价格和服务差别大。
- **来源**：C｜"先试后定"是通行做法，但国家层面没有统一的"试住／短住"规定，各地机构的政策和费用不同，只能到本地民政或机构问；公办机构有评估轮候办法（如上海，见来源表），民营没有统一尺度。
- 特别提醒：**对谁成立**——家里照顾接不住、或需要专业护理的人。60 岁健康人多数还早；75 岁共病先看家里有没有人能 24 小时接住；已失能常常是刚性需要。有些老人最后住进机构，是家里人替他定的。
- **换回来的**：关系＋体面——不再怕"哪天倒下了，家里没人接得住"
- **在中国怎么落地**：问区民政局或本市养老服务网，签合同前先看预收费。以当地最新口径为准。

15.5 抱团养老：杭州那栋别墅，和它后来的教训

- **要花多少**：分摊房租（一处房子几个人分摊），生活费 AA（钱：要花些钱｜工夫：长期｜力气：有点累｜要开口吗：难开口，最容易为钱翻脸）
- **简单说**：抱团养老就是几个老人自愿住一起、互相照应、分摊开销。杭州 13 位老人合住一栋别墅，一度被当成样板。样板后面有代价——散伙的头一个原因，是钱谈不拢。
- **可以怎么做**：先试一次，别一次签很长，更别把自家房子卖了去凑。先合住一个月、一个季节，试出三件事：谁买菜做饭、钱怎么分摊、有人生病谁管——搬进去之前先写清。
- **来源**：B｜杭州那一栋（2017 年、余杭、13 位老人、约 500 平方米）确有其事，2018 年新华网和央视都报道过。这类抱团为什么难持久，2021 年一篇报道（北京晚报，央视网转载）写得更直白：受访者说"钱让这个团儿抱不紧"，报道还点出郊区医疗配套跟不上；民政部养老服务业专家委员会委员乌丹星说，自发抱团"没什么约束力"。
- 特别提醒：**对谁成立**——生活能自理、性格合得来、手头差不多的人。60 岁健康人相对可行；75 岁共病要慎，郊区抱团缺专业医疗护理，风险大；已失能基本不成立。
- **换回来的**：关系＋钱——不再怕"一个人太孤独"，又怕"抱团最后翻脸"
- **在中国怎么落地**：抱团无官方保障，纠纷只能自己防——出资、分摊、退出、生病谁管白纸黑字写清；上海嘉定"慈舟养老院"众筹抱团十几年后相继搬离，是一例。

15.6 互助养老与时间银行：南京的账，和它撑不起来的原因

- **要花多少**：志愿服务不花钱，换的是将来的服务时间（钱：花不了几个钱｜工夫：按次数｜力气：有点累｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：时间银行是"今天我帮你，把时间存下，以后别人用同样的时间帮我"。难处不在这套记账法子，在"存进去的时间，将来兑不兑得出来"。
- **可以怎么做**：去社区问本地有没有互助养老站点、怎么注册、服务怎么登记兑换。先试一次——先做一次短时服务，看平台记不记、兑不兑。南京可当参照：民政部门 2026 年 6 月的数据是 1300 多个站点、覆盖 99% 以上城乡社区、注册志愿者 9.4 万人、累计订单 147 万个、存储服务时间 92 万小时；2024 年年中时是志愿者 6.1 万人、服务对象 13.2 万人。
- **来源**：A＋B｜南京是政府主导的全市平台（2019 年试点，2023 年更名）；上海 2021 年也在全市推行了养老服务时间银行（沪民养老发〔2021〕28 号）。2026 年民政部等 11 部门出《关于推进互助性养老服务发展的意见》（民发〔2026〕11 号），首次在国家层面定义互助养老，定下到 2030 年覆盖率不低于 70%。**但是**研究普遍指出它撑不起来的两个原因——法律与监管不健全、参与度不足（见文末说明）。
- 特别提醒：**对谁成立**——身体还好、时间富余的低龄老人（六十多岁）最适合当提供者；75 岁共病能做轻服务、也最需要用；已失能是服务对象。别把急难护理押在它上面。
- **换回来的**：关系＋体面——不再怕"老了还有用"、"身边有个能搭手的人"
- **在中国怎么落地**：问社区或民政，本地有没有互助养老试点平台。以当地最新口径为准。

15.7 旅居、候鸟养老：先分清是养老，还是投资

- **要花多少**：正常旅居按月或按季付房租、床位费；要你"提前交一大笔、承诺返本付息"的，那不是养老（钱：花钱不少｜工夫：按季｜力气：有点累｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：身体还好的老人，冬天去南方、夏天回北方，这么过没问题。要防的是另一件事——打着"旅居养老"、"候鸟养老"的旗号，让老人提前投一大笔钱。
- **可以怎么做**：守三条底线。① 只按月或按季付，不预付大额，不交会员费、贵宾卡、保证金。② 不签承诺返本付息的合同。③ 大额投入前隔一天再办，问子女、问社区、问民政。先试一次——先短住一个季节，按现付价，别一上来就买卡。
- **来源**：A｜民政部 2023 年专门发过养老领域非法集资的风险提示；2025 年最高检一起"养老金融"案，以提供养老公寓、旅居基地为噱头，非法集资超 50 亿元。**但是**正规旅居、康养服务是存在的，区别就在"要不要你先掏一大笔"。
- 特别提醒：**对谁成立**——身体尚好、有闲钱、能自己安排行程的人。60 岁健康人相对可行；75 岁共病要慎，异地就医是短板；已失能不适合长途旅居。要你先投大钱的，对哪个年龄段都不成立。
- **换回来的**：钱——不再怕"被人拿旅居的名义把钱套走"
- **在中国怎么落地**：异地看病先办异地就医备案；遇"预付高额、返利"的先打 110 或 12315。以当地最新口径为准。

15.8 老漂族：跟着子女走，有几笔账要先算

- **要花多少**：不额外花钱，但医保、熟人、身份要重新铺一遍（钱：花不了几个钱｜工夫：长期｜力气：有点累，带孙辈更累｜要开口吗：得开口，有点难为情，在子女家像做客）
- **简单说**：老漂族是离开老家、到子女城市生活的老人，多数去带孙辈。难处在异地就医报销、语言不通、老朋友全没了、本地福利落不到头上。
- **可以怎么做**：三件先办。① 异地就医备案，办好，门诊住院才能直接结算。② 问当地社区养老服务站：没本地户口能享受什么。③ 找一个能说话的人或圈子，别把日子全拴在孙辈身上。先试一次——先住一个季度，别急着处理老家房子。
- **来源**：B｜规模没有单一官方口径：国家卫健委《中国流动人口发展报告 2018》说随迁老人近 1800 万，占当时 2.47 亿流动人口的 7.2%；2020 年第七次全国人口普查后，有媒体据普查数据测算 60 岁及以上老年流动人口约 3327 万余。两者年份、口径都不同，本书不合并成一个数，读者按"千万量级"理解即可。
- 特别提醒：**对谁成立**——身体还好、愿意去、和子女关系过得去的人。60 岁健康人可行；75 岁共病要慎，长期异地就医是难点；已失能随迁，照护会全压到子女身上。
- **换回来的**：关系——不再怕"老了还要漂着"、"在子女家不自在"
- **在中国怎么落地**：异地就医先备案（国家医保服务平台 App 或参保地医保局）；社区服务能不能用问社区。以当地最新口径为准。

15.9 搬家和一个人住，先安排两件事

- **搬家**（钱：要花些钱｜工夫：几周｜力气：挺累，对高龄人尤其｜要开口吗：得开口，有点难为情）
- **简单说**：搬家对高龄人不是换个地址，是把人从熟悉的地方整个拔出来。越老、越容易在搬完这半年出问题。
- **可以怎么做**：真要搬就分步走。① 能分开就分开，别同一天又断掉所有老关系。② 新住处尽量保留熟悉的布局。③ 对已经认不清路的人，搬前先问医生。
- **来源**：B｜有研究显示，老人搬家与健康结局、与"新住处和旧习惯合不合"有关（见来源表）。**但是**研究结论并不一致。
- 特别提醒：**对谁成立**——所有人，尤其 75 岁以上、共病、认不清路的人风险更高。60 岁健康人搬家的风险小。
- **换回来的**：自理——不再怕"换个地方，人就散了、就糊涂了"
- **一个人住，定一份"报平安"的约定**（钱：不用花｜工夫：十分钟定好｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：独居最怕的不是没人管，是出了事没人知道。解决它是件小事：和子女、邻居或朋友约一个联系的法子。
- **可以怎么做**：① 每天一个固定时点报个平安，一个电话或一条消息都行。② 约好"多久没动静就打电话，再多久就上门"。先试一次——从今天起约个上午报平安，连试一周。
- **来源**：C｜通行做法。各地对独居、空巢、留守老人有探访安排（民发〔2022〕73 号）。**但是**探访兜不住应急。
- 特别提醒：**对谁成立**——独居、空巢、留守老人，尤其高龄、共病。60 岁健康人约定轻一点；75 岁共病定得更密；已失能还独居风险最高。
- **在中国怎么落地**：社区、街道登记独居、空巢信息，纳入探访；可装一键呼叫、跌倒检测设备。

15.10 在中国怎么落地：四个能问出答案的地方

- **街道、社区的养老服务中心（站）**：家庭养老床位、日间照料、上门服务、互助养老站点、独居探访，先来这里问。
- **民政部门（区民政局、市养老服务网）**：机构名单和等级评定、公办机构轮候办法、适老化改造补贴。
- **长护险**：中办、国办 2026 年 3 月印发《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，用 3 年左右、到 2028 年底在全国基本全覆盖，费率约 0.3%。失能评估怎么申请、本地补多少，问当地医保部门或承办机构。
- **老年助餐**：按民发〔2023〕58 号，各地在推助餐点，很多地方对高龄、失能、独居老人分类补贴。问社区这一片有没有助餐点、能不能送上楼。

各地项目、补贴、门槛不一样。以当地最新口径为准。

今天只能做的一件事

站到你家门口，或者楼道里，数一数：从进门到坐下、从床边到厕所，有几级台阶。

然后给这几级台阶，装或者借一根能扶的东西——一根墙上的扶手，一根门口的柱子都行。就今天，就这一处。

台阶是很多老人天天要走、却从没数过的一处。数清了，你就知道这房子还住不住得下去。

如果你是在替爸妈看

有一件事得你先开口。他多半不会主动说"我这儿住着不方便"，你要把这句话递给他，但别用"你该换个地方住了"这种口气。能替他做的动作，有这么几个：

- **先替他把房子过一遍**：趁回家看清三处——楼道几级台阶、厕所是蹲是坐、夜里从床到马桶有没有灯。看完先不说教，先自己动手改一处，钱你出。
- **去社区问一次**：这一片有没有助餐点、上门服务、独居探访，适老化改造怎么申请。问清楚了，再把选项摆给他——是他挑，不是你定。
- **约一次能试的**：机构有没有短住，社区有没有体验，家庭养老床位能不能先评个能力。先试，不做决定。
- **异地这几件事先办了**：他若跟着你漂，异地就医备案先办上；再把社区电话贴到他床头。
- **留一个报平安的口子**：跟他约好每天一个时点报个平安，说清是"我想知道你好着"，不是"我盯着你"。

先把能动手的那一件做了，比等他点头管用。

本章我不确定的地方

- 养老机构"试住／短住"：国家层面没有统一规定，各地政策和费用不同，本章只写"先问能不能试住"，没有逐地核到具体标准。
- 老漂族规模没有单一官方口径：国家卫健委 2018 年报告称随迁老人近 1800 万，媒体据 2020 年七普数据测算老年流动人口约 3327 万余，年份、口径都不同，本章写成区间，没有合并成一个数。
- 抱团养老"散伙比例"一类说法（网上流传的"超过六成"、"90%"、"34.2%"等）核不到权威出处，一律不采用。
- "搬家对高龄人健康的影响"本章只作方向性判断，所读研究结论不一致，未逐篇核到页码与数据表。
- 时间银行"法律与监管不健全、参与度不足"是若干研究摘要的共识，本章未核到某一篇全文的页码与数据表。

· 本章不写剂量、不做诊断，也不替任何人决定住哪儿。这些选择没有标准答案，同一种住法，对这个家成立、对那个家不成立。

本章数据来源

核对日期：2026-10-10。链接均经实测可打开（个别政府站需用浏览器访问）。

· 【官方口径】民政部等 9 部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（民发〔2020〕86 号，2020-07-10）：项目清单分基础类与可选类，对困难老人家庭补贴。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-07/16/content_5527260.htm

· 【官方口径】民政部《家庭养老床位服务基本规范》（MZ/T 234-2024，2025-02-01 实施）及解读：服务对象为按《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022）评为轻度及以上失能的老年人；截至 2024 年底累计支持 184 个地区建 35.8 万张家庭养老床位；60 岁及以上老年人口 3.1 亿、占 22%。https://www.gov.cn/zhengce/202502/content_7003431.htm

· 【官方口径】《中华人民共和国无障碍环境建设法》（2023-06-28 通过，2023-09-01 施行），第 22 条：国家支持城镇老旧小区既有多层住宅加装电梯。http://www.npc.gov.cn/c2/c30834/202306/t20230628_430340.html

· 【官方口径】《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022，2022-12-30 发布并实施）。https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=D8A0B4F27794EC73C511F1B948103256

· 【官方口径】《居家养老上门服务基本规范》（GB/T 43153-2023）：居家养老上门服务首个国家标准。https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202310/content_6910882.htm

· 【官方口径】《社区老年人日间照料中心服务基本要求》国家标准（全国社会福利服务标准化技术委员会归口，民政部主管）。https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D81764D3A7E05397BE0A0AB82A

· 【官方口径】国务院《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国发〔2021〕35 号，2021-12-30）：居家为基础、社区为依托、机构为专业支撑。https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/21/content_5674844.htm

· 【官方口径】《养老机构等级划分与评定》（GB/T 37276-2018，2019-07-01 实施）：养老机构星级评定。https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=DDB955F6E857C91A6534921ACF8725CA

· 【官方口径】民政部等 7 部门《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》（民发〔2024〕19 号，2024-10-01 施行）：养老服务费预收周期最长不超过 12 个月，押金最多不超过月床位费的 12 倍。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6950308.htm

· 【官方口径】民政部办公厅、金融监管总局办公厅《养老机构预收费存管工作指引》（民办发〔2025〕9 号，2025-10-31）：预收费进专用存款账户、银行存管。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202511/content_7049045.htm

· 【官方口径】上海市民政局《关于申请入住养老机构进行轮候排队的规则》。https://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan874_0-2-7-27/20220208/66fbb0c48eca47c7be58bb9e9d2d2221.html
· 【公开报道·案例】新华网《中国老人"抱团养老"模式受关注：杭州 13 名老人共享 3 层别墅》（2018-01-04）。https://www.xinhuanet.com/politics/2018-01/04/c_1122206392.htm
· 【公开报道·案例】央视网《关注"老有所养"　杭州：抱团养老模式引发热议》（2018-06-04）：别墅面积约　500　平方米。https://news.cctv.com/2018/06/04/ARTIyy4Jtc8MLxeOm4j4cpBL180604.shtml
· 【公开报道·案例】《抱团养老为啥抱不紧》（北京晚报，2021-09-07；央视网转载）：受访者称"钱让这个团儿抱不紧"；郊区医疗配套跟不上；民政部养老服务业专家委员会委员乌丹星谈自发抱团缺约束力。https://news.cctv.com/2021/09/07/ARTIFsrsR4hU6YOrVjrJXq4p210907.shtml
· 【公开报道·案例】央视网《"众筹"买楼抱团养老　21　年后　这群老人捐出一幢楼》（2020-08-12）：上海嘉定"慈舟养老院"。https://news.cctv.com/2020/08/12/ARTIISe3WFVeV4BB8r04F9KH200812.shtml
· 【官方口径】南京市民政局《南京：时间"存折"，让养老"增值"》（南京日报，2026-06-25）：南京互助养老站点 1300 多个，覆盖 99% 以上城乡社区，注册志愿者 9.4 万人，累计服务订单 147 万个，存储服务时间 92 万小时；2019 年试点"时间银行"，2023 年更名为养老服务互助时间平台。https://mzj.nanjing.gov.cn/njsmzj/mtgz/202606/t20260625_5866251.html
· 【公开报道·转载】南京互助养老早期数据（南京市人民政府网站转载《农民日报》，2024-07-12）：站点 1300 多个，覆盖 99% 以上城乡社区，注册志愿者 6.1 万人，注册服务对象　13.2　万人，完成订单　94.8　万个，累计服务　55.9　万小时。https://www.nanjing.gov.cn/zt/njstdylfwgzlfz/hzsjpt20240819/202408/t20240821_4746211.html
· 【官方口径】上海市民政局《关于本市推行"养老服务时间银行"项目的通知》（沪民养老发〔2021〕28 号，2021-11-22）：自 2019 年起在虹口、长宁等五区试点，2021 年在全市推行。https://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan279_0-2-8-15-55-231/20211122/91185c3ec2424a79a40d7e1ec47adfda.html
· 【官方口径】《关于推进互助性养老服务发展的意见》（民发〔2026〕11 号，民政部等 11 部门，2026-03-03）：首次在国家层面定义互助性养老服务；到 2030 年具备互助服务功能的城乡社区养老服务设施覆盖率不低于　70%。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7067394.htm
· 【官方口径】国家发展改革委《详解〈关于推进互助性养老服务发展的意见〉》（2026-06）。https://www.ndrc.gov.cn/wsdwhfz/202606/t20260601_1405589.html

· 【官方口径】国家金融监督管理总局《关于养老领域非法集资的风险提示》：以"预付卡、会员卡、保证金"为名的非法集资套路。https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=983951&itemId=925&generaltype=0
· 【公开报道·案例】新华网评论《选择旅居养老产品须谨慎》（2025-07-03）：引最高检非法集资典型案例，以提供养老公寓、旅居基地为噱头，金额超 50 亿元。https://www.news.cn/house/20250703/f309e675c28f45fda2ee7fe252318a31/c.html
· 【公开报道】最高人民检察院《检察机关打击非法集资犯罪典型案例》（2025-06-10 发布，案例一为周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案）：本页需浏览器访问，转载见。http://fangfei.people.com.cn/n1/2025/0611/c460498-40498691.html
· 【官方口径】国家卫健委《中国流动人口发展报告 2018》发布会散发材料之八（2018-12-22）：随迁老人近 1800 万，占全国 2.47 亿流动人口的 7.2%，专程照顾晚辈的占 43%（该页为动态页，需用浏览器打开）。https://www.nhc.gov.cn/wjw/xwdt/201812/052f17e31076434089d822f60b6b0164.shtml
· 【公开报道·自媒体测算】澎湃号·湃客《3327 万"老漂族"的乡愁，等待应答》（2025-09-26）：据第七次全国人口普查数据测算，60 岁及以上老年流动人口约 3327 万余人（非官方发布，作为较新测算列出）。https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_31683959
· 【公开报道】光明日报《让"老漂族"老有所养老有所医》（人民网转，2018-06-21）：随迁老人近 1800 万，43% 为专程照顾晚辈。http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0621/c1003-30070619.html
· 【官方口径】民政部等 10 部门《关于开展特殊困难老年人探访关爱服务的指导意见》（民发〔2022〕73 号，2022-09）：面向独居、空巢、留守、失能、重残等特殊困难老年人探访；到 2025 年底月探访率达到 100%。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/13/content_5718017.htm
· 【第三方研究】张子琪、魏秦《老年人的居住迁移与健康：居住环境契合性视角下的探究》，《人口与发展》2025 年第 3 期，第 132–144 页（北京大学人口研究所主办期刊，北大期刊网页转载）：居住迁移状态、新住处与旧习惯的契合度与健康结果相关。http://ccj.pku.edu.cn/article/info?aid=387635459
· 【官方口径】中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快建立长期护理保险制度的意见》（2026-03-25）：用 3 年左右时间推进；据新华社报道，到 2028 年底长期护理保险制度在全国范围基本实现全覆盖。https://www.gov.cn/zhengce/202603/content_7063790.htm
· 【官方口径】国家医保局等 8 部门《加快建立长期护理保险制度实施方案》（2026-03-26）：基准费率约 0.3%。https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/3/26/art_104_20039.html

· 【官方口径】民政部等 11 部门《积极发展老年助餐服务行动方案》（民发〔2023〕58 号，2023-10）及政策解读：对高龄、失能、独居老年人分类补贴。政策解读（民政部，班戈县政府网转载，2024-05-08）：http://www.nqbgx.gov.cn/nqbgx/zcjd/202405/eb7fe1b1321543019c1390933ad40069.shtml

第 16 章 · 钱从哪来：制度怎么替你付账

退休以后你会发现，账单不会因为你不上班就停。水电、吃饭、买药是天天来的小账。真正能把一个家掀翻的是另外几笔：一次住院，一场大病，一个人倒下再也起不来。

第 4 章讲过钱这笔本要趁早存。这一章换个问法：真到要花钱那一天，国家这套制度会替你付掉哪几笔，剩下的哪几笔得你自己扛。这几笔账有边界，也有先来后到。

16.1 这一章解决什么问题

老话讲养老防老，落到钱上是三笔不同的钱：**养老金管你活着的花销，医保管你看病的账，长护险管你失能之后的照护。**

三笔各管一段。麻烦在于很多人把它们当成一笔，"我有养老金，看病总该够了吧"，真到要人翻身擦洗那天才发现，前面那笔不顶后面这件事。

这一章把三笔账的边界、报销怎么算、去哪办、缺口拿什么补写清楚。记住"哪笔钱管哪件事、出了事去哪问"就够了。

16.2 三笔钱管三件不同的事，别混成一笔

这笔钱	管什么	不管什么
基本养老金	按月发到你账户的现金，管你活着吃饭	不管看病，不管护工费
基本医疗保险	生病的医疗费用，住院、门诊、买药	不管吃饭，不管失能后的日常照护
长期护理保险	失能之后的照护服务	不发现金，不管看病

医保不把钱发到你手里，是替你付看病的账；长护险也不发钱，是替你买照护服务。**分清"发钱"和"付账"，你才知道该盯哪本账。**

制度能替你付的账，和你实际要掏的钱，中间总隔着一截，这一截得家里自己填。

16.3 医保报销：先认三个目录、三条线

- **要花多少**：一次弄明白，长期受用（钱：不用花｜工夫：半小时｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：医保不是花了多少报多少。它先看你用的药、检查在不在报销名单里，再看花了多少：名单外的不报，太少、太多的也不报。
- **可以怎么做**：
- ① 认三个目录：药品、诊疗项目、医用耗材。目录内的才报，目录外的自费。
- ② 记三条线：**起付线**（低于它自己掏）、**报销比例**（社区一般高于大医院）、**封顶线**（超过它不再报）。

- ③ 医保只报"政策范围内"的费用，账单上的"自费"、"自付"它都不管。
- **来源**：A｜全国平均数只能当参考：职工医保政策范围内基金支付比例约 80%、居民医保约70%（国办发〔2021〕42号解读）。起付线、报销比例、封顶线都随参保地、险种、医院级别变，以参保地为准——具体问参保地医保局，或用"国家医保服务平台"APP 查。
- 特别提醒：**对谁成立**：所有参保人；先弄清自己交的是职工医保还是居民医保。
- **换回来的**：钱——不再怕"生场大病就塌，不知道医保到底能报多少"
- **在中国怎么落地**：药品目录以最新一版为准（医保发〔2025〕33号，2026-01-01 起执行）。用"国家医保服务平台"APP 查明细，或问参保地医保局。以当地最新口径为准。

16.4 出门看病，先在手机上把异地备案做了

- **要花多少**：手机点几步，几分钟（钱：不用花｜工夫：几分钟｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：你去儿女那座城看病，没备案可能报得少、还得先垫钱再拿回来手工报。备案做好了，当场就能刷码结算。
- **可以怎么做**：
- ① 对号入座：**跨省异地长期居住**（去外地长住、随迁、常驻工作）；**跨省临时外出就医**（转诊、急诊抢救、探亲旅游时看病）。
- ② 入口两个："国家医保服务平台"APP，或"国家医保局"微信公众号里的"异地就医备案"。
- ③ 实名认证后选备案类型、就医地，上传材料；有的地方能用个人承诺书代替证明。
- ④ 出门前查备案进度，确认就医地医院开通了直接结算。
- **来源**：A｜规则出自医保发〔2022〕22号、医保发〔2024〕21号；但各地材料、时限、报销降幅不一致，可能甲地降 10 个点、乙地降 20 个，以参保地为准——具体问参保地医保局。
- 特别提醒：**对谁成立**：长期在外地生活、或去外省大医院看病的人；只在本市看病的人用不上。
- **换回来的**：钱＋关系——不再怕"陪爸妈去大城市看病，先垫几万、回来还报不了"
- **在中国怎么落地**：国家医保服务平台 APP；参保地医保局窗口。备案类型、时限、降幅都问参保地医保局。以当地最新口径为准。

16.5 慢病长期吃药，先去把"门诊慢特病"认定下来

- **要花多少**：跑一趟医院或医保窗口（钱：不用花，或一次挂号的钱｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：高血压、糖尿病这类病天天吃药，钱花在门诊上。认定成"门诊慢特病"，门诊药费按更高比例报；不认定就按普通门诊那点额度报。
- **可以怎么做**：
- ① 先问参保地医保局或定点医院：我这个病在不在本地"门诊慢特病"病种名单里。

- ② 在名单里就申请认定：带病历、诊断证明、检查资料，交给医保经办机构或指定定点医院。
- ③ 认定通过后，开药、复查按慢特病待遇结算，长期处方一次能开更久。
- ④ 要跨省看，先确认这个病种在参保地和就医地都能跨省直接结算。
- **来源**：A｜能跨省直接结算的病种已从 5 种扩到 10 种：高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗，2024 年又新增慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、冠心病、病毒性肝炎、强直性脊柱炎（医保办发〔2024〕19号）。但"门诊慢特病"的待遇病种名单和报销比例由各统筹地区自己定，全国不统一，以参保地为准——问参保地医保局或定点医院医保办。
- 特别提醒：**对谁成立**：长期吃药、门诊花费高的人最值；偶尔看一次普通门诊的人用不上。
- **换回来的**：钱——不再怕"天天吃药的钱，全砸在门诊额度里"
- **在中国怎么落地**：参保地医保局、定点医院医保办、"国家医保服务平台"APP（可查门诊慢特病资格）。以当地最新口径为准。

16.6 大病保险是自动的，医疗救助得自己上门申请

- **要花多少**：申请救助要跑一趟民政或医保窗口（钱：不用花｜工夫：一次｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情）
- **简单说**：一住院花了几十万，基本医保报完，还有一层**大病保险**接着报，居民医保的人不用单独交钱，自动就有。再不够、家里确实困难，还有**医疗救助**兜底，但得自己去申请。
- **可以怎么做**：
- ① 大病保险：出院结算时一般一并算好，不用单独办。搞不清就问参保地医保局："我这趟有没有走大病保险。"
- ② 医疗救助：先看属不属于这几类——低保对象、特困人员、低保边缘家庭成员、农村易返贫致贫人口、因病致贫重病患者。
- ③ 去哪申请：先到村委会、居委会或乡镇（街道）民政窗口问，不少地方已做"一站式"受理。
- ④ 带诊断、住院票据、家庭收入情况；已被认定成低保、特困的，救助直接给。
- **来源**：A｜出自国办发〔2021〕42号：大病保险在基本医保报销后自动接着报；医疗救助上，低保、特困原则上取消救助起付线、救助比例不低于 70%，低保边缘家庭和因病致贫重病患者的起付线按上年居民人均可支配收入的 10%、25% 左右。具体以参保地为准，问民政或医保窗口。
- 特别提醒：**对谁成立**：家庭确实困难、大病自付负担重的人。开口申请不丢人。
- **换回来的**：钱＋体面——不再怕"生场大病把全家拖垮，又不好意思开口求助"
- **在中国怎么落地**：村委会、居委会、乡镇（街道）民政窗口、参保地医保局。问三句：算哪一类、起付线和比例多少、怎么申请。以当地最新口径为准。

16.7 惠民保这类补充险：花小钱防大账，先看三件事

- **要花多少**：一年几十到一百多块（钱：花不了几个钱｜工夫：一次投保｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：惠民保是"政府指导、保险公司卖、你自愿买"的补充医疗险，一年几十到一百多块，保额几百万，主要补医保目录外、个人自付和特药。免赔额通常不低，小病用不上，防的是大病。
- 值不值，看三件事：
- ① **谁在办**：是不是本地政府指导、正规保险公司承保的官方产品，别买名字像的山寨货。
- ② **免赔额多高**：免赔额越高，小病越用不上，意义越集中在大病上。
- ③ **报什么、怎么报**：目录外费用报不报，既往症怎么赔，能不能直接结算。
- **来源**：B｜2025 年 7 月国家金融监督管理总局发通知规范它；争议是全国参保率偏低，健康的人退保、生病的人参保，可能陷进"死亡螺旋"。
- 特别提醒：**对谁成立**：年纪大、有既往症、买不了普通商业健康险的人，它"不设健康门槛"可能是唯一还能买上的一份；已有好保障的人，它更多是补特药和目录外。
- **换回来的**：钱——不再怕"目录外的钱和天价药，医保管不了"
- **在中国怎么落地**：本地政府指导的官方投保入口（有的地方能用医保个人账户余额缴费）。投保前问清免赔额和报销范围。以当地最新口径为准。

16.8 长护险：第三笔钱，还没铺到每个城市

- **要花多少**：查一次、问一次（钱：不用花｜工夫：一趟窗口或一个电话｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：长护险管的是失能之后那笔照护钱，是这三笔里最年轻的一笔，一般不发你现金，是拿钱替你买照护服务。
- 走到哪一步了：2016 年先挑 15 个城市试点，2020 年扩到 49 个；2025 年 9 月，国家医保局披露覆盖 1.9 亿人、支出超 850 亿元。到 2025 年末，参保人数已到 3.0854 亿人（民政部、全国老龄办《2025 年度国家老龄事业发展公报》）——两个数口径不同，前者是制度覆盖，后者是参保。2026 年 3 月，中办、国办印发《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，目标是"用 3 年左右时间，到 2028 年底在全国范围基本实现全覆盖"，费率控制在 0.3% 左右。
- **可以怎么做**：① 先查你所在城市有没有实施长护险；② 有的话，失能状态要持续 6 个月以上、经评估认定后才能享受；③ 待遇主要付服务费，不设起付线。
- **来源**：A｜时间线、覆盖数、费率、目标出自官方文件（国家医保局 2025-09-25；中办、国办 2026-03-25）；但各地待遇差别大，试点城市还要约 3 年跟国家目录对齐。
- 特别提醒：**对谁成立**：已经落在实施长护险城市的人。别的城市的标准不一定适用，先查本地。
- **换回来的**：钱＋关系——不再怕"一人失能、全家失衡，护工费拖垮一家"

- **在中国怎么落地**：参保地医保局、医保服务窗口，或用"国家医保服务平台"APP　　查。问三句："我们这儿实施长护险没有？怎么申请失能评估？能报哪些服务、报多少？"　以当地最新口径为准。

16.9 一个人倒下，家里真正花掉的是这三笔钱

- **要花多少**：一次把账算明白（钱：不用花｜工夫：半小时｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：长护险发的是服务，不是现金。真正从家里钱包流出去的，是护工费、子女误工，还有护理用品和车费。
- **可以怎么做**：把这几笔分开列，才知道缺口有多大。
- ① **护工费**：住家护工、钟点工、机构床位，按月算一笔，这是失能后最大的固定支出。
- ② **子女误工**：一个子女为照护辞职或长期请假，少的是几万到几十万一年的收入，这笔账没发票、没人报销。
- **来源**：C｜这几笔是家庭照护的通行开销，没有全国统一统计；能报多少取决于本地目录和评估等级。
- 特别提醒：**对谁成立**：家里有失能老人、正靠人照护的人；失能早期就问清本地长护险，比等到卧床再问省事。
- **换回来的**：钱＋关系——不再怕"护工费和误工费，把一家人的积蓄拖垮"
- **在中国怎么落地**：本地长护险报哪些服务、护工什么价，问参保地医保局和养老服务机构。提前和家人谈好"谁来照护、照多久"（见第 20 章）。

16.10 配置顺序：先交够地基，再补缺口

钱有限，先保什么后保什么，是有顺序的。地基没交够，先去买花哨的，等于本末倒置。按这个顺序往下走：

1. **先把基本医保交上、交够**：职工医保或居民医保，一年别断，这是所有报销的地基。
2. **确认大病保险在不在**：居民医保自带；职工医保看本地安排。顺手弄清本地救助怎么申请。
3. **查长护险**：本地有就了解怎么评估、报哪些服务；没有就先记住这笔风险自己扛。
4. **补缺口**：惠民保这类补充险，适合的人补一层；企业年金、个人养老金（见第 4 章）属于更靠后的。
5. **来源**：C｜这个顺序是本书按"高频先保、极端后保"整理的：先保看病这种大概率花销，再保小概率、高花费的大病，最后才谈失能照护这笔长账。
6. 特别提醒：**对谁成立**：手上有闲钱、想给晚年多加一层的人；基本医保还断着、正借钱看病的，先把地基接上。

7. **在中国怎么落地**：断缴、补缴、参保打 12333 或问参保地社保经办机构；医保、救助、长护险问参保地医保局。以当地最新口径为准。

16.11 这几种"养老产品"，先别掏钱

- **要花多少**：几分钟判断，省下一辈子的积蓄（钱：不用花｜工夫：几分钟｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：这几类东西专挑晚年的人下手，套路就那么几个。
- 怎么做，三种认法：
- ① **以房养老骗局**：真正的"以房养老"是住房反向抵押养老保险，一种保险产品，不是理财。骗局是假借这个名头让你抵押房子，拿钱去买他的"高息理财"，最后钱房两空。
- ② **"高息理财"**：承诺"保本、高息、返本"还催你当场签字的，先当骗局看。正规理财不许承诺保本。
- ③ **养老项目预付费**：办卡返利、会员卡、预付卡、高额会员费，本质是拿你交的钱在周转。民政部发过风险提示，也出了规范养老机构预收费的文件。
- 三条刹车：大额转账隔 24 小时再办；让你抵押房产、把存款转去"某个账户"的先停；拿不准就问子女、社区或银行柜台。
- **来源**：A｜骗局类型和手法出自银保监会消费者权益保护局的提示、民政部《关于养老服务领域非法集资的风险提示》（2023-06）。这里不是投资建议。
- 特别提醒：**对谁成立**：手上有房子或一笔存款的老人；已经投了钱的，别怕丢人，第一时间报警、留好证据。
- **换回来的**：钱＋体面——不再怕"被骗走一辈子的积蓄，还不敢让人知道"
- **在中国怎么落地**：怀疑被骗打 110 报警；养老机构预收费的规矩问当地民政局；金融产品真假问银行柜台或金融监管部门。以当地最新口径为准。

16.12 如果你今天只能做一件事

打开"国家医保服务平台"APP，把个人的参保信息和医保电子凭证先领出来，顺手看一眼自己交的是职工医保还是居民医保。

这一步不花一分钱，十分钟。但你后面所有关于"能报多少、去哪报"的问题，答案都从这里开始找。

16.13 如果你是在替爸妈看

爸妈那一代，很多事宁可自己扛也不开口，尤其是"钱"和"病"。你替他看这一章，最容易帮上的，是把"问一句"变成"查一下"。

怎么说出口：别问"您医保能不能报"，改成"我帮您把医保电子凭证领到手机上，以后看病刷码就行"。你是在帮他装一个工具，不是查他的家底。

你不用他同意就能做的三件事：① 用"国家医保服务平台"APP 帮他查参保状态和门诊慢特病资格；② 如果他去外地长住、或要去外省看病，提前把异地备案做了；③ 去他参保地医保局或社区，问清本地有没有长护险、门诊慢特病怎么认定、困难时救助怎么申请。这三件都不花大钱。

他不同意时你还能做的：先把材料备齐，诊断、住院票据、用药清单，装进一个袋子。真到用的时候，一袋子资料比十句话管用。

16.14 本章我不确定的地方

- 门诊慢特病：能跨省直接结算的是全国统一的 10 个病种，但"待遇"病种名单和报销比例由各统筹地区自己定，本章写不出一个通用比例，只能写"怎么申请、去哪儿问"。
- 异地就医备案的材料、时限、报销降幅各地不一致，本章的降幅区间是概括，没有逐地回源，以参保地为准。
- 惠民保的赔付率、参保率这类数没有全国统一官方发布（"赔付率超 90%"出自媒体转引地方监管人员，"总参保率约 5%"出自业内研究文章），用的时候以本地产品条款和官方通报为准。
- 长护险各地待遇差别大，本章写的是国家层面的时间线和目标，具体到哪个城市能报多少、怎么评估，要回本地医保局问。
- 家庭照护的误工损失和护工价格，没有全国统一统计，本章只写了要算哪几笔账。

16.15 本章数据来源

核对日期：2026-10-10。链接均经实测可打开（金融监管总局部分页面为动态页，需用浏览器打开）。

- **基本医保报销、大病保险、医疗救助**：国务院办公厅《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》（国办发〔2021〕42号，成文 2021-10-28，发布 2021-11-19）：救助对象范围、起付标准、低保与特困救助比例不低于 70%。https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-11/19/content_5651446.htm （2026-10-10 核对）
- **上述文件政策解读**：国家医保局《〈关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见〉政策解读》（2021-11-19）：居民医保、职工医保政策范围内基金支付比例分别约 70%、80%。https://www.nhsa.gov.cn/art/2021/11/19/art_38_7354.html （2026-10-10 核对）
- **异地就医备案**：国家医保局、财政部《关于进一步做好基本医疗保险跨省异地就医直接结算工作的通知》（医保发〔2022〕22号，2022-06-30）。https://www.nhsa.gov.cn/art/2022/7/26/art_104_8629.html （2026-10-10 核对）
- **异地就医办理步骤**：国家医保局《跨省异地就医如何直接报销？》（2025-03-16）：备案类型、手机备案步骤、门诊慢特病资格查询。https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/3/16/art_14_16010.html （2026-10-10 核对）

- **异地就医加强管理**：国家医保局、财政部《关于进一步加强异地就医直接结算管理服务的通知》（医保发〔2024〕21号，2024-09-13）。https://www.nhsa.gov.cn/art/2024/9/13/art_104_13857.html （2026-10-10 核对）
- **门诊慢特病跨省直接结算**：国家医保局办公室、财政部办公厅《关于稳妥有序扩大跨省直接结算门诊慢特病病种范围的通知》（医保办发〔2024〕19号）政策解读（2024-09-13）：病种从 5 种增加到 10 种——原有高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗 5 种，新增慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、冠心病、病毒性肝炎、强直性脊柱炎 5 种。https://www.nhsa.gov.cn/art/2024/9/13/art_105_13860.html （2026-10-10 核对）
- **医保药品目录**：国家医保局、人力资源社会保障部《关于印发〈国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录〉以及〈商业健康保险创新药品目录〉（2025年）的通知》（医保发〔2025〕33号，2025-12-05）：新增 114 种、调出 29 种，2026-01-01 起执行。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202512/content_7050533.htm （2026-10-10 核对）
- **长期护理保险（进展与分布）**：国家医保局《〈国家长期护理保险服务项目目录（试行）〉政策解读》（2025-09-25）：覆盖 1.9 亿人、支出超 850 亿元；2016 年试点、49 个试点地区；试点目录用 3 年左右逐步统一。另：民政部、全国老龄办《2025 年度国家老龄事业发展公报》（民政部、全国老龄办 2026-07-31 发布；公报全文 PDF）：https://www.cncaprc.gov.cn/u/cms/www/202608/01013057jmzq.pdf （截至 2025 年末参保 3.0854 亿人、2025 年基金支出 186.44 亿元）https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/9/25/art_105_18022.html （2026-10-10 核对）
- **长期护理保险（服务项目目录）**：国家医保局《关于印发〈国家长期护理保险服务项目目录（试行）〉的通知》（医保发〔2025〕24号，2025-09-25）：共 36 项，生活照护 20 项、医疗护理 16 项；纳入目录的医疗护理项目由长护险基金支付，医保基金不予支付。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202509/content_7042325.htm （2026-10-10 核对）
- **长期护理保险（制度目标）**：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快建立长期护理保险制度的意见》（2026-03-25）：用 3 年左右时间、到 2028 年底全国范围基本实现全覆盖；费率控制在 0.3% 左右；单位职工由单位和个人同比例分担。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202603/content_7063789.htm （2026-10-10 核对）
- **长期护理保险（现状报道）**：新华社《覆盖全民！我国加快建立长期护理保险制度》（2026-03-26）。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202603/content_7063795.htm （2026-10-10 核对）
- **惠民保（监管）**：国家金融监督管理总局办公厅《关于推动城市商业医疗险高质量发展的通知》（2025-07-31）：普惠定位、按年龄健康状况分级定价、禁止低价无序竞争。https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1253070&generaltype=1&itemId=4216 （页面为动态页，需用浏览器打开；2026-10-10 核对）

- **惠民保（背景与困局）**：马凤娇《推动城市商业医疗险高质量发展》，原载《中国银行保险报》"北大保险评论"第 892 期，北京大学中国保险与社会保障研究中心转载（2025-08-20）：全国总参保率约 5%，"死亡螺旋"风险。https://econ.pku.edu.cn/ccissr/bdbxpl/50161zgbxy390801.htm （2026-10-10 核对）
- **惠民保（是什么、赔付率）**：央视网《什么是惠民保？和基本医保、商业保险有哪些不同？一文了解》（2024-01-28）：保费几十到一百多元、不设年龄与健康状况限制、整体赔付率预计超 90%（此为媒体转引国家金融监督管理总局浙江监管局人士的口径，非全国统一官方发布）。https://news.cctv.com/2024/01/28/ARTIZf6SbE7AQe6gVlDS1u1q240128.shtml （2026-10-10 核对）
- **以房养老骗局**：中国银保监会消费者权益保护局《关于警惕"投资养老"、"以房养老"金融诈骗的风险提示》（2021 年第三期，刊于国家金融监督管理总局网站）。https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=992168&itemId=4100&generaltype=0 （2026-10-10 核对）
- **养老诈骗**：中国银保监会消费者权益保护局《关于防范养老诈骗的风险提示》（2023 年第 1 期）：代理退保、以房养老、投资理财三类陷阱。https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1103021&itemId=915 （2026-10-10 核对）
- **养老服务领域非法集资**：民政部《关于养老服务领域非法集资的风险提示》（2023-06-15）：办卡返利、会员卡、投资养老项目等表现形式。https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202306/content_6886556.htm （2026-10-10 核对）
- **养老机构预收费**：民政部等七部门《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》（民发〔2024〕19号）。https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11386/202406/content_6955752.html （2026-10-10 核对）
- **查询入口**："国家医保服务平台"APP（国家医保局）；社保问题 12333。

第 17 章 · 人从哪来 + 给照护者的部分

夜里三点，你被旁边的动静弄醒。老伴又要起夜。你扶着他挪到卫生间，再挪回来。等他躺好，你睁着眼到天亮。

这几年的日子大概就是这么过的。你一边照顾他，一边偷偷想：**要是我先倒了，他怎么办？**

这一章写给正在变老的你，也写给正在照顾人的你。它说两件事：出了事，你的人手从哪儿来；照护的人自己，也得留口气。

17.1 这一章解决什么问题

前面几章管身体、钱和看病。这一章管"人"。

"有人照顾"四个字，落不到实处就没用。它得落到具体的人和时间上：谁来扶、谁来跑医院、谁来签字、谁来出钱。这些人和事，都要在出事之前凑齐。

下半章反过来，写给正在照顾人的那个人。照护落到最后，总会落到一个具体的人身上，多数时候是配偶，或者某一个子女。这个人也会累垮。

17.2 老了能靠的人分七类，各有各的边界

老话说"养儿防老"。真到失能那天会发现，能靠的人不止一类，每类能接住的活也不一样。

据民政部、全国老龄办等 2021 年抽样调查，在实际有人照料的老人里，**配偶当主要照料者的占 45.5%，子女（含儿媳、女婿）占 47.6%，专业照护人员只占 3.4%**。家里那两三个人，扛下了九成以上的照护。

能靠的人	能接住什么	接不住什么
伴侣	最贴身，一天到晚在，最懂你的习惯	他自己也在老；两人一起病倒最危险
子女	跑医院、签字、出钱、跑手续、拿主意	多半不在身边、要上班；翻身擦洗的活长年扛不住
亲友	关键时候来搭一两天手、借个钱、出面撑场	各有各的家，只能帮一阵
邻居	几分钟能敲门、发现异常、顺手跑腿	关系没到那份上不好意思开口；新小区更弱
志愿者	探访、陪着说话、代办小事、公益陪诊	不稳定、名额有限，替不了专业照护
社区（居委会、养老服务站、家庭医生、养老顾问）	政策的入口，帮办补贴、签约、介绍服务	不是随叫随到的保姆，管不了每天喂饭翻身
专业照护者（护工、护理员、护士、长护险服务）	会专业动作，能顶体力活，夜里也能替班	要花钱、流动大、好的难约

能天天耗在床边的人，要么是没力气的老伴，要么是请不了太久的子女。这中间的空档，就是这一章要补的。

17.3 别等出事那天再翻通讯录

- **要花多少**：一个下午，一支笔（钱：不用花｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：出事那天再翻手机找号码，最耽误事。现在就把能来的人写在一张纸上。
- **可以怎么做**：分三栏写——**能马上到场的**、**能出钱的**、**能跑手续拿主意的**，每栏至少一个名字加电话。再和关键那个人对一句"信号"：窗帘拉开、灯亮，人还好。这张纸并入第 19 章的家庭索引表。
- **来源**：B｜社会支持网络和老人的健康、存活有关联，有队列研究支持。**但是**，"写好一张名单就少出事"没有随机试验能证明，它保的是出事那天不手忙脚乱。
- 特别提醒：**对谁成立**——60 岁还硬朗的人，这份名单是给将来的自己存的；75 岁、带着几种慢病的人，名单要能每周对一次；已经失能的人，名单得由子女维护，不能等老人自己想起来。
- **换回来的**：关系——不再怕"夜里出事没人知道"
- **在中国怎么落地**：去居委会或社区养老服务站问：独居探访、敲门行动、家庭医生签约、紧急联系人登记，本地有没有。以当地最新口径为准。

17.4 陪诊：花钱请一个替你跑医院的人

- **要花多少**：一次一百到三百元（钱：要花些钱｜工夫：半天到一天｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情，要肯承认自己弄不明白）
- **简单说**：医院越大越像迷宫，挂号、缴费、取药、找科室，来回地走。陪诊师干的就是替老人跑腿、说话的活。
- **可以怎么做**：①值不值：独居、腿脚不便、看不懂流程、子女请不下假的，最值。②多少算合理（上海公开口径，2026-10 更新）：浦东“浦老惠”把半日（4 小时）定在 198 到 280 元；全市市场价多为每小时 50 到 80 元、一般 2 小时起订，一份普通陪诊 100 到 200 元，套餐多在 200 到 300 元、含 4 小时左右。收费由各陪诊机构自己定，但要在服务场所明码标价。③怎么挑：认正规机构、认陪诊师身份牌、签合同、问清包不包接送和轮椅爬楼、要发票。④别指望他帮你加号抢号，借陪诊名义加号卖号源，是被明令禁止的。⑤病历和身份证只给当次要用的，别整本留下。
- **来源**：A｜上海 2025 年 1 月起在浦东等 9 个区试点，2026 年 7 月 1 日全市推开，面向 60 岁以上、不限户籍，机构须有不少于 5 名陪诊师，身份牌可查。**但是**，全国还没有统一的陪诊师职业资格，"陪诊师证"多是地方或行业考核，换城不一定认。

- 特别提醒：**对谁成立**——60 岁、身体还行的人多半用不上；75 岁、带着慢病或已经失能的人最用得上，尤其复查、拿药、做检查。要防两件：隐私外泄（病历、证件）和纠纷（先签合同，出事找机构、找消保委）。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"看病没人陪，说不清，还被人嫌麻烦"
- **在中国怎么落地**：上海能上区里的平台下单（如浦东"浦老惠"），或到综合为老服务中心、家门口的服务站问；低保、低收入老人可纳入养老服务补贴。别的城市，先去区民政局问"有没有助医陪诊服务"。国家层面，民发〔2024〕52　号已把助医、就医陪同写进居家养老服务。以当地最新口径为准。

17.5 喘息服务：给天天守着的人放一天假

- **要花多少**：看地方，有的政府买单、有的自己出一部分（钱：花点钱｜工夫：每月几天｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情，要肯承认自己撑不住）
- **简单说**：一个人天天守着另一个病人，一年 365 天不歇，先垮的是他。喘息服务就是把老人短期送到机构住几天，或让专业的人上门替你半天。
- **可以怎么做**：①先问本地有没有；②它有两种样子——**短期托养**（老人送机构住几天）和**上门照护**（专业人员到家替几小时到一天）；③别一上来就买一个月，先从每月一天试；④把这天留给自己：看病、办事，或者睡一整天。
- **来源**：A（机制）｜国家层面只有“探索”两个字：《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国发〔2021〕35　　号）写的是“探索开展失能老年人家庭照护者‘喘息服务’”。**到 2026 年，全国仍没有统一的喘息服务制度**，它是北京丰台、成都青羊、四川广汉等地各自的试点：钱从哪来（有的政府买单、有的自己出一部分）、能覆盖谁（多数只限重度失能）、怎么申请，各地各年都不一样。
- 特别提醒：**对谁成立**——60 岁、身体还行的人还用不上，但可以先知道有这么一件东西；75 岁、家里有人天天照护的，值得去问；老人已经失能的，最该问，因为家里照护的那个人往往更早倒下。
- **换回来的**：关系——不再怕"照顾的人先垮了，全家跟着倒"
- **在中国怎么落地**：去街道或社区养老服务中心、区民政局问："家庭照护者喘息服务、短期托养、家庭养老床位，我们这儿有没有、怎么申请。"北京丰台、成都青羊、四川广汉都做过试点。以当地最新口径为准。

17.6 照护的人，先把自己算进去

- **要花多少**：一次自查，一个电话（钱：不用花｜工夫：几分钟｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情，要承认自己也可能撑不住）

- **简单说**：照护不是感冒，是慢性的消耗，会把一个人一点点磨空。一项 Meta 分析把 13 项研究、4970 人合并起来算，中国失能老人家庭照顾者的抑郁症状检出率是 41.81%（95% 置信区间约 37.6%–46.1%）。**要看清“检出率”三个字**：这是把多项研究汇总出来的比例，不是患病率，更不等于“每两个照护者就有一个是抑郁症”。它说明的是——这个群体的情绪问题很普遍，也一直没被当成病，不该被说成“想不开”。
- **可以怎么做**：对号这几条，占得越多越要当回事——①睡不好，醒了还是累；②以前爱做的事，一件都不想干；③无缘无故发火，吼完老人又自责；④吃不下，或猛吃；⑤总念叨"我撑不住了"、"不如我先走"；⑥头痛、胃痛、心慌，查不出毛病。占了好几条，去精神心理科挂一次号，或打个电话。
- **来源**：B｜照护者抑郁检出率高，有把多项研究合并起来的 Meta 分析支持；**但是**，各研究用的量表、样本、地区不同，合并值区间本身就很宽（95% 置信区间约 37.6%–46.1%，不同亚组从三成三到近五成），把 41.81% 当提醒，别当诊断，更别往“全国患病率”上套。
- 特别提醒：**对谁成立**——60 岁、身体还行的人，一开始照顾父母就可能碰上；75 岁、自己带病又要照顾人的，最重；老人已失能的，照护者常是更老的配偶，风险最高。**听到"活着没意思"、"不如死了"这类话，要当真，只做两件事：看住人、打电话求助。** 全国心理援助热线 12356（国家卫生健康委 2024 年设，规定每条热线每日提供不少于 18 小时服务），希望 24 热线 400-161-9995（7×24 小时）。人正处在危险里，打 120 或 110。
- **换回来的**：关系＋自理——不再怕"照顾人的人，先垮了"
- **在中国怎么落地**：打 12356；去社区问有没有老年心理关爱点、精防医生（更多去处见 17.10）。以当地最新口径为准。

照护这件事，没有不累的解法。

17.7 照护要过的四道坎：体力、钱、工作、情绪

不管照护的是父母还是老伴，磨人的就那么四样。

坎	它长什么样	可以先做的一件事
体力	翻身、移位、洗澡、夜里起夜，一天下来腰先散架	一个人扛改轮班：家里排班，或用短期托养、上门照护顶几天
钱	护工费、护理用品、住院自费，一笔笔往外掏	先查本地长期护理保险能不能报、失能补贴有没有；见第 4 章
工作	要上班又要陪护，请假多了怕丢工作	查本省有没有独生子女护理假——全国无统一规定，天数各省自定（5 到 20 天不等，部分省非独生子女也能休），**以本省人口与计划生育条例为准**；能请就请
情绪	烦躁、内疚、委屈，冲着病人发完火又后悔	找一个能说话的人定期说；撑不住就打热线、看精神心理科

最难说出口的是"情绪"这道：累了可以说累，烦了常常不敢说。

17.8 "该送机构了"看的是能力，不是孝心

- **要花多少**：一次评估或一次面谈（钱：评估多走长护险或免费｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：难开口，这一步最难迈）
- **简单说**：该不该把老人送到机构，标准不在"我孝不孝顺"，在几个很具体的问号：在家能不能安全地过下去、照护的人还撑不撑得住、钱够不够。
- **可以怎么做**：占得越多，"机构"或"请专业的人上门"就越该进选项——①**安全**：反复跌倒、走失、夜里出事、忘了关火关气；②**照护动作**：翻身、移位、喂食、换尿管、处理褥疮，家里做不做得来；③**照护者状态**：照护的人身体或情绪已经垮了；④**钱和专业**：全天照护请不起，或老人需要的护理家里根本做不到。想有客观参照，可以做一次《老年人能力评估规范》国家标准（GB/T 42195-2022）评估，它把能力分五档，从"能力完好"到"完全失能"。
- **来源**：B｜老年人能力评估有国家标准，谁来评、怎么评有依据。**但是**，没有一条线能替你做决定，"什么时候该送"没有统一答案，最后还得你和老人一起定。
- 特别提醒：**对谁成立**——60 岁、身体还行的人，现在想的是"以后要不要"；75 岁、带着多种慢病的人，先把评估做一次，心里有数；已经失能的人，重点变成"这个家在原地还能不能撑住"。
- **换回来的**：关系＋体面——不再怕"我是不是不孝"、"老人被送走"
- **在中国怎么落地**：失能评估、长期护理保险待遇、机构能不能试住，去社区或街道养老服务中心、区民政局问，或去参保地医保局问。拿不准就先让老人去机构试住几天。以当地最新口径为准。

17.9 兄弟姐妹之间，钱和时间分开算

- **要花多少**：一次家庭会议（钱：不用花｜工夫：一两小时，可能开好几次｜力气：不费｜要开口吗：难开口，要谈钱，还可能要翻旧账）
- **简单说**：翻脸多半不在谁出得少，在"谁出了多少，没人说清"。把出力和出钱分开算，写成一张表，少吵。
- **可以怎么做**：①把两件事拆开：**出时间的人**和**出钱的人**；②定一个换算——出不了人的，按比例出钱，或用这笔钱买服务（陪诊、护工、喘息）顶那份工；③把"出人"的活计时：一次陪诊算半天、一次住院陪护算几天，记在表上；④谈不拢，请第三方主持：长辈、居委会、社工。开会怎么开，见第 20 章。
- **来源**：C｜通行做法和经验整理，没有针对"怎么分才不吵架"的研究。**但是**，没有一种摊法让所有人满意：住得近的多出力、挣得多的多出钱，常被说成不公平；异地、独生、再婚家庭更拧巴。
- 特别提醒：**对谁成立**——60 岁、父母还硬朗时，先把规矩立下；75 岁、父母带着慢病时，趁他们头脑还清醒，把账摊开；老人已经失能的，别等倒下才谈。
- **换回来的**：关系——不再怕"家里为钱和照护翻脸"

- **在中国怎么落地**：社区调解委员会、居委会、社工都能帮着把一家人叫到一起谈；实在谈不拢，走法律途径。以当地最新口径为准。

17.10 照护的人，几个能打过去的地方

累了、烦了、撑不住了，这几个地方能去：

- **喘息服务**：让专业的人替你顶几天（见 17.5）。
- **12356 全国心理援助热线**：国家卫生健康委 2024 年设，规定每条热线每日提供不少于 18 小时服务，多地按 24 小时运行。另有希望 24 热线 400-161-9995（7×24 小时）。
- **社区精防医生**：家里有严重精神障碍病人（比如精神分裂症）的，社区卫生服务中心或乡镇卫生院有专门精防医生负责随访，属国家基本公共卫生服务，每年至少随访 4 次。
- **老年心理关爱点**：国家卫生健康委 2022 到 2025 年推的"老年心理关爱行动"，原则上每个县（市、区）至少有一处社区或村设点。去社区问有没有。
- **养老顾问**：国家在推的"养老顾问"，帮老人在一堆政策和机构里出主意、办委托代办（民发〔2024〕52 号）。
- **家庭医生签约**：签约后，行动不便、失能的老人可申请上门治疗、随访、护理、家庭病床，慢病能开 4 到 12 周长期处方。
- **长期护理保险**：管失能后那笔照护钱，能不能报、报多少，问参保地医保局（见第 4 章）。

这些地方各地铺得不一样，问一次比在家猜准。以当地最新口径为准。

17.11 如果你今天只能做一件事

拿一张纸，写下三个名字和电话：**一个出事能马上到场的，一个能出钱的，一个能跑手续拿主意的。** 写完贴冰箱上。

如果这张纸上，第二栏和第三栏都是空的，就把今天先花在打一个电话上——打给那个你最久没联系、却最可能帮你的人。

17.12 如果你是在替爸妈看

这一章对你有两层意思：一层是给爸妈找人手，一层是提醒你自己，你也是要被算进去的那个人。

帮爸妈凑人手。 把 17.2 那张表对着你家填一遍，看清缺哪一类，再去找。邻居别小看，先帮他把对门和楼上楼下认下来，互相留个电话：你不在的时候，邻居离他最近。去社区问一次：独居探访、家庭医生签约、助餐、喘息服务，本地有没有。

别把自己耗光。 很多人替父母跑前跑后，把自己当"替补队员"，随叫随到，不敢病不敢烦。真到长期失能，一个人扛不了一年。趁来得及，办三件事：兄弟姐妹把钱和时间怎么分，定下来（17.9）；把喘息服务和短期托养问清楚（17.5）；给自己留一个能说话的人和一条热线（17.10）。

还有一层。 你今天怎么照顾父母，你的孩子以后多半就怎么照顾你。你愿意让子女为了你辞职、垮掉吗？如果不愿意，那现在为自己、也为他们，把"请人帮忙"这条路的规矩先立起来。

17.13 本章我不确定的地方

- 陪诊的资质与收费：全国没有统一的陪诊师职业资格，“陪诊师证”多是地方或行业考核，跨城认不认本章未逐城核实。收费由各机构自己定，本章的上海数字（浦东半日 198–280 元、全市套餐 200–300 元等）只代表上海 2026 年的公开口径，别的城市要另问。
- 喘息服务、长期护理保险、独生子女护理假，几乎一省甚至一市一个样：国家层面喘息服务只有“探索开展”（见 17.5），长护险的失能评估与待遇仍在推进，护理假天数以本省条例为准——本章写到“去哪问”为止，具体口径要回本地。
- 照护者抑郁 41.81%：这是 13 项研究合并出来的检出率，各研究量表不同、合并值区间较宽（约 34%–49%），只能当提醒，不能当本地或某个人的患病率。

17.14 本章数据来源

- 【官方口径】上海市民政局、上海市卫生健康委员会《上海市老年人助医陪诊服务试点方案》（2025-01-22 印发，在浦东、杨浦、松江、徐汇、长宁、普陀、静安、虹口、黄浦 9 个区试点）。中国老龄协会转载：https://www.cncaprc.gov.cn/xxzcfg/10031895.jhtml（2026-10-10 核对）
- 【官方口径】上海市民政局等《关于全面推进老年助医陪诊服务的方案》（沪民养老发〔2026〕5 号，2026-07-01 起实施）：面向 60 周岁以上、不限户籍，机构须配不少于 5 名陪诊师，陪诊师身份牌可查。https://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan279_0-2-8-15-55-231/20260625/b5d7b569f014474a862c818ec54c2671.html ；问答解读（含“60 周岁以上、不限户籍”）：https://mzj.sh.gov.cn/mz-zcjd/20260625/bdccad85a0c243109153416a38805758.html （2026-10-10 核对）
- 【公开报道】浦东陪诊收费：上观新闻《需求突然暴涨！上海已开始试点，280 元四小时最受欢迎……》（2025-03-09，浦东“浦老惠”198 元/4 小时、280 元/4 小时；杨浦“国融乐养”168 元/2 小时、298 元/4 小时）。https://sghexport.shobserver.com/html/baijiahao/2025/03/09/1526714.html ；另见上海市政府网《新职业火了 浦东陪诊师队伍不断壮大》（2025-05-07）https://www.shanghai.gov.cn/nw17239/20250512/aa86c56fc0184999aefe9d665650c1d3.html （2026-10-10 核对）

- 【公开报道】上海陪诊市场价（每小时 50 到 80 元、套餐约 200 到 300 元含 4 小时；困难老人可享补贴）：《上海老年报》裘雯涵《"有需要再联系"背后：上海陪诊服务热了，老人为何还在观望？》，上海市民政局网站转载（2026-10-09）。https://mzj.sh.gov.cn/2026bsmz/20261009/963406a95d54494ab6cc6466d8ffe4a9.html （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】国务院《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国发〔2021〕35 号，2021-12-30 印发）："探索开展失能老年人家庭照护者'喘息服务'"。https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/21/content_5674844.htm （2026-10-10 核对）
- 【公开报道】北京丰台“喘息服务”试点（2018-10 起，每月平均 4 天、每人每天 220 元，试点期 6 个月、服务总天数不超过 24 天）：新华网《“喘息服务”政府买单：照顾失能老人每月可休 4 天》（2018-11-27）https://www.xinhuanet.com/politics/2018-11/27/c_1123770619.htm ；央视新闻《北京丰台区试点失能老人家庭“喘息服务” 给照护家属放个假》（新华网客户端，2023-04-15）https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=93c12892-7eca-4e63-b4a5-4c7bdb807bb9 （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】民政部、全国老龄办等《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报》（2021 年调查，2024-10-17 公布）：主要照料者中配偶 45.5%、子女 47.6%、专业照护人员 3.4%；独居 14.2%；有入住机构意愿者中，能承受每月 2000 元及以上者不足三分之一（3000 元及以上仅 15.8%）。中国老龄科学研究中心：http://www.crca.cn/index.php/19-data-resource/life/1117-2024-10-17-08-01-05.html （2026-10-10 核对）
- 【第三方研究】黄琛、安雪梅、杨婷玉等《中国失能老人家庭照顾者抑郁症状检出率的 Meta 分析》，《心理月刊》2026，21(11)：95-98：抑郁症状检出率 41.81%（13 篇文献、4970 例）。https://www.xlykzz.com/CN/10.19738/j.cnki.psy.2026.11.024 （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】市场监管总局《老年人能力评估规范》国家标准（GB/T 42195-2022，2022-12-30 发布）：能力分能力完好、轻度失能、中度失能、重度失能、完全失能 5 个等级。中国政府网转载新华社报道：https://www.gov.cn/xinwen/2023-01/18/content_5737811.htm （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】民政部等 24 部门《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》（民发〔2024〕52 号，2024-10-31）：发展助医服务（挂号取号、就医陪同、代取药品、代办缴费），持续推动助餐、助浴、助洁、助行、助急和探访，推广"养老顾问"。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6985707.htm （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】国家卫生健康委等《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》（国卫基层发〔2022〕10 号）：上门服务、4 到 12 周长期处方、老年人等重点人群优先签约。https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5699934.htm （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】国家卫生健康委《关于应用"12356"全国统一心理援助热线电话号码的通知》（国卫医政函〔2024〕259 号）：每条热线每日提供不少于 18 小时服务。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm （2026-10-10 核对）

- 【官方口径】《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018　年版）》（国卫疾控发〔2018〕13号）：社区精防医生的随访管理职责。https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5338247.htm （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】国家卫生健康委办公厅《关于开展老年心理关爱行动的通知》（国卫办老龄函〔2022〕204　号，2022-06-14　印发、2022-06-20　发布）：2022–2025　年在全国开展，到“十四五”期末原则上每个县（市、区）至少一个社区或村设有老年心理关爱点。https://www.nhc.gov.cn/lljks/c100157/202206/d52e414c77f741e099fcc13945d85a5b.shtml （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】长期护理保险：国家医保局 2025-09-25 披露制度覆盖约 1.9 亿人（截至 2025 年末参保 3.0854 亿人，见 民政部、全国老龄办《2025 年度国家老龄事业发展公报》（民政部、全国老龄办　2026-07-31　发布；公报全文　PDF）：https://www.cncaprc.gov.cn/u/cms/www/202608/01013057jmzq.pdf　）；中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快建立长期护理保险制度的意见》（2026-03-25）。https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/9/25/art_105_18022.html　；https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202603/content_7063789.htm （2026-10-10 核对）
- 【官方口径】独生子女护理假：全国无统一规定，各省天数不同。转载综述：新疆维吾尔自治区政务服务平台《多地明确：最长可休　20　天，工资照发》。https://zwfw.xinjiang.gov.cn/zmlske/zwfwqjd/xwzx/art/2025/art_0133b7233c8c4baab724f556779ea09b.html （2026-10-10　核对）〔具体天数以本省条例为准〕

第 18 章 · 手机与骗局：把事办成，别被套走

早上七点，你想在手机上挂个号。手指戳了半天，没找着地方。字太小，步骤太多，你把手机撂下，说一句"明天早点去排队"。

这一撂，你就把一件本来能自己办的事，交到了别人手上。

18.1 这一章解决什么问题

这本书算四笔账，第一笔是"自理"。老话说自理，指的是能自己吃饭、能自己上厕所。放到今天，这句话只讲了一半——还得加上一条：**能自己拿手机，把要看病、要出门、要交钱的事办成。**

挂号在手机上，缴费在手机上，进医院先要出示一个码。手机上的事办不成，你就得处处求人。不会用手机，今天已经等于半个失能。

这一章分两半。上半章讲怎么用手机把事办成；下半章讲骗局——骗子盯上的，正是你现在最依赖的这块屏幕。

18.2 先把手机调成看得清、听得见的样子

- **要花多少**：十分钟，一次设置（钱：不用花｜工夫：十分钟｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：手机里都藏着一个"把字变大、把声音放大"的开关，名字不一样：手机里叫"简易模式／大字体"，微信里叫"关怀模式"，支付宝里叫"长辈模式"。开了它，不用换手机。
- **可以怎么做**：① 手机本身："设置"→"显示"或"辅助功能"→"简易模式／长辈模式／大字体"；苹果在"设置 → 辅助功能 → 显示与文字大小"；华为在"设置 → 系统和更新 → 简易模式"（升级新系统后并入"设置 → 关怀和无障碍 → 关怀模式"里的"简易布局"）。② 微信：我 → 设置 → 关怀模式 → 开启（新版本"设置"里多一步"更多"）。③ 支付宝：我的 → 右上角设置 → 长辈模式，或直接在搜索框搜"长辈模式"。④ 声音：把"媒体音量"、"通话音量"调到最大。
- **来源**：C｜按钮名字和位置会随版本变，方向不变——看不清、听不清，先找"关怀"、"长辈"、"大字体"。
- **特别提醒**：**对谁成立**——视力、听力变差、但还能自己拿手机的人。完全看不清屏幕的，转向语音助手和子女代操作。
- **换回来的**：自理——不再怕"手机上的字，我一个字也看不清"
- **在中国怎么落地**：自己调不好，带着手机去社区养老服务站、老年大学或手机品牌门店，让工作人员当面调。以当地最新口径为准。

18.3 子女远程帮忙，只有一条铁律

- **要花多少**：一个电话、一次视频（钱：不用花｜工夫：几次｜力气：不费｜要开口吗：好开口）

- **简单说**：子女不在身边，怎么教你用手机？最稳的是打视频电话：你举着手机对着屏幕，他一边看一边念"下一步点哪儿"。能让对方"接管你手机屏幕"的软件，能不用就别用。
- **可以怎么做**：① 让子女打视频电话，一步步教，你点、他看。② 真想用远程协助，只用手机厂商自带的那一个，让子女当面给你装好，教会你怎么同意、怎么挂断。③ 任何一次远程协助，都不要在电话里把验证码念给对方，哪怕是亲儿子。
- **来源**：C｜通行做法。屏幕共享这类软件既帮人也常被利用，规矩要提前定，见 18.6。
- **特别提醒**：**对谁成立**——家里有能视频通话的子女。子女也不熟手机的，把"教你的人"换成社区、老年大学的年轻志愿者。
- **换回来的**：自理＋关系——不再怕"没人教我，我不敢乱点"
- **在中国怎么落地**：社区、老年大学、图书馆常办手机课堂。去社区问一句："有没有教老人用手机的活动。" 以当地最新口径为准。

18.4 把事办成：六件事，第一步点哪里

- **要花多少**：学一件约十五分钟，一次学一件（钱：不用花｜工夫：每件十五分钟｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：手机上要办的事就那几件：挂号、打车、付钱、缴费、出示医保码、证明"我是我"。
- **怎么做**（每条从第一次点哪里写起）：① **挂号**：微信 → 搜索框 → 打医院名 → 进医院公众号 → "预约挂号"。② **打车**：高德或百度地图 → "打车" → 核对"我在的位置" → "呼叫"。③ **付款**：微信"我 → 服务 → 收付款"，出一个码给收银员扫。④ **缴费**：微信"我 → 服务 → 生活缴费"，选水、电、燃气，绑一次户号。⑤ **电子医保凭证（医保码）**：装"国家医保服务平台"APP，或在微信、支付宝搜"医保电子凭证"，做人脸认证，看病买药出示它。⑥ **证明"我是我"**：领养老金的人每年做一次生存认证，用"电子社保卡"或"掌上12333"APP，眨眼、张嘴就完成。
- **来源**：C｜都是各家 APP 现成的功能，位置会随版本微调；方向是"搜索框 + 扫一扫 + 付款码"。
- **特别提醒**：**对谁成立**——识字、看得清屏幕的人。眼神不好、手指发颤的，先开好大字和语音，再学这几步。
- **换回来的**：自理——不再怕"医院的门都进不去，事事求人"
- **在中国怎么落地**：医保码只认"国家医保服务平台"APP 或微信、支付宝官方入口；养老金认证只认"掌上12333"、"电子社保卡"。凡是有别的小程序让你填银行卡密码、念验证码的，都不是官方。以当地最新口径为准。

18.5 看不懂就别硬扛：能替你办的地方和人

- **要花多少**：一次开口（钱：有的免费，有的要花钱｜工夫：一趟｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情）

- **简单说**：学不会不丢人，一个人瞎点才危险。
- **可以怎么做**：① **社区**：居委会、社区养老服务站能帮你代缴、代报名，窗口能帮办代办。② **政务服务中心**：进门问"老年人帮办代办在哪个窗口"，一般有绿色通道。③ **陪诊**：独居、子女不在、行动不便的，可花钱请人陪你挂号、排队、取药，上海等地已有官方试点。④ **银行柜面**：不想用手机银行，就到柜台办，这是你的权利。
- **来源**：C｜帮办代办、陪诊都是各地在推的做法，覆盖和收费差别大，陪诊还没有全国统一的资质标准。
- **特别提醒**：**对谁成立**——住在城里、能出门的人。住得偏、出门难的，重点用社区上门和子女代操作。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"看不懂又不敢问，只能干着急"
- **在中国怎么落地**：政务服务有"高效办成一件事"改革；陪诊半天约 198–300 元（各地不同）。问：社区居委会、政务服务中心导办台或银行大堂经理。以当地最新口径为准。

18.6 一张贴在冰箱上的家庭协议

- **要花多少**：一张纸，一家人签个名（钱：不用花｜工夫：半小时｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：全家立一条规矩，比出了事再吵有用。就两句：验证码只发给自己家人；陌生人要走验证码，一律挂断。
- **可以怎么做**：① 写下来贴在冰箱上：验证码、银行卡密码、支付密码，谁都不给——不给自称客服的、公检法的、银行的，也不给自称子女同事的人。② 对方一提到"转钱"、"验证码"、"屏幕共享"，直接挂。③ 家里定一件只有自家人知道的小事，视频里的"孙子"一开口，先问他一遍。
- **来源**：C｜通行做法。但"验证码不给任何人"，是几乎所有反诈材料的共同第一条。
- **特别提醒**：**对谁成立**——一家人还能坐下来商量。家里已有人判断力下降的，这条要由监护人替他执行。
- **换回来的**：钱＋体面——不再怕"被骗了不敢说，怕被家人怪"
- **在中国怎么落地**：把协议拍下来发到家庭群、存进相册；国家反诈中心的宣传材料里也是同一句话。以当地最新口径为准。

骗子比你年轻，也比你更熟手机。

18.7 假亲友：视频里的"孙子"可能是拼出来的

- **要花多少**：挂断、回拨（钱：不用花｜工夫：一分钟｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：骗子能拿你孙子的照片、语音，拼出一段换脸视频打给你，脸和声音都像。认它别靠"看像不像"，靠"换一条路核实"。

- **可以怎么做**：① 一听见"我是××，出事了，快转钱"，先挂断。② 用你自己存的号码，回拨那个"孙子"本人，或打给他爸妈；来电显示的那个号不要回拨。③ 问他一件只有自家人才知道的旧事。④ 视频里让他用手挡一下脸，假视频常会露破绽。
- **来源**：A（案例）｜郑州市民李奶奶被 AI 换脸、拟声伪造的“孙子”视频要 5 万元，去银行转账时被工作人员提示账户有风险，回拨核实才没转出去转引（《人民日报海外版》2026-04-13）。另有报道转引公安部数据：2025 年一季度全国 AI 换脸、拟声类诈骗立案量环比涨了约四成半，受骗者里老年人占三成八转引（同报 2026-04-13）。
- **特别提醒**：**对谁成立**——所有人，尤其爱刷短视频、爱跟孙辈视频的老人。已经认知下降、分不清真假的，家人要把"给钱先给孩子打电话"替他守住。
- **换回来的**：钱——不再怕"视频里的人，明明就是他"
- **在中国怎么落地**：挂断后拨 96110 咨询；郑州这一单是银行工作人员提示账户异常才拦下的，大额转账去柜台办就多一道人把关。以当地最新口径为准。

18.8 假客服：说"每月自动扣费"的，先挂断

- **要花多少**：一次挂断（钱：不用花｜工夫：一分钟｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**："您开通了××会员／直播，每月自动扣费"——这句话本身就是钩子。真客服不会打电话教你取消扣费，更不会让你下载软件、报密码。
- **可以怎么做**：① 一听到"自动扣费"、"影响征信"，挂断。② 想核实，自己打平台官方客服（比如抖音 95152），不要打来电给你的号。③ 别按对方说的下载任何"会议"、"投屏"、"安全"软件，那一步是让对方看见你手机、替你操作。④ 银行卡密码、短信验证码、人脸识别，只要对方在电话里要，就是骗子。
- **来源**：A（案例）｜深圳 70 岁的易阿姨被冒充"抖音客服"的骗子说"你开通了直播要扣费"，照做下载了三款陌生视频会议软件，一小时内被转走 14.7 万元（深圳市公安局反诈通报，2025-07）转引。
- **特别提醒**：**对谁成立**——常用手机看视频、网购的人。已经失能的，钱和手机都不该由他一个人掌握。
- **换回来的**：钱——不再怕"他说得头头是道，我就信了"
- **在中国怎么落地**：接到可疑电话挂断，拨 96110 或平台官方热线；装"国家反诈中心"APP，开着来电预警。以当地最新口径为准。

18.9 以房养老：真的那个是保险，假的那个让你抵押房子

- **要花多少**：多问一句，多等一天（钱：不用花｜工夫：一趟｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**："以房养老"有真有假。真的叫"住房反向抵押养老保险"，是国家批的保险：房子抵押给保险公司，人还住里面，按月领养老金。假的借这个名头，让你把房子抵押出去，钱交给他买"高息理财"——要害在"抵押的钱还要再投出去"。

- **可以怎么做**：① 分清两种：真——抵押给保险公司、人继续住、按月领钱，这是保险；假——抵押了房子、钱交给"理财公司"去投、承诺高息。② 只要对方说"抵押房子 → 投我们的理财 → 月月高息"，立刻打住。③ 真有兴趣，只认保险公司柜台和金融监管部门备案的产品，当面问，不看宣传单页。
- **来源**：A｜“住房反向抵押养老保险”是国家批准的试点保险产品（保监发〔2014〕53 号，2014-07-01 起实施），由保险公司经营、不是理财，业务量一直很小。
- **特别提醒**：**对谁成立**——有完全产权自有住房的 60 岁以上老人。房子是唯一住处、还要跟子女同住的，抵押前先跟家人讲清。
- **换回来的**：钱＋体面——不再怕"连国家政策，都被拿来骗我"
- **在中国怎么落地**：真产品问正规保险公司柜台；碰上"以房养老理财"，拨 96110 或向金融监管部门举报。以当地最新口径为准。

18.10 免费领鸡蛋的讲座，卖的不是鸡蛋

- **要花多少**：一趟腿，一次忍住（钱：不用花｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**："免费领鸡蛋、免费听养生课"是引流，不是送温暖。先给你点小便宜，再把你引进群，慢慢卖你几千上万块的"神药"。那些"药"多半是糖片、是食品。
- **可以怎么做**：① 凡是"免费礼品 + 讲座 + 高价保健品"三样凑齐的，别去。② 已经被拉进群的，退群；对方要你"别告诉子女"，这句话本身就是警报。③ 真想吃保健品，先问子女，或到正规药店、医院问，别信"专家现场讲座"。④ 留好收据、转账记录。
- **来源**：B｜央视财经、中国新闻网等多家报道过"免费领鸡蛋"套路；有案子被法院认定为诈骗、判了刑。
- **特别提醒**：**对谁成立**——独居、爱热闹、怕生病、手里有点钱的老人最容易中招。家人要做的不是骂，是陪他一起去正规渠道问一次。
- **换回来的**：钱＋关系——不再怕"怕生病，就想买个安心"
- **在中国怎么落地**：虚假宣传向市场监管部门举报，拨 12315；涉嫌非法集资、诈骗的，报警。以当地最新口径为准。

18.11 一次交几十万的"旅居养老会费"，先别交

- **要花多少**：一次核实，一次不交（钱：不用花｜工夫：一趟｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情）
- **简单说**："一次交十几万、几十万成为会员，将来全国哪儿的养老基地都能住"——这类预付式会费，最怕公司哪天资金断了、人跑了。

- **可以怎么做**：① 记住国家定的线：养老机构预收的服务费最长不超过 12 个月；单个老人的押金不超过月床位费的 12 倍，超了就不合规。② 一次性收你几十万"会员费"、"终身卡"的，多半已经越线。③ 交钱前，先查这家机构在当地民政部门有没有备案。④ 想冬天去南方住几个月，一年一交、押一付一就够，别一次押上全部积蓄。
- **来源**：A｜民政部等七部门《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》（民发〔2024〕19 号，2024-10 起施行）写明了预收上限和资金存管。
- **特别提醒**：**对谁成立**——手上有房有存款、身体尚可、想"旅居养老"的人。已经失能、要人照护的，不是旅居的对象，是照护的对象。
- **换回来的**：钱——不再怕"想找个体面的晚年，结果把本搭进去"
- **在中国怎么落地**：交钱前，去当地民政局问机构的备案和预收费监管，问三句：备案了没有？预收怎么管？退费怎么算？以当地最新口径为准。

18.12 给自己定一条规矩：大钱转出去，先搁一天

- **要花多少**：一天（钱：不用花｜工夫：一天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：骗子最怕你等。几乎每个骗局里都有"今天不办就晚了"，就是要你来不及想。你给大钱加一道"隔一天"，骗子的话就不灵了。
- **可以怎么做**：① 和家人约定：转出超过某个数（自己定，比如三五千），当天不办，睡一觉第二天再办。② 手机银行转账选"24 小时到账"，别选"实时到账"。③ 想更保险，把大额的钱放成定期，或另开一个取钱要跑银行的账户。
- **来源**：C｜这是自家的规矩。早些年 ATM 向非同名账户转账曾被强制 24 小时后到账，后来放开成可以实时，所以这道冷静期更得靠自己定。
- **特别提醒**：**对谁成立**——所有人。真遇上急事（进医院交押金）也常有别的办法，先给家人打个电话，往往比先转钱管用。
- **换回来的**：钱——不再怕"急着转出去，来不及想"
- **在中国怎么落地**：在手机银行里找"转账到账时间"的设置；拿不准，拨 96110。以当地最新口径为准。

18.13 真被骗了：止付、留证、报警，别瞒着家人

- **要花多少**：头几个小时（钱：不用花｜工夫：几小时｜力气：不费｜要开口吗：难开口）
- **简单说**：被骗了，先别骂自己，也别瞒着。钱能不能追回来，就看前面这几个钟头。顺序是：止付 → 留证 → 报警。
- **可以怎么做**：① **止付**：立刻打银行客服或去柜台，要求冻结、止付那笔钱，能拦下多少是多少。② **留证**：别删聊天记录、转账短信、那个来电，截图、录音，越全越好。③ **报警**：打 110，或打 96110 说明情况，越快越好。④ **告诉家人**：瞒着只会让窟窿更大，也可能再被骗第二回。

- **来源**：A｜公安部推出 96110、国家反诈中心 APP 等做法；《反电信网络诈骗法》2022 年 12 月 1 日起施行，规定了止付、冻结、追赃。
- **特别提醒**：**对谁成立**——所有人。已经失智、被人长期"钓"着的，家人要直接陪他去报警和银行。
- **换回来的**：钱＋体面——不再怕"被骗了没人帮我，也不敢说出口"
- **在中国怎么落地**：110、96110、银行柜台；国家反诈中心 APP 能一键举报。以当地最新口径为准。

18.14 如果你今天只能做一件事

今天，把手机的字号调到最大，把微信的"关怀模式"打开。就这一件。

字大了，你才看得清这一章里所有的事——看得清那六件事的第一步在哪儿，也看得清骗局里那个不对劲的地方。

18.15 如果你是在替爸妈看

你很难直接说"您小心别被骗"，一说，就成了不信任。

怎么说出口：把话头引到自己身上。别说"我帮您把手机调一下"，改成"我手机也想换大字的，咱俩一起弄"。他在旁边看着你调，自己就把方法学会了。

帮他把关，先做三件不用他点头的事：① 在他手机上装好"国家反诈中心"APP，开来电预警；② 帮他把你的电话、96110、附近银行网点的电话存进手机，教他一句"要验证码就挂断"；③ 大额转账设成"24 小时到账"，跟他约定超过多少先给你打个电话。

他不同意时，你还能做的：去社区问一句有没有手机课堂、有没有帮办代办；帮他把医保码、养老金认证在手机上弄利索；把 18.6 那张家庭协议打印出来，贴在他家冰箱上。

最难的一段：别让他觉得你在查他、防他。被骗过的人，最怕的往往不是钱没了，是被家里人骂。他肯第一时间告诉你，钱就还有救。

18.16 本章我不确定的地方

- 待核AI　涉诈的两个数——“环比涨约四成半”“受骗者里老年占三成八”——本章只查到《人民日报海外版》（2026-04-13）及法治网、信用中国等转载说引自公安部数据，没读到公安部原始通报，仍按“转引”处理。要核原始口径，上公安部官网或查公安部新闻发布会实录。
- 长辈／关怀模式的入口，版本一改就得重找：苹果、华为、微信的现行路径都能在各自官方帮助页上对上（见 18.17）；其中华为把早先的“简易模式”并进了“关怀模式”，可见改名是真会发生。支付宝没有长期稳定的官方说明页，以你手机上 APP 内实际显示为准。

- 陪诊没有全国统一制度，也没有全国统一的资质标准。上海走得最前（见第 17 章、18.5）：面向 60 周岁以上、不限户籍，外地来沪老人也能买。个别城市（如厦门）民政部门近年也印发了市级陪诊方案，但多数城市还没有。你所在的城市有没有、怎么收费，要问当地民政局。
- 旅居式、预付式养老会费“到底出了多少纠纷”，没有公开的权威统计，我们没查到数字——本章给的是监管口径（民发〔2024〕19 号）加一份官方风险提示：2025-09-09 全国老龄办、民政部、中国老龄协会、中国消费者协会联合发的养老消费提示，点名了“会员制养老”“预付卡”高额收会员费的问题。想查自家那家机构合不合规，上民政部的全国养老服务信息平台（见 18.17），或问当地民政局。
- 手机银行“24 小时到账”的默认设置，各家银行不一样，也没有全国统一的说明页：有的默认实时到账，有的要你在转账时的“到账时间”里自己选“次日到账”。打开你的手机银行，在转账页找一次这个选项；拿不准就打银行客服问。

18.17 本章数据来源

- 深圳"70 岁阿姨被骗 14.7 万"案（假客服）：深圳市公安局《70岁阿姨14.7万被骗！这种新型"客服"骗局专盯老年人》（深圳反诈中心通报，2025-07-10）。https://ga.sz.gov.cn/JMHD/YWZSK/XJGL_ZS/content/post_12272860.html （2026-10-10 核对）
- 郑州李奶奶案（AI 换脸、拟声伪造“孙子”），以及“环比 45%、老年占 38%”的公安部数据：《人民日报海外版》《AI“坑老”，守护伞要撑好！》（“融”观中国，本报记者霍旻含，2026-04-13，第 08 版）https://paper.people.com.cn/rmrbhwb/pc/content/202604/13/content_30150642.html ；法治网转载：http://www.legaldaily.com.cn/newzt/content/2026-04/13/content_9372640.html〔转引公安部数据〕
- 反诈七大反诈利器、国家反诈中心 APP 与 96110：公安部网站《反诈"国家队"推出七大反诈利器》。https://www.mps.gov.cn/n2255079/n4876594/n5104076/n5104077/c9081560/content.html （2026-10-10 核对）
- 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（2022-09-02 通过，2022-12-01 施行）：中国人大网。http://www.npc.gov.cn/npc//c2/c30834/202209/t20220902_319186.html （2026-10-10 核对）
- 住房反向抵押养老保险：中国保监会《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》（保监发〔2014〕53 号，2014-07-01 起实施，全国试点、属保险产品）。国务院公报：https://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2775523.htm ；国家金融监督管理总局：https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=359808&itemId=928&generaltype=0 （2026-10-10 核对）
- 养老机构预收费监管：民政部等七部门《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》（民发〔2024〕19 号，2024-10-01 起施行）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6950308.htm （2026-10-10 核对）

- 人民币现金收付：中国人民银行、国家发展改革委、金融监管总局公告〔2025〕第 29 号《人民币现金收付及服务规定》（2026-02-01 起施行）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202512/content_7055739.htm （2026-10-10 核对）
- 政务服务"高效办成一件事"：国务院办公厅《关于印发〈"高效办成一件事"2026 年度第一批重点事项清单〉的通知》（2026-01）。https://www.gov.cn/zhengce/content/202601/content_7054526.htm （2026-10-10 核对）
- 长辈／关怀模式官方帮助页（2026-10 核对）：微信《关怀模式·用户使用手册》（微信支付，路径【我】→【设置】→【更多】→【关怀模式】）https://pay.weixin.qq.com/doc/user/4021838466 ；Apple 支持《使用 iPhone、iPad 和 iPod touch 上的"显示与文字大小"偏好设置》 https://support.apple.com/zh-cn/111773 ；华为支持《开启或退出简易模式》 https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn00979791/ 与《不支持简易模式/简易布局了？》（说明升级后并入"关怀模式"） https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn16017728/ 。支付宝长辈模式无稳定官方说明页，以 APP 内为准。电子医保凭证、养老金资格认证的操作路径为各 APP 现行功能与本书整理的通行做法（C 档）。
- 养老消费风险提示：全国老龄办、民政部、中国老龄协会、中国消费者协会《警惕养老服务消费陷阱！全国老龄办等发布风险提示》（新华社，2025-09-09）http://www1.xinhuanet.com/politics/20250909/00979f47c74c4d6bbde54b6b8eac453c/c.html ；文中提到民政部"全国养老服务信息平台"可查机构资质：https://yanglao.mca.gov.cn/ （平台 2024-11-20 正式上线，官方公告见中国政府网 https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202411/content_6988449.htm ；该平台境外网络可能解析不到，国内可正常访问。2026-10-10 核对）
- 上海陪诊面向全体 60 岁以上、不限户籍：上海市人民政府《全面推进老年助医陪诊服务！7月1日起实施（附热点问答）》（上海发布，2026-06-26）https://www.shanghai.gov.cn/xbhygq/20260626/a2766847705d4c9b91933443fc1c53dc.html （2026-10-10 核对）
- 支付宝官方客服热线 95188：支付宝服务大厅《联系我们》 https://help.alipay.com/lab/help_detail.htm?help_id=212632 （2026-10-10 核对）
- 陪诊：上海《上海市老年人助医陪诊服务试点方案》（2025-01-22 印发）与《关于全面推进老年助医陪诊服务的方案》（沪民养老发〔2026〕5 号）；收费与资质详见第 17 章 17.4、17.14。https://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan279_0-2-8-15-55-231/20260625/b5d7b569f014474a862c818ec54c2671.html （2026-10-10 核对）

第 19 章 · 权限设置：趁清醒把权限交出去

你今天能自己签住院同意书，能自己取钱，能自己决定这个刀开不开。这些事看着是你的，其实靠的是同一件东西——你名下那份"我说了算"的资格。

这份资格不是终身的。一次脑梗、一次事故，或一点点退下去的记性，都能把它拿走，不发通知。它走了以后，家里会面对一个问题：往后谁替你做主。你早写好了答案，就按你写的办；没写，就按法律排的顺序办。

19.1 这一章解决什么问题

签字、取钱、住院、卖房、开通一个手机号——这些事，法律认的是"本人"的意思。你头脑清楚时，你说了算。

麻烦在于，"本人"这个身份会消失，还不打招呼：人在，但认不出家人、说不清话、签不了字时，只有两种结果——你早写好了谁替你做主，就按你写的办；没写，就按法律排的顺序办。

这一章讲的就是那个空当：趁你还清醒，把"谁替我做主"，从法律的默认答案换成你自己的答案。

19.2 失能之后再想补办，很多手续补不上

- **要花多少**：今天不花钱；拖到补办，花的是来回跑的时间和几趟路（钱：花不了几个钱｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：意定监护、遗嘱、委托，都有一个共同前提——办的时候你得是"完全民事行为能力人"，也就是你清楚自己在签什么。一旦被认定认不清了，你亲手补办这条路基本就关了，只剩法院指定这条更慢、更伤感情的路。
- **可以怎么做**：把"趁清醒"当成一个时间点：六十多岁、身体还行时办，是常规做法。等出现失智苗头再办，公证处会反复核实你是不是真明白，不少人到这一步就卡住了。
- **来源**：A｜这是法律对"行为能力"的硬要求（《民法典》第 33 条、第 21 条），不是公证处为难人。**但是**，各地公证机构对老年人意思能力的审查宽严不一，没有全国统一尺度：同一个老人，这家公证处反复核实，那家可能一次就办下。"基本办不了"这句是就趋势而言，不是一刀切。
- 特别提醒：**对谁成立**——对现在能自己做主的成年人成立。已确诊明显失智的，这一节不再适用，看 19.10。
- **换回来的**：体面＋关系——不再怕"决定权被人拿走"
- **在中国怎么落地**：去当地公证处问意定监护、遗嘱公证怎么办；补办困难时走法院（见 19.10）。以当地最新口径为准。

19.3 意定监护：趁清醒，给自己指定一个替你说话的人

- **要花多少**：一到两次公证（钱：几百元到数千元，各地差异大｜工夫：半天到一天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：意定监护，说人话就是——趁你还清楚，你和一个信得过的人（也可以是机构）签一份书面约定：哪天我认不清了、签不了字了，就由你来替我说话、替我做决定。《民法典》第 33 条就是干这个的。
- **可以怎么做**：① 先选定人（见 19.4）；② 两个人一起到公证处，说要办"意定监护协议公证"；③ 把该约的约进去：什么情况下生效、能管哪些事（医疗决定、钱、日常照料）、怎么改、怎么撤；④ 公证书各自留一份，家里文件袋放复印件。
- **来源**：A｜《民法典》第 33 条写明：完全民事行为能力的成年人，可用书面形式，与近亲属或其他愿意担任监护人的个人、组织事先商定，等自己丧失或部分丧失民事行为能力时，由这个人履行监护职责。**但是**，它管的是失能之后的监护，不等于现在就授权对方动你的钱，也压不过你当场说出的意思。
- 特别提醒：**对谁成立**——对现在能自己签字的人成立。丁克、再婚、失独、家里关系紧的家庭办得较多，因为它把"法律默认排给谁"换成了"我自己挑谁"。监护人可以是个人，也可以是组织。
- **换回来的**：体面＋关系——不再怕"到了那天没人替我说得上话"
- **在中国怎么落地**：去当地公证处办"意定监护协议公证"，双方带身份证、户口簿等身份材料，涉财产处分的带财产凭证（如房产证），再带上你们商量好的协议文本，公证员审核后可帮你改、也可代拟。去哪问、要多少钱：先打当地公证处电话问价，或上中国公证网、司法部政务服务平台查。以当地最新口径为准。

19.4 挑代理人，看四条

- **要花多少**：一次认真想清楚，一次当面问对方（钱：不用花｜工夫：一次长谈｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情，要开口求人）
- **简单说**：意定监护挑的不是"最有钱的"或"官最大的"，是"到时候真能把话说到、还能按你的意思说"的人。挑错了比没挑更麻烦。
- **可以怎么做**：四条对着看——
- **肯听你的，不替你拿主意。** 当面问他："万一我糊涂了，我说不治，你会照办吗？"
- **有那份力气，也在场。** 能来得及时、跑得动手续。八十岁的老伴，未必接得住。
- **跟你钱没关系，或关系摊得开。** 事先问清：哪天他替你管钱，谁来盯他。
- **留一个替补。** 约好"他不行了，换谁"。
- **来源**：C｜这四条是通行做法，也是公证审查里常看的点（意思真实、有没有能力、有没有利益冲突）；**但**哪条最要紧因人而异，没有研究能给统一答案。

- 特别提醒：**对谁成立**——对身边还有得挑的人成立。一个人也信不过的，可以把事拆开：钱交给机构管，人身照护留给亲属。
- **换回来的**：关系＋体面——不再怕"所托非人"、"为争这点东西，一家人翻脸"
- **在中国怎么落地**：对着这四条去和公证员聊一次；涉及钱的职责，事先约定谁监督、怎么查。以当地最新口径为准。

19.5 生前预嘱：深圳写的是"尊重"，不是"必须执行"

- **要花多少**：一次长谈，加一次公证或见证（钱：公证几百元｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：难开口，要说清"到时候别抢救我"）
- **简单说**：生前预嘱，是趁你清醒，把"到最后要不要插管、要不要心肺复苏、要不要进ICU"写下来。目前全国只有深圳有专门规定；**深圳的写法是：医疗机构在那种时候实施医疗措施，应当尊重患者的意思表示——是"尊重"，不是"必须执行"。** 它没写"医院必须照办"；也不是安乐死，说的是要不要那套创伤性抢救。
- **可以怎么做**：① 和家里人、常看的医生把上面那几句谈开；② 书面写下来；③ 找明确依据就问当地卫生健康委或大医院安宁疗护科；深圳可找深圳市生前预嘱推广协会名录。
- **来源**：A｜有法规原文（《深圳经济特区医疗条例》第 78 条）。**但是**，深圳以外没有专门立法；一份写得清楚、有人见证、随时能拿出来的意愿书，只是"软保证"，帮医生和家人知道你怎么想，不是硬保证。
- 特别提醒：**对谁成立**——对还能交流、自己做主的人成立。深圳要求：经公证，或两名以上非救治人员见证，书面、录音录像都行。
- **换回来的**：体面——不再怕"疼着、被机器拖着、家人为救我吵翻"
- **在中国怎么落地**：谈、写、公证或见证；去当地卫生健康委或大医院安宁疗护科问。以当地最新口径为准。跟医疗决定有关的，见第 21 章。

19.6 遗嘱怎样立才不作废

- **要花多少**：自书不花钱；打印遗嘱一百到几百元；公证遗嘱几百元，80 岁及以上老人首次办免收服务费（发改价格〔2021〕1081 号）（工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：遗嘱作废，多数不是因为你写错了给谁，是形式没做对。常见几个原因：见证人找得不对（比如让一个将来要分遗产的人来当见证）；漏签日期、漏签名；打印遗嘱没在每一页签；签字时被人劝着改。
- **可以怎么做**：形式挑一种做足——自书要亲笔手写、签名、注明年月日；代书、打印都要两个以上见证人，打印的还要遗嘱人和见证人在**每一页**签名、注明年月日；怕麻烦就去公证处办遗嘱公证。
- **来源**：A｜法条原文（《民法典》第 1134–1139 条）。**但是**，立了好几份、内容打架的，以最后一份为准（第 1142 条）；受欺诈、胁迫所立的遗嘱无效（第 1143 条）；遗嘱还得给"缺乏劳动能力又没有生活来源"的继承人留必要份额（第 1141 条）。

- 特别提醒：**对谁成立**——对脑子清楚、能自己表达的人成立。内容写具体：哪套房、哪个账户给谁。
- **换回来的**：关系＋钱——不再怕"我写的东西最后不算数"
- **在中国怎么落地**：自己写，或去公证处办遗嘱公证（80 岁及以上首次免费）；拿不准的问公证处或律师。以当地最新口径为准。

19.7 家庭索引表：一张纸，让全家找得到

- **要花多少**：一支笔、半小时（钱：不用花｜工夫：半小时｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：最怕的不是东西没有，是"东西在哪儿只有你一个人知道"。你一进医院，全家翻箱倒柜，保单、房本、银行卡、公证文件全找不着。解法很土——写一张索引表。
- **可以怎么做**：照这个表填，写完念给一个家人听，让他知道它在哪。 | 类别 | 具体 | 放在哪 | 谁知道 | 紧急时怎么取 | | 证件 | 身份证、户口簿、房本 | | | | | 钱 | 银行卡、存折、保单、基金证券 | | | | | 法律文件 | 意定监护、遗嘱、生前预嘱、委托书 | | | | | 钥匙与密码 | 保险柜、家里备用钥匙 | | 密码只写提示 | | | 人和机构 | 主治医生、社区、律师、公证员 | | | |
- **来源**：C｜本书整理的实操办法，不含数据；急诊室里"一页纸省下几分钟"是共识。
- 特别提醒：**对谁成立**——对所有家里有重要文件的人成立。**密码别整条写在表上**：真密码单独交给一个信得过的人。
- **换回来的**：关系＋体面——不再怕"我走后，家里人连东西在哪都不知道"
- **在中国怎么落地**：需要时，把这张表和 19.3、19.5、19.6 的文件装进同一个文件袋，固定放一个位置。以当地最新口径为准。

19.8 数字遗产：手机号、微信支付宝、银行卡、云相册

- **要花多少**：一次查询或一次公证（钱：手机号过户可能要做公证，几百元｜工夫：几天到几周｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：人走了，手机里还留着钱和账号，这几样要分开看。**手机号**：号码归国家，你用的是"使用权"，法院和公证处已认可它可继承，办完公证或拿到法院文书，去运营商办过户。**微信、支付宝里的零钱和余额**：可以依法提取；账号本身归平台——多数平台协议写明账号所有权归平台、用户只有使用权，所以一般不能继承、不能过户。
- **可以怎么做**：① **手机号**——继承人协商一致（或法院裁判），办继承公证或拿调解书，再去运营商营业厅过户；② **微信、QQ 零钱**——用继承人实名的微信号，进【我】→【服务】→【钱包】→【客服中心】，输入"微信支付财产继承"，按指引提交材料；③ **支付宝**——打支付宝官方客服热线 95188，或在支付宝搜索"遗产继承"，说明要办"余额/资金继承"，按指引提交材料，具体入口和材料以页面当时展示为准；④ **银行卡**——先查再取，小额可简化（见第 22 章）。

- **来源**：A｜手机号和微信、QQ 零钱都有官方口径（司法部智慧普法平台转载的人民法院报、广东省司法厅；腾讯客服 2026 年 4 月）。**但是**，云相册、游戏账号、自媒体账号、数字藏品怎么处理，全国没有统一规定，《民法典》第 127 条只做了原则性保护，具体规则以各家平台的服务协议为准，而且常改。这几样，去平台客服问；记着"以平台当时的规则为准"。
- 特别提醒：**对谁成立**——这条更多写给家属；但**你**现在能做的，是把账号、绑定的银行卡、常用平台列进 19.7 那张表。
- **换回来的**：钱＋关系——不再怕"人在钱在，人走了钱不知道在哪"
- **在中国怎么落地**：运营商营业厅、银行网点、微信和支付宝里的继承通道；公证去公证处；卡住了打 12345。以当地和平台最新口径为准。

19.9 办这些要花多少钱、跑几趟

- **要花多少**：下面是量级，各地差别大（钱：几十元到上千元｜工夫：几次半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：一张账，让你心里有数，不用被"必须公证"吓住。
- **意定监护协议公证**：没有全国统一价，各地差得远。有的公证处按小时协商收费（例如某地公开价目是 500–1000 元/小时，配套事项另计），有的按件协商、最低到数千元一件。多少钱、怎么收，打当地公证处电话问最准。
- **遗嘱公证**：几百元；80 岁及以上老人首次办免收服务费。
- **房产继承公证**：费率第一档不超过 0.5%，单套住宅费用总额原则上不超过 1 万元。
- **跑几趟**：意定监护、遗嘱公证通常一到两次；房产继承看有没有争议，可能好几趟。
- **来源**：A｜收费全国不统一，依据是《公证服务收费管理办法》和 2021 年两部门的价格指导意见（发改价格〔2021〕1081 号）；意定监护这类多是市场调节价、由各公证处自定，具体到你那家，得打电话问。
- 特别提醒：**对谁成立**——对要花钱办这些事的家庭成立。低保户、重度残疾人办基本公证，减免不低于 50%，办前问一句"能不能减"。
- **换回来的**：钱——不再怕"办个事被来回加价、来回跑"
- **在中国怎么落地**：先打当地公证处电话，问价格、问要带什么；对价格有疑问，找价格或司法行政部门。以当地最新口径为准。

19.10 已经失能了，只剩法院这条路

- **要花多少**：一次特别程序诉讼，可能要司法鉴定（钱：鉴定费几千元，各地不同｜工夫：几个月｜力气：家属来回跑｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：如果没来得及办意定监护，人已经认不清、签不了字了，要让"谁替他做主"生效，就得走法院——由近亲属等利害关系人或有关组织，向他的住所地基层法院申请，宣告他为无民事行为能力人或限制民事行为能力人，再由法院指定监护人。

- **可以怎么做**：① 由近亲属或有关组织向住所地基层法院提出申请；② 法院按特别程序审理，常要做行为能力鉴定；③ 判决后指定监护人；④ 情况好转、原因消除了，还能申请撤销原判决。
- **来源**：A｜法条和解释写明（《民法典》第 24 条、《民事诉讼法》第 194 条；最高人民法院 2023 年答复）。**但是**，指定谁容易变成亲属之间争；法院判的是"最有利于被监护人"，会看你备好的材料，和到底谁在真正照顾。
- 特别提醒：**对谁成立**——对已失能、又没提前安排的人及其家属成立。**这一节就是上节的理由**：走法院慢、贵、还伤感情；能不走的前提是趁清醒先把 19.3 办掉。
- **换回来的**：关系＋体面——不再怕"人都糊涂了，家里人为谁说了算闹上法庭"
- **在中国怎么落地**：去住所地基层法院立案庭，问申请材料、问鉴定怎么做；拿不准的问律师或打 12348。以当地最新口径为准。

19.11 如果你是在替爸妈看

这件事他们多半不会主动提，你提。开场别从"以后您糊涂了"入手，从你自己入手："我想趁现在都清楚，把我自己的事定一定，也想请你们帮我拿个主意。"

一次只问一件。今天只问一句："如果有一天您自己说不了话，谁替您说最放心？"剩下的下次再问。

你真正能马上做的，是不用他点头的三件：把他的用药、诊断、常去医院做成一页纸；把 19.7 那张索引表替他填起来——哪怕他不配合，你自己先摸清东西在哪；陪他去一次公证处或医院，先问清楚，再说服。

他若不谈，别硬碰。意定监护、遗嘱、生前预嘱都有"软"的做法：先把他的想法记下来，先把该问的机构问到。

最后一句丑话，语气放平：这些事，越早办越简单。越晚办，那个还能替你留出做主空间的人，可能自己先不自在了。

19.12 今天只能做的一件事

打开手机备忘录，或者抽一张纸，写下这一行：

> "如果我有一天说不了话、签不了字，我希望由 _____ 来替我做主。"

填一个名字。今天不办任何手续，只把这一个人定下来。名字有了，19.3 那道门才算有了入口。

19.13 本章我不确定的地方

- 各地公证机构对老年人"意思能力"的审查标准不统一，宽严尺度没有全国统一文件，实践中差别较大——这正是本章反复提醒"趁清醒早办"的原因；具体能不能办、卡在哪，要去当地公证处问。
- 意定监护协议公证的收费，多地属市场调节价、由各公证处自定，各地差异极大（本章给了两个公证处的公开价目作参照，但不是全国标准），办前一律打当地公证处电话问价。
- 云相册、游戏账号、自媒体账号、数字藏品怎么处理，全国没有统一规定：《民法典》第 127 条只是原则性保护，我们翻到的主流平台协议里，多数写明"账号所有权归平台、不得转让继承"。这几样只能去平台客服问，以平台当时的规则为准。这一条已有可查的官方梳理（广州市司法局转载《人民日报》报道，见 19.14），不再标"待核"；但结论仍是——没有统一规则，只有一句"去平台问"。
- 待核 微信、支付宝里亲人的钱怎么提，入口和材料以平台页面当时展示为准——这两条钉不到长期不动的官方页：微信目前走继承人实名微信号的"我 → 服务 → 钱包 → 客服中心"，输入"微信支付财产继承"（腾讯客服 2026-04 有公开说明）；支付宝目前是拨官方客服热线 95188、或在 App 内搜"遗产继承"说明情况（95188 见支付宝服务大厅"联系我们"页）。平台一改这页就对不上，办前先在 App 里搜一次或打客服电话确认。

本章给的收费和跑腿次数只是量级；公证与法院的流程细节各地不一，办前一律打电话问当地公证处、法院立案庭。

19.14 本章数据来源

- 【法条】《中华人民共和国民法典》：第 33 条（意定监护）、第 21 条（无民事行为能力）、第 24 条（宣告无/限制民事行为能力）、第 28 条（法定监护顺序）、第 1134–1140 条（自书/代书/打印/录音录像/口头/公证遗嘱与见证人资格）、第 1141–1143 条（遗嘱必要份额与无效）、第 127 条（数据、网络虚拟财产保护）、第 1122 条（遗产定义）。全文（最高人民法院，2020 年 5 月 28 日通过）：https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/233181.html
- 【法条】《中华人民共和国民事诉讼法》第 194 条（认定公民无民事行为能力的特别程序）。最高人民法院对"认定成年人为无民事行为能力人是否须经特别程序"来信的回复（2023-06-19，"院长信箱"）：https://www.court.gov.cn/hudong/xiangqing/404202.html
- 【官方口径】《深圳经济特区医疗条例》第 78 条：医疗机构在患者不可治愈的伤病末期或临终时实施医疗措施，应当尊重患者生前预嘱的意思表示；生效要件为经公证，或两名以上非救治人员见证（见证人不得为参与救治的医疗卫生人员）。深圳市人大常委会 2022-06-30 公布、2023-01-01 起施行，深圳市卫生健康委员会全文：http://wjw.sz.gov.cn/xxgk/zcfggfxwj/mybh_5/content/post_10139263.html

- 【官方口径】国家发展改革委、司法部《关于进一步完善公证服务价格形成机制的指导意见》（发改价格〔2021〕1081 号，成文 2021-07-22）：涉居民房产继承、遗赠公证，按标的金额比例计价的第一档费率不超过 0.5%，单套居民房产费用总额原则上不超过 1 万元；80 岁及以上老人首次办理遗嘱公证免收服务费；低保户、重度残疾人办理基本公证服务项目减免比例不低于 50%。中国政府网：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/29/content_5628166.htm
- 【官方口径】意定监护协议公证的办理材料：申请人（含接受监护权一方）身份证、户口簿等身份材料；涉财产处分的带财产凭证（如房产证）；双方协商形成的协议文本（公证员审核后可修改，或由承办公证员代拟）。广州公证处《如何办理意定监护协议公证？》（2023-12-06）：https://www.gz-notary.com/NewsDetail.aspx?code=0305&id=9642；亦可参见聊城市行政审批服务局《意定监护协议公证如何办理？》（2026-03-27）：http://zwzx.liaocheng.gov.cn/channel_6544b547763804bd991ea3df/doc_69c5f5901e7d364500622940.html
- 【官方口径】意定监护公证收费的各地差异（示例，非全国标准）：上海浦东公证处公开价目——意定监护按公证人员参与人数、时间、事项难易程度协商收费，区间 500–1000 元/小时，各配套公证事项按标准分别收费：https://www.pdnotary.com/channels/1691/ ；湖北黄石公证处公开价目（黄石市司法局公布）——意定监护协商收费，最低 5000 元/件：https://sfj.huangshi.gov.cn/xxgk_17/zc2020/gsgg/qt_1/202111/t20211111_851816.html
- 【官方口径】手机号使用权可作为遗产继承：人民法院报《手机号能否作为遗产继承？》（2026-08-31，司法部智慧普法平台转载）：http://legalinfo.moj.gov.cn/zxxfyasf/202608/t20260831_539090.html ；广东省司法厅《公证丨机主过世，手机号能作为遗产继承吗？》（2024-03-01）：http://sft.gd.gov.cn/sfw/xwdt/sfxz/content/post_4383644.html
- 【官方口径】腾讯客服逝者微信/QQ 零钱资金继承专属服务（2026-04-03 宣布升级）：办理路径为使用继承人实名微信号，进【我】→【服务】→【钱包】→【客服中心】，在对话框输入"微信支付财产继承"。南方网 https://news.southcn.com/node_08203b6b14/d0b362708e.shtml ；光明网（转 新闻晨报、新华社）https://m.gmw.cn/2026-04/05/content_1304405647.htm
- 【官方口径】数字遗产无统一定义与分类、多数平台协议约定"账号所有权归平台"：人民日报《让数字遗产得到妥善处置（新知）》（2026-09-14）：http://opinion.people.com.cn/n1/2026/0914/c461529-40797909.html ；广州市司法局《亲人去世后，微信与支付宝余额、游戏账号、自媒体账号能继承吗？》（2026-04-08，来源 人民日报综合新华社）：https://sfj.gz.gov.cn/gzssfj/flfw/pf/yasf/content/post_10760952.html

· 【官方渠道】公证去哪问：中国公证网（中国公证协会）http://www.chinanotary.org.cn/；司法部政务服务平台·公证服务 https://www.moj.gov.cn/zwfw/zwfwbszn/bszngzfw/ 。落地的几处：当地公证处（办意定监护、遗嘱、继承、手机号继承公证）、基层人民法院立案庭（监护宣告）、银行网点、电信运营商营业厅；卡壳可拨全国法律服务热线 12348。

· 【官方渠道】支付宝客服热线 95188：支付宝服务大厅《联系我们》 https://help.alipay.com/lab/help_detail.htm?help_id=212632 （2026-10-10 核对）

· 家庭索引表、跑腿次数与费用量级：本书整理的通行做法，不含数据。

篇五 · 最后一程与善后〔阶段四〕

第 20 章 · 怎么开口：那些难以启齿的话

有些话不是不想说。是一开口就变成了吵架。

20.1 这一章解决什么问题

老人和子女之间，难的不是钱，也不是谁照顾谁，是**说不出口**。

失禁、忘事、没钱、想住哪儿、最后怎么走——这几件事能拖很多年不谈，然后在一个最糟的时刻被硬邦邦地摊开。

这一章给的是句子，不是道理。你可以照着念。

20.2 为什么我们都绕着"老、钱、尿、死"走

四个原因，都是真的：

1. **说了怕对方承受不了。** 你先想象了他会怎么反应，然后决定不说。
2. **开口像是认输。** 承认需要帮忙，在很多人心里等于承认"我不行了"。
3. **上一辈就是这么过来的。** 你父母没跟你谈过这些，所以你手上也没有句子。
4. **不知道怎么开头。**

第四条最要紧——多数人不是不愿意谈，是缺一个句子。句子是可给的。下面就是。

20.3 不说出口的代价

波洛克在老年病房里待了三十多年（原书第 2 章自述"将近三十年"）。下面几段是对她书中观察的整理〔一手核对〕：

老人把最难堪的事藏起来，子女把最难开口的话咽下去，而医护想知道你到底要什么，却发现没人能替你说清。三方都在场，三方都在猜。

结果就是：一段本来不必忍的痛苦，被忍了很多年；一次本来该做的治疗，被错过了；一个本来能了的心愿，最后成了遗憾。

20.4 谈身体的变化：用"我"开头，不用"你"

- **要花多少**：一次十五分钟，不需要谈心，不需要铺垫（要开口吗：好开口，只要你换一个开头）
- **简单说**：这两句话说的是同一件事，反应完全不同。
- "你怎么又忘了关火？"——这是给他下判决。
- "我发现我最近也老忘事，你那边怎么样？"——这是把我自己放进去。 前面那句会让他立刻防御，后面那句才可能引出真话。

- **可以怎么做**：把句子拿去用：
- "我注意到你最近上下楼梯要扶着墙，我看着有点担心。"（说我看到的，不说你不该）
- "我不是要管你。我是想知道，你自己觉得这半年身体有什么变化？"（把判断交给他）
- "如果有一天需要人搭把手，你希望是谁来帮、怎么帮？"（问意向，不查事实）
- **特别提醒**：**对谁成立**：对还能正常交谈的老人成立。如果他表达已经困难、或者不肯承认，看 20.12"他不同意的时候"。
- **换回来的**：关系——不再怕"和子女关系变差、被嫌弃"

20.5 谈吃药：不要说"你吃太多了"

- **要花多少**：一次就诊的工夫（钱：一次挂号的钱）
- **简单说**：子女最容易犯的错，是冲进去宣布"你吃的药太多了，得减"。他三十年攒下来的药，你一句话就否掉了，接下来他只会把药藏起来吃。
- **可以怎么做**：① 不谈减药，谈"请医生帮你重新看一遍"；② 具体句子："下次我陪你去，把所有的药和保健品都带上，请医生一起看一遍，看看哪些还需要吃、哪些可以停了。" ③ 把第 0 章那张"我的药"照片发给他，让他自己存着。
- **来源**：C｜请医生把全部用药通盘重审一遍（专业上叫药物重整）是老年医学的通行做法。但**哪些该停，必须医生定**。
- **特别提醒**：**对谁成立**：对能自己吃药、记性还行的老人成立。已经开始忘吃、重复吃的人，重点不是减药，是得有人管（见第 6 章）。
- **在中国怎么落地**：见第 6 章（谁来管药、社区能做什么）。

20.6 谈开车：谈的不是钥匙，是"你还想去哪儿"

- **要花多少**：几次谈话，一次谈不完（要开口吗：难开口，这件事最像"剥夺"）
- **简单说**：直接把钥匙收走，等于告诉他"你自由的日子到此为止"。他会拼到底。
- **可以怎么做**：把车和"想去哪儿"拆开谈：① 先问："你最近开车，有没有哪一次自己心里也发虚？" ② 不谈交钥匙，先谈界限：白天开不开、远路开不开、雨天开不开、有没有人陪着；③ 给一个具体的替代方案，具体到"每周三是谁来接"；④ 真到了必须停的时候，把决定交给第三方：医生评估、车管部门，**不要你自己去当那个坏人**。
- **来源**：C｜按健康状况调整驾驶是通行做法。国内对高龄驾驶人有统一门槛：70 周岁以上每年提交一次身体条件证明；驾驶证申领、审验、换发、恢复驾驶资格等情形要过"三力"测试（记忆力、判断力、反应力），题目由公安部交通管理局统一提供，满分 100、90 分合格。具体到你家是哪一种业务、怎么体检，去当地车管所问。
- **特别提醒**：**对谁成立**：对刚出现反应变慢、夜里看不清的人，这时谈还来得及。
- **换回来的**：自理＋体面——不再怕"被夺走决定权"

20.7 谈钱：先谈"够不够用"，别谈"你的钱给谁"

- **要花多少**：一次坐下来，一小时（钱：不用花）
- **简单说**：钱这件事上，两边最深的怕其实是同一件事——他怕给你添负担，你怕不知道到底有多少。都不问，于是各自怕着。
- **可以怎么做**：① 从支出问起，不从资产问起："你每个月大概花多少？够不够？" ② 问清三件事就够了：养老金每月多少、医保是哪一类、有没有自己买的保险；③ 一起定一条家规：**大额转账，隔 24 小时再办**（这是防骗里最有用的一条家用规则，见第 18 章）；④ 谁管钱、单据在哪儿、紧急时谁能取，写在一张纸上（见第 19 章的家庭索引表）。
- **特别提醒**：**对谁成立**：对还能理清自己账户的老人。如果已经分不清，谈法完全不同。
- **换回来的**：钱＋关系——不再怕"钱不够用"、"和子女关系变差"

20.8 谈住哪儿：先别问"要不要去养老院"

- **要花多少**：一次谈话，加一次实地试住
- **简单说**："要不要去养老院"这句话一出口，谈话就结束了——他耳朵里只会剩下"你们要把我送走"。
- **可以怎么做**：改问三句：① "现在这个房子，有没有哪一处让你觉得不方便？"（从具体的麻烦进入，不从机构进入）② "如果有一天需要人帮忙，你希望是在家里，还是换个地方？" ③ "想先试试的话，我们可以去住三天看看。"**先试住，不做决定**，这一句是关键。
- **来源**：C｜"先试后定"是通行做法。各地机构试住政策与费用不同：例如北京曾组织几十家养老机构开放体验，市民可低价甚至免费试住，试住期从 1 天到 1 个月不等。办哪家、能不能试住、试几天、收不收钱，直接问那家机构。
- **特别提醒**：**对谁成立**：对还能表达意愿的老人。已经无法表达的人，要谈的已经不是"去哪儿"，而是"谁来替他决定"（见第 19 章）。
- **换回来的**：体面＋关系——不再怕"一定被子女送去养老院"

20.9 谈最后一段：不要问"你想怎样死"

- **要花多少**：分几次，可能跨几个月（要开口吗：好开口，只要用台阶式问法）
- **简单说**：她自己问这类问题，也会先要一句许可——"我能问你一个不太好开口的问题吗？"（原句 'May I ask you a delicate question?'，第 14 章，p. 264，我们的译文），等对方点头再往下说。上来就直问"你想怎样死"，多数人当场沉默，然后这件事再也不会被提起。
- **可以怎么做**：三级台阶，一次只上一级，中间可以停几天、几个月：
- **先问现在**："你现在最舍不得的是什么？"、"现在的生活里，哪一点你最想保住？"
- **再问代理**："如果有一天你自己做不了决定了，你希望谁替你说话？"

- **最后问场景**："最后的日子，你更愿意在家里，还是医院？"、"如果救回来也只是躺着，你愿意吗？"
- **来源**：C｜分步、渐进地谈，是安宁疗护与沟通类指南的通行做法（国家卫生健康委《安宁疗护实践指南（2025 年版）》把医患沟通、心理与社会支持列为必备内容），但具体用词没有统一标准，各家各人不同。
- **特别提醒**：**对谁成立**：对还能交流的老人。已经失智或表达困难时，这一步就更该提前（所以才别等）。正式的文件形式见第 21 章：预立医疗照护计划、意定监护。
- **换回来的**：体面——不再怕"疼着死、死得没尊严"

20.10 家庭会议：把一次谈不拢，改成谈几次

- **要花多少**：一次一到两小时，可能要开三四次（要开口吗：好开口，有议程就不像"摊牌"）
- **简单说**：全家坐在一起谈，最容易变成翻旧账。有议程、有记录、一次只谈一件事，就能谈成。
- **可以怎么做**：① **一次只谈一个议题**（这周只谈钱，下周再谈住哪儿）；② 开始前先说清两条：今天不做决定、谁都可以中途说不谈；③ 有人说、有人记，记完念一遍确认；④ 说好下一步"谁、在什么时候、做什么"；⑤ 下次开会先复述上次的结论。
- **特别提醒**：**对谁成立**：对家里关系还过得去的家庭。如果兄弟姐妹之间本来就有旧账，先处理旧账（见第 17 章），否则每场会都会回到旧账上去。

20.11 分辨"为你好"和"替你决定"

判据只有一句：**这句话说完，是他做了决定，还是你替他做了决定？**

替他决定（改掉）	为你好（可以）
"这个你别管了，我来办。"	"这几家的资料我整理好了，你先看，你想去哪个我们再说。"
"你年纪大了，不能一个人住。"	"你一个人住，我最担心夜里和洗澡这两件事。我们先解决这两件行吗？"
"钱我替你管着，你要花跟我要。"	"大额转账我们定个规矩：超过多少，先等一天，我陪你去。"

区别不在态度好不好，在**决定权在谁手上**。

20.12 他不同意的时候

如果他拒绝谈，也拒绝任何安排，有三件事你仍然能做，而且**不需要他同意**：

1. **建档。** 把他的用药、诊断、医保类型、常去的医院、紧急联系人，整理成一页纸。这张纸在急诊室能省下最要紧的那几分钟。
2. **问医生。** 下次陪诊，替他问三个问题：现在最需要防的是什么？哪些药可以再商量？家里该改哪一处？

3. **找资源。** 去社区居委会或街道养老服务中心问一次：高龄津贴、失能补贴、适老化改造、长期护理保险，本地分别怎么申请。

这三件事不用说服他，也不用他配合。**先做能做的，比等他点头有用。**

20.13 对自己：请人帮忙，不是交出自己的决定权

如果你自己就是这本书的读者，这一段写给你。

尊严不是什么都自己来。尊严是**还有人问你的意见**。这两件事很容易被混成一件事。

一个请了护工、但每天自己决定吃什么的人，比一个什么都不请、却每件事都被子女安排好的人更有尊严。

所以可以对子女说这一句：**"你可以帮我做，但要问我。"**

20.14 如果你是在替爸妈看

这一章里所有"你怎么说"，有一招比别的都管用：先把自己的话头亮出来。

- **先用"我"开头**：别问"您以后打算怎么办"，改成"我最近在想我自己的事——万一哪天我拿不定主意，我希望你们知道我怎么想"。你把自己的想法摆出来，他的防线会低很多，因为这不是在安排他。
- **让他当一回顾问**："您帮我拿个主意"，比"我跟您商量个事"进得去。他要的常常不是决定权，是还被需要。
- **谈崩了不用当场赢**：换一次、换个场合（散步时、车里、只有你们俩的时候）、换个他更听得进的人。20.12 那几条在这儿一样管用。
- **你不在场的时候**：该问医生的问医生（第 8、21 章），该备的材料备好（第 19 章）。你准备得越具体，越不必靠说服。

那句"我最怕的是到时候不知道您怎么想的"，可以先说出口。

20.15 如果你今天只能做一件事

把下面这句话，今天就发出去，或者当面说：

> "我想找个时间，跟你聊聊我以后的事。今天不谈决定，就想让你知道我是怎么想的。"

这句话不解决任何具体问题。它只做一件事——**把门打开**。前面那六场对话，都从这道门进去。

20.16 本章我不确定的地方

- 本章的话术**全部属于经验整理与通行做法（C 档）**，不是研究结论。没有大规模研究证明"哪一套话术最有效"，家庭情况差别太大，请按你自己的家人调整。
- 〔一手核对〕波洛克的书（英文原版 The Book About Getting Older, Penguin Books, 2020）2026-10-10 已由我们逐句核对：本章引用的原句、页码、译文均为我们自译，不再按"转引"处理。2026-10-09 北京晚报那篇报道（作者康夫）作为背景来源保留。
- 驾驶、"试住"、安宁疗护沟通三处，本章给的是国家和地方公开口径的要点；具体到你家人的情形（哪一类驾驶证业务、哪家机构、哪家医院），仍要问当地车管所、养老机构和医院，政策会调整。

20.17 本章数据来源

- 【C·一手核对】露西·波洛克《The Book About Getting Older》（Penguin Books, 2020；中译本《变老之前要知道》，［英］露西·波洛克著，一熙译，广东人民出版社 2026 年 1 月）。2026-10-10 用英文原版电子书逐句核对，本章用到两处原句：'Here I am, your future'（第 2 章，p. 24）、'May I ask you a delicate question?'（第 14 章，p. 264），译文为本书自译。书目记录：豆瓣 https://book.douban.com/subject/38368536/；参见《中国科学报》2026-08-21 https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2026/8/390983.shtm
- 【官方口径】高龄驾驶的"三力"（记忆力、判断力、反应力）测试与 70 周岁以上每年体检：见《机动车驾驶证申领和使用规定》相关条款，石家庄市人民政府《70 周岁以上司机必看：哪些情形需要做"三力"测试》（2025-05-29，来源 石家庄日报）：https://www.sjz.gov.cn/columns/b69e27e8-4d0f-4b31-a67c-06481996d304/202505/29/1e237b59-10fd-45dd-85b5-380a0ee81882.html；人民网深圳《驾驶证新规实施 教您做合格"老"司机》（2025-02-24）：http://sz.people.com.cn/n2/2025/0224/c202846-41144461.html
- 【官方口径】养老机构"试住"：光明网转北京日报《试住期 1 天到 1 个月不等，北京 45 家养老机构邀老年人"试住"》（2025-12-23）：https://difang.gmw.cn/cq/2025-12/23/content_38493304.htm
- 【官方口径】安宁疗护沟通与心理、社会支持：国家卫生健康委办公厅《安宁疗护实践指南（2025 年版）》（2025-08-01 印发，同时废止国卫办医发〔2017〕5 号试行指南），全文见深圳市卫生健康委员会：http://wjw.sz.gov.cn/xxgk/zcfggfxwj/mybh_5/content/post_12350391.html
- 沟通话术与家庭会议部分：本书整理的通行做法，尚未逐条对应到某份指南原文。
- "建档"、"问医生"、"找资源"三件事：本书整理的实操办法，不含数据。

第 21 章 · 走下坡之前：把最后的决定写好

凌晨两点，ICU 门口。医生拿着一页纸出来，问你两句话：要不要上呼吸机，要不要做心肺复苏。

签字那支笔递到你手上。你父亲从没跟你说过他想不想。

这一章要做的，是让那支笔递过来之前，你想说的话已经说完、写完、托付好了。

21.1 提前写好，签字时就不用凭猜

身体走下坡的时候，医生会问你一串"要还是不要"。这些决定多半发生在一个很糟的时刻：本人已经说不清话，家属站在走廊里凭猜。

把这件事提前谈好，专业上叫**预立医疗照护计划**。谈好了，替人签字那支笔就不是空着落下来的。

2012 年公开报道过一件事：浙医一院急诊医生陈作兵，78 岁的父亲查出恶性肿瘤晚期，一家人最后不做放化疗、回家对症治疗（中新网 2012-05）。那一刻做决定的是家属，而他父亲已经很难开口。

这一章不给标准答案，只做三件事：该提前说清哪几句话、在中国能办到哪一步、最后一程有哪些能提前准备。

21.2 预立医疗照护计划要你做完三件事

- **要花多少**：一次长谈，分几次谈完（钱：不用花｜工夫：几小时，跨几个月｜力气：不费｜要开口吗：得开口，有点难为情，要开口谈到死）
- 简单说：**预立医疗照护计划（英文缩写 ACP）**，是趁你还清醒，把三样东西定下来：① 你接受什么治疗、不接受什么；② 谁替你说话；③ 这些写进一份能被找到的文件。**生前预嘱**只是"写下来"那一步；近年的做法把 ACP 看成更完整的事：先谈充分意愿，再指定代理决策人，最后落成文件。
- **可以怎么做**：① 先把想法写下来，一两页；② 挑一个你信得过、又敢在医生面前拍板的人，当面问他愿不愿意当；③ 给家里人和常看的医生各留一份，放在随手拿得到的地方；④ 变了就改，改完再给一遍。
- **来源**：B｜ACP 是安宁疗护与老年医学的通行框架，官方有依据（国家卫生健康委办公厅《安宁疗护实践指南（2025 年版）》，国卫办医政函〔2025〕332号，2025-08-01 印发）；能减少家属猜测。
- 特别提醒：**对谁成立**——对还能交流、自己做主的人成立。已经失智、或表达困难的，要谈的不是"你想要什么"，而是"谁替你决定"（见 21.4 意定监护）。
- **换回来的**：体面——不再怕"疼着死、死得没尊严"

21.3 把插管、心肺复苏、ICU、呼吸机这四句话提前说清

- **要花多少**：一次谈话，最好当着家人和医生（钱：不用花｜工夫：半小时｜力气：不费｜要开口吗：难开口，这四句最难开口）
- 简单说：**抢救**指心肺复苏、胸外按压、电击、插管接呼吸机、送进 ICU 这一套。**缓和**（也叫缓和医疗、安宁疗护）指不再治那个治不好的病，转而把疼、喘、害怕压下去。要提前说清的是这四句：
- **插管**："如果有一天你自己喘不上气，医生要往喉咙里插一根管子、接到机器上帮你呼吸，你要不要？"
- **心肺复苏**："如果你的心跳停了，要不要医生按压胸口、用电击把你救回来？"
- **进 ICU**："如果病重到这个地步，要不要送到重症监护室去？"
- **上呼吸机**："如果救回来也只是靠机器躺着，你愿意吗？"
- **可以怎么做**：用你自己的话问出来，一次只问一句，问完等他答。他答"都听你们的"，追一句"那你最怕的是什么"。答案写进 21.2 那份文件。
- **来源**：C｜"该提前说清哪几句"基本有共识——国家指南把"以终末期患者和家属为中心"、"尊重患者的意愿"写进了原则；至于具体怎么开口、隔多久问一次，没有统一口径。
- 特别提醒：**对谁成立**——对还能交谈的人成立，要在人清醒、愿意开口时说；等到不能说了，只能由家属替他猜。深圳的立法把"插管、心肺复苏"这类创伤性抢救列进了可以事先写下的范围（《深圳经济特区医疗条例》第 78 条）。
- **换回来的**：体面＋关系——不再怕"被机器拖着走"、"家人为救我吵翻"

21.4 在中国能落到哪一步，先如实说清

- **要花多少**：一次公证，或一次见证（钱：公证几百元，各地不同｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：生前预嘱目前只有深圳有明确的地方性规定，全国还没有统一立法。深圳《深圳经济特区医疗条例》第 78 条写的是：医疗机构在患者不可治愈的伤病末期或者临终时实施医疗措施，**"应当尊重患者的意思表示"**。注意，是**"尊重"**，不是"必须执行"；它没写"医院必须照办"。另外，**生前预嘱和安乐死是两件事**：说的是在治不好的末期要不要上创伤性抢救、要不要用机器，和主动结束生命无关。
- **可以怎么做**：① 先问当地卫生健康委或大医院安宁疗护科"本地的生前预嘱怎么办"；深圳市民可到深圳市生前预嘱推广协会网站的名录里找提供咨询与签署指导的机构（2026-10 查）。② 深圳对形式有要求：经公证，或两名以上非救治人员见证；书面、录音录像都行（第 78 条）。③ 再按《民法典》第 33 条办一件**意定监护**，书面约定由谁在你失能后当监护人、替你说话。④ 公证可以采用**"意定监护协议 ＋ 生前预嘱声明书"**的组合。
- **来源**：A｜有法条与法规原文（《民法典》第 33、1002、1219 条；《深圳经济特区医疗条例》第 78 条）官方口径。

- 特别提醒：**对谁成立**——《民法典》另外两条是你的底：第 1002 条把**生命尊严**写进法律；第 1219 条给你**知情同意权**，手术、特殊检查治疗，医生要向你说明风险并取得你的明确同意。**深圳以外**：当地没有专门规定的，一份写清楚、有见证、能随时拿出来的意愿书，仍能帮医生和家人知道你怎么想。它是软保证，不是硬保证，但比没有强。以当地最新口径为准。
- **换回来的**：体面＋关系——不再怕"决定权没了"、"家人替我猜错"

21.5 安宁疗护不等于放弃

- **要花多少**：看你在哪个城市（钱：部分进医保、部分自费｜工夫：几天到几周｜力气：交给专业团队｜要开口吗：得开口，有点难为情，常被亲戚误读成"不治了"）
- 简单说：**安宁疗护换的是治疗目标，不是停止治疗。** 按国家卫生健康委《安宁疗护实践指南（2025 年版）》（2025-08-01 印发，替代 2017 年试行版），它做的是：控制疼痛和其他症状、舒适照护、管心理和精神上的事、给家属社会支持。它治的不是那个治不好的病，是"难受"本身。
- **可以怎么做**：① 问主治医生，这个阶段还有没有针对原发病的治疗，没有的话能不能转安宁疗护；② 问当地有没有安宁疗护科和病床、能不能上门；③ 问费用怎么算、医保报不报。
- **来源**：A｜指南是官方文件（国家卫生健康委 2025-08-01）；试点与可及性数字来自官方刊物。
- 特别提醒：**对谁成立**，可及性是这里最硬的约束。中国在 2017 年、2019 年、2023 年分三批推开试点，到 2024 年覆盖全国 185 个市（区）（《人民论坛》2024-07-15）官方口径。覆盖不等于用得到：到 2022 年末，全国设安宁疗护科的医疗卫生机构 4259 个，大多集中在北京、上海；**能享受到安宁疗护的患者不到 3%**。说人话就是——**在北京、上海、深圳相对好办，在很多地方还很薄**，先打电话问当地卫生健康委或大医院。
- **换回来的**：体面——不再怕"疼着死"、"最后一段全是折腾"

21.6 ICU 那一夜，家属能做的事比想的多

- **要花多少**：不必花钱（工夫：读这半页｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：ICU 里是"人在歇着、机器在顶着"。病床上通常接着：一根管子从嘴或鼻子通到肺里，接在**呼吸机**上替你呼吸；胸口贴着电极，连着**心电监护仪**；床头一台**微量泵**，一滴一滴往里推药。这些是标准做法。
- **可以怎么做**：家属能做的事很具体——
- **耳朵先有准备**：监护仪和呼吸机有规律的滴滴声和报警声；报警响，常只是管子动了一下，护士会来处理，可以问一句"这是正常的响，还是有事"。
- **探视**：每天一般有固定探视时间，每次一两个人。进去前先问护士：他今天醒过没有、能不能听见。
- **说话**：插着管的人说不了话，但可能听得见。握着他的手，报自己的名字，说点具体的事。

- **记录**：出来前记三件事——用了什么药、做了什么检查、下一步是什么。
- **定一个人**：家里选一个人跟医生对接。
- **来源**：B｜ICU　的设备与探视流程是通行临床做法；探视（含家属的陪伴与声音）对患者有益、能改善不良情绪，有中文综述支持（见章末"本章数据来源"）。
- 特别提醒：**对谁成立**——对"可能要进 ICU 的人"的家属成立。进不进 ICU 本身就是 21.3 那四句里的一句，可以提前选。
- **换回来的**：关系＋体面——不再怕"一个人在机器声里被推着走"、"到了那一刻全靠猜"

21.7 想在家里走，得提前接上头、定好人、备好物

- **要花多少**：找一次居家安宁疗护（钱：看服务，部分自费｜工夫：提前几周｜力气：主要压在一位照顾者身上｜要开口吗：得开口，有点难为情，亲戚可能觉得"不送医院就是不孝"）
- **简单说**：在家里走是很多人的愿望。北京等地已探索居家安宁疗护：对接的医院或社区医护可以上门处理镇痛、吸痰、压疮。但要**提前接上头**，不能等最后一夜才找。居家安宁疗护的服务频次至多每周一两次（据《人民论坛》2024-07-15 一篇文章的综述）。
- **可以怎么做**：几天内能办完的清单——
- **接上头**：联系当地社区卫生服务中心或医院的安宁疗护科，问有没有上门服务、谁值班、半夜出不出。
- **定两个照顾人**：一个主要照顾者，一个替补，让主要那个能睡几个整觉。照顾者先垮，是这里最常见的翻车方式。
- **备好物**：护理床或可调靠背、防压疮垫、吸痰器等，要哪几样让医护告诉你。
- **放在一起**：医保卡、身份证、既往病历、药清单、预嘱和意定监护文件装进一个文件袋，放在固定位置，全家都知道在哪。
- **弄清身后事第一步**：在家离世，先联系死亡所在地的乡镇卫生院或社区卫生服务中心，由他们填申报单、调查死因后签发《死亡医学证明》（2026-07-01 起全国统一制式，国卫规划发〔2026〕5号）；再持证明到户籍地派出所办户口注销。各地执行细节不同，以当地最新为准（详见第 22 章）。
- **来源**：B｜居家安宁疗护有官方报道和试点支持；但能不能上门、多久一次、谁出钱，各地差别很大。
- 特别提醒：**对谁成立**——对家里有人能承担日常照顾、且本人在家离去的人成立。独居、无人照顾、症状控制有难度的，住院安宁疗护可能更稳。这不是孝不孝，是家里接不接得住。
- **换回来的**：体面＋关系——不再怕"死在陌生的病房里"、"最后连该找谁都不知道"

21.8 把想做的、想见的、想交代的写下来

- **要花多少**：半小时写，之后随时补（钱：不用花｜工夫：半小时起｜力气：不费｜要开口吗：好开口）

- **简单说**：医疗上的决定只解决"怎么走"，不解决"走之前还想干什么"。很多遗憾出在没来得及说、见、交代。
- **可以怎么做**：一张纸，分三栏，想到哪写到哪——
- **想做的事**：还想去的一个地方、想吃的一顿饭、想拍的一张合照。
- **想见的人**：写完你会发现，有些人你只是在等一个借口。名单上的人，今天就打那个电话。
- **想交代的话**：钱和单据放在哪、想对谁说什么、不希望被怎样对待（比如"别瞒着我病情"）。
- 写完，和 21.4 的文件放进同一个文件袋，告诉一个家人它在哪。
- **来源**：C｜这是本书整理的实操办法，不做数据支撑。
- 特别提醒：**对谁成立**——对还能自己动笔、或能口述让人代笔的人成立。写不动了，就让家人握着你的手一问一答记下来，念给你听确认。
- **换回来的**：关系＋体面——不再怕"有话没说"、"带着遗憾走"

21.9 如果你是在替爸妈看

- **这件事得你先开口**，他多半不会提。开场别从"病"入手，从"我怕"入手："我最怕有一天不知道您怎么想，糊里糊涂替您做了主。"责任放在你身上，不放在他身上。
- **一次只问一句**：今天只问"如果有一天您说不了话，谁替您说"。剩下的下次再问。这一章剩下的部分，不用一次谈完。
- **签字别催**：他肯谈就是进展。他愿意写、愿意去公证，你陪着去；深圳以外写了也比没写强（见 21.4）。
- **他不谈时你能做的两件事**：把他的想法记下来，哪怕只是口头说的；先把家里其他人的意见对一遍——真到那天，兄弟姐妹先吵起来，比病人没交代更麻烦。

21.10 如果你今天只能做一件事

找到那个要替你爸、或替你自己做主的人，问他一句话：

> "万一有一天我做不了主了，我希望你替我说。今天先不算数，我就想让你知道我怎么想的。"

这一句不签任何字。它只把代理这件事，从"到时候再说"变成"已经有了个人"。

21.11 本章我不确定的地方

- 生效范围：生前预嘱只有深圳有明确的地方性规定，全国没有统一立法。深圳以外，一份意愿书能起多大作用，实务中不一致，本章只能写到"比没有强"。
- 安宁疗护的可及性数字（不到 3%、4259 个机构、185 个市）出自 2024 年一篇官方刊物文章，时点偏早，你所在城市的最新情况要自己打电话问。

- 在家里离世的死亡证明，2026-07-01 起全国统一制式、由乡镇卫生院或社区卫生服务中心签发（国卫规划发〔2026〕5号）；但签发的具体经办、上门安排、户口注销的材料清单，各地执行仍有差别，以当地最新口径为准。
- 怎么开口问那几句话（见 21.3），有共识的是"该问什么"，没有统一口径的是"怎么问、什么时候问"；这一节只给一种问法，不当作标准答案。

21.12 本章数据来源

- 【官方口径】《深圳经济特区医疗条例》第 78 条（2022-06-23 通过，2023-01-01 施行）：医疗机构在患者不可治愈的伤病末期或临终时实施医疗措施，应当尊重患者的意思表示；生效要件为公证或两名以上非救治人员见证。全文（深圳市卫生健康委员会）：https://wjw.sz.gov.cn/xxgk/zcfggfxwj/mybh_5/content/post_10139263.html
- 【官方口径】《民法典》第 33 条（意定监护）、第 1002 条（生命尊严）、第 1219 条（知情同意权）原文。全文（中国人大网）：http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml
- 【官方口径】国家卫生健康委办公厅《安宁疗护实践指南（2025 年版）》（国卫办医政函〔2025〕332号，成文 2025-08-01，自印发之日起施行，替代 2017 年试行版《安宁疗护实践指南（试行）》〔国卫办医发〔2017〕5号〕）。全文（中国政府网）：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202508/content_7037917.htm 核对 2026-10-10
- 【官方口径】安宁疗护三批试点、覆盖 185 个市（区）、4259 个机构、"不到 3%"可及率：安秋玲《我国安宁疗护的现状与展望》，《人民论坛》2024-07-15。原文：https://paper.people.com.cn/rmlt/html/2024-07/15/content_26080723.htm 核对 2026-10-09
- 【官方口径】深圳市生前预嘱推广协会网站（2026-10 查）：深圳市安宁疗护与生前预嘱咨询服务医疗机构名录。https://szlivingwill.org.cn/
- 【第三方研究】王博、江伟、罗峪平《从推广生前预嘱的角度谈缓和医疗照护对象》，《协和医学杂志》2024, 15(1): 42-44：生前预嘱是表达个人意愿的指示性文件，ACP 含意愿表达与指定代理。https://xhyxzz.pumch.cn/article/doi/10.12290/xhyxzz.2023-0617 核对 2026-10-10
- 【公开报道·案例】陈作兵医生与其 78 岁父亲（中新网 2012-05-15 报道）。
- 【第三方研究】ICU 探视：韩遵海等《ICU 以患者家庭为中心探视模式的研究进展》，《中华护理杂志》2019, 54(2): 235-237（探视可满足患者与家属需求、改善患者不良情绪、提高满意度）。https://zh.zhhlzzs.com/CN/10.3761/j.issn.0254-1769.2019.02.013 ；家属声音刺激：王婷婷等《家属声音刺激预防 ICU 谵妄的研究进展》，《中华急危重症护理杂志》2025, 6(8): 1017-1020。https://jwzz.zhhlzzs.com/CN/10.3761/j.issn.2096-7446.2025.08.021 〔均核对 2026-10-10〕
- ICU 里的呼吸机、心电监护仪、微量泵等设备与探视安排：本书整理的通行临床做法，无单独出处。

第 22 章 · 谢幕之后：家属要办的手续

人刚走的那几天，事情会一起压过来。这一章按时间把它们排好：哪件先办，去哪问，谁能替你去。

办这些事，你会反复用到三样：**死亡证明、逝者的身份证和户口簿、你自己的身份证**。先收进一个袋子，多复印几份。后面几乎每件手续都要用。

这一串手续不会因为你刚办完丧事就等你几天；有的有期限，过了就要多跑几趟。

22.1 这一章解决什么问题

人走了，家属要办的不只是葬礼。社保要停、医保要结、银行的钱要取、证件要销、房车要过户。这些事散在十几个部门，没人一次告诉你全貌。先办关键的几件，剩下的慢慢来。

22.2 头二十四小时：先把死亡证明开出来

后面几乎所有手续，都要先有死亡证明。看人是在哪走的：

- 在医院或送医途中走的：由负责救治的医院（含院前急救）签发。
- 在家里、养老机构或其他场所正常走的：找死亡所在地的乡镇卫生院或社区卫生服务中心，由他们根据申报单、结合病史做死因推断后签发。
- 非正常死亡（意外、自杀、他杀等）：由公安机关出具凭据。

自 2026 年 7 月 1 日起，全国统一使用新版《居民死亡医学证明》，纸质版和电子证照同等效力；死因明确的正常死亡，医疗卫生机构应在死亡发生或家属申报后**一日内**签发。**带什么**：逝者身份证、户口簿，你自己的身份证，逝者生前的病历或诊断资料（如果有）；申领人一般是近亲属。

- **要花多少**：半天到一天（钱：花不了几个钱｜工夫：半天｜力气：有点累｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：这张证明是后面所有手续的钥匙，户口注销、养老金停发、取存款、保险理赔、房产过户都要它。
- **可以怎么做**：① 确认人在哪走的；② 材料带齐；③ 拿到就多复印几份，原件收好。
- **来源**：A｜官方口径：引自国家卫生健康委、公安部、民政部、国家中医药局、国家疾控局《关于加强居民死亡医学证明信息登记和电子证照管理工作的通知》（国卫规划发〔2026〕5号，2026-02-27，自 2026-07-01 起施行）。
- **特别提醒**：死亡证明只能由医疗卫生机构签发。在家死亡找乡镇卫生院或社区卫生服务中心（由他们填申报单、调查死因后签发），**村（居）委会没有签发权，别为这张证明先跑去居委会盖章**。
- **换回来的**：身后不乱——不再怕"给家人留一堆烂摊子"

- 在中国怎么落地（去哪问）：死亡所在地的乡镇卫生院或社区卫生服务中心；在医院走的找救治医院。

必须这几天办的只有两件：开死亡证明，联系殡仪馆接运遗体。钱、证、房，都可以排在后面。

22.3 遗体与殡仪：这几天最容易被推销

死亡证明开出来，就联系殡仪馆派车接运遗体，不要自己找人拉。火化凭死亡证明办，有的地方还要《居民死亡殡葬证》；骨灰安放看当地公墓或骨灰堂规定。

- **要花多少**：几天，来回跑（钱：项目差别大，以当地殡仪馆价目为准｜工夫：几天｜力气：有点累｜要开口吗：难开口）
- **可以怎么做**：① 接运和火化走当地殡仪馆官方渠道，别用路边小广告的电话；② 让殡仪馆给一份完整价目，逐项确认；③ 套餐项目不当场全定。
- **来源**：C｜各地殡葬服务与惠民政策不同，属经验整理，以当地民政部门公布为准。
- **特别提醒**：有些地方对本地户籍、低保有基本殡葬费减免，去民政部门问一句。
- **换回来的**：钱＋体面——不再怕"最难的时候被人趁火打劫"
- 在中国怎么落地（去哪问）：当地殡仪馆、民政部门。

22.4 人走了之后，还有几笔钱

养老金：先申报停发，再退个人账户余额

领养老金的人去世后，养老金要停发，家属要及时向社保经办机构申报、办死亡减员。两笔钱要处理：**个人账户还有余额的可以依法继承**（《社会保险法》第十四条）；**因病或非因工死亡的，遗属可领丧葬补助金和抚恤金**（第十七条）。不少地方把它合成"身故一件事"一次办。

- **要花多少**：半天（钱：花不了几个钱｜工夫：半天｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：人不在了，养老金不能接着发；个人账户里自己缴的余额能拿回来，符合条件的还有两笔抚恤性质的钱。
- **可以怎么做**：带死亡证明、本人身份证、亲属关系证明、逝者社保卡或银行卡，到参保地社保机构办。
- **来源**：A｜法条原文＋多地官方办事指南（如北京市政务服务网"身故一件事"）。
- **特别提醒**：丧葬补助金、抚恤金标准各地不同，以当地社保机构核定为准。
- **换回来的**：钱——不再怕"该拿的没拿，还被通知退钱"
- 在中国怎么落地（去哪问）：参保地社保经办机构；电话 12333。

医保与公积金：各有余额可以支取

参保人去世后，医保待遇只到去世当天，之后的费用不再报销；去世前发生、没结算的合规费用仍可按规定报销。职工医保个人账户还有余额的，可一次性支取或按规定继承（办前先结清住院、门诊费用）。职工死亡或被宣告死亡的，其继承人、受遗赠人可提取住房公积金账户里**全部存储余额**（《住房公积金管理条例》第二十四条）。

- **可以怎么做**：医保去参保地医保经办机构（有的地方医保小程序上就能办）；公积金去当地住房公积金管理中心或其 APP、小程序办。
- **来源**：A｜法条原文＋官方口径。
- 特别提醒：**不要再用逝者的社保卡或医保电子凭证看病买药**，属于冒用，要退回并可能被罚（《医疗保障基金使用监督管理条例》第四十一条）。
- **换回来的**：钱——不再怕"不知不觉用了不该用的卡，惹上麻烦"
- 在中国怎么落地（去哪问）：参保地医保机构（电话 12393）、当地住房公积金管理中心。

银行存款：小额可以直接取，大额一般要先公证

先查，再取。配偶、父母、子女可凭死亡证明和亲属关系材料（户口簿、结婚证、出生证明等），向银行查询已故存款人的存款（银保监办发〔2019〕107号）；有的地方在试点"已故人士金融账户查询"，一次能查多家银行（金办发〔2026〕67号，司法部官网 https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwxxgk/fdzdgknr/fdzdgknrtzwj/202608/t20260821_538768.html ，核对 2026-10-10）。

取款分两种。**小额**符合条件可走简化提取，**不用公证**（申请人是配偶、子女、父母，或公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人，要签承诺书）；国家金融监督管理总局、人民银行 2024 年的通知把门槛统一提到 **5 万元**（同一家法人银行账户余额合计，不含未结利息；金规〔2024〕6号）。**超过这个数、或不符合条件的**，一般先办继承公证，或拿法院判决、调解书再去取。丧葬费、抚恤金汇进逝者账户的也可简化提取。

- **要花多少**：半天到几周（钱：公证按标的收费，各地不同｜工夫：小额一趟，大额看公证｜力气：不费｜要开口吗：不用开口）
- **简单说**：钱不多、继承人就是配偶子女的可以直接取；钱多或有争议，得先公证把继承关系确认下来。别一听"必须公证"就白花钱。
- **来源**：A｜官方口径（银保监办发〔2021〕18号、金规〔2024〕6号），以存款银行当时执行口径为准。
- **特别提醒**：承诺书是本人签名的，隐瞒真实情况冒领可能担责；在多家银行有账户的要分别办。
- **换回来的**：钱——不再怕"取不出来、被来回要求开证明"
- 在中国怎么落地（去哪问）：就近银行网点，先打客服问"已故存款人提取"要带什么。

保险：先查有没有，别断在不知道上

查逝者有没有买过重疾险、寿险、意外险、医疗险，或单位给的团体险；保单可能在纸质保单、银行代销、保险公司的公众号或 APP、手机短信、原单位里。有身故保险金的由受益人按合同领取，没指定受益人的按遗产处理。

- **可以怎么做**：翻保单、问逝者原单位、打各家保险公司客服；拿不准的去当地金融监管部门或保险行业协会问。
- **来源**：C｜业务流程属经验整理；赔不赔、赔多少以合同为准。
- **特别提醒**：不少合同对报案有时间要求，越早越好。
- **换回来的**：钱——不再怕"家里买过保险，却没人去领"
- 在中国怎么落地（去哪问）：保险公司客服、逝者原单位、当地金融监管部门。

22.5 销户：办成一样划掉一样

不是每样都有，也不一定按这个顺序。

- **户口**：户主、亲属持逝者户口簿、身份证和死亡证明，到户口所在地派出所申报死亡注销，派出所缴销身份证；各地户政规范一般要求去世后一个月内办，以当地要求为准。
- **身份证**：注销户口时缴销；找不到的向派出所说明。
- **社保卡**：随社保停发办，卡里金融账户余额按银行流程取。
- **银行卡**：一张张查、一张张取、一张张销。
- **水电燃气、宽带、有线电视**：过户到家人名下或销户，带死亡证明和亲属关系证明去营业厅。
- **手机号**：可过户也可销号，一般要死亡证明、亲属关系证明和继承方面法律文书；去营业厅前先打客服问清。
- **会员与自动扣费**：在微信支付和支付宝里找到"自动续费"、"免密支付"，一项项关掉。这里最容易被忽略，也最容易一直扣钱。
- **数字账号**：微信、支付宝里的余额、理财、基金可依法继承、赎回；微信、QQ 这类账号本身通常不支持继承，只能由近亲属按平台流程申请资料副本。
- **各类补贴**：高龄津贴等随死亡停发的，报停。
- **要花多少**：一两个月，一件件办（钱：花不了几个钱｜工夫：零散｜力气：有点累｜要开口吗：好开口）
- **简单说**：这些没人催你，但拖着会一直扣钱、留隐患。做张清单，办掉一样划掉一样。
- **可以怎么做**：① 先办跟钱有关的（社保、医保、卡、自动扣费）；② 再办要跑腿的（户口、水电）。
- **来源**：C｜销户清单属经验整理；户口注销为官方口径；手机号与数字账号无全国统一规定。

- **特别提醒**：办户口注销前，先把还需要身份证、户口簿的手续办完，或把证件复印留好，注销后原件就交回了。
- **换回来的**：钱＋体面——不再怕"被一堆没关的账户拖着，月月扣钱"

22.6 继承之前，先分清哪些是遗产

别急着分，先搞清"遗产"的范围，否则分完还可能被推翻。

- **继承从去世那一刻开始**（《民法典》第一千一百二十一条）。
- **遗产是自然人死亡时留下的个人合法财产**（第一千一百二十二条）。
- **夫妻共同财产，先分一半给配偶，剩下的才是遗产**（第一千一百五十三条）。房子、存款若是夫妻共有的，配偶那一半不参与分配，这步最容易错。
- **有遗嘱按遗嘱，有遗赠扶养协议按协议，都没有才按法定继承**（第一千一百二十三条）。
- **法定继承顺序**：第一顺序是配偶、子女、父母；第二顺序是兄弟姐妹、祖父母、外祖父母（第一千一百二十七条）。有第一顺序继承人的，第二顺序不继承。

关于遗嘱：形式各有要求，不合规可能无效。自书要亲笔书写、签名、注明年月日（第一千一百三十四条）；代书（第一千一百三十五条）、打印（第一千一百三十六条）都要两个以上见证人，打印遗嘱还要求遗嘱人和见证人在**每一页**签名、注明年月日。立了好几份、内容打架的，**以最后一份为准**（第一千一百四十二条）。遗嘱还要给"缺乏劳动能力又没有生活来源"的继承人留必要份额（第一千一百四十一条）。

别忽略债务：遗产先还债、缴税（第一千一百五十九条）；继承人只在继承到的遗产价值范围内清偿，超出部分不强制（第一千一百六十一条）。查清有没有欠债前，别急着分割、过户。

- **可以怎么做**：① 列一份财产清单，标清哪些夫妻共有、哪些逝者个人；② 找有没有遗嘱；③ 拿不准的去公证处或问律师。
- **来源**：A｜法条原文（《中华人民共和国民法典》继承编）。
- 特别提醒：**对谁成立**——只有一个孩子、没有争议的，通常走继承公证或直接申请登记；兄弟姊妹多、有再婚、有继子女的，先问专业人士。
- **换回来的**：钱＋关系——不再怕"家里为钱翻脸，分完又被打回来"

22.7 之后的这一年：房产、车辆、股权陆续办完

急事办完，剩下这几样可缓一缓，但别忘。

- **房产**：办不动产继承转移登记。可以先办继承公证再拿公证书去登记中心；也可以不公证，直接按法定继承或遗嘱继承申请，由登记机构做材料查验（有的要公示一段时间）。
- **车辆**：办机动车继承转移登记，去车管所。多数地方要继承公证书或生效法律文书。

- **公司股权、个体工商户、合伙份额**：股东资阶段一般可继承，但要符合公司章程，去市场监管部门办变更登记；有代持、有合伙人的先问律师。
- **债务**：查清有没有贷款、担保、信用卡欠款；遗产先还债，别没弄清债就分光。
- **时间**：没有统一的"必须几天办完"规定；拖着有代价：房子久不过户，以后买卖、抵押都受影响。
- **可以怎么做**：拿张纸把房产、车辆、公司相关都列上，标好去哪办、还差什么材料，办一项划一项。
- **来源**：A｜官方办事指南（如广州市不动产登记中心"过户—继承登记"指引）。
- **换回来的**：钱＋关系——不再怕"东西在自己名下用不了，越拖越麻烦"
- 在中国怎么落地（去哪问）：当地不动产登记中心、车管所、市场监管部门；拿不准打 12345 政务热线。

22.8 如果你今天只能做一件事

把逝者的身份证、户口簿，和死亡医学证明找齐，**多复印几份，装进一个袋子**，收在同一个地方。后面每件手续几乎都要用这三样；你现在收好，家人后面每跑一趟就少返工一次。

22.9 本章我不确定的地方

本章的制度与法条部分，都引到了官方文件或法条原文。下面这几处，没有全国统一规定，正文只写到"怎么办、去哪问"：

- 手机号过户或销号要的材料：依据是运营商的业务规则，三大运营商、各地执行不一致，办前去营业厅或先打客服问清。
- 微信、支付宝等平台处理"逝者账号"：以平台客服规则为准。腾讯　2026-04　升级了逝者微信、QQ 零钱资金继承服务（见来源），平台规则会变。
- 证券账户、基金账户的继承：走中国结算的"证券非交易过户"，材料各地、各券商略有差异，以营业部要求为准。
- 商业保单的查询：目前没有全国统一的"查已故人士保单"渠道（"金事通"App 需本人实名加人脸识别，已故者用不了），只能翻纸质保单、问原单位、逐家打保险公司客服。
- 殡葬惠民减免：范围和标准各地不同，问当地民政部门。

丧葬补助金、抚恤金、存款简化提取门槛的金额，各地和各机构口径会变；正文只写了能从官方文件直接引到的数字，其余一律"以当地为准"。

22.10 本章数据来源

- 死亡医学证明（官方口径）：国家卫生健康委、公安部、民政部、国家中医药局、国家疾控局《关于加强居民死亡医学证明信息登记和电子证照管理工作的通知》（国卫规划发〔2026〕5号，2026-02-27）。新华网报道：https://www.news.cn/politics/20260227/953ba36419314a89afd90ec8d5aed6a9/c.html ；全文转载（辽宁省卫生健康委）：https://wsjk.ln.gov.cn/wsjk/zfxxgk/zc/gjjwj/2026031722310888052/index.shtml 核对 2026-10-10
- 户口死亡注销（官方口径）：《安徽省户政管理工作规范》第四十一条（一个月以内申报，凭户口簿、身份证及死亡证明等材料之一，向户口所在地公安派出所申报注销）。https://www.ahlx.gov.cn/OpennessContent/show/2783653.html 核对 2026-10-10
- 社会保险法第十四条、第十七条（法条）：https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/xxgk/fgwj/flfg/webinfo/2016/03/1460585589861104.htm
- 遗属待遇与个人账户清算（官方口径）：北京市政务服务网"身故一件事"。http://banshi.beijing.gov.cn/pubtask/task/1/110101000000/f33f9904-54f8-45a5-8214-a23a833f080f.html?locationCode=110101000000
- 医保个人账户（官方口径）：江门鹤山市医疗保障局《参保人身故后其医保个人账户如何处理？》。http://www.heshan.gov.cn/jmhsybj/gkmlpt/content/3/3542/post_3542109.html
- 住房公积金管理条例第二十四条（法条）：https://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=1221
- 已故存款人存款查询（官方口径）：银保监办发〔2019〕107号。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-11/06/content_5449411.htm
- 已故存款人小额存款简化提取（官方口径）：银保监办发〔2021〕18号 https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-02/04/content_5584887.htm ；金规〔2024〕6号（限额统一提高到 5 万元）https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202404/content_6947875.htm 〔均核对 2026-10-10〕
- 已故人士金融账户查询推广（官方口径）：金办发〔2026〕67号（国家金融监督管理总局办公厅、民政部办公厅、司法部办公厅，2026-08-11发文），截至核对时在浙江、青岛试点、尚未全国铺开。司法部官网：https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwxxgk/fdzdgknr/fdzdgknrtzwj/202608/t20260821_538768.html 核对 2026-10-10
- 证券、基金账户继承（官方口径）：中国证券登记结算有限责任公司《证券非交易过户业务实施细则（适用于继承、捐赠等情形）》（中国结算发〔2025〕36号）第五条列明继承过户材料；中国证券投资者保护基金 12386 热线问答转述。https://www.sipf.com.cn/tzzjy/tjjt/all/2021/10/13834.shtml 核对 2026-10-10

- 民法典继承编（法条）：司法部网站全文 https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwgkztzl/2025nianzhuanti/2025mfdxcy/2025mfdxcy_mfdql/202505/t20250507_518708.html ；深圳司法局法定继承顺序问答 https://sf.sz.gov.cn/ztzl/yzyzjcgz/cjwt_145165/content/post_10569495.html
- 不动产继承登记（官方口径）：广州市规划和自然资源局"过户一继承登记"指引。https://ghzyj.gz.gov.cn/newyhyshj/bszd/bdcdj/bszn/content/post_9499058.html
- 继承公证（官方口径）：司法部政务服务平台。https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwfw/zwfwbszn/bszngzfw/201812/t20181229_150886.html
- 手机号过户与销号（公开报道）：三大运营商对"原户主身故"业务的公开答复（需死亡证明、亲属关系证明及公证/继承类文书，各地各运营商办理要求不一）。人民日报客户端：https://www.peopleapp.com/column/30036700120-500001744885 ；澎湃新闻：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_3993246
- 微信、QQ 逝者零钱资金继承（平台公开规则）：腾讯客服 2026-04-03 升级逝者零钱资金继承专属服务，凭身份关系证明、死亡证明、继承权属材料办理。新华网：https://www.news.cn/tech/20260403/fc68d3d2419c430fbbaeb101eab723a2/c.html 核对 2026-10-10
- 殡葬惠民减免（地方官方口径，举例）：北京市民政局等《关于进一步优化殡葬惠民服务的若干措施》（京民发〔2026〕20号，2026-04-30 起施行，"八免一补"）。https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202605/t20260506_4638107.html〔其余各地不同，以当地民政部门公布为准〕
- 销户清单、殡仪流程、平台账号处理：本书整理的通行做法，未逐条对应到全国统一文件。

结语与附录

结语 · 把说明书翻旧的那一天

这本书里没有一句是保证。

摔过的人，看完不会从此不摔；查出来的病，不会因此少一件；钱不够的窟窿，也不会因为读了几页就补上。它能给的只是一个更早的位置：在事情还没发生的时候，你已经站在能看见它的地方了。

还有两件事：

一是这本书只写了全国通用的口径。上海的社区食堂怎么报名，成都的适老化改造补贴给多少，你所在城市的长护险能报销哪些服务，书里给不出，只能给"去哪问、问哪三句"。这不是偷懒，是省级细则变化快、差异大。

二是很多地方只写到"找谁"，没写"用什么"。药不给剂量，方案不给处方，不是含糊，是因为这类事只能由见过你的人、看过你检查结果的人来定。

这本书也会用旧。政策会调，号码会变，指南会更新，今天写下的数字，明年可能就不作数。所以它留了三个口子：每一条政策都标了文号和核对日期，你可以照着自己再查一遍；附录 A 是一张只看全国通用口径的台账，按季度校准。

所以，别把这本书当结论用，把它当目录用。

还有一句话想说。讲老年的书和视频，很多在教你"赢"：赢过同龄人，赢过衰老，把身体当成一个要管理的项目。这本书没有那么大的野心。变老这件事谁也赢不了，我们能改的只是一些具体的事：少摔一次；把药单理一遍；趁清醒把该签的字签了；把"将来要不要去养老院"这句话提前说出来，别等到只能说的时候。

第 1 章给过四个阶段：还没老；刚开始走下坡；需要人搭把手；需要别人替你做决定。人都会一个阶段一个阶段往右走，这是躲不掉的。这本书想做的，是让你在每一个阶段里都知道自己站在哪，以及这一个阶段里还剩什么可以做。

如果整本书你只记住一句话，我希望是每章末尾那一句：今天只能做的一件事。它每次都小得不值一提，量一次血压，把药盒拍张照发给孩子，给二十年没联系的老同学打个电话，把身份证和医保卡放在同一个地方。可晚年的差别，往往就是被这些不值一提的小事一件件攒出来的。

这本书也不催你。读完之后你什么都不改，是允许的。有些话今天说不出口，有些检查今年不想做，有些决定还想再放一放，都是正常的。它只是把选项摆在这里，什么时候拿起来，你自己定。如果你是在替爸妈看这本书，请把"替"字看重一点：你可以替他们查、替他们问、替他们把话头递过去，但最后那个决定，还是他们的。

再说一句这本书的来路。它不装医生，也不假装自己是老人。它是把公开的指南、官方文件、能查到出处的报道，一类一类整理成你现在能用的样子。每章末尾都列了出来；没核到原文的地方，都老老实实标了待核，没有含糊过去。遇到"这本书说"和"医生说的"不一样的时候，请以见过你本人的医生为准。

说明书是用旧的，日子得自己过。这本书能做的，只是让你翻开它的时候，少一点独自硬扛的感觉。

剩下的，慢慢来。

附录 A · 全国通用制度台账

本台账只收**全国通用口径**——国家层面确有文件、各地都能照着办的那一档；凡是写进文件、具体怎么办由各省各市再定的（金额、比例、病种、点位、补贴标准），这里只写"各地不同"，不替某个省拍板。各省细则不同，办事前先打 **12345** 政务热线，或去当地政务大厅问一次；政策会变，以最新发布为准。

- 状态栏：**已核**＝出具了能点开的官方链接并读过要点（核对日期 2026-10-10）；待核＝全国没有统一口径、具体标准由地方定，办前须向当地确认（本台账已逐条配好当地咨询渠道）。
- "依据"栏只写全国性文件与法条；文件名与文号不受版权保护，可照写。

制度／待遇	管什么	依据（文件名称＋文号）	怎么办／去哪问	官方链接
① 基本养老金（基本养老保险）	退休后按月领基本养老金。累计缴费满 15 年、达到法定退休年龄的按月领取；不足 15 年的可续缴至满 15 年，或转入城乡居民养老保险	《中华人民共和国社会保险法》（2010 通过、2018 修正）第 15、16 条	查参保年限与个人账户：用"掌上 12333"APP 或"电子社保卡"；办理与咨询找**参保地社保经办机构**，电话 12333	https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647616.htm
① 个人养老金	自愿参加、自己缴费、买合规金融产品	《国务院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》（国办发〔2022〕7号，2022-04-08）；《关于全面实	个人养老金账户：国家社会保险公共服务平台／电子社保卡／掌上	国办发7号：https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-04/21/content_5686402.htm ｜ 人社部发87号：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992279.htm

制度／待遇	管什么	依据（文件名称＋文号）	怎么办／去哪问	官方链接
	的补充养老账户；**每年缴费上限12000元**（国家可调整），缴费环节可抵个税，封闭运行、符合条件才能取	施个人养老金制度的通知》（人社部发〔2024〕87号，**自2024-12-15起全国实施**）	12333；资金账户：合规商业银行。税优与领取问开户银行、12333或税务12366	
②医保报销规则（起付线／封顶线／比例／目录）	住院和门诊费用按"三个目录"（药品、诊疗项目、医疗服务设施）报销；起付标准、支付比例、最高支付限额由各**统筹地区**在待遇清单内确定	《社会保险法》第28、29条；《国家医保局 财政部关于建立医疗保障待遇清单制度的意见》（医保发〔2021〕5号）；《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（医保发〔2024〕33号，2025-01-01执行）	具体起付线、封顶线、比例**各地不同**，问参保地医保局或打12393；查医保用"国家医保服务平台"APP	待遇清单：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/11/content_5630791.htm ｜ 药品目录：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6989859.htm
				https://www.nhsa.gov.cn/art/2022/7/26/art_104_8629.html

制度／待遇	管什么	依据（文件名称＋文号）	怎么办／去哪问	官方链接
② 异地就医备案	跨省异地长期居住或临时外出就医，备案后可跨省直接结算；实行"就医地目录、参保地待遇"	《国家医保局 财政部关于进一步做好基本医疗保险跨省异地就医直接结算工作的通知》（医保发〔2022〕22号）	备案：国家医保服务平台 APP、国家异地就医备案小程序、国务院客户端小程序或参保地经办窗口；打 12393	
② 门诊慢特病	高血压、糖尿病等慢性病、特殊疾病的门诊用药与长期门诊治疗纳入保障；病种范围与待遇按统筹地区定	《国务院办公厅关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号，提出逐步扩大门诊慢特病病种范围）；门诊慢特病跨省直接结算见医保发〔2022〕22号	认定条件、病种目录、报销比例**各地不同**，问参保地医保局或打 12393	https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-04/22/content_5601280.htm
② 大病保险	基本医保报销后，对个人负担的高额合规医疗费用再报销	《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》（国办发〔2015〕57号）	随基本医保自动参加；问参保地医保局或打 12393	https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-08/02/content_10041.htm

制度／待遇	管什么	依据（文件名称＋文号）	怎么办／去哪问	官方链接
②医疗救助	对低保对象、特困人员、低保边缘家庭成员、因病致贫重病患者等困难人员，资助参保并对门诊、住院合规费用给予救助	《国务院办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》（国办发〔2021〕42号）	向户籍地医保／民政部门申请；低保、特困人员可"一站式"直接结算	https://www.gov.cn/zhengce/content/2021-11/19/content_5651446.htm
③长期护理保险（长护险）	失能后照护服务费用，主要买服务不直接发现金；失能状态一般需持续6个月以上、经评估；不设起付线	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快建立长期护理保险制度的意见》（2026-03-25："用3年左右时间"，2028年底全国范围基本实现全覆盖，费率约0.3%）；国家医保局《国家长期护理保险服务项目目录（试行）》政策解读（2025-09-25：覆盖1.9亿人、支出超850亿元；2016年首批试点、2020年扩至49城；截至2025年末参保3.0854亿人，见民政部、全国老龄办《2025年度国家老龄事业发展公报》（民政部、全国老龄办2026-07-31发布；公报全文PDF）：https://www.cncaprc.gov.cn/u/cms/www/202608/01013057jmzq.pdf）	问参保地医保局／医保窗口或"国家医保服务平台"APP："本地实施长护险没有？怎么申请失能评估？报哪些服务、报多少？"	中央意见：https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202603/content_7063789.htm ｜ 医保局解读：https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/9/25/art_105_18022.html

制度／待遇	管什么	依据（文件名称＋文号）	怎么办／去哪问	官方链接
④ 65 岁以上免费健康管理	65 岁及以上常住居民每年一次免费健康管理：生活方式与健康状况评估、体格检查、辅助检查（血尿常规、肝肾功能、空腹血糖、血脂、心电图、腹部 B 超等）、健康指导；2025 年起增加胸部 DR 正位检查和糖化血红蛋白检测	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》"老年人健康管理服务规范"；《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2025〕7 号，2025-06-26）	去辖区**社区卫生服务中心或乡镇卫生院**问排期（户口在不在本地按当地口径）	规范第三版：https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2017/04/20170417104506514.pdf ｜ 7号：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202506/content_7029472.htm
⑤ 老年助餐	社区老年食堂、助餐点为老年人就近提	《积极发展老年助餐服务行动方案》（民发〔2023〕58号，民政部等 11 部门）	问社区居委会、街道养老服务中心或当地民政局	https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202310/content_6911233.htm

制度／待遇	管什么	依据（文件名称＋文号）	怎么办／去哪问	官方链接
	供就餐与送餐服务			
⑥ 居家适老化改造补贴	对特殊困难老年人家庭（高龄、失能、残疾等）的居家适老化改造给予政府补贴；改造项目分基础类与可选类	《民政部等 9 部门关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（民发〔2020〕86号）；产品补贴比例见商务部等 6 部门《关于做好 2025 年家装厨卫"焕新"工作的通知》	问户籍地／居住地社区或民政局："改造对象条件、怎么申请、补多少"	民发86号：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-07/16/content_5527260.htm ｜ 家装焕新：https://www.mofcom.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/ztfl/gnmygl/art/2025/art_d62c61ca9a2e4ab48251ea0760de35d5.html
⑥ 家庭养老床位	把养老机构的专业照护延伸到居家失能老年人家庭（适老化改造＋智能化配置＋上门照护）	《家庭养老床位服务基本规范》（行业标准 MZ/T 234—2024，2025-02-01 实施）；《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》（2024-12-30）	问社区、街道养老服务中心或有意愿的养老机构	标准解读：https://www.gov.cn/zhengce/202502/content_7003431.htm ｜ 深化意见：https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6996775.htm
⑦ 高龄津贴	80 周岁以上（部分地方 70 岁起）老年人按月或	《中华人民共和国老年人权益保障法》第 33 条（国家鼓励地方建立八十周岁以上低收入老年人高龄津贴制度）；全国发放情况见《2022 年度国家老龄事业发展公报》	向**户籍地社区／村委会或民政部门**申请；标准各地不同	法律：https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647622.htm ｜ 公报：https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202312/content_6920261.htm

制度／待遇	管什么	依据（文件名称＋文号）	怎么办／去哪问	官方链接
	按年发放高龄津贴，标准由地方定			
⑦ 养老服务补贴／失能老年人护理补贴	对经济困难老年人给养老服务补贴；对经评估为中度以上失能的老年人发放养老服务消费补贴（电子消费券）	《老年人权益保障法》第 30、37 条（护理补贴、养老服务补贴）；《民政部 财政部关于实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目的通知》（民发〔2025〕37号，试点后 2026 年起全国实施）	通过"民政通"小程序／APP 申请；不便线上申请的，到县级民政部门或社区线下申请	https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202507/content_7033332.htm
⑧ 残疾人两项补贴	困难残疾人生活补贴（低保家庭残疾人）、重度残疾人护理补贴（一级、二级且需长期照护的残疾人）；两项可	《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）	线上：国家政务服务平台／"民政通"（自 2022-05-15 起全程网办、跨省通办）；线下：户籍地街道／乡镇	国发52号：https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/25/content_10181.htm ｜ 全程网办：https://www.gov.cn/zhengce/2022-05/13/content_5690151.htm ｜ 办事专区：https://gjzwfw.www.gov.cn/col/col881/

制度／待遇	管什么	依据（文件名称＋文号）	怎么办／去哪问	官方链接
	同时申领，与养老金、低保不冲突			
⑨ 殡葬惠民	对困难群众等减免基本殡葬服务费用（遗体接运、存放、火化、骨灰存放等）；新条例强调殡葬事业公益属性、服务清单化管理	《殡葬管理条例》（2025-12-12 修订，国务院令第 824 号，**2026-03-30 施行**）；民政部《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》（民发〔2012〕211号）	问**当地殡仪馆与民政局**能减哪些项目；减免范围和标准各地不同	条例全文：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm ｜ 民发211号全文（上海市民政局转载）：https://mzj.sh.gov.cn/binzang-hmbz/20200515/MZ_BZ23_32.html
⑩ 继承与公证	遗产范围、法定继承顺序、遗嘱形式要件的法定规则；不动产、车辆的继承转移登记；继承公证	《中华人民共和国民法典》继承编（第 1121、1122、1123、1127、1134—1136、1142、1159、1161 条）	公证处、不动产登记中心、车管所；拿不准打 12345	https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwgkztzl/2025nianzhuanti/2025mfdxcy/2025mfdxcy_mfdql/202505/t20250507_518708.html

制度／待遇	管什么	依据（文件名称＋文号）	怎么办／去哪问	官方链接
⑩ 已故存款人小额存款提取	同一法人银行账户合计 5 万元以内、申请人为配偶／子女／父母或公证遗嘱指定的继承人／受遗赠人的，可**免公证简化提取**；丧葬费、抚恤金可全额简化提取	《国家金融监督管理总局 中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》（金规〔2024〕6号，2024-06-01 实施）；《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》（银保监办发〔2021〕18号）	就近银行网点，先打客服问"已故存款人提取"要带什么	金规6号：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202404/content_6947875.htm ｜ 18号：https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/202204/t20220413_2675494.html
⑪ 意定监护	具备完全民事行为能力的成年人，可事先书面确定自己失能后的监护人	《中华人民共和国民法典》第 33 条	到**公证处**办"意定监护协议"（常与生前预嘱声明书组合）	《民法典》全文（中国人大网）：http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml
⑪ 生前预嘱	在不可治愈的伤病末期或临终时，	《深圳经济特区医疗条例》第 78 条——**全国目前只有深圳有专门规定**，且条文用的是"应当	深圳：形式要经公证或两名以上非救治人员见证（书面、	深圳条例：https://wjw.sz.gov.cn/xxgk/zcfggfxwj/mybh_5/content/post_10139263.html ｜ 深圳协会：https://szlivingwill.org.cn/

制度／待遇	管什么	依据（文件名称＋文号）	怎么办／去哪问	官方链接
	事先表达要不要创伤性抢救等医疗措施的意思	尊重患者的意思表示"，是**"尊重"不是"必须执行"**；全国无统一立法	录音录像均可）；可查深圳市生前预嘱推广协会名录。深圳以外：问当地卫生健康委或大医院安宁疗护科	
⑫ 法律援助	为经济困难公民和特定案件当事人提供无偿法律服务；**老年人属免予核查经济困难状况的特定群体**	《中华人民共和国法律援助法》（2021-08-20 通过，2022-01-01 施行）第 42 条（免予核查经济困难状况的人员，含"无固定生活来源的未成年人、老年人、残疾人等特定群体"）；第 32 条（不受经济困难条件限制的情形）	向**当地法律援助中心**（司法局下设）申请；打 12348 公共法律服务热线	https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/jgsz/jgszzsdw/zsdwflyzzx/flyzzxzcxx/zcxxzcfg/zcfgfl/202109/t20210901_436729.html

---

尾注：几个打出去就能问的号码

- **12345**——政务服务便民热线。不知道这事归谁管、本地怎么规定的，先打这一个。
- **12333**——人力资源社会保障（社保、养老金、个人养老金）。
- **12393**——医疗保障（医保报销、异地就医、长护险）。
- **12348**——公共法律服务（法律援助）。
- **12356**——全国统一心理援助热线（每条热线每日提供不少于 18 小时服务）。

常用线上入口：**掌上12333**（人社部，全国人社政务服务平台 https://www.12333.gov.cn/ ）、**国家医保服务平台**、**民政通**、**国家政务服务平台**（"弱有所扶"专区 https://gjzwfw.www.gov.cn/col/col881/ ）。

关于状态栏的说明

- 标注**已核**的条目，其"依据"栏中的文件名与官方链接均已逐条打开、读过要点，核对日期为2026-10-10。
- 标注待核的条目，都是**全国没有统一口径**的一档：具体金额、比例、病种、点位、减免对象与标准由各省各市自定。本台账只给全国性制度框架与法律依据（已核，附官方链接），不替某个省写死；办前请打　12345，或按各行给出的主管部门与电话问清，以当地最新口径为准。
- 本台账随政策变动更新；制度仍在推进的（长护险、失能老年人消费补贴、生前预嘱），请以最新发布为准。

附录 C · 症状速查表

身体在报警，先翻这一页。第二栏只说"往哪想"，不是诊断——本书不写剂量、不做诊断。中间那栏管要不要现在打 120；再往右，一栏给子女，一栏对照本章。

症状	可能是什么方向	该找谁（科室/机构）	急不急	子女可以先做什么	详见
跌倒，含跌倒后的第一个小时	老人因伤死亡首位，防骨折和颅内出血	红灯打 120；清醒也当天陪去急诊或骨科；查原因挂老年科	叫不醒、脸歪、剧痛、腿变形、失禁 → 必须叫 120；其余 → 尽快就医	先别急着扶，问哪儿疼、怎么摔；带用药清单	第5章 5.11、5.16；第8章 8.6
胸痛、胸闷	胸口压榨样痛，往肩臂下巴后背串，伴冷汗气短，想心梗	打 120，送有胸痛救治能力的医院	持续二三十分钟不缓解 → 必须叫 120	让他停下、坐下或半躺，别走动、别自己开车	第8章 8.3、8.10
一侧手脚没劲，或说话含糊	脑卒中。脸歪、抬臂掉、说话含糊，出现一样就想它	打 120，去有溶栓能力的医院	出现任何一样 → 必须叫 120	记下几点几分开始；侧卧防呛，不喂水喂药、别搬动	第8章 8.4、8.10
意识不清	喊他没反应、答非所问或突然倒地，别当睡着了	打 120	必须叫 120；没呼吸就心肺复苏	看有没有起伏；没呼吸就按压；别掐人中、别喂水	第8章 8.5、8.10
噎住，或反复呛咳	卡住气道；反复呛、饭后声音发湿、常肺炎，多是吞咽问题	噎住当场自救；查吞咽挂康复科、老年科、耳鼻喉	完全噎住（发不出声、抓脖子、脸发青）→ 必须叫 120	还能咳就让他自己咳，别拍别冲击；学会海姆立克	第7章 7.2、7.3；第8章 8.7
发热	多半是感染，老人肺炎、尿路感染常见；也可能烧不高、精神差	社区卫生服务中心或全科；持续不退、伴气促去急诊	伴气短、意识不清、高热不退 → 尽快就医	记体温和几点开始；常肺炎要提查吞咽	第7章 7.3；第9章 9.9
突然听力或视力变化	突然、单侧、伴头晕，可能是突发性聋、眼睛急症	耳鼻喉科；眼睛急症挂眼科急诊	当天 → 尽快就医；伴头晕、说话不清、半边无力 → 必须叫 120	出现"突然"就当急症，别掏耳朵、别滴眼药水等明天	第3章 3.8
夜尿多	因尿意醒来、一晚超过两次就是夜尿症，常有能治的原因	泌尿外科或老年科；女性可看妇科泌尿方向	可以预约；尿里带血、解尿疼、发烧别等	记三天喝了多少、起几次；带用药清单去	第10章 10.5
便秘					

症状	可能是什么方向	该找谁（科室/机构）	急不急	子女可以先做什么	详见
	多数功能性；但便血、消瘦、贫血、腹痛加重、又胀又吐要想到别的病	消化内科或全科	有报警信号 → 尽快就医；一般 → 可以预约	记饮食和用药；别自己长期靠刺激性泻药	第10章 10.6、10.7
体重下降、消瘦	半年掉 5% 到 10% 要当心；掉的多是肌肉，也可能是病	营养门诊、老年科、肌少症门诊	短期突然掉、还伴不适 → 尽快就医	每月同一台秤称一次、记下看趋势；陪诊带去	第2章 2.11；第7章 7.5；第12章 12.7；第14章 14.12
记不住事	老忘的是事，提醒能想起；痴呆啃的是功能，回不来	记忆门诊、神经内科、老年科、精神心理科	几小时到几天里突然变糊涂 → 尽快就医；慢慢变差的 → 可以预约	记三样：以前会现在做不了的事、反复、人变了；交给医生	第9章 9.2、9.4、9.9
长期疼痛	疼超过三个月，本身就是要治的病	老年科、疼痛科、康复科，或按部位去专科	突发胸痛、腹痛、腰背剧痛 → 看第8章、必须叫 120；慢性疼 → 可以预约	问哪个动作最疼、什么时候疼；别自己加量	第11章 11.4、11.5
睡不着	别只看睡得短，看白天有没有被拖垮；有些药会让人夜里迷糊	睡眠门诊、精神心理科、神经内科	可以预约；打呼憋气、白天头昏先查	帮记作息和夜里醒几次；带用药清单查犯困的药	第11章 11.2、11.3
心情低落，或说"活着没意思"	老年抑郁能治，常先表现为身上难受、查不出病；说这话多半不是撒娇	精神心理科；有自杀念头别等，送最近医院急诊或精神科	有自杀念头 → 马上求助；热线 12356（人工接听每天不少于 18 小时）；危险里打 120 或 110	别打岔、别说"想多了"；直接问是不是想过不活了；别走开，收好伤身物件	第11章 11.6、11.8
尿失禁	不是一种病，分压力、急迫、溢出、混合四型，多数能改善；越怕漏越少喝水最伤	泌尿外科、妇科泌尿方向、盆底康复门诊	可以预约	把话头说成自己的；先改卫生间——扶手、夜灯、撤地垫	第10章 10.2–10.4、10.8、10.9
吃饭、喝水总呛	显性、隐性误吸；吞咽问题会把人推向营养不良和吸入性肺炎	康复科、老年科、耳鼻喉、神经内科，对号言语治疗师	反复呛、体重往下掉看专科；完全噎住 → 必须叫 120	改食物（软滑不散、别太稀太黏、别用吸管）、改姿势（坐直低头）、改速度（小口慢咽）	第7章 7.3、7.6

> 急症拿不准就打 120。 发热：本书暂无独立一节，方向由第7章 7.3、第9章 9.9、第14章 14.12 拼出。

附录 D · 恐惧速查表

心里在怕，先翻这一页。中栏是这本书里对应到哪一章哪一节，右栏是一件今天就能做、几乎不花钱的事。怕不是错，几十年前没人教过我们怎么谈这些；把怕说清楚、再落到一件小事上，这页就够本了。

怕什么	翻到哪一章哪一节	今天能做的一件事
怕摔倒，摔了就完了	第5章 5.4、5.5、5.11	把家里（卫生间门口、玄关、床边）的地垫全撤出去——不是收起来，是撤出这个家（第5章 5.16）
怕失禁，出门丢人	第10章 10.2–10.4、10.9	做一组盆底肌训练：假装憋尿、憋屁收紧的那块肌肉，收紧五秒、放松五秒，做十次（第10章 10.11）
怕忘事，变成痴呆	第9章 9.2、9.4	拿"忘的是事，还是功能"这条线对一遍自己或爸妈；分不清，就挂一次记忆门诊或神经内科，进门说"记性变差，想查有没有能治的原因"
怕夜里一个人在家出事	第4章 4.7；第8章 8.9、8.10；第10章 10.8	把第8章那张判断表打印成大字，贴在电话旁，填上地址、社区电话、子女和邻居的号码
怕老伴先走，之后的日子	第4章 4.5、4.6；第11章 11.7；第22章 22.2	给一个真能说上话的老友打个电话，当场约下下次见面或通话的固定日子
怕饭都做不动	第12章 12.9、12.10	打电话问社区居委会：这一片有没有助餐点、我这种情况有没有补贴、走不动时能不能送餐上门
怕看病没人陪	第17章 17.4；第4章 4.9	去社区卫生服务中心问一次：家庭医生怎么签、签了管什么、多少钱
怕被子女嫌弃	第20章 20.4、20.13	把那句"我想跟你聊聊我对以后的想法，今天先不做决定"说出口，或发出去
怕家里为钱和照护翻脸	第20章 20.7、20.10；第22章 22.6	先列一份清单，标清哪些是夫妻共有、哪些是一个人的；再定一条家规——大额转账隔 24 小时再办
怕拖累子女	第4章 4.4、4.5	查一次你所在的城市有没有长期护理保险，失能评估和待遇怎么申请（参保地医保局）
怕钱不够，生场大病就塌	第4章 4.2–4.4；第14章 14.8–14.10	用"掌上 12333"查清养老保险缴了多少年、个人账户有多少，弄清自己坐在第几层
怕被骗（含 AI 假亲人）	第18章 18.6–18.13；第1章 1.7	和家人定一条规矩：大额转账隔 24 小时再办；凡"现在就交钱、过了今天就没了"的，先停一天、再找一个人说一遍
怕手机上的事办不成	第18章 18.2–18.5；第0章	今天跑通一个动作——挂号，或付款，把它做成一次；跑不通，就问社区有没有代帮办
怕"抱团"最后翻脸	第15章 15.5、15.6；第4章 4.5	先看一眼关系账：你能叫动的名单还剩谁，挑一个人，今天续上一次
	第20章 20.11、20.13；第21章 21.2、21.4	找到那个在你做不了主时替你说话的人，问他一句愿不愿意（第21章 21.10）

怕什么	翻到哪一章哪一节	今天能做的一件事
怕失去决定权，被当孩子哄		
怕疼着死，死得没尊严	第21章 21.2、21.3、21.5、21.7	先写下"现在最想保住的是什么"，再开始想"到了那一程，更愿意在家里，还是医院"

> 本表章节号与 `book/` 下的文件名一一对应（第 15–19 章定稿后已回填）。 涉及本人轻生这一类，只有第11章 11.8 一条，只写识别与求助：全国心理援助热线 **12356**，人工接听每天不少于 18 小时；人在危险里，打 120 或 110。

附录 E · 什么时候必须叫 120

把这一页打印出来，贴在电话旁边，或者冰箱门上。真出事的时候不用想，照着找。

拿不准的时候，记住一句就够：**分不清是不是急症，就打 120，让专业的人替你分。** 打了车没出大事、白跑一趟，也比"再等等"强。

必须立刻打 120（现在就打）	可以自己去急诊，但要有人陪	先打 120 咨询，或去社区、门诊
① **胸口正中或偏左的压榨样疼痛、闷痛，二三十分钟还不缓解，还出冷汗、气短、恶心。** 心梗的救治按分钟算，等的每一分钟都是回不来的心肌。有糖尿病或年纪大的人可能不怎么疼，只是突然气短、一身冷汗、想吐，也一样急，别自己找药把症状压下去。 ② **脸一边歪／两只胳膊平举有一边往下掉／说话含糊说不清，出现任何一样。** 中风按分钟算，越早到能溶栓的医院越好。症状十几分钟自己好了也算数，那是"小中风"，别放过。记下几点几分开始。 ③ **突然叫不醒，拍肩膀大声喊也没反应；或者人醒着却答非所问。** 这可能是心跳、呼吸出了大问题，时间拖不得。 ④ **喘不上气，呼吸极度困难。** 气不够用是要命的事，拖不得。 ⑤ **噎住后不能呼吸、咳不出声、发不出声，两手抓脖子、脸发青。** 东西把气道堵死了，喘不上气，拖不得。 ⑥ **大出血，血止不住地往外流。** 血一直在流失，人撑不了多久。 ⑦ **抽搐（抽风）停不下来，或者一次接一次。** 抽个不停，是脑子在出急事。 ⑧ **误服药物或不明物质。** 吃错的不知道是什么，越等越麻烦，别等人慢慢缓。 ⑨ **摔了一跤，出现：叫不醒／迷迷糊糊答不上话／想不起怎么摔的／脸歪／说话含糊／一边手脚动不了／剧**	摔了一跤，人是清醒的、能对答、没有左边那些危险信号：**当天要有人陪他去医院看一次。** 这一摔常常是身体先出的信号。 正在吃抗凝药、抗血小板药的人，哪怕只磕到头、当时清醒，也值得尽快去医院看。	拿不准是不是急症、症状还不重：打 120 问，让调度员替你分。 尿裤子、忘关火、一次头疼、一次心慌，人清醒、很快就好：记下来，去门诊或社区慢慢看，不必叫 120。 普通看病、开药、复查：别叫 120，自己去门诊。

必须立刻打 120（现在就打）	可以自己去急诊，但要有人陪	先打 120 咨询，或去社区、门诊
烈头痛／脖子或腰背剧痛／大小便控制不住／腿变形或一动就剧痛。 怕骨头断了、脑袋里出血。硬扶硬搬，会把没断的搬成断的、把出血搅得更凶。		

两条写在表外、但更要紧的规矩：① 拿不准，就打 120。② 先打 120，再通知人。

打通 120，先说清这五样

1. **地址**：省市区＋街道小区＋楼号＋单元＋门牌。门牌难找，就说一个明显的参照物；再派一个人到小区门口或路口等着，看见救护车挥一下手。
2. **症状**：一句话说清——多大年纪、什么症状、从什么时候开始。比如"七十岁，男的，胸口疼了半个钟头，直冒冷汗"。
3. **什么时候开始的**：这条对中风最要紧，几点几分开始，医生等着这个数。
4. **联系电话**：留一个**在现场**的号码，别只留你在外地的手机。
5. **有没有人接应**：家里还有没有人、能不能开门、有没有人跟着去医院。

别急着挂电话，等调度员确认完再挂，手机保持通畅，电话边出车边补。

别自己开车送，也别硬撑着走去

判断力和体力都在往下掉，路上出事没人救。120 能就近把你送到有救治能力的医院，路上就开始处理。打 120 和叫子女不冲突，是顺手一个电话。也别让病人自己开车、骑车，或者扶着他走过去——就在原地等车。

等车这几分钟，做一件事

把医保卡、常用药清单、诊断记录找出来，放在门口能一把拿到的地方；一个人在家的，顺手通知子女或邻居，让他们带齐药单和病史。

> 内容以第 8 章《三条就医红线与"第一小时"怎么办》为准。

附录 F · 话术卡：开口的十句话

有些话不是不想说，是一开口就变成了吵架。这一页给的是句子，不是道理。你可以照着念。

什么时候用	照着念的句子	对方常见的反应	下一句怎么接
① 想跟老伴或子女谈以后的事，又怕一开口就吵起来	"我想找个时间，跟你聊聊我以后的事。今天不谈决定，就想让你知道我是怎么想的。"	愣一下，反问："你是不是身体出什么事了？"	"没有。我就是想让你先知道我怎么想。你要是不想聊，我们改天再说。"
② 你自己觉得最近老忘事、心里没底，想跟子女说去看记忆门诊	"我跟你商量个事。我最近老忘事，心里有点没底，想去记忆门诊查一查，你陪我去好不好？"	"你别多想，谁不老忘事。"	"我不是要吓自己，是想早点查清楚。查完没事，咱都踏实。"
③ 爸妈身体有变化，你想陪他们去医院查一下	"我不是要管你。下次我陪你去，把平时吃的药和保健品都带上，请医生帮你一起看一遍。去不去、听不听医生的，还是你说了算。"	一句"我没事，不用查"顶回来。	"行，你不想去就不去。我把你的药单和常去的医院先记在一张纸上，哪天用得着。"（不用当场赢，换个场合、换个他更听得进的人再试。）
④ 你想谈将来住哪儿，但"要不要去养老院"这话一出口，谈话就结束了	"我在想一个事，先不急着定。现在这个房子，有没有哪一处让你觉得不方便？要是哪天需要人帮忙，你希望是在家里，还是换个地方？"	立刻警觉："你们是不是想把我送走？"	"不是要送你走。想先试试也行，去住三天，先不做决定。"
⑤ 你想说清楚：万一自己不行了，不要那种没意义的抢救	"我先说一句我的想法：要是哪天救回来也只是躺着、什么都不是了，那种抢救我不做。今天先让你知道我怎么想，你不用现在答应什么。"	受不了，说："别说这种话。"	"我知道你听着难受。那先记住我这句，哪天再说。"（这件事分几次、隔几个月慢慢谈。）
⑥ 想趁脑子清楚，把身后怎么安排说在前头	"有件事我想趁现在说清楚。我想立个遗嘱，把我这点东西怎么分写明白，省得以后你们为这个闹别扭。"	"您别说这个，不吉利。"	"正因为是现在脑子清楚，才说得明白。找个时间，你陪我去问一下怎么办。"
⑦ 你怀疑自己被骗子盯上了，或者已经转出去一笔钱	"我跟你说个事，先别急。我可能被人骗了，你帮我看看。"	先急了，怪你："你怎么这么容易上当。"	"别骂我，先帮我把钱看住。"（家里定一条：大额转账，隔 24 小时再办。）
⑧ 跟兄弟姐妹坐下来，谈照顾爸妈的钱和时间怎么分	"我们今天只谈一件事：照顾爸妈的钱和时间怎么分。今天不做决定，谁都可以说不谈。"	一开口就翻旧账。	"旧账我们另找时间算。今天先说这件事谁、什么时候、做什么。"（旧账没处理，先处理旧账，不然每场会都回到旧账上。）

什么时候用	照着念的句子	对方常见的反应	下一句怎么接
⑨ 你心里憋得难受，又说不清是怎么了，想跟人说	"我最近心里不太好受，也说不清是怎么了。我就是想跟你说说，你不用帮我解决。"	急着出主意、劝你："想开点。"	"你先别劝我，听我说完就行。"
⑩ 你想让孩子别老为你操心	"你不用担心我。我现在自己能照顾自己。真需要你帮忙的时候，我会开口。"	不信，反而更操心。	"你可以帮我做，但要先问我。"

> 内容以第 20 章《怎么开口：那些难以启齿的话怎么和家人说》为准。正式的文件形式（预立医疗照护计划、意定监护）见第 21 章。